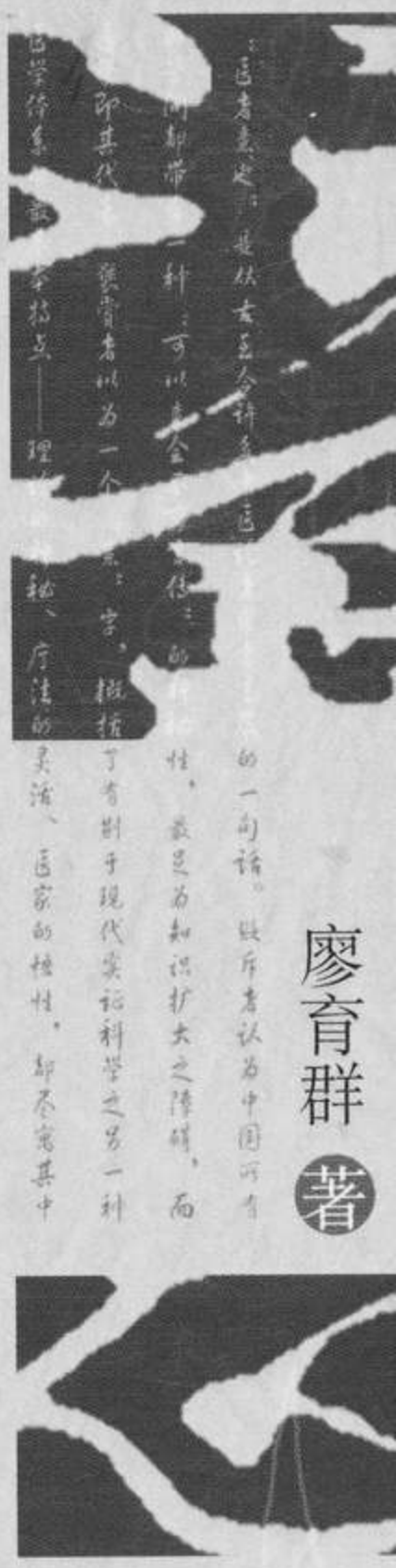
医者意也

认识中医



廖育群 著

GUANGXI NORMAL UNIVERSITY PRESS
广西师范大学出版社

作者介绍

廖育群，祖籍湖北省兴山县，1953年生于北京。“文革”期间作工务农，1982年毕业于北京第二医学院后，就职于中国科学院自然科学史研究所。1996年晋升为研究员，2000年始兼任副所长。主要著作有《岐黄医道》、《中国科学技术史·医学卷》（合著）等，论文多发表于《自然科学史研究》、《中华医史杂志》、《中国科技史料》等刊物。

组稿编辑：郑纳新
责任编辑：魏　东
责任质检：玉　明
封面设计：奇文雲海 视觉传达
qwyh_cn@yahoo.com.cn

Digitized by the Internet Archive
in 2019 with funding from
Kahle/Austin Foundation

https://archive.org/details/yizheyiyerenshiz0001liao

医者意也

认识中医

廖育群 著

广西师范大学出版社
·桂林·

著作权所有:©东大图书股份有限公司

本书中文简体字版由东大图书股份有限公司授权广西师范大学出版社在中国境内(台湾、香港、澳门地区除外)独家出版。

版权所有,未经著作权所有人书面授权,禁止对本书之任何部分以电子、机械、影印、录音或其他方式复制或转载。

著作权合同登记号桂图登字:20-2006-044 号

图书在版编目(CIP)数据

医者意也:认识中医/廖育群著. —桂林:广西师范大学出版社,2006.5

ISBN 7-5633-6006-9

Ⅰ.医… Ⅱ.廖… Ⅲ.中国医药学-关系-传统文化-研究 Ⅳ.R2-05

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 028248 号

广西师范大学出版社出版发行

(广西桂林市育才路 15 号　　邮政编码:541004

网址:http://www.bbtpress.com)

出版人:肖启明

全国新华书店经销

山东新华印刷厂临沂厂印刷

(山东省临沂市高新技术开发区工业北路东段　邮政编码:276017)

开本:890mm×1240mm　1/32

印张:7.75　　字数:165 千字

2006 年 5 月第 1 版　　2006 年 5 月第 1 次印刷

印数:00 001~10 000 册　　定价:18.00 元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与印刷厂联系调换。

(电话:0539-2925659)

透明狮子(代序)

这既不是名人捧场的序,也不是抒发情怀的点缀。这里所讲的"故事",本身就是你了解中医的绝好资料。

我与中医的缘分,始于幼时的耳提面命。常言道:"熟读唐诗三百首,不会作诗也会吟。"医坛则云:"熟读汤头三百首,不会开方也会开。"所以五六岁时即开始就着唐诗背"汤头",其后继之以《药性赋》、十二经脉、针灸腧穴,最终则是《伤寒论》、《黄帝内经》等经典的学习,这大概就是传统中医教育方式的写照。然而虽说是"家传",但实际上我与父亲几乎是同时接近中医的——因为他这位出身于福建马尾海军学校的"洋"工程师,是在中年患病后才改弦易辙变成了一位笃信传统医学的"土"中医。所以除了中医书籍外,父亲也让我读朱洗所著《荷尔蒙》之类的近代生命科学著作。

据父亲说,神农采药时总带着一只透明狮子,随时让它吃药并观察体内的变化。而爸爸的"透明狮子",就是他自己和我们姐弟三人。记得那时家中至少有三个煮药的砂锅,学医不久的父亲一会儿说我们脸红"上火"了,便令每人喝上一杯清热之剂;一会儿又说我们脸变白了是"脾虚",于是又让每人喝上一杯"四君子汤"。酸的谓之"梅汤",苦的说是"咖啡",连哄带逼反正得把药喝下去。所以我想告诉你:"实证"并非近代科学的专利。

不知是自幼当惯了"实验动物",还是父亲"实证"身教的影响,使我养成了"尝药"的习惯,毫不夸张地说:凡是出自我笔下的药,没有没亲自吃过的。不仅是乌头、肉桂、大黄、芒硝这些一般医生望而生

畏的“将帅之药”,而且我还长期服用过硫磺,偶尔尝过砒霜——因为小时听爸爸讲,冬季入水摸鱼的人之所以不怕冷,是因为常服“能起命门真火”的硫磺;某种口红中掺有砒霜,能延长青春。所以提笔开方时,对于某药吃下去会有什么效果、多大剂量才能起到作用、这副药会是什么味道等,皆心中有数。某些胡子一大把,终生只轻飘飘地开过“逍遥散”、“八珍汤”,或是几乎所有的药一律都开“三钱”(10克)的郎中、专家、教授,一看即知缺乏“吃药”的体验。

初中毕业“上山下乡”,经过不懈的努力,终于争取到当一名生产建设兵团卫生员的机会,并开始接受西医培训。从此头脑中便有了两种医学,并由此造成认识上的第一次“中西医学的冲撞与会通”,每周总要写上几封信问父亲许多问题,例如:西医的“伤寒”,是中医的什么病?而中医的“伤寒”,又是西医的什么病?等等。那时对拔牙、开刀、用洋文开张西药处方真的非常迷恋,也觉得比使用针灸、草药更有面子。但到了想靠“一技之长”谋个离开边疆的出路;或是离开边疆、返城当了工人,又想谋个职工医院大夫的岗位时,都还得靠“祖传中医”这张牌,于是便又从灵魂深处心甘情愿地回到了中医的“阵营”。屈指算来,在那八年“无照行医”的岁月中,凭着家传的技艺,也确有不俗的表现:在贵州绥阳,一纸药方治愈十八个小孩的“慢脾风”,使得县医院的院长当场开出接收证明,同意将我从云南兵团调入当地的医院当大夫;曾在安徽某汽车制造厂供销科长身上大施三折肱的妙手,痛快地购得当时极为紧俏的汽车配件;至于说那种小小年纪即备受恭维的享受,就更是经常可以体验一番了。

1977年“文革”结束,使我有机会进入医学院校接受正规教育,由此在新的层面上展开了第二次“中西医学的冲撞与会通”。正规的现代医学教育,固然是每一个医务工作者掌握医学基础知识的必由之路,但对于许多中医院校的学生来说,却成了学习中医、理解中医的

障碍。当他们进入学习中医的阶段后,类似前面所言“西医的伤寒是中医的什么病,而中医的伤寒又是西医的什么病”之类的问题,同样会困扰着这些初尝“两种医学体系冲撞”之滋味的中医后学。许多人也许会在从事多年临床治疗后,仍然摆脱不了“西医诊断、中药治疗”模式的束缚。而现代医学知识对于我这样一个已然有过多年中医实践、早已反复体验过“冲撞”滋味的人来说,却倍感亲切——因为只有在系统学习了现代科学知识后,我才获得了理解中医何以能治疗某病,中医何以要如此治疗某病的“密钥”。换言之,只有依靠现代医学知识,才能说清中医治病的“所以然”问题。所以在经历了第二次“冲撞与会通”后,我开始考虑将来著书立说,把“中医”解释得让中医、西医乃至一般人都明白,并自信能够做到这一点。然而在有了新的经历后,才知道要想达到这一目的,仅仅懂得两种医学体系的“科学”、“技术”成分——理论与技艺,仍是不够的。

大学毕业后,意外地走上了治“科学史”的道路。这一新的经历又意外地使我获得了更多理解中医的契机。概言之,现代科学知识可以帮助我们理解中医何以能够治病的问题;而历史知识却能告诉我们那些玄妙的中医理论是如何形成的。我知道,如此高度的概括总结,对于毫无切身经验的人来说,恐怕根本无法理解。因而不妨举两个小例子:一次无意间听到有人讲:“我的口疮一吃辣椒就好。”这确实太让我吃惊了,不要说是医生,就是普通百姓也会说:口疮是因为“上火”,吃些“牛黄解毒丸”败败火就会好的。但吃辣椒无异于火上浇油,怎么口疮反倒好了呢?这个问题伴随我多年,直到接受正规的科班教育后才找到答案。这是我要说的第一个问题,即“科学知识”的作用。再举一个例子来说明“历史知识”的作用:在“无照行医”的年月中,虽然不乏“过五关,斩六将”的骄人战绩,但也有“走麦城”的丢人之时。一次,仿效《黄帝内经》中“半夏秫米汤”的意思,为

一位失眠的患者处方一纸，次日，当听到患者说“大夫，我昨晚整夜未闭眼”时，顿时汗流浃背。但究竟错在何处，乃是在我学会以历史的眼光去分析《黄帝内经》何以要用半夏、秫米治疗失眠的原因后，才认识到的。总之，科学知识可以在中西两种医学体系间架起理解的桥梁；历史知识，可以在古今之间铺设沟通的道路，但无论哪一方面都是一个二维空间的平面，只有将科学的解释与历史的解释结合在一起，才有可能构建一个立体的三维空间，才有可能全面地理解“中医”。

小时候，爸爸曾经对我说：“有朝一日，你把《黄帝内经》彻底批判了，就是真正读懂了。”这些年的研究工作，可以说正是在朝着这个目标不断逼近。所有中医的“忠实”捍卫者一定会情绪激动地说：“你这是在挖中医的祖坟！”但我可以轻松地回答说：“不必紧张，因为今日的中医，早已不是《黄帝内经》时代的中医；旧瓶之中早已换了新酒。”要是不信，就认真看看我在这本书中是如何说的。

1998年5月2日，75岁的父亲突然出现轻度中风的症状。由于这些年来，年老的父亲对于中医的“忠诚”已经发展到了极端状态——听不得任何找他看病的人说“西医如何如何说”，每逢此时他一定会把病人大骂一顿，把西医大骂一顿，并经常说“我决不会住医院、让西医去整治”，等等，因此我想让他在家吃些中药，慢慢恢复。但两天后情况仍不见好转，体温开始升高。不得已，只好将他送进了医院。CT检查的结果是大面积脑出血，是否转到专科医院手术治疗，需要家属决定，当然结果不可预料。在这种状况下，每当有身穿白大褂的医生进来查房时，处于半昏迷状态的父亲总会怒目相视，掀开被子，表现出要回家的样子。最终，我决定坚持保守疗法。做出这一艰难的决定，除了我的医疗经验、其他大夫的预后分析外，还有一个十分重要的因素——父亲的心愿。这是一个悲壮的抉择，因为两

种治疗途径都有或生或死的可能。我的脑海中不断浮现出因接受手术治疗而得以存活的父亲会是怎样一种尴尬的表情与心态,他能够承受这种现实的折磨吗?他愿意接受这一结果吗?既然两种治疗途径都有或生或死的可能,我何不遂了他的心愿,成全了他的"晚节"呢。5月11日,父亲离开了人世。他的学生安慰我说:看着老师那慈祥微笑的面容,知道他已经到了一个极乐的世界;并告诉我说:老师常说"人之生颇易,死却极难,总是要受尽磨难才能超脱"。而我的父亲却是在基本没有什么痛苦,在诸多学生的日夜精心照料下,安详地走了。

我时常会问自己:父亲对我的决定是否满意?——作为一个中医!

目录

CONTENTS

生命科学与传统文化 …… 1

一、“科学”与“文化” …… 1

二、以人为核心的中国文化 …… 3

三、医学的文化研究 …… 6

四、以医化人 …… 9

五、人参文化 …… 11

六、叫花传艺 …… 16

七、《古脉法》与道教医学 …… 21

八、复古心态 …… 32

九、“名医”的故事 …… 35

医者意也——中国医学的一个传统观念 …… 42

一、出典与含义 …… 43

二、“意”之内涵的转变 …… 46

三、药物与“意” …… 51
四、脉诊与“意” …… 56
五、医案与“意” …… 61
六、反对者的意见 …… 67
七、科学的难点 …… 69

咒禁疗法——“意”的神秘领域 …… 72
一、咒禁疗法在医学中的地位 …… 73
二、咒禁疗法的作用力与转移方式 …… 79
三、咒禁疗法与宗教 …… 85

循环与对立——阴阳家的“意” …… 91
一、阴阳家及其学说旨要 …… 91
二、医学中阴阳循环、对立的不同表现 …… 94
三、医学中的特例：三阴三阳 …… 98
四、医学与易学 …… 102

气血运行——意构的生命理论框架 …… 109
一、问题的提出 …… 109
二、中国古代医学不知“心脏跳动” …… 112
三、以胃为中心的循环体系 …… 115
四、动脉—脉动 …… 118
五、对于呼吸的认识 …… 122
六、讨论 …… 125

运气的天空——高阁中的“意” …… 127
一、运气学说的基本内容 …… 128
二、运气学说的形成与演变 …… 134
三、科学与玄学——两种错误的解释 …… 145

脚气——意想的风土之疾 …… 149
一、亲身经历所引出的困惑 …… 149
二、近代的脚气病 …… 152
三、中国古代的脚气记载 …… 159
四、矿物药中毒的问题 …… 162
五、脚气病史的研究 …… 168

性命双修——道家养生之意 …… 175
一、道家生命观 …… 175
二、道家本旨与“养生” …… 178
三、“养形”之术 …… 180
四、道家学术思想的演变 …… 183
五、道家社会地位演变的影响 …… 187

“意”的领地——中医各科要义概说 …… 190
一、内科：疾医、大方脉、风科 …… 191
二、外科：疡医、疮肿科 …… 193
三、儿科：少小、小方脉 …… 194
四、妇产科：带下医 …… 196
五、骨科：正骨、接骨 …… 197

六、眼科 …… 199
七、口齿咽喉科 …… 200
八、针灸科 …… 201
九、祝由科 …… 204

“意”的延续——唯一存活的传统科学 …… 206
一、承认中医 …… 206
二、存活的理由 …… 208
三、我们正在丢弃什么 …… 211

中国传统医学的“传统”与“革命” …… 215
一、传统中的“传统” …… 215
二、传统中的“革命” …… 220
三、传统医学的现代化 …… 230

生命科学与传统文化

一、“科学”与“文化”

“科学”与“文化”，既是当代最为流行的两个词汇，也是内涵不定、外延颇广、歧义甚多的两个词汇。这两个词汇的另一个共同特点是：同属中国旧有，但古今含义不同。

“科学”一词，源自近代日本学者取中国“科举之学”中的“科学”二字译 Science，于是在日文中便有了“科学”一词，并从日本传入中国。这一翻译的取意，或许更为接近作为 Science 一词语源的拉丁语 Scientia（泛指学问或知识）；或与之最为接近的德语对应词 Wissenschaft（包括一切有系统的学问）的内涵。但是在大多数情况下，“科学”一词的含义，如同在英语中一样，实际上已然成为“自然科学”的简称①。而在当代民众的思想意识与语言表述中，“科学”甚至成了“正确”的同义语，所以在批评他人的观点不正确时，习惯的说法是：“这不科学。”

“文化”的准确含义是什么？这恐怕是个更难说清的问题。西方人释文化的含义为有教养②；考古与历史学中，一般是将文化定义为

---

① 参见 W. C. 丹皮尔：《科学史及其与哲学和宗教的关系》，李珩译，商务印书馆，1975 年，第 9 页。

② “Culture”源于拉丁语“耕作、修理、收拾、修整”，体现了以“农业”为教养之始的观点。“Culture”兼具教养与养殖栽培两义，这与中国古代的“神农”传说、当代释人兽之界出现于种植谷物之时，可以说都是相通的。

低于“文明”的发展阶段①;在中国古代,文化的本义是指“以文化人”,即使用非武力的方式来征服、教化民众②;而当代人一般是将文化定义为泛指人类创造的一切精神与物质财富。此外还有民众间的一些通俗用法,例如学习识字叫作“学文化”,一般知识水准叫作“文化水平”,等等。

作为流行之语,“某某科学”、“某某文化”之说随处可见;且可见到两词连用而成“科学文化”(Science as Culture 或 Culture of Science)的用法。“科学”与“文化”,无论是分别使用,还是连用,无疑都表明二者不是一回事;但从后一种用法中又隐约可以发现“科学”与“文化”的界限并非泾渭分明——科学之中也有文化,科学也可作为一种文化现象来加以研究。“科学”之所以也可以作为一种文化现象来加以研究,是因为“科学”具有发展的历史;是因为“科学”一旦成为历史,便转化成一种文化的积淀;是因为这种文化的积淀不仅代表着前人在认知自然方面的智慧结晶、思维方式,而且是当代科学发展的基础,并以某种形式影响未来。从文化的角度对“科学”进行研究时,其对象已然不是科学的对象——自然,而是科学本身——人类认识自然与知识体系形成的过程,甚至是创造科学的主体——人。

尽管在当代西方世界的知识分类中,“医学”已不再隶属于“科

---

① 在考古学中,指同一历史时期的不依分布地点为转移的遗迹、遗物的综合体,如仰韶文化、龙山文化。历史学用语:通常用来指尚未有文字、总的发展水平比较低下的社会或时期。但这个术语还有其他含义。有时候它用来指知识和艺术成就,如文学、艺术、音乐、哲学和科学。有些历史学家用它来表示一个民族或帝国在某个特定时期的思想、成就、传统和特征的整个综合形式(〔美〕爱德华·麦克诺尔·伯恩斯,菲利普·李·拉尔夫:《世界文明史》第一卷,罗经国等译,商务印书馆,1987 年,第 25 页)。

② 刘向《说苑·指武》:“文化不改,然后加诛。”又,《管子·轻重》:“黄帝作钻燧生火以熟荤腥,民食之无滋味之病而天下化之。”(按,此篇所言“化之”者,还有农、数、阴阳等知识。)

学”的范畴，但谁又都难于彻底否认“医学的确也是一门科学”。这一矛盾的存在，显然与“科学”这一概念的内涵并不十分明确有关，但更为重要的还是由于“医学”本身的复杂所决定。以养护万民健康为目标的卫生保健制度，体现了医学的社会性；有关人体生理、构造、疾病的认识，是人类认识“自然”的一个方面，构成了医学这门学问的科学内涵；利用与创造各种工具、手段方法来治疗疾病，是医学的技术要素。医学的对象“人”，既是“自然”的一部分，又是所有文化与知识的创造者、操纵者。因此，无论过去、现在，还是未来，医学都是一个十分复杂的多面体，而不是一门纯粹的自然科学。当人们谈到“医学文化”这一问题时，其中的“医学”，无疑相当于“科学文化”中的“科学”；但医学显然又比任何一门其他自然科学更具文化色彩。尤其是传统医学，其理论的建立、技术的形成往往与自然哲学、交感巫术具有种种联系。因而“医学文化”便成了近年来科学史乃至一般史学研究领域中悄然兴起的一个新话题。

二、以人为核心的中国文化

中国民众的普遍心态，是以现世人生为关注点，他们并不那么向往超凡脱俗的天堂仙境。所以才会有织女不堪天上寂寞而来人间结婚生子；王母娘娘的七仙女也甘愿舍弃天仙身份在人间与董永相配，生儿育女，过上了男耕女织幸福生活的种种神话传说广为流传。这种民众心态、价值取向，决定了饮食、养生以及与之相关的医学等，必然会受到重视。因而有人将中西两种文化比喻为两株大树，前者是“生命之树”，后者是“知识之树”。并说：“中国哲学就是生命哲学，中

国的道教就是生命宗教，中国文化就是以生命为本的文化。”①

没有必要深究这个比喻是否恰当，但对于其中谈到的“生命哲学”、“生命宗教”、“生命文化”，却有必要给出两点或许符合作者本意、或许超乎作者本意的诠释。首先，就时间坐标而言，尽管中国人有着一种与亚里士多德相类似的“灵魂阶梯”理论，承认“人”是天地万物中最得灵气者，位居阶梯的最高处，但对于生命与健康的重视，却是随历史演进逐渐达成的。早期的政治家并不太注意个人生命的延续，而是更多地注重家族的延续。孟子云“不孝有三，无后为大”，正是此意。

再者，似乎只有将“生命”理解为“人”，才能准确概括中国哲学、宗教与文化的特征。因为“人”有多方面需要治理：肉体、精神以及相互关系。在中国历史上占有主导地位的儒家“礼教”，讲的主要是社会秩序，是人与人的关系，子夏云“学而优则仕”——治理万物之灵被视为最高等的工作。古代的睿智哲人，在“近取诸身，远取诸物”模拟思维方式的指导下，以为天地一太极，人身亦一太极，天地大宇宙与人身小宇宙的构造、运动规律可以互证类通。因而他们往往以人身生理、疾病之因、治疗之道——这些易于理解、可以身验的事例，去阐说治世之道，谓之“缘医以知政”、“上医医国”。而真正能够治理肉体疾患的医疗技艺，却被视为“君子不齿”的百工贱业之一。

同样，常常被解说成以追求长生不老为终极目标、以言说养生之道为主旨的道家学问，在早期其实与儒家“礼教”一样，是一种言说如何治理社会的政治论。《庄子》中的《养生主》篇，实际上主要是讲擅为政者，当如庖丁操刀解牛——顺其纹理之自然。因此道家所

---

① 高旭东：《生命之树与知识之树》，河北人民出版社，1989 年，第 7 页。

讲的“养生”,实际上乃是“治生”。到了汉代,道教的第一本经典《太平经》提出“我命在我不在天”的口号,时常被人们用作阐说道教如何重视“生命科学”的论据。但实际上《太平经》所鼓吹的却是:行善可以“增算”(延长寿命)、作恶必至“减算”(缩短寿命)这样一种宗教观念。

同样是在汉代这一中国传统文化空前发展的重要历史时期,作为一种政治论的道家学问才逐渐被解释与改造成注重生命延续甚至是追求生命永驻的“养生之道”。一系列至今仍被奉为医学经典的著作,也是出现在这一历史时期。同时,儒家的“仁政”也更多地涉及到对医学技艺的需求。由于对父母应该“厚养薄葬”,故为人子而不知医,不足以言孝;奉君持家者,亦需稍识医药,如此方能“上以疗君亲之疾,下以救贫贱之厄,中以保身长全”;为政养民者,不仅要操心人类社会纲常伦理、百姓的衣食温饱,还要在疫病流行时施医给药。所以从骨子里轻视自然科学与百工技艺的儒家“礼教”,却间接地导致了上至帝王将相,下及庶民百姓对医学的普遍重视。宋代以后有“儒医”之说,知识分子将“认识生命”与“治理生命”提高到与“治人”、“治世”同等重要的地位,视医学为“吾儒格物穷理之一端”,由此进一步推动了医学,尤其是医学理论研究的发展。知识分子“不为良相,则为良医”的价值取向,无非是“治人”的两个不同侧面——“良相”治理由人组成的社会的疾病;“良医”治理自然之人的肉体疾病,所以中国文化的确是以人为核心的文化。

“人”之地位的逐步提高,是文明发达的重要标志之一,或者说是文明构成的要素之一。殉葬、伤残肢体之酷刑的废除,对于死刑的慎重,是“人”之地位上升、政治进步、文明发达的种种表现。而医学的逐渐发达与受到重视,也同样是“人”的地位逐渐提高的一种表现形式与证明,同样是文明不断成长的一个重要侧面。

三、医学的文化研究

1990年,李良松、郭洪涛编著的《中国传统文化与医学》(厦门大学出版社)问世并获奖,似乎可以看作是中国开展医学文化史研究的嚆矢。其后,李良松又与刘建忠合编了《中华医药文化论丛》(鹭江出版社,1996年),继续从文化的角度研究中国的传统医学。上海方面有马伯英等著《中外医学文化交流史》(文汇出版社,1993年),以及马伯英的个人著作《中国医学文化史》(上海人民出版社,1994年)。这些都是瞄准"医学—文化"之关系、幅越50万字的巨著。此外还有诸如李经纬等编著的《中国古代文化与医学》(湖北科学技术出版社,1990年);孙文采、王嫣娟围绕着人参的历史编写的《中国人参文化》(新华出版社,1994年);中国中医药学会等编辑的《中国道家医学文化研究》(黄山书社,1997年);以及各种侧重时间、空间、气象、阴阳五行、象数等与医学之关系的专著出版。另外还有一些虽然没有直接以"文化"为书名,但或是在绪言中强调其书注重文化研究,或是在内容中将医学作为一种文化现象加以研究的著作。再者,各种各样以"医学文化"为主题的学术研讨会亦可谓屡见不鲜。据此,言"文化研究"风行于当代中医界,谅不为过。同时,还有一类聚焦于历史上与疾病、卫生、医疗有关的社会问题,名曰"医疗社会史"的研究。这两方面研究的共性首先在于,在史料的利用方面均超越了古代医学著作的范围,诸如骚人墨客、九流十家、民俗故事等,皆在涉猎范围。其次则是论述的视野宽阔,以至在许多情况下已然完全脱离了医学的知识体系、医家的实践活动或客观存在的疾病现象,成为"没有医学

的医学史”或“没有疾病的疾病史”①。总之，由于研究的范围、利用的资料、所要说明的问题等已然超越了“医学”的自然科学属性，故加上“文化”二字以正其名。

我以为“中医文化”、“传统医学与文化”或“医疗社会史”一类话题之所以盛行于中医界和史学界，并形成相互影响、促进之态势的主要原因是西方“文化人类学”的影响以及史学研究的自身发展所致。人类学起源于地理大发现时代欧美学者对现代西方文明之外的社会的研究；20 世纪以来，文化人类学与体质人类学分离。非西方的其他文明，被分别作为一个独立的文化单元加以研究，因而西方的中医研究很多都属文化人类学范畴（或可称汉学研究范畴），而不是将其作为一种“医学”加以研究。在这种学术风潮的影响下，“某某文化史”成为时髦之语。

另一方面，就史学的发展而言，在 20 世纪史学发展中极具影响的法国“年鉴学派”的核心旨要，可以说就是提倡扩大研究与资料利用的范围。民国以来“新史学”的出现，亦不越这一轨范。近年，台湾“中央研究院”历史语言研究所在前所长杜正胜先生的带领下，开展了“另类医学史”的专题研究，其实质即是扩大了史学研究的范围——从以往的政治、经济史研究扩大到“生命问题”；注目于以往史学家未曾注意的“医药学史料”，以此来弥补以往“文化史”研究的片面与不足。在这两方面因素的综合作用下，于是乎人文科学的研究中便出现了对于“人类自身”的特别关注——人类如何认识生命、身体、疾病、思维、感觉、梦、心理……，以及不同社会、民族、文化的认识有何不同。

---

① 例如，医学史的研究无疑会包含各种疾病的历史，而医学文化史或医疗社会史的研究则会超越所有的疾病，选择“装病的历史”作为研究的对象。

文化研究盛行的另一个原因，是社会的发展为“文化人”提供了更多的生存空间。学医的人未必一定要当医生才有饭吃。不难发现，凡大谈中医文化者不外两种情况：学过中医，但无意于临床，也无意于实验或理论研究；文史哲出身，因某种因缘而对中医有所了解，但并不懂如何治病，也不懂中医何以能治病。尽管这两种人的出身不同，但共同的特点是天生乃是一文人。中医能够治病这一客观现象，对于他们的感官往往没有任何刺激作用，或者在大脑中无法产生“共鸣”。因而自然就会无视传统医学的“科学”属性，片面地将其视为一种传统文化的遗存。还有一种情况是在某些人的头脑中，习惯于将符合现代科学的东西称之为“古代科学”，不符合的统统称之为“传统文化”。因而尽管一般说来，中医的知识体系与现代医学有所不同，含有较多的文、史、哲内容，但请注意：这必须是在将现代科学、西方医学定义为“医学”的前提下才能成立，如果以传统医学自身为标准，那么恐怕所有的内容都属于“医学”的范畴。应该说，不管是从哲学、社会、宗教等任何一个角度对传统医学进行研究，还是搜罗骚人墨客诗词歌赋中的病名、药名、患病经过、医家交往等，都有助于全面了解中华文明的重要组成部分——传统医学。

其实，早在数十年前，就曾有史学家感叹中国缺少真正的“通史”著作，即达到上下贯通、左右旁通之水准的“通史”。这样的“通史”不是大而全、无所不包的“拼盘”，而是希望将我们现在习惯划分的“社会科学”与“自然科学”两大领域融于一炉。然而这个美好的愿望恐怕永远只能存在于东方地平线上——可望而不可即。科学史研究应该由科学家来承担，还是由史学家来承担？这个国际科学史界长期争论的话题，反映出两方面学者各有短长的实际状况；而在此基础上的全面融会贯通，更是难有胜任者。纵观这些年国内的“医学文化”研究，基本上属于“历史性的”，即主要围绕着医学与哲学、宗教、经

济、交流等的关系，综合性地探讨医学知识发生、发展的过程。所以从长远的角度、宏观的角度看，“中医文化”、“传统医学与文化”的研究，应该视为史学研究的一部分，应该成为中国文化、中华文明的一部分。

四、以 医 化 人

站在“文化”原本是指教化民众这一最原始的含义上思考“文化”，则不难理解古人何以会对钻燧取火、凿井筑屋、尝百草定可食等大加渲染。概因人类生活中一切看似平淡的小事，无不始于教化。在此之前，人类的生活与其他动物应该没有什么区别——使自己的生活适应自然环境。人类为自身的发展规定了方向，呈现出“自行驯化”的状态，这就是“文化”。那么医学当中是否也存在着“文化”的过程呢？答案无疑是肯定的。中国人产后“坐月子”，不吃冷物、不妄劳作，而西方人则无此习惯；日本人原本是有这些习惯的，但明治维新后被西方医学所“化”，产妇已毫无顾忌地吃起了冰淇淋。① 中国人妇孺皆知受凉会感冒，但在西方人的思维中却没有将自然气候与疾病发生联系在一起，而是必在病原体的感染上找原因。中国人说好

① “坐月子”是一个十分复杂的问题，需要专文详加论说。因为(1) 中国唐以前的医学文献中从未言及此事，宋代之后才突然出现，其源头何在，有待深入研究；(2)“坐月子”在现代中国人的认识中，仅仅是指产后避风、避冷物、不妄作劳等，但古代却真的要“坐”，故称“坐月”；(3) 说西方人没有“坐月子”的习惯亦不准确，据一位美国朋友讲，在不太很久的过去，美国人产后也有种种“禁忌”，所以应该将“坐月”译为 confinment。这或许正是 confinment 具有“分娩”与限制、禁闭两种含义的原因。

发脾气是“肝火太旺”，而法国人则认为消化不良是“肝火不足”所致。① 民众为何会有这些普遍看法，如果以为原因在于“生活经验”，那么为何在具有“同样身体”的“不同民族”间没有产生共同的经验性认识呢？所以这实际上是由于“医学文化”——医学的教化所决定的。不同的社会中有不同的医学认识，因而教化的结果——民众的普遍认识、生活习惯亦因而不同。古人说孕妇不能吃兔肉，否则生子成兔唇，民众信而遵行之，于是便成了民俗、习惯、普遍认识，但这并不是生活经验，而是被教化的结果。至于说中国的医家为何会将疾病的发生与气候变化联系在一起（准确地说是和天地间的“邪气”联系在一起）；为何会有食兔成兔唇的说法；为何会将肝火与脾气联系在一起，而不是与消化不良联系在一起，则是研究考察“认知方法”、“医学理论”者的任务了。古人知道同姓结婚，其生不藩，并以此教化民众，但民众并不接受这种教化。拒绝教化，也是文化研究的内容。禁止近亲结婚在当代已成为法律，法律已然不是文化。越南在12世纪前后接受了中国医学理论后，民众的语言中才开始出现“感寒”、“感热”等词汇以及相应的疾病观，这个过程也是医学文化——教化的过程。这类过程是怎样进行的，进行当中异邦民众接受了哪些、拒绝了哪些、改造了哪些、何以会接受、何以会拒绝等，可以说都是“医学文化”所应研究的内容。

求生是动物的本能，但在有病时接受医学的治疗却不是本能，而是教化的结果。《史记》中谈到“信巫不信医”；《汉书》中鼓吹“有病不治，常得中医”②，显示了早期民众对医学的拒绝态度。经过不断的

---

① 因为法国的古代医学理论认为：胃是装食物的“锅”，肝是锅下的“炉子”。炉火不旺，自然无法煮熟食物，所以法国人将暴饮暴食之后出现的消化不良现象称之为“肝急变”。

② 此处之“中医”，是“中等之医”的意思。

教化，演变成当代民众对医学的绝对信任："医生说咋治就咋治"，而且病人及家属都没有随便翻看病历(治疗记录)的权力。而在当代西方世界，这种将自己完全委付医生、由医生决定自己命运的时代已经过去——民众被告知：你有权了解自己的病情、选择治疗的方法。

西方医学传入之后，中国民众从"宁死不开刀"、"身上不能缺点儿什么"、极端恐惧，到普遍了解、能够接受手术疗法的过程，并不是医疗技术本身的发展过程，而是文化的过程——接受西方医学、被其所化的过程。

如此看来，如果我们不忘老祖宗说"文化"就说"以文化人"，那么"医学文化"研究未必一定要搞得似乎是文人墨客的闲情逸致；未必一定要避让开医学理论与治疗技艺的核心内容；未必要将传统医学划分成"科学"与"文化"两种内容。的确有许多应该研究但尚未被注意的题目值得注意。

五、人参文化

相信许多与我同龄的人都看过一部名为《人参娃娃》的动画电影，或是读过同名之书、听过这个故事。但是你可能未曾注意："人参"能够作为童话故事、动画电影的题材，说明故事的主题具有广泛的民众基础——许许多多的大人、儿童都知道人参，知道人参是宝贝；反之，这个童话故事的广泛传播又起到了进一步宣传"人参是宝贝"观念的作用。因而就这样一部电影的存在而言，其本身就既是"文化"的结果，也是继续"以文化人"的过程。当今有那么多中国人将人参作为滋补保健品来服用，能说与这个故事没有一点关系吗?

同样，如果没有《白蛇传》故事的传播，会有那么多人知道灵芝仙草与雄黄酒吗？尽管古代的医学著作有所记载、中医治病也使用这些药物，但其宣传效果、普及范围肯定要小得多。

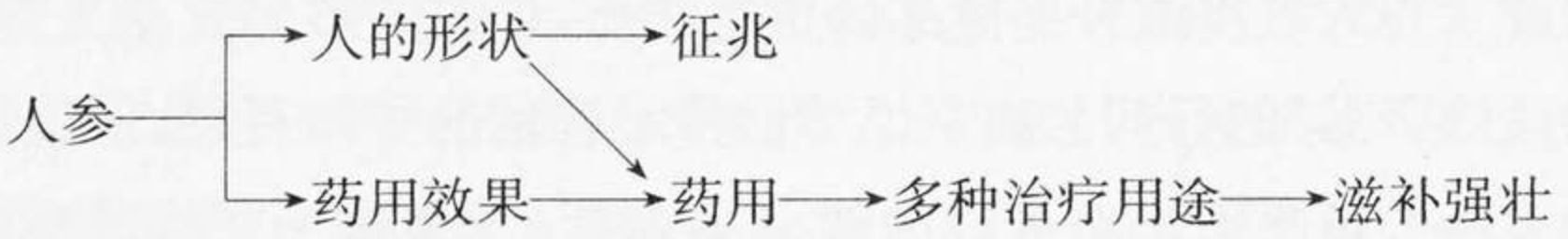
再者，《人参娃娃》的故事中还蕴含着另一个不容忽视的要点，即人参是个“娃娃”。这固然是一种“拟人化”的艺术处理，但根源却是因为在传统文化中，人参本来就具有“人”的特征。在较早的文献《范子计然》中说“人参出上党，状类人者善”；其后则进一步被描述为“一如人体状，夜有人呼声”。另外，还有一些更加离奇的记述，如南朝宋叔敬所作志怪小说集《异苑》中说：“人参一名土精，生上党者佳。人型皆具，能作儿啼。昔有人掘之，始下数铧，便闻土中有呻声，寻音而取，果得一头，长二尺许，四体毕备而发有损缺处。将是掘伤所以呻也。”《隋书·五行志》中亦提到：“高祖时，上党有人宅后每夜有人呼声，求之不得。去宅一里所，但见人参一本，枝叶峻茂，因掘去之，其根五尺馀，具体人状，呼声遂绝。”

具有人体形状的人参，自然与一般植物不同，古人以为其中蕴藏着某种“精气”。例如汉代的《春秋·运斗枢》中说：“摇光星散为人参，废江淮山渎之利，则摇光不明，人参不生。”这是说天上的“摇光星”散落地上生成人参，如果皇帝的行为、政令有问题，则天上的“摇光星”失去光辉，地上也不会生长人参。同样，《礼·斗威仪》也说：“君乘木而王，有人参生。”①古代的辞书《广雅》将人参解释为“地精”，即地之精气凝聚而成。有关十六国时期后赵的建立者石勒(274～333)的传记中记载，由于人参生于石勒的家园，故人们知道日后他必定显贵不可量：“所居武乡北原山下草木皆有铁骑之象，家园中生人参，花叶甚茂，悉成人状。父老及相者皆曰：‘此胡状貌奇异，

① 《太平御览》卷九九一，中华书局，1960年影印本，第4385页。

志度非常，其终不可量也。’”①这个体奇貌异、有大志量、家园中生长了枝叶繁茂之人参的胡人，终于当上了皇帝。此外，在汉墓出土的殉葬品中也能见到人参，其目的是让具有人体形状的人参代替墓主人“受过”。

具备科学头脑的当代之人，当然不会认为一种植物长得像人体形状就有什么神仙之气，也不会想像人参能够发出“儿啼”、“人呼”之声，他们通常是按照“科学的态度”与“唯物史观”来观察医学发展的历史、解释人类认识与利用自然药物的过程，以为人类对自然界中动、植、矿物的治疗作用的认识，都是来源于生活、生产实践，即吃了某种东西之后，不仅充饥填肚，还有某种治疗作用，由此逐渐认识了草根树皮的药用效果。但这也许并不是古人认识事物的真实途径，就人参这种药物而言，至少在现存古代文献的记载中，我们看到的却是因其具备“人形”而引起了人们的重视；是作为一种“征兆”而出现在现实生活当中。可见，虽然人参在汉代已经入药——出现在本草著作与医方中，但我们却不能认为当时仅仅是将人参作为一味药物来认识，至少还同时认为人参是一种吉祥的征兆，这种认识甚至有可能早于药性认识。归纳一下，人参进入人类生活后的情况如下图所示。



不论是作为吉祥的征兆，还是作为药用，最初显然都与人参的形状有关；但服用之后，却获得了实际效用的体验。实际上传统医学中的药物知识，往往都是源于这种分不清究竟是巫术还是科学、是经验还是先验的认知途径。然而不管怎样讲，在后来的岁月中，人参的尊贵地位毕竟是建立在药效的基础之上。《潜夫论》言：“夫理世不得真

① 《晋书·石勒传》，中华书局，1974年点校本，第2707页。

贤，譬犹疾不得真药也。疾当得真人参，反得萝菔，己不识真而饮之，病浸以剧，不知为人所欺也。”《梁书》说：“孝绪母王氏忽有疾，合药需得人参。旧传钟山所出，孝绪躬历幽险，累日不逢。忽见一鹿前行，孝绪感而随后，至一所，遂灭。就视，果获此草。母得服之，遂愈。”唐代李翱的《卓异记》载：“骆琼采药北山月下，……于古松下得参一本，食之而寿。”均反映了世人是将人参作为一种难得的宝贵药材来看待的。此外，出产人参的朝鲜半岛，将其作为贡奉中国朝廷的特产；唐代诗人的佳作中，时常谈到以人参作为馈赠朋友的礼品；明清时期，苏州等地有专营人参的“参行”，等等，也都显示了人参的身价。

正是由于人参的贵重，所以一般人治病，是用不起人参的。这种情况持续了多久呢？数十年前，中国百姓患病一般仍是不用人参的，因为人参属于“贵重药品”，公费医疗不允许报销，所以概用党参、沙参、太子参等代替。近些年，人们吃人参及人参制品已经相当普及，决定性的因素有两点：一是经济发展了，生活水平普遍提高了；二是人参的大量种植，导致“物不希”，价格自然也就不贵了。然而虽说是经济发达了，人参的价格相对而言不贵了，但如果将中国百姓的一般工资收入与人参等滋补保健品的价格相比，仍旧应该将其纳入“高档不耐用消费品”的行列。向来以节俭持家著称的中国百姓，何以会在收入有限的情况下拿出可观的钱去买人参、人参蜂王浆等滋补药品呢？换个外国人，大概不肯将这种开支纳入自己的家庭经济计划吧。这就需要看到：老百姓吃人参，是一种文化现象，也就是我们所要强调的“文化过程”。这个“文”，就是有关人参能够滋补强身、有益健康的知识；而“化”的过程，却大约花费了一千多年的时间才达到今日如此普及的程度。今天，如果我们就“最名贵的中药材是什么？最有益于健康的中药是什么？身体虚弱时应该吃哪种中药？以中药为礼品时，选什么较好？”这样一些问题进行一次问卷调查，相信许多中国人

都会回答：是人参。甚至可以推想，如果将调查范围扩大到我们的邻国朝鲜、韩国、新加坡、印度尼西亚等地，其结果都会是相同的。但是到了印度，情况就或许会大不相同，许多人大概会以他们心目中的神草“苏摩”(soma)为答，当然这时设问的题目必须稍加修改——不能再用“中药”这个词汇。

当以“人参”为例而谈医学之“文”与医学之“化”的问题时，还应该从更宽泛的角度讨论一下中国人对“虚”这一概念的认识与恐惧。在西方，人们不会将疲劳、乏力、虚弱等视为“疾病”；但在中国，这些都是疾病。医生可以在病人询问自己患了什么病时回答说：虚证！包括气虚、血虚，脾虚、肾虚，阴虚、阳虚等。病人或许并不理解这些概念术语的准确含义，但他们却能够满意于这种“不明不白”的诊断——因为他们理解“虚”。对于“虚”这种疾病的恐惧，使得他们乐于购买人参等“治疗虚证”、“能够强身健体”的滋补药品。用一句当代最流行的话来说，叫作“花钱买健康”。西方人也并非没有“花钱买健康”的意识与行动，他们以旅游休息、去健身房等方式锻炼身体；中国人却通常将这些视为“玩”。另外，韩国的医史学家告诉我：在韩国，通常是妇女购买补药吃，希望青春永驻，免得失去丈夫的宠爱。总之，我们在比较这些问题所涉及的方方面面时，会发现不同社会、不同文明间无所不在的差异。随着西方文明的传入与普及，中国人不仅也开始热衷于旅游健身，而且维生素、微量元素等符合西方“补药”概念的滋补品也获得了相当大的市场份额。这种差异渐呈缩小的趋势，也是一种“以文化人”的过程，只不过是以西方之“文”化东方之“人”，但传统的观念仍旧根深蒂固地发挥着潜在的影响。

文化的交流总是双向的，北美虽然生长着我们称之为西洋参、花旗参的植物，但据说洋人最初并不食用这种植物，仅仅是向中国等地出口。然而现在西方人不仅食用西洋参，而且开始从中国进口人参

蜂王浆等滋补品。目前，西方医学已经不再无视疲劳、乏力、虚弱等现象，尽管他们仍然不认为这是“疾病”，但至少承认这是不健康的表现，所以名之曰“第三种状态”；随着免疫学的进展，许多疾病被认为是因人体自身的免疫力低下所致，而人参等滋补类的中药又被证明具有增强免疫系统功能的作用，那么今后会不会出现“人参文化”漂洋过海，“化”掉西方人的局面呢？从根本上讲，这还要看医学的发展，要靠实验医学拿出足以令人信服的临床统计资料与理论性的说明——因为他们毕竟没有类似中国那样的传统文化。

有人将不同的文明比喻为鸡和鸭。鸡有鸡的特点，鸭有鸭的长处。以西方近代兴起的实证科学为唯一标准来衡量其他文明，就好比以鸡为标准来衡量鸭。老百姓说“三十年河东，三十年河西”是有道理的，遇到水塘沟渠时，鸡过不去鸭却能过去。对于各种文化优劣短长的了解，好比说“既要知道有鸡，也要知道有鸭”；对于各种文化之长处的吸收，好比是“养鸡又养鸭”。

最后需要说明的还有一点，人参是滋补强壮药的代表，但绝不是使人长生不老、青春永驻的仙药，其危害也是不容忽视的。中国古代有句老话说：“人参杀人无罪，大黄救人无功。”一方面是要人警惕人参也会致人于死地；另一方面则是针砭世人盲目崇信人参的时弊。归根到底，中医中药讲究的是“辨证施治”，最基本的要点就是要能够区别疾病的阴阳属性，再以相应的药物补偏救弊。弄反了，则成为火上浇油、雪上添霜。

六、叫花传艺

据司马迁《史记》讲，先秦时期著名医家扁鹊的独特医疗技艺，乃

是得自异人长桑君的传授。而长桑君之所以将自己的“绝技”传授给扁鹊，其原因在于身为馆舍管理员的扁鹊，礼待他十年有加，于是有一天：

> （长桑君）呼扁鹊私坐，闲与语曰：“我有禁方，年老，欲传与公，公毋泄。”乃出其怀中药予扁鹊：“饮是以上池之水，三十日当知物矣。”乃悉取其禁方书尽与扁鹊。……扁鹊以其言饮药三十日，视见垣一方人。以此视病，尽见五脏症结，特以诊脉为名耳。

不管司马迁采撷民间传说编写成的《扁鹊传》中的这段故事是真是假，但类似的事情却确实存在。

我的故乡在三峡之滨的崇山峻岭之中——以“昭君故里”而闻名的湖北省兴山县。舅爷家世代为医，并开有自家经营的药店。由于乐善好施，所以在民国时期也算得上是当地名声不错的乡绅之一。听父亲讲：某日有叫花上门讨饭，饱食一餐之后仍不肯离去，要求寄宿一段时间。此后叫花每日随伙计吃住，既无人驱赶他，也没有人注意他。

一日，叫花让伙计将舅爷请来，声称自己要走了。舅爷笑道：“要走就走，莫非我还留你不成？”叫花道：“我吃了你家这许多时光的饭，总要有所回报，以示感谢才好。”舅爷一副漫不经心的样子说：“你一个叫花子，能有什么东西用来谢我？”叫花亦笑着说：“彭先生，你治病卖药，我传你些看病的本领如何？”随即言说一二。这时舅爷才意识到：遇到异人了！此后自然是设宴摆酒、礼遇款待，听其传授。

众所周知，技术与科学的不同点之一是技术所具有的经济价值，当代社会推行专利制度，以求在保证技术发明者利益的基础上，促进先进技术的使用与推广。从这样的角度出发来看待在没有专利制度保障的环境下，工匠对技术持“保守”态度，显然就是十分自然与合理

的了。医学中含有大量的实用技艺，从某种角度讲，医生也是一种“工匠”——医者，治病工也。然而在中国传统医学领域中，业者的技术价值观却要比其他领域复杂得多。首先，确有一部分医疗技艺的持有者将其视为“换饭吃的本事”而持保守态度。同时也有相当一部分人将医学视为“仁术”，著书立说、广授生徒、自费刻印，甚至将有用之方刻石立于路边——概言之，希望采取一切可能的方式使天下之人皆能受惠于自己的医学知识。但另外还存在着一种深深影响技艺持有者价值观的理念：“得其人乃传，非其人勿言”①；“非其人勿教，非其真勿授，是谓得道”②。概言之，非其人而传，谓之妄泄天机；得其人不传，谓之失道。这种技艺传授的原则，见述于现存最早的医学经典《黄帝内经》之中。从长桑君授艺扁鹊，到本文所讲述的发生于现代中国社会的故事，都是以此为技艺传授的指导原则的，但这种传授方式的“用心所在”却未必相同。有着眼于“量才施教”者，如《灵枢·官能》谓：

> 明目者，可使视色；聪耳者，可使听音；捷疾词语者，可使传论；语徐而安静，手巧而心审谛者，可使行针艾，理血气而调诸逆顺，察阴阳而兼诸方；缓节柔筋而心和调者，可使导引行气；疾毒言语轻人者，可使唾痈咒病；爪苦手毒，为事善伤者，可使按积抑瘕。各得其能，方乃可行，其名乃彰。不得其人，其功不成，其师无名。故曰：得其人乃言，非其人勿传，此之谓也。

另一种情况与发生在宗教群体中的“宗派”现象有些相似。宗派与学派的区别在于，它不仅有自己的学说，而且还有某些特定的“教规”，并和财产的继承权相关而更加强调“衣钵传承”。在今本《黄帝

---

① 《灵枢·官能》。
② 《素问·金匮真言论》。

内经》中，专论某种特定脉诊方法的《素问·三部九候论》见有“歃血而受，不敢妄泄”之语；专论另一种脉诊之法的《灵枢·禁服》亦说：“此先师之所禁，坐私传之也，割臂歃血之盟也。”讲授运气学说的《素问·气交变大论》则谓：“非斋戒不敢发，慎传也。”由于医学知识既是一种财产，同时又是一种学说，因此医学知识的传授便流露出与宗派具有“教义与财产”双重含义之“衣钵传承”相同的味道，尤其是某些在当时属于具有特殊意义的医学知识与技艺——例如脉诊。而当这种技艺的传授附带有“歃血为盟”等仪式时，宗派的性质也就更加明显了。这种“宗派”式的医学传授，在后世大概主要存在于道教群体之中，但在日本“近世”（江户时代）却表现得远比中国明显，诸如“道三流”、“意斋流”等冠以师祖之名的医学“宗派”比比皆是，各具特色的医疗技艺也仅限于传授给本门弟子。

第三种情况可以叫做“老师对学生的追求”。由于人命至重，所以如果没有良好的医德，则越是握有高深技艺，就越可以用其搜刮民财，干预造化（例如堕胎、转女为男①），甚至助纣为虐，夺人性命。医学这种既可救命亦可害人的“双刃剑”性质，与“开锁”的技艺十分相似——既可助人解困，亦可入室自盗，因而为师者在选择弟子时往往会对“德性”如何有所考虑。同时，要想真正掌握“只可意会，不可言传”的医学技艺，还需要一定的“悟性”。正如唐代大医家孙思邈所云，一个好的医生应该“行方、智圆、心小、胆大”，如此可作“苍生大医”，反此则是“含灵巨贼”。为师、为父者，对于德、才有所欠缺者，往往会“只传些看家吃饭的本领”——使其既不致为生活所困，又不致恃“技”作孽。所以要想找到一个真正能够继承衣钵的合适人选，绝非易事，不仅要靠老师去发现、去追求，还得有缘分。据说，在诺贝尔

① 不管胎儿的性别是否真的可以转换，但古代医生认为这是可以办到的。

奖得主间呈现较高的“近亲繁殖”现象，也与作为获奖者的老师求贤若渴地“追求学生”具有一定关系。他们通常会以猎人般的眼睛搜寻“可以作为学生”的优秀人才，并将其网罗麾下，着力培养。从这一点讲，本故事中的“穷叫花”与身为科学巨匠的诺贝尔奖获得者，倒是具有某些人格上的相同之处。

真是无法将持此种“师道”者，与那些一生辛苦育人、桃李满天下者放在一起来评论其优劣短长、孰是孰非。两种“老师”都是社会生活中的现实存在，也都十分高尚、令人钦佩，其区别在于他们具有不同的人生道路——前者以“出世”的潇洒风度行“济世”之实；后者以“入世”的积极态度实现“园丁”的理想。再者，他们所握“知识”的性质也必定有所不同，前者握有的一定是“个性”；后者握有的一定是“共性”。

没有人知道那位叫花子究竟传了哪些“技艺”给我的舅爷，但他手中从此有了一种神奇的“布”——含在口中，任何疼痛皆堪耐受。

发生在舅爷家的事，令我的爷爷颇为好奇。因为虽然他经营的只是县城中的一家点心铺，但也好医、好善——在家中供养了一位懂医的孤老王慈臣，为百姓疗疾治病不取分文；且每晚少不了要听王老先生谈医论道。所以自然要屡屡向舅爷询问这“布”到底是怎做的。但舅爷却总是闭口不谈。被缠得无奈，才大致讲了些皮毛：上山采药时在腰间缠上一块布，将某些药物的浆汁涂布其上；到病人家看病时，再用此布揩病人之汗，且越是重病越佳，如此重复多次，布厚如革即成。

爷爷最终没有问出“神奇之布”上究竟涂了些什么药，所以后来也当了医生的爸爸只能是将这段传奇故事告诉孩提的我；舅爷死了，昭君故里再没有人知道“神奇之布”的做法；叫花子走了，不知他是继续使用这样的方式去“发现”值得传授技艺的“有德之人”呢，还是觉

得已然完成了传授大任而如释重负。“神奇之布”的制作方法大概真的再没有人知道了，这种“技艺的失传”是否令人惋惜呢？我看倒也未必。因为即便是其制作方法仍然为人知晓，当代大概也无法继续使用这种独特的制作工艺；再者，普鲁卡因等麻醉药已然完全解决了手术止痛的需要。同时我们还必须认识到，中国传统医学作为唯一存活下来的“传统科学”，其存活的“理由”并非在于某些特殊的“技艺”，而是因为其中蕴含着一种与近代医学完全不同的思维方式，以及以此种思维方式为基础建立起来的理论体系。当然，其中也的确不乏种种足以令世人瞩目的美妙技艺。

七、《古脉法》与道教医学

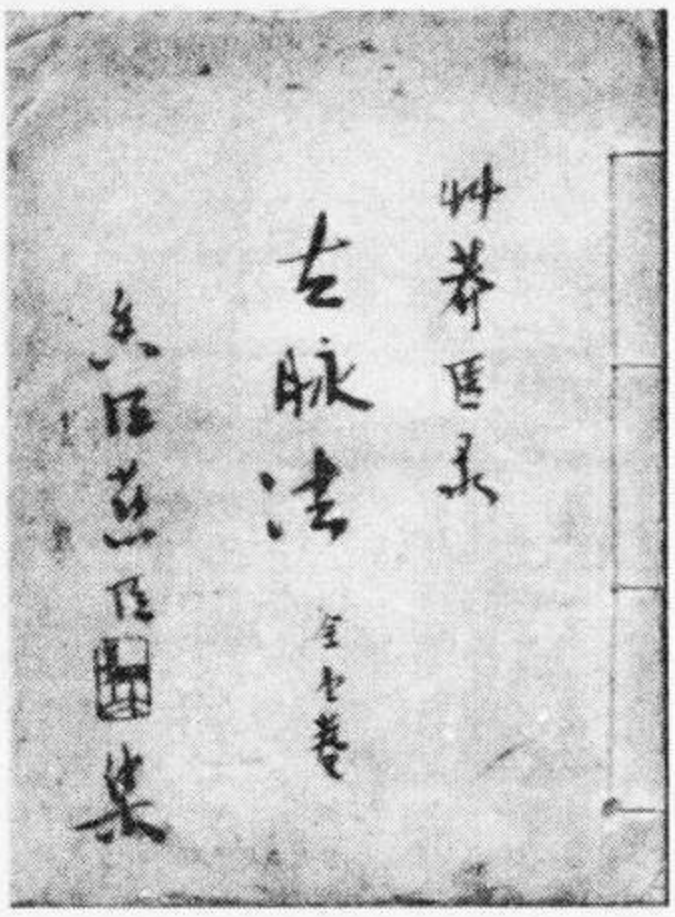
由于成书于今本《黄帝内经》之后的医学经典《难经》开篇即提出这样一个问题：“十二经中皆有动脉，独取寸口以决五藏六府死生吉凶之法，何谓也？”又由于在西晋太医令王叔和所著《脉经》中才开始见到将两手的“寸口脉”①分成寸、关、尺三部，用以诊候人体上、中、下（或五脏）气脉盛衰与疾病状况的诊脉方法，所以一般认为：中医的诊脉方法发展成现今所见之方式，确实经历了一段漫长的历史过程，并将王叔和作为脉诊之法发生根本性转变的始作俑者，赋予这位魏晋时期的太医或褒或贬的种种评说。

尽管谁也不知道早期的中医究竟是如何诊脉的，但根据湖南马王堆、湖北张家山汉墓出土的竹简帛书，及传世的今本《黄帝内经》、

---

① 即位于手腕的桡侧动脉。

《难经》等医学经典中所存留的马迹蛛丝，大抵可知古代医学曾经使用过诸如“分经候脉”、“三部九候”、“四时脉法”、“人迎寸口诊”等一些与现今所见中医诊脉之法不同的脉诊方法，所以我在讨论中医诊脉之法的发展演变时①，将这些早期的诊脉之法统称为“古脉法”。也不知道在浩如烟海的古今中医著作中是否早已有人使用过“古脉法”一词，但我以此概括与指称那些见之于古代医学经典、现今早已废弃不用的诊脉方法，却完全是由于家学渊源的影响——在家藏医书中，有名之曰《古脉法》的抄本一卷。



家藏抄本《古脉法》

《古脉法》出自家父之手，其主体内容却是源于一位具有奇特经历的四川医家周潜川的讲述。周潜川（1905～1964?），祖籍四川威远县，世居成都。早年从军为护士；后得岳丈资助，入国立武汉大学；又以官费赴英国学军工化学。回国后习武术受伤，幸得丹药救治而获痊愈，故好岐黄。离军后，负笈峨嵋、贡嘎、青城、武当诸山，遍访民间宿医与精谙医术之僧道，获益良多，家资亦尽耗于此。个人天资与如此经历，使得周氏之学既能旁及诸子、术数、气功、武术，又始终以医家的理论与实用技艺为核心；既得道家真传，又旁通儒佛两教；既有留学海外的经历和西方近代实证科学的熏陶，又能坚持东方传统文化的韵味。这些都是一般医林人物难望项背之处，其所成就的颇具特色的一家之学，自然与古往今来靠文字功

① 廖育群：《汉以前脉法发展演变之源流》，《中华医史杂志》，1990年第4期，第193页。

夫吃饭的“医学教授”以及在这个知识体系下养成的医家不同；当然也与各承家技、混饭糊口的江湖郎中有异。

抗战结束，周氏悬壶上海。20 世纪 50 年代应社会名流之邀来京施诊；又以效奇而蒙诸翁向中央举荐，遂在卫生部某副部长的安排下，由上海迁至北京“三时学会”旧址应诊，晚间开讲授业。记得当时周氏的诊费为人民币 5 元（足够维持一般人的每月生活）——如此昂贵的诊费可以说明其“身价”。60 年代初，因治愈山西省委秘书长之顽疾痼病，又被盛情聘入山西省中医研究所工作。此间周氏每年应邀赴各省、军区为高层人物治病，讲授气功与养生之道，但不久即因此蒙难入狱而亡。周氏以写书、授徒、炼丹为平生之“三愿”，但除了在山西工作期间曾撰写并出版《气功药饵疗法》、《峨嵋十二庄释密》外，其他均是述而未刊的草稿与课授生徒的讲义。其门人将这些材料记录整理成《丹医语录》若干卷（表 1），相互传抄或油印散发。

表 1　周潜川著述目录

序号	书　　名	序号	书　　名
1	丹医语录·阴阳大论品第一	10	“玄门九九八十一小丹”秘授
2	“玄门四大丹”秘授	11	毒龙丹证治应用 100 法
3	丹医语录·证治大法品第二	12	气功药饵疗法与救偏手术
4	丹医语录·针灸大法品第三	13	气功纠偏药疗法
5	丹医语录·骨伤科大法品第四	14	养生学讲义
6	丹医语录·外科大法品第五	15	农村医生卅门
7	《黄庭经》受业笔记第六	16	望神气术（又名《望诊 240 条》）
8	天罡指穴法受业笔记第七	17	分经候脉法
9	丹药概要	18	伤寒心法十诀

续 表

序号	书　　名	序号	书　　名
19	温病心法十诀	28	癫、狂、痫三大证治心法
20	试论王叔和	29	考《奇经八脉考》
21	四川草药简辑	30	《神农本草经百种录》补注
22	峨嵋白云禅师考	31	《内经知要》述义
23	医易大要	32	胎胪旨要
24	太素脉法评介	33	改进人类素质之设想
25	潜川先生《三焦论》	34	医学密典(未完成)
26	潜川先生《三消论》	35	验方回忆录
27	经络“里支”内照图	36	《峨嵋十二庄释密》

我手中存有周氏 1962 年在河北中医学院讲述“分经候脉法”时的记录稿(目录中的第 17 种),其第一部分述“分经候脉”之由来,全文如下:

分经候脉法①

(周潜川大夫报告)

分经候脉之由来:

古人的分经候脉与现今独取寸口切脉法有很大区别。分经候脉不仅具有很多优点,而且在中医理论上也是很有

---

① 记录稿前见有河北中医学院的如下识语:

本院于 1960 年 12 月 27 日邀请周潜川大夫作分经候脉法的报告,对继承发扬祖国医学中的诊断法,是很珍贵的资料。本文系记录稿,未经本人审阅,难免有与原义不符之处。倘有讹误,经周大夫审阅后,再行更正。

河北省中医研究院 1962 年 5 月 11 日

根据的。王叔和的《脉经》，高阳生的《脉诀》是我国较早的两部脉学专著。在此以前有关脉学的记载，则散见于各医书之内。但不论专著也好，散载也好。既往有关脉学的知识均很不系统。并且受了旧文字的限制，令人难以体会及掌握。从医生诊脉时的差别性极大的情况，就说明切脉法缺少一个客观的标准。也表明过去脉学根据是不够完备的。晋以后由于大家都舍难从易，在四诊中大都偏重于问诊了。切脉不但含糊不清，而且仅仅限于太渊寸关尺三部而已。这样就失去了《内经》的原义。《内经》中还强调天地人三部合参的切脉法。仲景在《伤寒论》中也曾批评过切脉“按寸不及尺，握手不及足”的不合理。由此可见现今流行的脉学及检查方法已很是失去了古人的真传，不绝如缕了。由临床工作及师傅的体验中，感到古人分经候脉的诊断方法可靠性是很大的。这部分遗产，《内经》中虽有部分记载，但以后的医书内已经失传。历代名家如喻昌之流，虽然批驳王叔和《脉经》的错误，却没有具体纠正它。因此医家已不习惯分经候脉法，但它却被保存在丹道家的手里。现在所流行的青城派道士张太素所撰的《太素脉》，还不是丹道家脉学的真髓。然而它已比王叔和、高阳生的脉学高出一筹了。宗教内部所保留下来的脉学，多是口传或抄写等传授，简单、具体，常常仅凭切脉就能辨证疾病所在。丹道家脉法被称为“太素脉”，其含义并不是因张太素而得名，乃是根据“太素”二字为人“形生”之始生的意思。即旧说“太素者，形之始也”，才这样立名而称呼的。人身有了病，检查其“形生”的脉学，就被叫作太素脉。太素脉至秦以后晋以前，已相当完备了。晋以后则逐渐隐晦起来。金元四家以后在

医家中已不流行。但是今天从医家和诸子百家的零星记载中，从宗教内部的著作中，从以后对太素脉的批评中，我们还可以概括地看出它的全貌来。另外从印度的佛教中还传来了一套脉法，它与丹道家的脉相似，现存于西藏密教“医方明”经典内，有少数喇嘛能掌握，对人体气脉比丹道家分得还要复杂，左右共有一百部脉（丹道家才二十部脉，即十二经与奇经八脉）。不过其中有好多是纯宗教的东西，不切合医药的应用，“医方明”经典未传到内地来，但是从丹道家内部及“医方明”入手，是可以挖掘出许多脉学宝藏来的。太素脉及“医方明”脉不是根据解剖尸体的方法，从外部求得的，而是根据“内视”的方法。从活人体上向内求得及建立其理论体系的。他们主张用分经候脉的方法，来诊断脏腑气脉的疾病，每一经脉都有其专门的作用，抓住了脉的“体”和“用”之后，再把所有的脉互相沟通起来，掌握住他们彼此间的关系，这样才能真正做到辨证论治及分清阴阳表里寒热虚实，正确地做到辨证。而彼此间的关系中最主要的母子生化的关系，即相生相克的道理及表里的关系，这样根据后天形生的色相，从而推论先天受气的偏盛。从推断脏腑平素的强弱和已经受病的虚实，而定其人的寿夭、性情、生死、吉凶。

该讲稿的第二部分从各脉的“所候”、“部位”、“诊法”、“所主”四方面分述二十部脉的具体诊法与主病，实即《古脉法》抄本的主体内容。限于篇幅，在此仅抄录“手厥阴心包络经”一节以为举隅。

离经脉第二 《易》曰：一阴夹于二阳间，故曰离。以象心之用。

一、所候：手厥阴心包络经。

二、部位：甲、鬼哭穴(在中指尖下)。

乙、蟹眼穴(中指本节与第二节交界横纹处)。

丙、外劳宫(手背中指本节内侧歧缝间，脉管呈人字纹处；一说与内劳宫相对，脉诊当依前说)。

丁、天河穴(由外劳宫循歧缝上行至手腕关陷中有脉处)。

三、诊法：分候脉、候气、候寒热三部。

甲、以离经指法候鬼哭穴之脉跳(但有人离经脉行于指尖两侧)，阳脉为心阳外开，阴脉为心阳不足。

乙、此以候气：捏鬼哭穴，外劳宫脉动加大；捏蟹眼穴，天河穴脉动加大，以候心气。与候脉结合，则用以推气与脉之间的辨证关系。左右手相比较，则可推心气心血之辨证关系。

丙、候指尖寒热。

四、所主：甲、小儿出疹发痧，身虽热，而指尖冷。

乙、离经无脉者，可断其心气不出井，为心气虚故。四逆者，必先见离经寒，次发展及手，厥过肘者不治。

丙、产妇分娩时离不出井，如气(热)与脉(动)由本节逐渐向上发展，待达于指尖，则宫口开大已至少三寸，胎儿将立刻娩出。

丁、离洪实而动甚者，慎勿投开散心气之品。证治大法详《证治大法品》。

《古脉法》的抄写者(如果从它是《分经候脉法》的抄本的视角出发)或撰写者(如果以为它属再创作)站在尚古、复古的立场上，对西

晋王叔和及从那时开始使用的“独取寸口”的脉诊方法持更加严厉的批判态度，并深信包括“十二正经”与“奇经八脉”合计二十部脉（表 2）的“分经候脉”之法就是古圣垂训，表现出此类早年受近代科学养成教育之人，在接触到中医这样一种传统文化与技艺后所具有的执著态度与认知方式。这种现象并非仅仅出现在中国，据精通梵文的日本科学史家矢野道雄讲，印度传统医学的复苏，乃是由于“在受过现代教育、欧洲学问之洗礼而意识到自身传统的人之间，发生了复古主义运动”①。

表 2 “分经候脉法”的脉名、所候

脉　名	所　候	脉　名	所　候
太渊脉第一	肺经	竿珠脉第十一	小肠经
离经脉第二	手厥阴心包络经	庚金脉第十二	大肠经
守灵脉第三	心经	吏仓脉第十三	胰经
趺阳脉第四	胃经	水曹脉第十四	膀胱经
人迎气口脉第五	上下气血盈亏	督脉第十五	督脉
青龙脉第六	肝经	冲脉第十六	冲脉
太冲脉第七	肝经，又为候血分之专脉	带脉第十七	带脉
龙曜脉第八	胆经	任脉第十八	任脉
神阙脉第九	脾经，亦候胰	阴阳二维脉第十九	阳维脉、阴维脉
育婴脉第十	肾经	阴阳二跻脉第二十	阳跻脉、阴跻脉

不管这种“分经候脉”的诊脉方法是不是西晋王叔和《脉经》之前

① 矢野道雄译：《印度医学概论·解说》，朝日出版社，1988 年。

的文化遗存，但确属浩如烟海、汗牛充栋的传世医书中所看不到的内容。由于我的师爷是在“道教医学”这家铺子里学到的这门手艺，所以难免又要引得我对“道教医学”这个热门话题说上几句。

清代文人刘鹗在其所著《老残游记》中评价三教异同时说：

> 儒、释、道三教，譬如三个铺面挂了三个招牌，其实都是卖的杂货，柴米油盐都是有的。不过儒家的铺子大些，佛、道的铺子小些，皆是无所不包的。

但是就“三教医学”而论，情况却有所不同。从某种角度讲，道教呈现给人们的印象简直就是古代研究生命科学的一个“神秘大本营”。不仅许多历史上著名的医学人物（如六朝的葛洪、陶宏景，唐代的孙思邈等）本身即属道教中人，而且诸如房中、气功、内丹、外丹等所有带有神秘色彩的养身之道几乎都与道教具有密切的关系，乃至道教研究者通常都会认为“道教是以追求长生成仙为最终目标的宗教”①。所以“道教医学”的铺子似乎要比“儒家医学”、“佛教医学”的铺子大得多。然而是否存在着一种独立的道教医学？却是一个无法用三言两语就能说清的问题。首先，显然不能将具有道士身份之人使用的医疗方法及其医学言论与著作，或在其属领之地进行的医疗活动，统统视为“道教医学”。那么是否应该像研究佛教医学者所定义的那样：是产生于特定宗教思想的医学。② 然而这时我们又会发现，与道教有关的一切生命之学和实践，诸如修身养性、顺应自然、药饵饮食

① 张钦：《道教炼养心理学引论》卿希泰序，巴蜀书社，1999年。

② 陈林《试谈佛教医药与医学的联系》一文中谈到：“佛教医药是具有佛教信仰特征的医药，是自我觉悟、自我制约、自我治疗保健的医药。是客观存在的、与医学相关的社会现象。不能把佛教医药简单片面地看作是存在于佛教中，又与佛教无关的医学；看作是由寺院、僧人掌管的，与医学的医疗方法和用药完全一致的医治疾病的方法和药物运用。”（文载李良松，刘建忠主编：《中华医药文化论丛》，第80～81页。）

与房中术等，都可以追溯到道教产生之前。即便是最具道教色彩的金丹大药，也不过就是要将金石不朽之性转移到人体——建立在交感巫术思维方式上的一种具体实践而已。可以说，道教求仙与养生方面的实践，是各种神仙方术与医学知识的集合；道教的宗教哲学与思想体系，是在将作为一种政治论的道家思想解释成求仙与养生之道的基础上构建起来的。可以说，道教从一开始就缺乏睿智哲人式的奠基人，所以只能奉老子为教祖，以《老》、《庄》为经典。然而从另一方面讲，道教又是一个巨大的载体——被改造成养生之道的道家思想，在历史上的地位与影响，已然远远超过了作为一种政治论的道家思想；相对儒家正统礼教而言，更具哲学味道的“玄学”，与道教思想彼此呼应；各种法术借助这个载体获得充分的发展，复又滋养与融入这个载体本身；自然的名山与人文的寺观相得益彰，助长着自身的神秘性与民众的崇信度。考虑到道教思想所具有的普遍性——在任何一个历史时期皆为世人所广泛了解，因而从理论上讲，诸如《古脉法》这种虽然带有一定的道教色彩，但从总体上讲仍然是以古代医学理论为基础的医学知识，也完全有可能产生于道教以外的环境中。然而按照印度人的思维方式说：未发生之事是没有原因可言的（无果即无因），而对于发生了的事情就应该努力去探寻其原因（有果必有因）。所以在审视与思考“道教医学”的问题时，与其刻意于那些不过是中国传统文化与哲学思想一部分的理论，毋宁将注意力集中在道教人士特定的生活环境、知识结构、修炼方式与传承制度上。换言之，就道教而言，或更加局限到诸如《古脉法》这样一个十分具体的个案而言，尽管宗教仪轨与医学知识的形成与发展并无直接联系，但这些或许才是使得此种有悖官学正统、独具一格的知识能够形成于斯，并在师徒间代代口耳相传的必要土壤。从这一立场出发，可以说确实存在着值得注意与研究的“道教医学”。但这种关注与研究的重

点，既不是炼丹、房中等虽可谓之“生命之学”，但与治病疗疾并无直接关系的神仙方术；也不是“道藏医籍”那种仅仅是在形式上与道教和医学似乎均有关系，实则与一般医学无异的表面现象，而是诸如《古脉法》中的医学理论与道教“生命知识”间的密切联系。

例如在《古脉法》中多次言及道教太清派的著作《黄庭经》①，欧阳修《删正黄庭经序》谓此书系“魏晋间道士养生之术也”；当代学者亦认为此书是“早期古典气功学专著”②。该书以人体脏腑等处皆有主神之说为本，《古脉法》中将与心、肾、脾、胆相关的脉分别称之为“守灵脉”、“育婴脉”、“常在脉”、“龙曜脉”，正是源于《黄庭经》中“心神丹元字守灵”、“肾神玄冥字育婴”、“脾神常在字魂停”、“胆神龙曜字威明”的说法。然而这还不过是一种表面现象，更为重要的是《黄庭经》中谈到“内视”——“内视肠胃，得见五脏”；“自见五脏肠胃”等。“分经候脉法”中以此作为丹道家脉学建立的基础——丹道家根据“内视”的方法，从活人体上向内求得及建立其理论体系。

不管“内视”之说是否真实，《古脉法》与所谓的“气功”之学间的联系却是显而易见的。在许多脉的诊候中，均可见到“候脉”与“候气”之法并存，甚至是只候气不候脉。这种潜藏寺观之中，既难为世人所知、亦不欲为世人所知的学问，非如周氏有“负笈峨嵋、贡嚝、青城、武当诸山，遍访民间宿医与精谙医术之僧道”的求学经历，是不可能获得的。

---

① 《黄庭经》之名始见于《抱朴子·遐览》。该书由《内景经》与《外景经》两部分组成，一般认为《外景经》早出，传自西晋女道士魏华存；《内景经》由《外景经》推衍而成。

② 详见马济人主编“气功·养生丛书”所刊《黄庭经》（上海古籍出版社，1990年）的“解题”。

八、复古心态

不知“尊古贱今”之风究竟起于何时，但在汉朝人的著作中已能看到对于这种思想观念的论说：

> 世俗之人多尊古而贱今。故为道者，必托之于神农、黄帝而后能入说乱世暗主。高远其所从来，因而贵之。为学者蔽于论而尊其所闻，相与危坐而称之，正领而诵之。（《淮南子·修务训》）

《淮南子》的作者在批评“尊古贱今”之风时，指责“托古入说”者的目的是为了“乱世暗主”，大概没有留意这本身也是一种“尊古贱今”的心态。好在像医学这种“君子不齿”的技艺，大概谈不上会有什么乱世暗主的罪责，至多不过是“高远其所从来，因而贵之”；使“为学者蔽于论而尊其所闻，相与危坐而称之，正领而诵之”而已。

“托古入说”，主要有两种形式。一是“伪托”——径将新作说成是古圣遗墨；一是“六经注我”——借阐述古人微言大义之名，行宣扬自己主张之实。这两种形式，在医学领域中均有所表现。就前者而言，诸多托名著作，如宋以后人托名孙思邈撰《银海精微》、1920 年由上海古书保存会铅印发行的《华佗神医秘传》等皆属此例。而后一种表现形式则比较复杂，包含有多种不同情况。首先，应该说这是学术发展的自然轨迹——在前人知识的基础上，不断补充与发挥。其作者或许根本没有想到要“高远其所从来”，或使后学“正领而诵之”。例如《灵枢·小针解》和《素问·针解》两篇的作者，对于保存在《灵

枢·九针十二原》中的原始经文的注释(参见表 3),即可以看作是一个典型的例子。可以说这两篇“注释性”论文的作者不过是按照自己的经验来理解“原始经文”的含义。换言之,如果这种阐发所表述的思想仅仅是注释者自身经验的话,那么就不妨说:医学的理论与实践在这时已然出现了变化——革新。

表 3 《素问》、《灵枢》对原始经文的不同注释

原　　文※	《灵枢·小针解》	《素问·针解》
凡用针者,虚则实之,	所谓“虚则实之”者,气口虚而当补之也。	刺“虚则实之”者,针下热也,气实乃热也。
满则泄之,	“满则泄之”者,气口盛而当泻之也。	“满而泄之”者,针下寒也,气虚乃寒也。
菀陈则除之,	“菀陈则除之”者,去血脉也。	“菀陈则除之”者,出恶血也。
邪胜则虚之,	“邪胜则虚之”者,言诸经有盛者,皆泻其邪也。	“邪胜则虚之”者,出针勿按。
……	……	……
言实与虚,若有若无;	“言实与虚若有若无”者,言实者有气,虚者无气也。	“言实与虚”者,寒温气多少也;“若有若无”者,疾不知也。
察先与后,若存若亡;	“察先与后若存若亡”者,言气之虚实,补泻之先后也,察其气之已下与常存也。	“察先与后”者,知病先后也。
……	……	……

※ 原文见于《灵枢·九针十二原》

以上一节所谈到的《古脉法》为例，将不知成于何时的诊脉方法说成是秦汉时期的旧法，在表现形式上无疑可以说是一种“托古”表现。然而与其说在作为“分经候脉法”讲稿与《古脉法》作者的师徒二人心中存在着明确的“托古”打算，倒毋宁说他们是不自觉地怀有强烈的“尊古”心态。例如在“分经候脉法”讲稿中明明谈到：在王叔和《脉经》与高阳生《脉诀》之前，有关脉学的记载不过是散见于各医书之内。有关脉学的知识均很不系统。但其后又说：切候形生的太素脉，在秦以后晋以前已相当完备了。后人之所以不知，不过是因为“晋以后逐渐隐晦起来”。《古脉法》的作者亦是同样，以为“古之脉学真髓已不可见”。

“尊古”心态的形成，是由多方面的因素决定的。首先，人类普遍具有“崇拜”的心理需求。一切虚构的神灵、古代的圣人、泥塑的菩萨、活着的偶像，皆具有满足人类此种心理需求的功能。而在传统医学的知识领域中，后人“打造”的崇拜对象，不仅包括诸如扁鹊、华佗、张仲景那样的医圣偶像，还有一个最具魅力的抽象偶像——“古代学术”。这种心态，不仅在中国的传统医学中表现强烈，同样也存在于周边国度。例如日本的汉方医学在已然接受了中国的宋明医学理论与治疗方法后，如同社会中涌起了批判朱子学、提倡孔孟儒学正统一样，在医学领域中也兴起了摒弃宋明医学、独尊汉代张仲景《伤寒论》的“古方派”。又如，“印度人通常认为所有的东西都是起源于印度，因为相信阿输吠陀在世界上是最古老的，所以即便是新传入的东西亦被梵文化、纳入文献之中，认为那是自太古以来就存在的”；“复古主义者主张阿输吠陀是绝对优越的，但在伊斯兰与英国统治期间堕落了，如果恢复其本来的清纯之姿，则可凌驾西洋医学之上”①。

---

① 矢野道雄译：《印度医学概论·解说》。

“尊古”之风带来的必然结果是泯灭了学者的自信——他们似乎从来不敢想像：我也有能力创造出新的、更好的理论学说或实用技艺。在他们看来，古代医学从建立之时起就是一个尽善尽美的“完成体”，已然没有发展的可能；一切新生事物，不过是“得道”的过程。这个过程的实现，或是因为有“得道”先人的传授，或是因为“悟性”使然——悟出了古代圣仙心中所藏的奥秘与具体的运用方法。在这条学术发展轨迹上，一切新知识的形成无疑都不会被看作是对旧有理论与体系的批判，而仅仅是“阐发”。这一过程周而复始不断循环的结果，是不断增强着“古代学术”的光辉与可崇拜度。

当我们看清了传统医学发展过程中隐含的这种“创新”方式后，就会自然而然地得出一个根本性的结论：当代存活着的传统医学，并非古代传统医学的“克隆”（复制）。因而尽管从表面上看，现代科学旗帜鲜明地以“进步”、“超越前人”作为心中的理念、追求的目标和价值判断的标准；而传统医学却是被盲目崇拜的“尊古”之风所笼罩，从来不敢理直气壮地去谈“创新”，甚至于连想都不敢想，但实际上无论“尊古”还是“复古”，都不过仅仅是一种心态，而不是客观事实。

九、“名医”的故事

某日，同事王女士闲聊道：“前些时候儿子病了，将云集中医医院的教授、专家号挂了一遍也没看好。一生气，花一角钱挂了个小大夫的号，却药到病除。你说怪不怪？”

看官，你觉得这事怪吗？以其为“怪”者，自然有“怪”的道理，因为照理说，老专家的经验必定丰富，教授的水准自然应该比“嘴上无

毛”的小大夫高，何以沙场老将反不如初出茅庐者？——真是没道理！认为“毫不奇怪”者，一定是生活经验丰富的长者，因为“我们这个社会中，不符合理性的事情难道还少吗？”——然而这毕竟只是一般生活经验的演绎，个中原委还得听业内人士为你细细道来。

我也曾在这家医院学习、工作过两年。当时分管的住院病人中有位患类风湿关节炎的漂亮小姐莉，虽说是我分管的住院病人，但每日却只负责查房、写病历，用不着开方、下医嘱——因为莉小姐的漂亮不仅给我留下了“永不磨灭”的深刻印象，而且也迷倒了两位号称专治此病的老专家。他们每周都会不顾鞍马劳顿，以 70 多岁的专家之躯亲临榻前为莉小姐把脉处方。

类风湿关节炎属于中医所说“痹证”，《黄帝内经》教导我们说：“风寒湿三气杂至，合而为痹。”本着如此“经训”，老专家的处方自然是温经散寒、除风祛湿——一派燥热之药。光阴荏苒，关节疼痛折磨得莉小姐寝食难安，血沉指标居高不下，而且不时鼻血横流。于是老专家便在“恪守经训”的基础上加入“牛黄 2 克”，以制其热。日渐消瘦的莉小姐终于对老专家失去了崇拜与信任，抱着“一试”的态度与我签订了为期一个月的“治疗合同”，条件是不许吃任何其他的药（因为此类病人通常靠激素控制症状）。很快，莉小姐的血沉降到了“19”（正常值为“20”），我在美人面前也出尽了风头。

莉小姐在这一个月间吃的药方，不过是治疗感冒与肺炎的最常用方剂“麻杏石甘汤”，加点银花、连翘之类清热解毒之品而已。如果要问何以会用治肺炎的方子去治关节炎，回答有三：

1. 因为病人舌红、脉快，是“热证”。

2. 因为父亲告诉我：这类疾病以及小儿肾炎都先要把嗓子（扁桃腺）“整”好。

3. 因为这是链球菌感染引起的躯体免疫（过敏）反应。

第一种回答是真正的“中医”——根据实际的临床表现，作出疾病属性（证）的判断，据此施以治疗，而不必管它是“什么病”。所谓“辨证施治”，即是此意。“老专家”的错误恰恰在于没有遵循这条基本的原则，而是按图索骥地套用《黄帝内经》的“经言”。

第二种回答是“家传”。所谓“家传一张纸，师传万卷书”，家传与师传的区别即在于此——当然这里所说的“师传”是指那种学院式的教育。因为这种知识的本质是“经验”，而且未必一定要“家传”，真正会治病的老师同样可以传授这样的经验。再者，有“悟性”的医生即便没有任何传授渠道，也一定可以在临床实际中，沿着“辨证施治”的路径，在治疗成功的基础上总结出这样的经验。这种“悟性”，就是“医者意也”的内涵解释。

第三种回答是“现代医学”。这类疾病和小儿急性肾炎在很多情况下都是源于咽喉部的慢性炎症所引发的躯体免疫反应，这就是“先要把嗓子整好”经验之谈以及何以不该墨守教条、何以可用治肺炎感冒之药治疗关节炎的“所以然”。在本书的序言中曾经谈到“只有现代医学知识才能够使你弄明白中医何以能够治病、何以要如此治病”，而此处所言不过是给出一个具体的案例。

事后，我曾将这一病例的全过程呈送主管大人，并就“名医不明”大发牢骚。老成的主管默然一笑道：“我不捧这些老家伙，又该捧谁呢？只有他们才是医院的招牌。”是啊，没有老专家的医院，就像没有几名“院士”的研究所——缺少招牌；更何况病人永远都会相信“老专家”的魅力，所以人们才会说中医这门职业是“养老不养小”。

云集医院是名老中医云集之处，随便再给你介绍几位：

风度教授长得天庭饱满、地角方圆，气度不凡。号称专治“男性不育”，于是护士在分诊的时候自然就会将所有要看此类疾病的患者统统发派到风度教授的诊室。天长日久，“男性不育专家”的名声也

就越来越大了。所以任何时候都不要忘了老百姓的格言:“不怕招招会,就怕一招鲜”;“坚持就是胜利”。风度教授桌上的玻璃板下,真的压着一张婴儿的照片——“看,这是吃了我的药才有的!”但许多年中,我只见过这一张照片。想来或许是其他患者在妻子怀孕生产后,过于高兴而忘了与风度教授分享这一喜悦吧。风度教授经常对进修大夫、实习学生,乃至漂洋过海去讲授如何治疗“男性不育”,道理很简单:“不育源于精液不足,故必须补阴;若妄用助阳之品,必至性欲亢进,更损其阴”;治疗的方子也很简单:“六味地黄丸”。你能说这不是中国古代哲学与传统医学的完美结合吗?你能说医学与“易学”没有关系吗?

风度教授的隔壁是一瘸一拐的厚道教授,对所有的人都和蔼可亲;对我们这些实习的大夫会在初次见面的时候嘱咐说:“在病人面前不要叫我老师,彼此皆以‘大夫’相称;拿得准的事不必问我,拿不准的病可一起商量。”沉默寡言的厚道教授每天总是最后才去吃饭,因为有很多病人专门在等着他。据说厚道教授的父亲也是一代名医,但爱财,所以导致宝贝儿子在读医科大学时得了脊髓灰质炎,成了小儿麻痹后遗症。所以人们猜测厚道教授的医德与为人,与他的经历有很大的关系。医学固然是一种职业,但却是一种特殊的职业,靠病人发财会遭报应的说法,也许没有什么“科学”道理,但我还是希望这种精神约束——对于“天谴”的恐惧,能够起到约束医、药从业人员行为的作用,因为患者已经亲切地将身着白大褂的医务工作者称之为“白狼”了。

当代名医时髦的经历更有意思。据他的老朋友邋遢讲,当年二人同在一家药店中坐堂应诊,时髦大哥在楼上,邋遢小弟居楼下。一日,时髦大哥对邋遢小弟说:“你在楼下,可谓近水楼台,把病人都挡住了,所以楼上难免寂寞。”邋遢小弟一听,忙与大哥调换位置,但从

此又呈现出病人舍近求远的景象。20 世纪 50 年代初，政府号召这些私人开业的医生“走社会主义道路”进医院工作，半天上班，月薪 72 元。许多人觉得赚钱太少，陆续退出；时髦先生却寻思：我回家开业还挣不到这些钱，便留了下来。后来，“号召”变成了“必须”，重新进医院的大夫们改成整天上班，月薪仍然是 72 元；而“坚持走社会主义道路”的时髦先生却因工作时间延长，工资也翻了一番。时髦先生一生不但会把病人的脉，还特别善于“把时代的脉”，抗美援朝战争爆发时，时髦先生身着长衫上街演讲，并报名参加志愿军；在我还是刚刚听说个人电脑的时候，时髦先生已然建立了个人的“专家诊治系统”，所以他一直在中医界挂“头牌”也就十分自然了。而他的老朋友邋遢先生的日子，亦过得别有一番滋味：虽然换了皮鞋，但却从不系鞋带，不穿袜子；吃遍京城的大饭馆，总说“太便宜”，因为认识他的饭店老板最多只收两块钱。

长年担任中医学会负责人的某位前辈感叹，真会治病的医生，也许会饿死；能出名的医生，一定有出名的办法！他告诉我说：

享誉京城的名医“时髦”，靠的是多年办教育、与政客文人有密切的交往。我曾见这位名医为身患心脏病的文联主席王某处方“虎睛一对”。虽说是文联主席，但也无法寻得这味药——所以不是我治不好你的病，而是你找不到治病的药。

与之齐名的“风月”先生，出身江浙，靠着一口乡音在“八大胡同”找到了无数的知己。你可千万不要小看这些青楼知己的社会力量，她们绝对可以让风月先生闻名遐迩。

情商一定很高的“智慧”先生，打出了慈善济世的招牌：每日的 1 到 10 号免费，于是无数的穷苦百姓为了求得这免费之号，不得不头天夜里就去排队等候。然而开门应诊时，却不为这 1 到 10 号先看，必须坐在门口的两排木桩上恭候，因为一旦叫到某号而人不在，即告

作废。

怀揣锦囊妙计的“智多星”,向朋友拆借了100块钱,进了京城。30块钱包了辆汽车,可以用一个月;30块钱租了房,挂上“智多星医师到京应诊”的大牌子;30块钱置办了家具行头,打扮得足够体面;还有10块钱留着吃饭。开张伊始,便时不时坐上汽车出去遛一圈,谓之“出诊”。这派头着实令世人瞠目结舌,很快就获得了预期的宣传效果。

这些发生在六七十年前的事情,对于我来说,真的只是故事,或许纯属恶意编造亦未可知。就“名医”而言,我还有一点感受,即最终都变得只会开一张方子。

据说从太医后裔“继承”教授诊室出来的病人,会在相互交流中“诧异”地发现,所有病人手中的药方都差不多。我在跟随80高龄的妇科专家“美髯”教授实习时,也发现了同样的现象,而且亲耳听到了原因的说明:“如果想了解我的学问,就去读读我年轻时的医案。现在脑子已经不转了,再看我治病没什么意思。”应该说这是发自肺腑的“自白”,只可怜那些不明此理的患者偏要根据胡子的长短来判定医生水平的高低。从某种意义上讲,“返老还童”乃是客观真理,因为青壮年时期全面发育起来的大脑皮层——这个人类智慧的中枢,在夕阳西下的时候已然渐渐失去了活力;他们通常会像孩子一样吃了饭就想更衣,因为大脑皮层对低级中枢的控制作用在不断减弱——作为基本生理活动的“胃肠反射”重新得以表现。记得有一本书名叫《病夫治国》,说的是老年人不该再玩政治;同样,如果你懂得类比,那么就不要再将自己的“至贵之躯”托付给性格、智力都和儿童差不多的“老顽童”去治理。

许多并非“老年痴呆”的医生治病时也会出现用药、处方越来越单一化的倾向。这是由于学问在头脑中不断被加工,形成了一个“由

博返约”的结果。例如自称“赵子龙”的某位儿科专家中年以后即只开一张方子，谓之“赵子龙一条枪”——不管敌人的兵器如何变化，我赵子龙只用一条枪就全能对付。这是因为一些中医归纳小儿之病皆属“二太”，即“太阳病”（外感）与“太阴病”（伤食）两方面。所以由解表药与消食导滞之品组成的“赵子龙一条枪”确实可以招架儿科门诊的大部分病人。

这种情况与号称“金元四大家”的刘河间、张子和、李东垣、朱丹溪分别将疾病的属性与原因归结为“火热”、“邪气”、“脾胃损伤”、“阴虚”可谓十分相似。也很像宋明理学家用理、气、太极、阴阳的概念去表述宇宙的终极真理。不同之处在于，理学家可以空谈终极真理，而医学家却必须解决实际问题。中医学到一定的火候，出现“由博返约”（异病同治）的现象的确十分自然，因为临床症状固然千变万化，但疾病的原因也许相同。但同时也不要忘记：相同的症状，有可能源于不同的原因，因此“同病异治”也是家常便饭。两者基于一个同样的道理：根据症状，辨别疾病的属性（证）。这就叫做“辨证施治”。

医者意也

——中国医学的一个传统观念

在中国古代医学著作中，时常可以见到“医者意也”的说法。好像医学理论的神秘性、治疗方法的灵活性、医家的悟性，都只能以一个“意”字来体现。换言之，中国传统医学的神韵，就蕴涵于其自身所具有的那么一种“可以意会，难于言传”的味道当中。然而，医学毕竟是一门自然科学与实用技术，医家究竟如何以“意”来构建这门学问，似乎并无人深究。

近代硕学梁启超曾说：“中国凡百学问都带有一种‘可以意会不可以言传’的神秘性，最足为智识扩大之障碍。”而其所举之例，即是“医学”。① 的确，中国传统医学较之于任何一种其他古代精密科学（如天文、算学）或实用技艺，都更具有传统文化的特征。或毋宁说，只有传统医学才能够体现传统文化“可以意会，难于言传”的韵味。

时至今日，当人们从不同角度对传统科技文化进行评价与研究时，一方面惊讶地发现：在近代西方科技繁荣昌盛、普及全球之后，唯有中国传统医学仍然具有不衰的生命力；但与此同时，人们又在不断地以西方科学的目光与标准来审视、衡量、评价、要求、改造这唯一具有生命力的传统科学。在这种情况下，“医者意也”所代表的传统医学之神韵——这种与近代科学格格不入、“最足为智识扩大之障

---

① 梁启超：《科学精神与东西文化》，《饮冰室合集》第14册，中华书局，1941年。

碍”的基本性格，自然就会受到更多的非难。①

作为医史研究，特别是医学思想史研究，理应对这句古来医家常挂嘴边、当代中医也还在以不同方式强调其重要性②的话加以注意。本文即从剖析“医者意也”在不同历史时期的多种含义与表现形式入手，以求理解中国传统医学的“神韵”所在；沿着医学的轨迹，而不是文人的雅兴③来探索传统医学的一些本质性问题。

一、出典与含义

“医者意也”初见于《后汉书·郭玉传》④。其记述如下：

> 郭玉，和帝(89～105在位)时为太医丞，多有效应。而医疗贵人，时或不愈。帝乃令贵人羸服变处，一针即差。召玉诘问其状。对曰：“医之为言意也。腠理至微，随气用巧，针石之间，毫芒即乖。神存于心手之际，可得解而不可得言也。夫贵者处尊高以临臣，臣怀怖摄以承之。其为疗也，有四难焉：自用意而不

① 费振钟《悬壶外谈》(浙江摄影出版社，1998年，第76页)指出：“医者意也”是“中医受到怀疑最多、责难最重的一个观点”。

② 直接之例，如净苦法师认为：“医者意也，意者医也”，全凭心意——佛慧佛德用功夫，不可执著，囿于成法(见李良松，刘建忠编：《中华医药文化论丛》)；间接之例，详见后述。

③ 前引费振钟《悬壶外谈》之封面，印着如下题记，展示着文人的特有视角：“医者，意也。”这句代表古典中医的话，受到后世许多人的责难与否定。但若是少了这句话，不仅历代名医失去他们医学上自由创意的愉悦，所有那些精妙的医术都会变得黯然无色，便连今天对于中医的叙说，亦复没有多少趣味了。

④ 中华书局1965年点校本，第2735页。

任臣，一难也；将身不谨，二难也；骨节不强，不能使药，三难也；好逸恶劳，四难也。针有分寸，时有破漏，重以恐怖之心，加以裁慎之志，臣意且犹不尽，何有于病哉！此其所为不愈也。”

这段记述，有两点值得注意之处：一是文中所言之“意”，并无后世所要表达的种种深远含义，而不过是指医家的注意力。即郭玉以为“医疗贵人，时或不愈”的原因在于心怀恐怖，自然处处先思保身，焉能一心疗病。

值得注意的第二点，是文中所涉郭玉、程高、涪翁师徒三代，皆是针石之医。尽管“针灸”与“药物”可以说是构成中国传统医学治疗方法体系的左膀右臂，但在不同历史时期，其发展水准与地位并不相同。从总体趋势上讲，“药物疗法”经过长期的发展，逐渐取得了绝对优势的地位。无论是从历代遗留之浩如烟海的中医著作，还是从当代中医的实际运用状况看，除针灸专科外，绝大多数的中医都是致力于药物的研究与使用。恰如左膀右臂，虽然它们并无明显差异地存在于人体之上，但左右手的能力及运用频繁程度，却有天壤之别。然而又如在人类以外的灵长类动物身上看不到左右手有如此明显的功能差异，且人类的“右利”之势古今亦有所不同①一样，药物疗法的绝对优势亦非成于一朝一夕。

从中国传统医学最重要的经典——今本《黄帝内经》（即《素问》与《灵枢》）主要是讲述针灸疗法即不难看出，针灸学在汉代不仅已然相当成熟，而且与中医基础理论体系的建立有着密切的关系。郭玉对于针法技艺微妙之处的释说，与今本《黄帝内经》中的一些相关论述极为相近。如郭玉说：“腠理至微，随气用巧”、“针石之间，毫芒即乖”、“神存于心手之际，可得解而不可得言”；而《灵枢》第一篇《九针十二原》概括针法之要时则有：“小针之要，易陈而难入。粗守形，上

① 人类学研究者通过测量左右手之长度，得出结论：古代“左利”多于现代。

守神。粗守关，上守机”等语；同书《小针解》篇对“上守机”的解释为：“知守气也。”那么，“上工”（高明之医）“守神”、“守机”、“守气”的针刺技法与“粗工”（匠人之医）“守形”、“守关”有何区别呢？请看《素问·宝命全形论》对我们通常大加赞誉的“虚者实之，满者泄之”——通过补虚泄实、调整阴阳以恢复健康的中医基本治则是如何评价的：

今末世之刺也，虚者实之，满者泄之，此皆众工所共知也。

而上工“法天则地”之技在针法中的具体表现为：

经气已至，慎守勿失，浅深在志，远近若一，如临深渊，手如握虎，神无营于众物。

读过上述经文，自然会导出这样一个问题：针法的治疗效果究竟与施术者的个人素质有多大程度的关联？甚至会有人问：在施以针刺的过程中，除了技艺因素外，是否还需考虑施术者与患者之间，有可能存在某种“气”的交流？即是否存在某种能量通过“针”，从施术者一方传递到受术者身上，从而对治疗效果产生影响的问题。相信随着科学技术的发展，这些问题都能通过实验弄清，目前似不应仅仅依据感觉轻率地做出肯定或否定的结论。要之，通过郭玉与今本《黄帝内经》的有关论述可以了解到：在中国传统医学中，对于医家悟性、灵活性等个人素质的强调，首先是出现在针法的相关记述中。相比之下，药物治疗在此时还处在强调“验方”之传授与使用的阶段。《汉书·艺文志·方技》中有“经方”类，其意即是“经验之方”。无论是文人儒士，还是医家，历来对“经验之方”都是十分重视的，因而才会有大量或简或繁的方书问世。至于说后世在药物疗法方面也出现了“古方不能治今病”，主张“宁失其方，毋失其法”的新思想，那正是本文后面将要讨论的问题。即“医者意也”观念在不同时期具有不同表现形式的问题。

二、“意”之内涵的转变

自郭玉倡言“医者意也”后，历代皆有援引以为据者，但援引者大多不是针法医，所欲阐发的旨趣也与针法无关。实际上，热衷此说者主要是一些注重药物理论与应用的医家，显示出医疗技艺重心从针灸疗法向药物疗法的转移。伴随着上述从针到药的转移，医者之“意”自然会因两种疗法性质不同而有所区别。换言之，“意”的内涵在悄然之中发生了种种改变，表述的思想内容已与出典风马牛不相及。为要弄清“医者意也”这只旧瓶所装新酒的味道如何，则必须先看看是何人于何时向此瓶中灌入了何酒。

就管窥所及资料而言，在郭玉之后较早言及“医者意也”的是南朝名士陶弘景(456～536)：

> 故陶隐居云：医者意也。古之所谓良医，盖以其意量而得其节，是知疗病者皆意出当时，不可以旧方医疗。①

陶氏于医学方面的主要贡献，是将旧传《神农本草经》加以扩充、注释而成《本草经集注》。故上述之语显然是就方药而言。其后有隋唐间人许胤宗，“每疗，无不愈”。故人问曰：“公医术若神，何不著书以贻将来?”胤宗答道：

> 医者，意也，在人思虑。又脉候幽微，苦其难别，意之所解，口莫能宣。且古之名手，唯是别脉，脉既精别，然后识病。夫病

① 王焘：《外台秘要》卷十八，人民卫生出版社，1955年，第496页。

之于药，有正相当者，唯须单用一味，直攻彼病，药力既纯，病即立愈。今人不能别脉，莫识病源，以情臆度，多安药味，譬之于猎，未知兔所，多发人马，空地遮围，或冀一人偶然逢也。如此疗疾，不亦疏乎！假令一药偶然当病，复共他味相和，君臣相制，气势不行，所以难差，谅由于此。脉之深趣，即不可言，虚设经方，岂加于旧。吾思之久矣，故不能著述耳。①

在唐代医家孙思邈(581～682)的著作中，则不止一次地提到这一观点：

张仲景曰：欲疗诸病，当先以汤药涤五脏六腑……故用汤也；若四肢病久，风冷发动，次当用散；……次当用丸……能参合而行之者，可谓上工。故曰医者意也。②

若夫医道之为言，实惟意也。固以神存心手之际，意析毫芒之理，当其情之所得，口不能言；数之所在，言不能谕。③

医者意也，善于用意，即为良医。④

从总体上讲，医家真正大谈“医者意也”是在宋代之后。试观以下诸例。《太平圣惠方》序称：

夫医者意也。疾生于内，药调于外，医明其理，药效如神，触类而生，参详变易，精微之道，用意消停。⑤

《夷坚乙志》记述北宋张锐以一种药治愈两人全然不同之病，因有人问其故：

---

① 《旧唐书》卷一九一，中华书局，1975年，第5091页。
② 《千金要方》卷一，人民卫生出版社，1955年，第3页。
③ 《千金翼方》自序，人民卫生出版社，1955年。
④ 《千金翼方》卷二十六，人民卫生出版社，1955年，第308页。
⑤ 冈西为人编：《宋以前医籍考》，人民卫生出版社，1958年，第92页。

敢问一药而治两疾何也？锐曰：此于经无所载，特以意处之。①

南宋刘开《刘三点脉诀》自序云：

夫脉者天真要和之气也……大抵持脉之道，非言可传，非图可状，……学者当以意会而精别之。②

南宋崔嘉彦《崔紫虚脉诀秘旨》自序，与上文全同。③ 又，《历代名医蒙求》苏霖序(1220)云：

昔人序《本草》，尝有言曰：医者意也。盖谓医为人之司命，必致其意。……况医之道，有神圣工巧之殊；药之性，有君臣佐使之别；人之受病，则寒热燥湿，强弱盛衰，千变万态，不可言。既苟非精其意而通其妙，乌能已人之疾。④

南宋严用和所著《严氏济生续方》自序云：

医者意也，生意在天地间，一息不可间断，续此方，所以续此生。⑤

金元四大家之一的朱震亨说：

古人以神圣工巧言医，又曰：医者意也。以其传授虽的，造诣虽深，临机应变，如对敌之将，操舟之工，自非尽君子随时反中之妙，宁无愧于医乎？今乃集前人已效之方，应今人无限之病，

---

① 冈西为人编：《宋以前医籍考》，第1044页。
② 同上书，第198页。
③ 同上书，第192～193页。
④ 同上书，第507页。
⑤ 同上书，第1145页。

何异刻舟求剑、按图索骥，冀其偶然中，难矣。①

明王文禄《医先》云：

医者意也，度时致病者意起之，立方医之，若天时圣教不同也。……是以医贵审运气，察人情，及致病之原。②

明谢肇淛《五杂俎》卷五云：

葛可久以气未足，初秋，取桐叶饮之，立下，此以意悟者也；……以命门无脉，而知为鬼，此以博识者也；……诊父之脉，而能道其子吉凶，此以理推者也。意难于博，播难于理，医得其意，足称国手矣。

夫医者意也，以医取效，岂必视方哉？然须博通物性，妙解脉理而后以意行之，不则妄而轻试，足以杀人而已。③

《惠民局本草诗签》蒋溥序云：

故河汾氏之言曰：医者意也，药者淪也。先得大意，后以药物疏淪之，此可谓善言医者矣。④

《圣济经》陈兰森序(1789)云：

医者意也，以意体之，方无不当。⑤

清代龙绘堂所著《蠢子医》原序(1882)云：

---

① 朱震亨：《局方发挥》，人民卫生出版社，1956年，第1页。

② 《古今图书集成·医部全录》卷五〇二，人民卫生出版社，1991年，第12册，第37页。

③ 陶御风等编：《历代笔记医事别录》，天津科学技术出版社，1988年，第209页。

④ 丹波元胤编：《中国医籍考》，人民卫生出版社，1956年，第208页。

⑤ 冈西为人编：《宋以前医籍考》，第1010页。

甚矣，医道之难也。医者意也，不可以妄试；不可以轻尝。①

清代臧达德《履霜集》自序(1814)云：

盖医者意也。借望闻问切四者，以一己之心理而揣度夫病理；援五行生克之标榜，而定其所伤何部。以形式而言，似属谈空，细绎之固有至理在焉。②

清代李光庭《乡言解颐》卷三云：

汉郭玉曰：医之为言意也。唐许允宗曰：医者，意也。思虑精则得之。望闻问切而不能知，或强不知以为知，遂以意为之，鲜有不败事者。东坡云：学书纸费，学医人费。③

十分明显，这些医家强调的“意”，早已不是在针法操作时需要集中的“注意力”，而是围绕着一个核心，即：医学是一门深奥的学问，而尤以诊脉、用药为难；治病不可生搬硬套、墨守成规；必须最大限度地发挥自己的聪明才智，方能正确辨识疾病，并找到适合的治疗方法。由此不难看出，中国传统医学在外表上虽然总是呈现出一种极强的继承性，令人觉得古今一脉并无多大变化，但实际上今古中医之不同远胜相同。其原因就在于历代医家虽然在口头上总是将诸如今本《黄帝内经》、《神农本草经》、《难经》、《伤寒杂病论》等一些古代医学著作奉为圭臬，称为经典，但旧有的名词、概念往往早已被多次赋予新的解释与内涵；同时，这些新旧概念又被无数次地加以重组——再建体系。这就是传统医学发展的历史、自我改造的历史，或者说是“革命”的历史。如果没有这种自我改造，中国传统医学肯定不会具有今日

---

① 《珍本医书集成》第14册，上海科学技术出版社，1986年。
② 同上。
③ 陶御风等编：《历代笔记医事别录》，第226页。

所见之强大生命力。关于这一点，只要我们想到人类早期各地区、各种文化间的相同之处远远多于不同；针刺放血、草药治病等医疗技艺与知识普遍存在于世界各地，至今也并未彻底消亡，但何以不具与现代医学相并存的力量，即完全不难理解。“医者意也”内涵的改变，自然是上述变化的一种体现；而医家以“意”改造医学的过程，简直可以说就是传统医学发展的过程。从宏观的角度讲，中国传统医学之所以能够从低水平、原始的经验医学发展成为一个“伟大的宝库”，正是因为有许多堪称“古代科学家”的人，肯于将其与生俱来的聪明才智用在这种曾被贬斥为“君子不齿”的贱业上，才使得医学的知识含量、理论水平得以逐步提升，终在宋代以后成为被儒家认同的学问体系——“格物穷理之一端”。此外，值得注意的另一个问题是，不同的民族具有不同的思维特征，古代医家以“意”构建自身传统医学的过程，实质上也就是以本民族思维特征与生活经验，构建一种实用技艺与学问体系的过程。因而可以说中国传统医学的基本性格，乃是由中国人固有之“意”所规定的。

以下我们不妨从微观的角度，认真分析一下那些“善于用意”的医家，是如何将“意”不断注入医学这个学问体系的。

三、药物与“意”

儿时随父在郊外玩时，他常要教我认药、采药，并讲故事。印象最深的一个故事是：一日，某师对其弟子言：“去采一种不是药的草回来，即可毕业。”弟子领命而去，以为不难。谁知数日后却空手而归，泣对师言：“看来弟子是不能毕业了。”师曰：“何也？”答曰：“遍观

草木，虽有不识，但无一非药。故难复师命。”师笑曰：“汝业已成，可去。”①

听讲者自然要问：“既有不识，焉知为药？”其实这正是故事所要表达的核心思想，即：自然万物的药用功效，可由一些基本的抽象原理而获知。例如“诸花皆升，诸子皆降”；以及见于今本《黄帝内经》的“辛甘发散为阳，酸苦涌泻为阴”；“色赤如心”，“味咸入肾”等，皆可作为分析药物功效的原则——演绎原理，即可获得具体知识。然而有关人类何以会对自然界的“药物”有所认识的问题，“医学史”却另有解释。

中国自古就有“神农尝百草，一日而遇七十毒”以识药物的传说②。现代医史著作在解释药物知识的形成途径时，基本上也都是沿袭这一模式。即“氏族成员由长时期采集逐渐转化为种植的过程中，对植物的咀咽尝试已多，积累了一些用植物治病的经验”③；“在此过程中，他们曾发生过不少的中毒遭遇，但从中也积累了不少药物知识”④；“由于饥不择食，人们经常误食某些有毒的植物，因而发生呕吐、腹泻、昏迷甚至死亡等情况。经过无数次的尝试，人们逐渐认识某些植物对人体有益，某些植物对人体有害，某些植物可以治病，这样便初步积累了一些关于植物药的知识”⑤。尽管这种改造“神农尝百草”而成的“中毒识药说”自身存在着许多难以解释的问题（中毒，往往只会给人留下“此物不可食”的经验），但因其立足点是“知识

---

① 关于此故事的来源，亦有许多值得研究的地方，但这已不是本文所要讨论的问题。

② 需要说明的是，《淮南子》言此之意在于解释食物鉴别知识的起源，而非指医药，即神农之所以称“农”的原因。其后才逐渐被解释成“识药”。

③ 孔健民：《中国医学史纲》，人民卫生出版社，1988年，第10页。

④ 俞慎初：《中国医学简史》，福建科学技术出版社，1983年，第6页。

⑤ 北京中医学院主编：《中国医学史》，上海科学技术出版社，1978年，第2页。

来源于经验”,故极易被接受。经验,无疑是获得知识的重要途径,但我们还应该知道,模拟与联想的思维方式(即被巫术研究者称为“相似律”与“接触律”的思维规律①)亦是言说药物功效的重要途径。例如,在古代文献《山海经》中记载:昆仑之丘的沙棠,身体轻浮,故可以御水,食之可以不溺;蓇草是上帝女儿化身,故食之即可为人所爱,服之媚于人;菅蓉“黑华而不实”,故食之使人无子,等等。又如生长在身体外部的赘疣,在古人头脑中并不认为是源出体内的皮肤疾病,而被看成是外物所附,因而食用皮肤光滑的鳝鱼(泥鳅)可以达到“食者不疣”的效果。在今本《黄帝内经》为数不多的几个方剂中,有一个治疗失眠的药方叫作“半夏汤”,其制作方法是:

> 以流水千里以外者八升,扬之万遍,取其清五升,煮之,炊以苇薪火,沸置秫米一升,治半夏五合,徐炊,令竭为一升半,去其滓,饮以一小杯。

为何要用千里以外的流水?煎煮的燃料与药效有何关系?如果沿着“科学”的轨迹去思索,那将永无答案。即便是对于其中的药物——秫米与半夏,至多也只能给出一个知其然,而不知其所以然的回答:因为它们是药,因为古人认为这两种东西能治失眠。然而如果我们知道当时对于失眠的病理解释是“阴阳之气不通”;如果我们能对古代的思维方式有所了解,那么就不难对这一切都做出某种合理的解释:千里以外的流水,具有“流动”的性质;苇是管状空心之物,具有“通”的性质;秫米(粘米)与半夏能熬出粘的汤汁,具有“滑”的性质,这些性质的集合构成了“半夏汤”的效能——纠正体内“阴阳之气不

---

① 详见 J. G. 弗雷泽《金枝:巫术与宗教之研究》(徐育新等译,中国民间文艺出版社,1987 年)对巫术思维规律的具体分析。

通”的病态。因而作者断言:“饮以半夏汤一剂,阴阳已通,其卧立至。”①

前引孙思邈有关药物不同剂型适用范围的解说,也是同理。汤者,荡也;散(ㄙㄢˇ)者,散(ㄙㄢˋ)也;丸者,缓也。总之,古人并不仅仅是从一种药物所含的“有效成分”去思考其作用;或者可以反过来讲,一切相关因素都是“有效成分”。因而他们决不会像今人,为了销售、保存、服用之便,而将治疗外感风寒等急性病的药物也制成丸药。由于原始文献的记载极为简略,故要逐一推敲每种药物功效建立过程中的思维过程与原理是不可能的,但诸如此类的线索确实可以使我们了解到,除实践经验外,模拟方式可谓古代建立药效之说的最重要途径之一。这种模拟(或称比类)与联想的思维方法,被古代医家称之为“意”。

北宋的苏轼就药与意的问题曾有这样一段记述:

> 欧阳文忠公尝言:有患疾者,医问其得疾之由,曰:乘船遇风,惊而得之。医取多年柁牙为柁工手汗所渍处,刮末,杂丹砂、茯神之流,饮之而愈。今《本草注·别药性论》云:止汗用麻黄根节,疾故竹煽为末服之。文公因言:医以意用药,多此比。初似儿戏,然或有验,殆未易致诘也。②

又如南宋吴曾《能改斋漫录》卷二中有关药理的解说,亦可谓旨趣相同:

> 王原叔内翰云:医药治病,或以意类取。至如百合治病,似取其名;呕血用胭脂红花,似取其色;淋沥滞结,则以灯心、木通,

---

① 《灵枢·邪客》。

② 《东坡志林》卷三。引自钱远铭主编:《经史百家医录》,广东科技出版社,1986年,第276页。

似取其类。意类相假，变化感通，不可不知其旨也。①

这种“以意用药”或“以意解药”的表现，也可说是“感应论”在医学中的具体运用。有研究者指出：“感应原理是中国人思考方法中的基本原理之一，尤其是天人相感论构成了他们思想框架的一个重要组成部分。”②古代文献中的典型记述，如秦汉时期的《吕氏春秋·有始览》云：“类固相召，气同则合，声比则应”；《春秋繁露·同类相动》言：“气同则合，声比则应……类之相应而起也”。至北宋赞宁(919～1001)，总结前人发现的种种“感应”现象，撰写了《物类相感志》。从“磁石引针”、“琥珀拾芥”开始，列举了77种“物类相感如斯”的现象。接着又按身体、衣服、饮食、器用、药品、疾病、文房、果子、蔬菜、花竹、禽鱼、杂著等十二门，分别记述了物类相感的种种特殊现象共计448例③。在现象罗列方面，可谓登峰造极。到了理学家手中，这些现象被形而上为一个基本原理：“天地之间，只有一个感与应而已。”④

要之，“感应”的思想方法具有既可产生巫术，也可产生科学的两面性。例如认为“兔唇”是“由妇人妊娠见兔，及食兔肉使然”⑤，显然是基于“相似律”或“接触律”而来的巫术“禁忌”，但被认为富含许多科学内容的古代“胎教”，实际乃是建立在同样的思维基础之上。明代的李时珍，是驰名中外、妇孺皆知的“著名古代科学家”，但在他的

---

① 陶御风等编：《历代笔记医事别录》，第276页。

② 山田庆儿：《〈物类相感志〉的产生及其思考方法》。见氏著《古代东亚哲学与科技文化》，辽宁教育出版社，1996年，第126页。

③ 同上书，第125页。

④ 《二程遗书》卷十五《伊川先生语一》，上海古籍出版社，1992年影印本，第116页。

⑤ 巢元方：《诸病源候论》卷三十《唇口病诸候》，人民卫生出版社，1955年影印版，第158页。

《本草纲目》中同样可以见到此类显然不是源于实践的“用药知识”。例如,“铳楔”用于“难产”(击发的功用,引起分娩的效果);梳子能治“乳汁不行”(梳子具有“通”的作用)。前者肯定于事无补;后者“通”的作用虽不可能转移到乳房,但“梳乳周回百余遍”的过程,却能起到按摩(物理治疗)的作用。诸如此类,不胜枚举。值得注意的有两点:一是不管这些技艺是荒谬无稽,还是确有实效,其发明原理却是一样的;二是这种简单、原始、人类最基本的思维方法,并不仅仅广泛应用于人类文明发展早期。从以上所举之例不难看出,唐宋时期药物学的发展,从某种意义上讲,正是有赖于这种思维方式被进一步广泛运用。

四、脉诊与“意”

“病家不必开口,便知病源何在。说得对,吃我的药;说得不对,分文不取!”此乃舞台上医家亮相时常用的开场白,也可说是“神医”展示技艺、获取患者信任的看家本领。如何才能作到“病家不必开口,便知病源何在”,最主要的手段不外望色观形、闻声诊脉。即略去“望闻问切”四诊之中的“问”,仅靠其他三法获取资讯、做出诊断。然如此这般仍不足说明医家的技艺超群,必令其无由望色、观形、闻声,单靠诊脉做出诊断才算高明。于是便有汉和帝命郭玉隔幛诊手①之

---

① 前引《后汉书·郭玉传》载:帝奇郭玉诊脉之神技,乃“令嬖臣美手腕者与女子杂处帷中,使玉各诊一手,问所疾苦。玉曰:‘左阳右阴,脉有男女,状若异人。臣疑其故。’帝叹息称善”。

故事，甚或悬丝诊脉①之笑谈，以示脉诊之神奇。脉诊是否果真如此神奇，不是此处所要讨论的问题，唯由前引许胤宗、刘开等人言论可知，“医者意也”之感慨，与“脉候幽微，苦其难别，意之所解，口莫能宣”；“持脉之道，非言可传，非图可状”的亲身体验有着密切关系。在此，又要提出与前一节中相类似的比较问题，即：其他医学体系中也有脉搏诊察，但却没有任何神秘性，何以中医的脉诊如此难于把握？欲要回答此问题，首先需要知道：中医的脉诊方法，古今有所不同；早期的诊脉之法或许并不很难掌握；沿用至今的、需要心领神会的脉诊技艺，乃是在医家对“古脉法”不断加以改造的过程中逐步形成的。

所谓古脉法，是指已弃而不用的早期诊脉方法。例如成书于东汉时期的《难经》在谈到各家脉法时说：“脉有三部九候，有阴阳，有轻重，有六十首，一脉变为四时，离圣久远，各自是其法，何以别之？”②足见在《难经》成书时，这些脉法已然成为过去的历史了。详细介绍种种古代诊脉方法的具体内容，将远离本文主题，有兴趣者请参阅拙著《岐黄医道》③。从总体上讲，古代的诊脉方法都是以“经脉”与“气”的理论为基础，但具体运用却有所不同。例如，由于“十二经脉”之中皆有动脉，故通过这些动脉分别诊候所属经脉的病况，乃是最直截了当的方法，故而有可称“分经候脉”的诊脉方法；有以为人之“头、手、足”与“天、地、人”相应的观念，故有在头、手、足之“三部”各取三

---

① 因男女授受不亲，医家诊脉亦在忌避之列，故诊妇人时乃系一丝于患者手腕，引出室外，而仅令医者诊其丝。故事云：一医行悬丝诊脉后，断为有孕。主人大怒，言：“毁坏我家小姐名节，该当何罪？”医言：“愿以项上之物作保！”主人乃引其入室，见丝系桌脚，问曰：“更复何言？”医乃索刀，劈开桌脚，见中有一虫，蠕蠕而动。

② 《难经·十六难》。

③ 辽宁教育出版社，1991 年初版；台湾洪叶文化事业有限公司，1994 年另版。

处动脉进行诊察的“三部九候”法；又因认为人身之气与天地四时阴阳之气的运动变化相关，故有“四时脉法”，等等。在这些诊脉方法中，有一种通过比较“人迎”（颈动脉）与“寸口”（手腕部的桡侧动脉）之大小，来判断疾病归属于某一经脉的方法，或许与今日所见诊脉方法有最密切的关系。此法集中表现在构成今本《黄帝内经》的《灵枢》之中，而在《素问》中只有两篇略略言及此种脉法。①

简单地讲，“人迎、寸口诊脉法”就是以“寸口”作为人体内部（阴）的诊候之处，以“人迎”作为人体外部（阳）的诊候之处；依据阴阳学说的基本原理，阴阳平衡即是健康无病，故正常人的脉象应该是：“两者相应，俱往俱来，若引绳大小齐等，春夏人迎微大，秋冬寸口微大，如是者名曰平人。”②当某一方的脉搏大于另一方时，即说明阴阳失去了平衡；或者应该反过来讲，当阴阳失去平衡的时候，脉搏就会出现一大一小的现象。不难看出，这是阴阳学说在医学领域的一种具体运用。然而，仅仅是笼统地辨别阴病、阳病还不够，医家还需要知道病在何经脉、何脏腑，故在这种脉法中还规定：

人迎大一倍于寸口，病在足少阳（胆）；一倍而躁，在手少阳（三焦）。

人迎二倍，病在足太阳（膀胱）；二倍而躁，病在手太阳（小肠）。

人迎三倍，病在足阳明（胃）；三倍而躁，病在手阳明（大肠）。

寸口大于人迎一倍，病在足厥阴（肝）；一倍而躁，在手心主

---

① 《素问》与《灵枢》间的种种区别，是研究今本《黄帝内经》（即《素问》与《灵枢》）究竟是《汉书·艺文志》所著录之“《黄帝内经》十八卷”，还是互不相干之两本独立著作的重要线索。在脉诊方面，“三部九候”法仅见于《素问》，且云：“三部九候为之原，九针之论（《灵枢》亦名《九针》）不必存。”可窥两书间的对立。

② 《灵枢·禁服》。

(心包)。

寸口二倍,病在足少阴(肾);二倍而躁,在手少阴(心)。

寸口三倍,病在足太阴(脾);三倍而躁,在手太阴(肺)。①

这种源于阴阳理论,而且能够做到与"三阴三阳"、"五脏六腑"配合完璧的诊脉方法,显然不可能是源于实践经验;是否真的能够应用于临床,亦颇值得怀疑。

稍后,《难经》中采用了"独取寸口"的脉诊方法。即以关骨(腕后高骨,现称:桡骨茎突)为界,将原本只用于候内(阴)的"寸口脉"分为寸、尺两部;关前名"寸脉",属阳,取代了人迎脉;关后名"尺脉",属阴,独揽了原寸口脉的地位。《难经》的诊脉法中虽然有寸、关、尺之名,但却只有寸、尺两部脉,"关"尚只是阴阳的分界。然而不管怎么说,这已然与今日所见之脉诊方法极为相似。在此后不久的医学著作中,即可看到作为分界的"关"变成了"关脉"。换言之,定式化的诊脉法在东汉末期即告成立,沿用至今未见大的变化。之所以说上述"人迎、寸口诊脉法"有可能与今日所用脉诊方法之间存在着密切的启承关系,是因其与《难经》的诊脉法间存在着极强的理论共性。两种方法均是立足于阴阳对比与上下划分的取脉方式上,其区别不过在于:前者取阴阳之脉的方法是在人体的上部(颈动脉)和手部(寸口脉)取两处动脉加以比较;后者则将这种思想与方式,进一步简化与浓缩到桡动脉一处。而定式化的"寸、关、尺"三部诊脉法,虽在形式上与《难经》的诊脉法极为接近,但在理论方面却存在着以"脏腑配位"置换阴阳学说的本质变化。即左手寸、关、尺主候心、肝、肾;右手依次候肺、脾、命门。而无处不在的阴阳理论则又由"左手主血(阴),右手主气(阳)"得到了体现。

---

① 《灵枢·禁服》。

其实，脉学中最令人难以把握的是“脉象”。《史记·扁鹊传》云：“至今天下言脉者，由扁鹊也。”①看来扁鹊可谓脉学鼻祖。然而在扁鹊的诊脉方法中，“脉象”并不太复杂，大、小、“损”（慢）、“至”（快）等脉象均不难把握②。即便是在今本《黄帝内经》中，脉象也还是不太复杂。纵观《灵枢》全书，只有《邪气藏府病形》一篇中含有真正可以称得上讲述脉象的专节；且涉及的脉象不过是“大、小、缓、急、滑、涩”六种。但到了晋朝太医令王叔和的《脉经》，脉象已变得相当复杂，包括：浮、芤、洪、滑、数、促、弦、紧、沉、伏、革、实、微、涩、细、软、弱、虚、散、缓、迟、结、代、动，计24种。虽然每一种脉象都有形象的描述，但对于临床医生来说，那真是叫做“在心易了，指下难明”！

脉学的发展与药学一样，包含着模拟思想的运用。例如，两手寸口脉的前部之所以主候心、肺，是因为这两个脏器位于人体的最上部；中间的左右关脉分候肝、脾，是由于这两个脏器位居人体的中部；而寸口脉最后面的尺脉，对应的乃是人体最下面的脏器：左右两肾。③ 另外，各种脉象所对应的疾病，基本上也是模拟而来。如“浮脉”（如水漂木，举之有余，按之不足），为阳，主病在表；“沉脉”（如石投水，必得其底）为阴，主病在里，等等。而脉学与药学的不同在于，脉诊的操作需要医家的灵敏感觉与体会。从这一点讲，“意”的内涵又回到了郭玉所言“心手之际”的最初含义。

近代西方医学对于中医脉诊的评价自不待言，就连以中国传统医学为基础、建立起“汉方医学”的日本医家亦觉得脉诊过于虚幻、难于把握。因而江户以来的日本近世医家，实际使用的乃是一种叫作

---

① 中华书局点校本，1982年第2版，第2794页。

② 扁鹊脉学的内容在西晋太医令王叔和所著《脉经》中有所保存，可参。

③ 《难经》提出一种新的学说：两肾左为肾，右为命门，后世遂有命门之说。左肾为“水”、属阴；右肾（命门）为“火”、属阳，仍不离阴阳学说的基本原则。

“腹诊”的查病方法，即通过触摸腹部，以获取全身疾病资讯的诊断方法。两相比较，不难看出中国人的性格之中含有一种对“意”字当中所含要素的特别崇拜。“读书万卷，何如指下三分；谨守成规，岂过心灵一点？”①对于脉诊的如此赞誉，不过是这种心态的一种表现。

五、医案与“意”

明代江瓘(1503～1565)自幼习儒，功名不利而业商。曾因呕血遍延名医，却屡治不效。乃自学其道，竟成名医。感《褚氏遗书》“博涉知病，多诊识脉”之论；念山居僻处，博历无由，故辑古来名医奇验之迹，撰成《名医类案 》十二卷。此书被誉为是我国历史上第一部系统而完备的医案著作，流传至今。在《名医类案》的再刻序文中，可见以下论说：乾隆庚寅(1770)杭世骏序云：“医者意也”云云；张一桂序云：“医者意也……夫法所以寄意，而意所以运法”②。又，清代名医叶天士《临证指南医案》③李治序中亦有类似之语：“夫医者意也；方者法也，神明其意于法之中，则存乎其人也。……彼《灵》、《素》诸书具在，而心领神会，则又存乎其人也云尔。”看来，医案也与“医者意也”的问题有关。

医案即“病历”(case history)，是患者情况与治疗经过的记录。从本质上讲，医案是一种“医事档案”和“医学资料”，故其用途亦不

---

① 清代王九峰语，见《武进阳湖县志》，光绪五年木刻本。引自《中华医史杂志》，1984，(2)：65。

② 人民卫生出版社，1957 年影印版。

③ 上海科学技术出版社，1959 年新 1 版。

外这两大方面。就中国而言，医案作为档案的历史与运用，至少可以追溯到《周礼·天官冢宰》中有关医政管理者（医师）之职责的说明：

> 凡民之有疾病者，分而治之，死终则各书其所以，而入于医师。岁终则稽其医事以制其食。

《史记·扁鹊仓公列传》载有汉代医家淳于意的“诊籍”，其中详细记述了医案25则。这是汉文帝四年（公元前176年），淳于意因罪被解往长安之后，为回答“诏召问所为治病死生验者几何人也，主名为谁？”的垂问，而提供的说明材料①。其后，至宋代“许叔微《伤寒九十论》，则可视为医案之始有专著。金元时医家每以医论、医案杂处。明清以还，医案学作为独立学科逐渐形成，医案著作大量出现”②。曾有人统计，清代的医案有近300种。③ 此时的医案，大多是医家自录行医身验之作，或后人爬梳前贤记述而成，其目的在于供来人参考。故其性质主要是作为一种“医学资料”。

清末以来的医家对于“医案”这种医学资料，给予了很高的评价与极大的重视。例如前清名医周澄之（即周学海）云：“宋后医书，惟案好看，不似注释古书多穿凿也。”④章太炎亦言：“中医之成绩，医案最著，欲求前人之经验心得，医案最有线索可寻，寻此钻研，事半功倍。”⑤民国时期，不仅“医界均重研读医案”，而且将其引入教材，如“施今墨创华北国医，编《医案讲义》；张山雷执教黄墙中医学校，亦以

---

① 详见《史记》卷一百五，中华书局点校本，1982年第2版，第2794～2813页。

② 参见聂尚恒《奇效医述》之出版者《前言》，中医古籍出版社，1984年。

③ 高春媛：《中医医案发展简史》，《中华医史杂志》，1987，(4)：207。

④ 何廉臣选编：《重印全国名医验案类编》绪论，上海科学技术出版社，1959年新1版。

⑤ 高春媛：《中医医案发展简史》，《中华医史杂志》，1987，(4)：207。

讲解医案为课程”①。目前，北京中医药大学亦在高年级中开设了医案这门课程，确实有达到了“逐渐形成独立学科”的味道②。

然而在现代医学著作中，却似乎没有“医案”类的著作，因为没有哪个医生会认为有必要将自己一生治病的经验与案例写成书；教学中也不会特别介绍某个医生如何“灵活处理”具体问题，有哪些“心得体会”。然而中国传统医学却有成千上万的“医案”类著作；不仅教学中会有这门课程，甚至总有人力图否定仿效现代医学形成的院校教育与基本教材；以为只有耳提面命、随师学艺的传统方式，才是真正能够学到中医精髓的唯一途径。这不能说不是中西两种医学体系的又一重要区别。

中医“医案”盛行的原因是多方面的，例如从《叶熙春专辑》之《编写说明》的如下之语，可以看出编辑出版“医案”亦具有明显的“政策性”意味，被当作继承名老中医经验的一项具体措施：

> 一九六五年，为了继承名老中医经验，在省卫生厅直接领导和叶老亲自指导下，叶老的同事和学生杨继荪……等同志共同整理了《叶熙春医案》，由人民卫生出版社出版，受到读者欢迎。行将完稿的《叶熙春医案续集》却毁于十年动乱，……近年来在认真贯彻党的中医政策，继承整理祖国医学遗产的工作中，……省卫生厅再次成立“叶熙春学术经验整理小组”，对叶老的学术思想、临床独到经验进行了总结，编成本辑。③

与此书一样收录于“近代名医学术经验选编”的《金子久专辑》，其编

---

① 黄煌：《晚清名医柳宝诒及其学术成就》，《中华医史杂志》，1987，(1)：23。

② 高春媛：《中医医案发展简史》，《中华医史杂志》，1987，(4)：207。

③ 浙江省中医学会，浙江省中医药研究所编：《叶熙春专辑》，人民卫生出版社，1986年。

辑者“收集到未发表的金氏医案抄本四十八册，以及所有已刊行的医案等”①，所投入的人力、物力可想而知。由此可见政策因素的巨大作用。除人民卫生出版社这样的专业出版社外，一些综合性出版社亦对编辑本地区名医的医案，怀有兴趣。例如上海科学技术出版社的《临证偶拾》，“收载张羹梅医生有效医案八十余例”②；云南人民出版社的《吴佩衡医案》，“是从他生前写下的临证验案及会诊记录中，选择了有代表性的一部分验案编辑而成”③。另外，尽管当代中医亦是以院校教育为主，但仍保持有各种形式的师徒关系。或由弟子尊师、爱师之心愿；或因借虎皮以出书、扬名之需要，为老师整理、出版医案之事自然也就越来越多。然而除去这些“政策性”、“社会性”因素，决定医案类著作大有市场的根本原因，归根结底还是中国传统医学的固有特点。即由“体”与“用”（理论与临床）间存在着的矛盾、差距所决定。近代医家何廉臣所编《全国名医验案类编》夏应堂序中对此有所说明：

> 盖以医虽小道，辄寄死生，不读书不足以明理，徒读书不足以成用；不读书不知规模，不临证不知变化。良以体质各异，病变不常，呆守成方，必多贻误。虽饱若孝先之腹笥，亦徒成赵括之兵书耳。案者治病之实录，临证之南针也。④

概言之，医案所以受到青睐，是由于从中可以找到一些解决实际问题的办法。那么，这些具体办法又是从何而来呢？明代医家聂尚恒在

---

① 浙江省中医研究所，浙江省嘉兴地区卫生局编：《金子久专辑》，人民卫生出版社，1982 年。

② 《临证偶拾》，上海科学技术出版社，1979 年。

③ 《吴佩衡医案》，云南人民出版社，1979 年。

④ 何廉臣选编：《重印全国名医验案类编》，上海科学技术出版社，1959 年新 1 版。

《奇效医述·小引》中的说明可为代表：

> 余究心于斯术，数十年来博取而精研之，深思而透悟之，自觉有如于神妙者。因病制方，不胶于古方；得心应手，不拘于成说。①

用现代之语说，这就叫“具体问题，具体分析”。而分析的能力、分析的过程，也就是古人所说的“意”。一般认为，中国传统文化具有重综合、轻分析的特征；在医学中则表现为重整体状况，轻具体病症。其实这是一种片面的看法。片面的成因，在于一般史学家、哲学家所能了解的大多是诸如汉代的阴阳五行、宋明的理气等一些类似“终极真理”的学说，极少能够深入我们今日所谓科学技术的领域，去观古人如何处理具体问题的过程。例如明末清初的医家吴有性在研究瘟疫病的过程中，“静心穷理，格其所感之气、所入之门、所受之处，及其传变之体”，不仅“格”出了：瘟疫与伤寒不同，乃天地间别有一种“戾气”自口鼻而入以致病的“基本原理”；而且从“牛病而羊不病，鸡病而鸭不病，人病而禽兽不病”等现象，分析出：“其所伤不同，因其气各异也”；并推论：如果能知道何物能制其气，则“一病只有一药之到，病已，不烦君臣佐使品味加减之劳矣”②。

较之于“医者意也”，当代医家更喜欢用“辨证施治”一词来表达中医的神韵，或者称其为中医“活的灵魂”。其要不外首先是对一位患者的具体病情加以详尽透彻、触及本质的分析，然后灵活地选择最佳治疗方案，而不是按图索骥地绳于经典、墨守成规地套用成方。的确，古今医家都极少妄发否定“古训经典、验方成法”之言，但他们的

---

① 聂尚恒：《奇效医述》，中医古籍出版社，1984年。

② 浙江省中医研究所：《温疫论评注》，人民卫生出版社，1977年，第1～3、211页。

创新意识与创造结果，却在医案中得到了某种体现。他们引用经典之说来证明自创之法的合理性，用经学家的话说，这叫“六经注我”；与古训相悖时，则缄口不言，用史学家的话说，这叫“皮里春秋”。只有看清这一点，才能了解中医学内部“旧瓶新酒”的变化、发展过程；了解医案中蕴涵的医家之“意”为何；了解医案的价值何在。

谈到医案与辨证施治，则还有一事不妨顺带说明。即当近代西方医学传入之后，自然引出国人对于两种医学体系之异同、短长的思考与比较。就异同而言，通常认为“西医辨病，中医辨证”是其重要区别之一（这或许可说是“辨证施治”一词赖以成立的根本原因）。虽然中医界力陈“辨证”之科学与重要，但却缺乏足够的说明力，或者说“很难说清”。而医案的“档案”性质似乎在此又得到了某种发挥——让事实作为中医的科学性、辨证的必要性的证明！高辉远等整理的《蒲辅周医案》似乎就隐含着如此苦心。其《整理的几点说明》中谈到：

> 整理形式仍以中医为主，多采用中医病名，……如中医一个病，可能包括西医的几个病，同是中医的眩晕，而西医则有美尼尔氏综合症或高血压之分。西医一个病，也可能包括中医几个病，同是西医的乙型脑炎，而中医则有暑温或湿温之分……蒲老治病的特点，特别强调辨证论治这个原则……①

医案对于中医来说，无疑是一种教材。无论是自我研读，还是课堂授业，都不仅起到传播技艺的作用，而且还兼有通过“有验之事、可验之法”向后学与社会证明这个医学体系之可信性，增强信任的潜在功能。

---

① 中医研究院主编：《蒲辅周医案》，人民卫生出版社，1972年。

六、反对者的意见

并非所有医家都支持“医者意也”的说法，然反对者的出发点却并不相同。大致有以下几种情况。

首先，唐代医家孙思邈虽在其著作中多次提到“医者意也”（见本文第三节的引用），但书中又有“医自以意加减，不依方分，使诸草石强弱相欺……”①的说法。无独有偶，《是斋百一选方》章楫序（1196）亦称：

> 古人方书，一药对一病，非苟云尔也。后世医家者流，不深明夫百药和剂之所宜，猥曰医特意尔，往往出己见，尝试为之，以故用辄不效。甚者适以益其病，而杀其躯者有之。②

这显示出古今医家对于“医方”的基本看法有所不同：古人称方书中所载医方为“经方”，即行之有效的经验之方，故只能照本宣科地加以利用，不得随意加减；今日固然仍有此类人物存在，但为数极少③，而大多数的医家只不过是将方书作为临证处方的参考。换句话说，中医师展现在众人面前的“随意遣药，灵活组方”之画面，并非古代文物，而是后世医家的新作（当然，这个“新”只是相对于汉唐而言）。对此有所了解之后，反观六朝隋唐时期大量方书涌现这一医学发展的时代特征，自然会有更加深刻的认识。

---

① 《千金要方》，第 10 页。

② 冈西为人编：《宋以前医籍考》，第 1123 页。

③ 此即所谓“经方派”人物，始于清末民初。尊张仲景《伤寒杂病论》为“医方之经”；视其医方为“经典之方”；并以能守原方、原量，甚至原服法而自誉。详见《中国医学百科全书·医学史卷》，上海科学技术出版社，1987 年，第 78 页。

其二，则是对许胤宗“书不可著”观点的批评。如《幼幼新书》李庚序(1150)云：“或者乃谓，医特意耳，不庸著书，……或是一偏之论也。”①又如《圣济总录纂要》吴山滔序(1681)亦云：“虽然医者意也，书不可尽废。”②此乃显而易见之道理，不必多述。

特别值得注意的，是苏轼对于源于感应论之“药物理论”的批判。在前引《东坡志林》有关“以意用药”的事例，以及欧阳修“医以意用药，多此比。初似儿戏，然或有验，殆未易致诘也”的感想之后，还有一段苏轼的反驳之词：“予因谓公：以笔墨烧灰饮学者，当治昏惰耶？推此而广之，则饮伯夷之盥水，可以疗贪；食比干之馂馀，可以已佞……公遂大笑。”③

苏轼的话之所以值得注意，是因为他表露出一种与中国传统思维方式相悖的“科学倾向”。但遗憾的是，这种“科学”的倾向比较少见；且当出现时，受诘者亦不过是一笑了之。同样，定式化的医方固然具有刻板保守的一面，但在某些场合也有追求规范的性质。这也可以说是一种“科学倾向”。例如被“医者意也”的支持者朱震亨斥为“何异刻舟求剑、按图索骥”的《和剂局方》，实为宋代官药局生产成药的规范。试想如果没有这样一个规范，成药又当如何生产？因而有人认为：《和剂局方》具有典型的药典的基本特征和功能，堪称我国药学史上第一部划时代的药典学著作。④

今天，即便是对“医者意也”充分理解、满怀眷恋者，亦难免有下述感慨与批评：

---

① 冈西为人编：《宋以前医籍考》，第391页。

② 同上书，第1123页。

③ 钱远铭主编：《经史百家医录》，广东科技出版社，1986年，第276页。

④ 吴克让：《评“我国药学史上的第一部药典”》，《中华医史杂志》，1984，(4)：254。

> 坦率地说，“医者意也”是缺乏现代科学性的，它很容易暴露出种种破绽，甚至流于荒诞不经，然而回到中医的源流上来理解，又会感到它不仅仅是文人用来说故事的题目，而且代表了古典中医的一种思想方法。……时至今日，随着中医现代化进程的加剧，在越来越精细严密的医学科学分析和技术要求面前，中医的思想传统已经失去了存身的基础，经典表述的声音也越来越微弱。如果有谁还对你说“医者意也”，那么他一定就是最后的中医。反对中医现代化，绝对是不切实际的愚蠢念头，谁敢与科学较劲呢？①

这种思想方法真的失去了存身的基础，无法与科学较劲吗？

七、科学的难点

承认中医能够治病，甚至能治疗一些连现代医学都感到棘手的疑难病症，这对于大多数具有种种直接或间接感受的中国人来说并不困难。遗憾的是成千上万乐于承认这一事实的专家学者，却无法以自己掌握的最先进的科学理论与技术手段，对这种感受的科学性、合理性加以证明，无法对现象背后所隐藏的原理、本质、“所以然”做出说明。这就是“科学的难点”。

中医之所以能够治病，固然与几千年之经验积累有密切的关系。但通过前面的论说，不难了解到中医的许多内容并非都来源于实践经验，而是与一些被近代自然科学排斥在外的思维方式有着密切的

---

① 费振钟：《悬壶外谈》，第79页。

关系。按道理讲，从这些被认为是属于“交感巫术”的思维方式出发，理应只能产生出伪科学与伪技艺——不真的认识与无效的操作。但在中医这片土地上，却结出了实实在在的果实。对于这样一种客观事实，哲学家或科学史家给予了必要的承认：“科学与方术在早期是分不开的”①；“无论这三者（巫术、宗教、科学）的实在关系如何，巫术好像终归是宗教与科学的摇篮”，只不过“科学比巫术有更清晰的洞察力，它谦卑地学习自然的法则，通过服从这些法则而取得控制自然的能力”②。

近代自然科学的确比巫术具有更清晰的洞察力，能够揭示许多自然现象与技术手段背后隐藏的“所以然”问题。例如在传统医学领域中，上述思维方式带来的最“伟大”成就，应该说是众所周知的“人痘接种法”。由于古时认为天花的病因在于人体内存在有先天的“胎毒”，欲要引出胎毒，就必需使用某种能与体内之胎毒产生“感应”的东西，于是便令小儿穿上病愈患儿之衣，或取病愈者的疮痂移植到未患过天花者身上，以实现“引胎毒外出”的目的。这种错误的认识虽然一直存在于中国医生的头脑中，但却丝毫不影响“人痘接种法”作为当时预防天花最有效之法所产生的实际效果。即便是在牛痘法传入中国后，人们也还是以此作为其原理解释③；而且对于牛痘的安全、优越性，同样给予了模拟式的解释：牛属土性，性情温顺，故用之万全。实际上，直到近代免疫学形成之后，人们才真正明白“种痘”何以能预防天花。同样，人们通常所说“吃什么，补什么”无疑也是来源于原始的模拟思维方式，并成为食疗，以及许多“自然之物”被广泛用

---

① J. 李约瑟：《中国科学技术史》第二卷《科学思想史》，何兆武等译，科学出版社·上海古籍出版社，1990 年，第 36 页。

② W. C. 丹皮尔：《科学史及其与哲学和宗教的关系》，第 479 页。

③ 最早介绍牛痘的著作名曰《引痘略》，显然是为了表述“引痘外出”之意。

作药物的理论依据。“科学家”开始对此嗤之以鼻，且常常与前引苏东坡难欧阳修之例一样地加以驳斥：中医言“色赤入心，色赤补血”，那么吃只红色的袜子能治什么病呢？中医言“白糖补气，红糖补血”，然白糖与红糖乃是一物，只不过纯度不同，红糖含有些杂质而已。然而当科学家，或者说是医学家弄清了相同器官的化学构成极为相近时，市场上出售的“猪肚子”（胃）则往往被刮去了内膜——用于生产某种胃药；同样，当人们不再仅仅是从制糖工艺的角度去看待红糖与白糖的区别时，“杂质”也就具有了一定的“名分”——许许多多黑色食品的特殊营养价值得到了充分的肯定。当我们了解到花中多含芳香烃、挥发油，具有扩张毛细血管（发散）的作用时，对于中医据比类之观而言“诸花皆升”，亦可理解；但对于那些至今还不能对其“所以然”做出解释的理论、技艺，又该如何对待呢？尽管从理论上讲，人类具有不断认识自然，逐步从“必然王国”走向“自由王国”的能力，但又永远不可能穷尽因果之间的全部链接细节。这不正是“科学的难点”之所在吗？在此种情况下，一种被称之为“哲学的荣誉”的认知方法——紧紧抓住因果两端，而将其间的细节问题留给未来自然科学的方法，不是也永远会具有存在价值与生命力吗？中医之所以在当代还没有消亡的根本原因，恰在于此。

又如脉诊的问题，如果从血液循环的有关知识出发，将永远无法解释与承认：以手腕处的一截动脉作为人体的缩影；按上下顺序划分成“寸、关、尺”三部，并与五脏相配的理论有何道理。然而局部可以作为全局之缩影，且可给出整体像的所谓“生物全息现象”，却越来越受到人们的注意，并由此产生了一些新的理论学说。总之，人类在认识自然的过程中，是否只有实验科学这一条路可走？或者说，以实验为特征之近代科学的局限性，是否可通过沿着自身轨迹的运动发展而被彻底克服，不能说不是一个值得思考的问题。

咒禁疗法

——“意”的神秘领域

当以“实证”为主要特征的近代自然科学体系形成后，一切解释自然及其运动方式的理论、学说，乃至根据这些认识创造的改造与利用自然的方法，均受到“科学”的检验。这种“检验”不仅仅指出以往一些具体的理论学说、方法技艺的正确、错误或不足，而且在“自然”与“超自然”之间建立了不可逾越的鸿沟。从而使得数千年来普遍存在于各种文化积淀中并依然存活于原始部落中的、因尚不具备“自然”与“超自然”概念区分而歪曲自然的认知体系——巫术，获得了“伪科学”之名。

巫术的伪科学性质，在于它是一种被歪曲了的自然规律的体系，也是一套谬误的行动指导准则。在这个体系中，为实现某种愿望而创立了各种操作法术，但由于这些法术或因所利用的作用力来源于虚幻的“超自然之力”，或因作用力的传递媒介与传递方式是“超自然”的，而使得其目的不可能实现。

巫术的体系与结构，可以概括为“理论巫术”（伪科学）与“法术”（伪技艺）两部分。如果深入研究，则不难看到其思维模式——巫术理论有如人们对于事物的科学认识一样具有自身的体系，只不过这个体系与思维方式未能正确反映客观世界的“真”，故而被称之为“伪科学”。其次，由于构成巫术的各种具体法术均是由其发明者运用自己的智慧创造而成，因而被称之为“伪技艺”。“理论巫术”并不是创

造技艺者所必须遵循的指导法则，而是研究者通过探索各种法术的共性，归纳总结出的抽象原理。由于这些“理论”的本质是人类某些思维方式的概括总结，所以这些“理论”就不可能仅仅是法术（伪技艺）的思维原则，而且同样是某些被今人称之为古代科学、技术文明赖以创立的抽象原理。因而研究巫术的目的并不在于批判其“不真”的本质，而是要在分析各种法术的具体结构，弄清其中各种行为的意义与思维方式的基础上，进一步研究巫术在人类文化发展史上的地位与作用，研究其在不同文化区域中的各自特征与共性。

一、咒禁疗法在医学中的地位

尽管在现代西方医学与中医学中均无咒禁疗法的立锥之地，但在古代（不论中外），咒禁疗法均是医学构成中的组成部分。而且其地位与运用范围并不因医学理论及其他各种确有实效之医疗技艺的发展而下降或萎缩。不必追述有关先秦时代巫、医两者间密不可分关系的种种记述①，仅举唐代医家孙思邈对于医学构成的言说为例：“故有汤药焉，有针灸焉，有咒禁焉，有符印焉，有导引焉。斯之五法，皆救急之术也。”②自隋代开始，太医署中设有“祝禁博士”③；唐代医生分为四类，“咒禁师”为其一（馀为医师、针师、按摩师）④；宋代太医

① 例如《韩诗外传》载：“俞跗治病，不以汤药，搦木为脑，芒草为躯，吹窍定脑，死者复苏。”又，《说苑·辨物》：“苗父之为医也，以菅为席，以刍为狗，北面而祝，发十言尔，诸扶而来者，举而来者，皆平复如故。”

② 孙思邈：《千金翼方》卷二十九《禁经上》。

③ 《隋书·百官下》，中华书局点校本，第776页。

④ 《旧唐书·职官三》，中华书局点校本，第1875～1876页。

局将“医学”分为九科，含“金镞兼书禁科”①；元、明两代的太医院亦皆有“祝由科”②。虽然历代不乏对于咒禁疗法的指责，例如汉代司马迁认为“信巫不信医”是“疾有六不治之一”③；宋代徽宗曾“诏禁巫觋”④，等等，但均不能改变咒禁疗法乃至巫术的存在，其原因就在于对于没有现代自然科学观的人来说，根本不存在自然与超自然间的概念差异，所以当法术失败时，被否定的仅仅是这一具体的法术本身，而不是整个认知体系。⑤ 李约瑟指出：“区分方术与科学，只有到了人类社会历史的较晚时期才有可能……是17世纪早期现代科学技术诞生以后的事——而事实上这一点却是中国文化所从未独立达到过的。”⑥这实有助于理解巫术的思维方式与具体法术在中国古代医学中占据何等重要的地位。

一般认为，在医学发达以前，由于人们对于自然的科学认识不足、抗争手段十分有限，对于各种疾患只能乞求神灵的帮助，因此是巫医占统治地位与巫术治疗盛行的阶段。这种观点虽然普遍出现在各种医学史的论著中，但却没有足够的史料作根据。这种观点流行的原因之一是由于许多人自觉或不自觉地接受了英国人类学家泰勒(E. B. Tylor，1832～1917)创立的“万物有灵论”，认为原始人在对自然缺乏正确认识及无力抗争自然时，会在宗教形成前先发生“万物有灵”的观念。但是近世的宗教学家却不承认这一观点。因为早期人

---

① 《宋会要辑稿·职官二十二之三十六》，中华书局，1957年，第2878页。

② 陶宗仪：《南村辍耕录》，中华书局，1959年，第188页；《明史·职官三》，中华书局，第1812页。

③ 《史记·扁鹊仓公列传》，中华书局，1959年，第2794页。

④ 《宋史·徽宗纪三》，中华书局，第398页。

⑤ 例如五代唐庄宗“重贿召募能破贼舰者，于是献技者数十，咸言能吐火焚舟，或言能禁咒兵刃，悉命试之，无验”(《旧五代史·庄宗纪第三》，中华书局，第395页)。

⑥ 李约瑟：《中国科学技术史》第二卷《科学思想史》，第36页。

类的思维方式尚未达到综合各种现象加以抽象的水平，所以至今并未发现任何实例足以证明早期文明中曾存在过“万物有灵”观念的现象。① 以念诵咒语的治疗方法为例，由于语言最基本的功能是表达思想，因而其对象理应是限定在“能够理解语言”——即可以接受语言讯息的对象范围之内。又因为在不同的历史时期，人们对于这个范围的认识是不同的，所以祝咒的应用范围亦相应不同。从马王堆出土医籍所保存的资料看，当时咒禁疗法的适用病种远不如后世广泛，其原因正是由于当时在“作用力来源”与“治病物”两方面能够接受语言讯息的对象并不如后世多。例如对于经今人考证以为是蝎伤的“蛩”病，只是威吓说：“凤鸟”将“贯而(尔)心”②。这“凤鸟”或许是指“凤凰”，但其思维方式大概不过是在模拟鸡可啄食虫类动物的观察基础之上。纵观《五十二病方》中所存近 30 条咒禁治疗方法，其中作为威慑力来源的神灵之名不过以下几种而已：

1. 天甸(电)、东方之王、西方□□□主冥冥人星(第 66 行)；
2. 凤鸟(第 82、84 行)；
3. 天神、神女(第 204 行)；
4. 黄神(第 308、427 行)；
5. 啻有五兵(第 381 行)；
6. 巫妇(第 443 行)。

其他则主要是依靠施术者本身的力量。后面将要谈到喷、唾等行为显然是威慑力的重要来源，如咒之曰：“喷者豦(剧)喷，上如篲(彗)，下如胎血”(第 51 行)；唾曰：“喷泰(漆)，三”(第 380 行)。另外则是以“斩”、

---

① 参见《简明不列颠百科全书·泛灵论》，中国大百科全书出版社，1985 年，第 3 册，第 15 页。

② 《五十二病方》，第 84 行，见《马王堆汉墓帛书四》，文物出版社，1985 年。

“磔薄”(碎尸)、“石击”、“斧斩”、“刀割”、“刖若肉”、“涂若豕矢”(屎)、“□若四体、编若十指、投若□水”之类现实而具体的惩罚作为威慑力。

《五十二病方》中使用咒禁之法治疗的疾病,可以归纳为以下几种病因:

1. 虫类:巢①,蛓(蝎,2条),蚘(蛇,3条),□烂,痈(2条),身疕(浸煽虫);

2. 狐:包括各种外阴部位的病变,如“瘕”(癃)、“颓”等(共7条);

3. 鬼:魅(小儿鬼),鬃(漆,病因为漆王,3条);

4. 不明:婴儿瘛②,伤者血出,尤(疣,6条)。

分析这些资料则不难看出,在当时的思维、认识中,作为能够接受语言讯息的对象,首先是动物,其次才是神灵。而且这些神灵亦不十分抽象,例如天甸(电)、凤鸟、巫妇、魅等均是确有可指的。因而对于以往医史研究中普遍认为超自然的病因解释与治疗方法主要出现在人类早期社会,逐渐被科学(物理与化学)的治疗方法所取代,两者间的关系属于此消彼长的观点,应该适当加以修正:通过比较汉、唐时期咒禁疗法的适用范围、语言对象即不难看出,随着文化的进步及人类思维的复杂化,超自然的疾病解释与治疗方法——咒禁之术,亦有其自身的发展变化过程。就中国而言,至少在从汉到唐的历史阶段中,医学体系中的科学内容(物理与化学的治疗方法及相关理论)与咒禁

---

① 巢,《马王堆汉墓帛书四》释为“体臭”,似不确。该书第261行有“未有巢者,……其虫出”,意为“虫巢”,故知病因为虫。

② 文中没有提到病因为何,山田庆儿先生对此条有详尽的考证与论述,认为病因是民间传说所言“九头鸟”之血落在小儿衣物上引起的,详见山田庆儿:《夜鸣之鸟》,译文载于《日本学者研究中国史论著选译》第十卷,中华书局,1992年,第231～269页。

疗法是呈平行发展之势的。在此后的运用中，虽然具体法术可见更新、繁衍①，但其所依据的准则基本上都是一致的。

当讨论巫术在医学构成与发展中的地位时，还应看到除表现形式明确的咒禁疗法外，巫术的基本思维方式——“相似律”、“接触律”，实际上也是中国古代医学理论体系许许多多“科学内容”赖以成立的基础，由此不仅构成了某种思维方式（例如联想与模拟）既可产生巫术，也可产生科学的不同效果，而且形成了巫术与科学分解的不确定性。以下各举一例说明之。

1. 相似律：例如毁坏敌人的偶像，或以针刺写有某人姓名、生辰的纸人，以期达到令对方失败或遭厄难之目的，是此种巫术原理的典型表现形式。在咒禁治疟法中，有“发曰执一石于水滨，一气咒曰：智智圆圆，行路非难，捉取疟鬼，送与河官，急急如律令。投于水，不得回顾”②，这种巫术原理的基本思维方式是相同原因（或形式）必然会产生相同效果，而其在医学中的运用，可谓不胜枚举。例如“兔唇”，“由妇人妊娠时见兔，及食兔肉使然”③，判定此说之谬当然十分容易，但要判定某些用药理论的是非就不那么容易了，例如根据钟乳石的形态与形成过程而言其功效为“下乳汁”④；食用动物的某一器官可以补养人体的相应器官（现代生物化学证明相同器官的化学构成相近似）；具有“滑”之性质者（例如米汤和滑石）可以通窍（前者已淘汰，后者符合溶质分子渗透利尿原理，故确有利尿作用），等等。李时珍以为“铳楔”可以治疗难产，显然不对；但用梳子“梳乳周回百余

---

① 如宋代《圣济总录》“符禁门”的文字长达6万余，有符300馀道。

② 葛洪：《肘后方》卷三，人民卫生出版社，1963年，第60页。

③ 巢元方：《诸病源候论》卷三《唇口病诸候·兔缺候》，第158页。

④ 《神农本草经·石钟乳》。引自《重修政和经史证类备用本草》，人民卫生出版社，1957年，第1269、1270页。

遍”治疗“乳汁不行”①却能成立。诸如此类，或正确，或谬误，但都是建立在相似律的原理之上。

2. 接触律：例如“在全世界许多地方我们都可看到，脐带尤其是胞衣被当成一个活物……在那里住着这个孩子的守护神或他灵魂的一部分。此外还普遍认为：采用什么方式来处理孩子的脐带或胞衣，也将影响他或她未来的身分或事业”②。马王堆帛书中有《胎产书》，画有如何埋胞衣的方位图；解释文字见《杂疗方·禹藏埋胞图法》③，正是此意。接触律的基本概念是认为事物一旦互相接触过，他们之间将一直保留着某种联系，即使他们已相互远离。《灵枢·癫狂》有取患者之血以候其病发之例：“置其血于瓠壶之中，至其发时，血独动矣。”在医学领域中最值得研究的“成功用例”是人痘接种法的发明！即令未患过天花的小儿穿着患儿衣服，或取病愈者的疮痂移种到未患过天花者身上，以实现“引胎毒外出”的目的。作为一种治疗方法，而未患天花者又普遍肯于接受这种“移植”，显然不能用“转移疾病”去解释这种行为的动机。发明者的意图不过是要借助患者身上之物（衣服、痘痂或脓汁）引导未患病者身上潜藏的“胎毒”外出。这种“胎毒”的病因解释一直延续到牛痘接种法传入中国以后，最重要的牛痘接种法著作即名之曰《引痘略》。人痘接种法之所以能够在没有任何病毒学、免疫学理论作基础的情况下产生，成为造福于人类的一大发明，恰恰是由于简单的“接触律”思维方式。

类似的治疗方法颇多，但由于研究者对古人的思维方式不甚了解，故多以现代医学的理论比附之。例如有人评价《肘后备急方》：“在狂犬

---

① 李时珍：《本草纲目》卷三十八“服器部”，人民卫生出版社，1957 年，第 1269、1270 页。

② 弗雷泽：《金枝》，第 32 页。

③ 《马王堆汉墓帛书四》，第 133～135、126 页。

病的治疗上该书首次记载了用狂犬脑组织治疗狂犬咬伤。这种‘仍杀所咬犬，取脑傅之，后不复发’的记载……姑且不论其治疗效果如何，至少可以认为这一发明与现代医学的免疫思想原则符合”①。但如果我们知道“人们曾普遍相信：在受伤者和致伤物之间存在着某种联系，因而在事件发生后，无论对该致伤物做什么事情都会相应地给予受伤者或好或坏的结果”②，则不难对“巫术”在古代文明发展中的地位与作用，建立起一个基本正确的认识。诚如丹皮尔所说：“巫术对宗教的关系和对科学的关系如何，仍然是一个争论的问题。”但是“无论这三者的实在关系如何，巫术好像终归是宗教与科学的摇篮”③。

二、咒禁疗法的作用力与转移方式

一、喷、唾——“气”的作用

在行咒禁之法时，施术者常常通过喷、唾等动作向受术对象吐气。例如在马王堆汉墓帛书所记载的咒禁疗法中可以见到：“湮（唾）之，贲（喷）：兄父产大山，而居□谷下，……”；“吙④：嗟年蓋杀人，今兹有（又）复之。”这种动作大多是在念诵咒文之前进行，虽少见有单独使用者，但却有其自身的独立意义。

唾，在中国传统习俗中始终是表示鄙弃、侮辱之意。如《左传》僖公三三年：“不顾而唾。”《战国策·赵四》：“太后明谓左右，有复言令

---

① 朱仁康主编：《中医外科学》，人民卫生出版社，1987年，第5页。
② 弗雷泽：《金枝》，第63页。
③ 丹皮尔：《科学史及其与哲学和宗教的关系》，第479页。
④ 吙，《玉篇》：“呼气。”

长安君为质者，老妇必唾其面。”然而在咒禁之法中，“唾”似乎并不仅仅是为了表示鄙弃、侮辱的意思。秦代法律文献《封诊式》中，有控告他人口中有毒的案例，称之为“言毒”①；《灵枢·官能》在论述如何根据个人的不同特点传授适宜的治疗技能时说：“疾毒言语轻人者，可使唾痈咒病。”另外，汉代王充在《论衡·言毒篇》中亦曾谈到：“太阳之地，人民促急；促急之人，口舌为毒。故楚越之人，促急捷疾，与人谈言，口唾射人，则人脉胎肿而为创；南郡极热之地，其人祝树树枯，唾鸟鸟坠。”因而咒术疗法中使用“唾”行为，极有可能是将“唾沫”视为口舌之毒的载体。此后虽然“毒言”、“口舌为毒”的说法不复流行，但唾在咒禁之术中却始终保留。

唾、喷等动作虽有所不同，但其共性与本质均是要向受术对象传递某种能量。王充的解释是：“巫咸能以祝延人之疾，愈人之祸者，生于江南，含烈气也。”②其后，晋代葛洪所著《抱朴子·内篇·至理》中也有相似之论：“善行气者，内以养身，外以却恶。然百姓日用而不知焉。吴越有咒禁之法，甚有明效，多炁(气)耳。”

比较以上王、葛二人之论，前者是从江南太阳之域“多含烈气”加以解释，而后者虽亦举吴越之地为例，但其立论已然转移到“百姓日用而不知”的人身固有之气。葛洪在解释能够“以炁禁之”的事物时，虽然范围颇广，但从中看不出任何宗教、神仙的色彩，完全是建立在以“炁”的能量制约他物的基础之上，例如从“以炁禁白刃，则可蹈之不伤、刺之不入”③看，则颇似现今屡见不鲜的“硬气功”。

从思想史的角度讲，葛氏之说代表着汉代儒家文化取代黄老之

---

① 《睡虎地秦墓竹简·封诊式》，文物出版社，1987年，第276页。
② 王充：《论衡·言毒篇》。
③ 葛洪：《抱朴子·内篇·至理》。

学后，“一批治黄老之学的知识分子分别转向从事学术和方术”①，从而使得“方术”逐渐理论化、体系化，具备了某种哲学思想与理论性解释的倾向。在唐代的有关文献中，可以看到“气”的应用更加医学化，形成了咒禁“六法”之一的“气道禁”——所谓“吹、呼、呵、嘘、嘻、咽”。其具体应用例如：“若唾热病，以冷气吹之二七，然后禁之；若唾冷病，以热气呵之二七，然后禁之。”②“吹”与“呵”在人体皮肤上产生的凉、热不同之感是不言而喻的，不管这种方式有没有治疗价值，但其医学意义却是极为明确的。而另一方面，“唾”亦仍然是咒禁之术的重要组成部分，只是添加了施术者先要“受禁”的程式，以乞求神灵的帮助，再将这种“神力”通过“唾”的方式转移到受术对象上。

二、语言的作用

念诵祝咒之文，是咒禁疗法的重要组成部分。对这一行为最常见，但却错误的解释是认为：咒禁疗法为精神疗法之一种。③ 这种解释之所以不能成立，在于它仅仅是看到咒禁之术与心理疗法在形式上均使用语言作为治疗手段，而没有深入研究两者间的本质不同。

现代精神病学之所以使用“语言”等方式进行心理治疗，是因为“有许多病，如神经症各类疾病，社会心理因素是致病因素，它对疾病的发生和发展起重要作用。这类心理因素的去除，又非药物及物理

---

① 朱越利：《道经总论》，辽宁教育出版社，1991年，第9页。

② 孙思邈：《千金翼方》卷二十九《禁经上·禁法大例第四》。

③ 河北医学院：《灵枢经校释》下册，人民卫生出版社，1982年，第313页。又如刘伯骥《中国医学史》说：“此等巫医，除使用药物外，并根据灵魂学、心理学为人治病，故其祷祝、念咒、歌唱或舞蹈，云替病者驱邪逐魔，照现代术语言，不过是一种催眠术与心理治疗而已。”（台湾华冈出版部，1974年，第1页）。近有袁玮《中国古代祝由疗法初探》（《自然科学史研究》，1992年第1期，第48页）亦从“心理疗法”的角度肯定祝由疗法的科学价值。

治疗所能奏效，必须借助于心理治疗。心理治疗系利用医生的言语影响患者的精神活动，使患者认识到发病原因、临床表现和疾病的过程。指导患者发挥主动性，去除病因和病后的焦虑，树立战胜疾病的信心，促使患者身心健康，达到治疗的目的”①。咒禁之术中虽然有“语言”行为，但其与心理疗法的本质性不同在于：

1. 咒语的对象并不是患者本身，而是能够接受语言讯息的对象，例如动物、鬼怪、神灵等；

2. 咒语的作用方式不是要影响患者的精神活动，亦不考虑任何“社会心理因素”，而是要求神赐力、威慑受禁对象，达到“禁”的目的（治疗疾病仅是其中的一部分）；

3. 咒术作为一种治疗方法，其适用的范围不仅不限定在精神疾患的范围，而且主要是针对各种躯体疾患。

因此可以断言：咒禁之术，特别是“语言”在其中的作用，是不含任何现代医学所言“心理治疗”成分的。

在纠正了所谓“科学评价”咒术的心理治疗价值后，还必须纠正另一种同样是未经深入研究，即简单地评说咒术为宗教迷信欺骗手段的看法：“巫术认为，神授的语句具有法力，这些语句据说只有巫觋才听得懂，才能使用。”②事实上，祝咒之文全部是由意思极为明确的普通语言组成，不仅任何人都能看懂听懂，且还可以习而用之。在施术者与受术者，甚至是整个社会都承认神灵、鬼怪存在的社会里，运用语言进行沟通乃是十分自然的事，并不存在“欺骗”与“被骗”。因此，分析咒术语言的意义在于弄清当时的人是如何看待世界、认识事物的，而不在于评说其是非对错。如前所述，由于语言的使用必须是

---

① 沈渔邨主编：《精神病学》，人民卫生出版社，1990 年第 2 版，第 195 页。

② 朱越利：《道经总论》，第 21 页。

以能够理解者为对象，因此语言本身并不是一种力，而只是一种讯息。咒语除了字面上所表述的那些威慑之意外，值得研究与注意的还有这些语言文字中所包含的“机”。有关“机”的概念及其按中国古代思想史中的地位，李志超先生曾有专文论述①，认为“机”发展成抽象概念“导致古人对讯息和控制的了解，首先阐发了意识和语言作为机的作用”。在咒禁疗法中，这种控制作用是通过“名”来实现的。董仲舒在《春秋繁露·深察名号》中说：“名者，大理之首章也。……其即几(机)通于天地矣。”在咒术语言中，即包含有这种概念的应用，如马王堆帛书《杂疗方》所记载的咒语即是十分典型的例证：“即不幸为蜮虫蛇蜂射者，祝，唾之三，以其射者名名之，曰：某，汝弟兄五人，某索知名，而处水者为鲂，而处土者为蛫，栖木者为蜂，瘥斯，蛰而之荆南者为蜮。而晋□未□，尔教为宗孙。某贼，尔不使某之病已，且复□。”②这条咒语因后半部缺字致使断句有些困难，且意思亦有难明之处，但其中要表达施术者知道为害者之名的意思却极为明确。有时，施术者说不出为害者姓名，则只能推诿有神灵知道：“六丁六甲，知鬼姓名。”③明确解释此种咒术语言作用的是晋代葛洪：“但知其物名，则不能为害也。”故入山林遇邪物或夜闻人音声大语，“知而呼之，即不敢犯人也”；“见之，皆以名呼之，即不敢为害也”④。不需附加威胁语言，但呼其名即可实现“禁”之目的的方法，虽然源远流长，但作为道教代表人物与古代杰出思想家的葛洪之所以要将这种方法视为原则，显然是借咒术之法阐发“语言”、“名”为“机”的“玄理”。诚如李

---

① 李志超：《机发论——有为的科学观》，《自然科学史研究》，1990 年第 1 期，第 1 页。

② 《马王堆汉墓帛书四》，第 128 页。

③ 孙思邈：《千金翼方》卷二十九《禁经上·禁温疫时行第七·禁疫鬼文》。

④ 葛洪：《抱朴子·内篇·登涉》。

志超之文在论述“机发论”、道教科学观时所说:“这一点非常重要,是研究中国传统文化、自然观、科学思想史等不可忽视的东西。”

三、力量的转移

在医疗方法中,各种内服、外用药,按摩,针灸等皆是以某种作用力施加于患病之躯的方式来实现治疗目的。咒禁疗法作为古代医学的一部分,亦同样是在竭尽全力、想方设法利用一切“可被利用的力”去实现治疗的目的。两者的区别仅仅在于,只有当选择的“外力”是客观存在的“自然之力”,并确实能够作用于对象物体时,才能形成医学的技艺;如果选择的“外力”或转移的途径为虚幻时,即形成巫术的治疗方法。

例如“取艾叶拭手,使汁受手中。七日勿洗手,持斋过七日以外,即成禁。……咒:‘愿我此手一切痈肿,一切诸毒,乃至一切病,手着即差。’……若治病时作想此手作热铁叉,想前人病如雪,手着病即散”①。虽然“艾”确实是一种药物,并广泛用于外治法,但上述治疗方法的“转移途径”不能确实有效地将这种外力转移到物体上,故不能成立。咒禁疗法的力量转移有时需要借助他物,如“候初电时举目看电,右手把刀以左手摩之,咒曰:‘助我行禁,振声如雷吼,万毒伏闭气。’待雷声尽讫”②。又如:“候燕初来时,以纸一张,浓点笔于纸上,望燕与点,燕没乃止。”③此后,这刀、纸等物即成为具有神力的治疗用具。

由于文化的发展,虚幻的神灵越来越多,力量越来越大,所以咒

---

① 孙思邈:《千金翼方》卷二十九《禁经上·受禁肿法》。
② 孙思邈:《千金翼方》卷二十九《禁经上·受禁法第二·同力受禁法》。
③ 孙思邈:《千金翼方》卷二十九《禁经上·受禁法第三·受禁疟法》。

禁疗法的施术者这时才逐渐转变成为“神力”与“疾病”间的媒介(但不是传达天意的 medium),他们的语言对象主要是能够理解语言的神灵,而不再是致病物。“弟子某乙愿持禁法,禁断邪恶鬼毒之气,救理人民,伏愿降真气流布臣身,令臣所行符禁应声除差,应手除愈。”①施术者以包括语言在内的种种方式“借到”神力之后,通过刀、水、唾等方式转移到受术对象之上,实现治疗目的。因此在这种情况之下,咒禁之术的治疗范围可以无限地扩大,不必限界在“能够接受语言讯息”的范围之内了。

三、咒禁疗法与宗教

一般认为,西周时期医与巫的分化,是中国传统医学发展之路上的一个重要转折点。② 就《周礼》所记载的医学分科、司马迁对“信巫不信医”之人的批判,以及医学经典《素问》对于“祝由”疗法的评价看,似乎自此开始,传统医学似乎确已走上了基本是沿自然科学轨迹发展之路,而咒禁之术则渐趋衰退,只不过是残存民间而已。然而如前所述,自隋代开始,医学体系的构成中重又出现了咒禁之术,直到明代,在医学分科中,咒禁之术均有其独占的一席之地。这一现象并不意味着医学发展的倒退,其原因与东汉以后佛教传入、道教兴起之文化背景作用于医学有较大关系。

有关佛教传入、道教兴起,以及儒释道三教之间如何相互借鉴吸

---

① 孙思邈:《千金翼方》卷二十九《禁经上·受禁法第二·七星受咒法》。

② 杜石然等:《中国科学技术史稿》,科学出版社,1982 年,第 78 页。

收与排斥诋毁，不是此处需要讨论的问题，需要说明的是，由于任何一种宗教都是在吸收该地区、该民族固有文化要素的基础上形成的，因此有关咒禁之术与佛教、道教间关系的考察，不过是研究这几个体系间的相互影响渗透而已，并非是从哲学与文化史的立场出发去探讨“巫术—宗教”间的起承转合。

先说道教。道教作为中国土生土长的宗教，在其发展过程中，从神仙方术、民间方术中吸收了不少东西。例如有人追溯道教徒广泛使用的符，以为其“出现最迟不能晚于桓帝元嘉元年(151 年)”①，实际上马王堆帛书中已有所表现：“以下汤敦符灰，即□□病者，沐浴为蛊者。”②符的使用，来源于人们将镇慑鬼怪之物的使用逐渐抽象化，例如相传东海度朔山有大桃树，其下有“神荼”、“郁櫑”二神，能食百鬼③，故民间有桃茢、桃梗、桃汤、桃人、桃板等一系列桃木制品的应用，逐渐演化为画二神于桃木板的“桃符”。以至画于普通纸上，但仍具有其内容与意义的“年画”。但画“符”之法，确实是在道教中得到了极大的发挥④，这是众所周知的事情。至六朝时期的医方著作中，已能见到较多的“书禁”治病法，如治疗小儿惊啼：“书脐下作贵字，大吉”⑤；治妇人乳中热毒肿：“朱砂书乳上作鱼字，良”⑥，等等。其后，宋代太医局的医学分科竟然不再称“咒禁”，而是改作“书禁科”，这恐怕与“宋代

---

① 吴荣曾：《镇墓文中所见到的东汉道巫关系》，《文物》，1981 年第 3 期，第 56 页。

② 《马王堆汉墓帛书四》，第 73 页。

③ 王充《论衡·订鬼》谓其源出《山海经》，但今本《山海经》无此文。

④ 例如东汉张角即长于“符水咒说以疗病”，见《后汉书·皇甫嵩传》。又，葛洪《抱朴子》中亦记载了不少画符之法。

⑤ 马继兴主编：《敦煌古医籍考释·单药方》，江西科学技术出版社，1988 年，第 193 页。

⑥ 马继兴主编：《敦煌古医籍考释·不知名方第九种》，第 272 页。

茅山宗变成以符箓为主，统治者重视的也是符箓派道士，与唐代相比都发生了很大变化”①的社会背景是紧密关联的。

其次，道教在理论体系上继承了先秦道家虚静、无为的思想，李约瑟以儒家贵阳、道家贵阴来概括其特点。② 这种咒禁之术本身并不需要的哲学思想，亦在唐代咒禁理论中有所体现：“《神仙经》曰：阳道坚强而易歇，阴道微软而久长。圣人闭口，万物可藏。……众人游戏，而我独住；众人浩浩，而我独静；众人言说，而我独嘿，此行禁之道毕矣。”③因而唐代的咒禁之法已不似马王堆医书那样简单，学习咒禁法的人需遵守五戒、十善、八忌、四归等戒律；“七日之中，闭口不共人语，乃可受之”；“诵禁文比不得出声，令自耳闻声，若闻之咒，即禁法不行”④。

在力量来源方面，唐代的咒禁之术既不像马王堆医书那样主要是依靠唾、喷的内在力量和语言的恐吓，亦不同于葛洪那充满哲学味道的“以炁禁之”、“但知其名，即不能为害”之论，而是乞求一切神灵赋予施术者力量。枚举几条《禁经》所载咒语中的神灵之名为例：

持禁斋戒法第一：万神扶助，禁法乃行。

受禁法第二：上启三师、神童、玉女、天医、卢医、一切诸师、太上老君、诸仙神王、日月五星、二十八宿、北斗、三台诸神仙官属大神王。

都受禁文：东方木禁、南方火禁、西方金禁、北方水禁、中央

---

① 朱越利：《道经总论》，第95页。

② 李约瑟：《中国科学技术史》第二卷《科学思想史》，第33页。

③ 孙思邈：《千金翼方》卷二十九《禁经上·受禁法第二》。

④ 以上分见孙思邈《千金翼方》卷二十九《禁经上》中的《持禁斋戒法第一》、《受禁法第二》、《禁法大例第四》。

土禁、天师、东王公、西王母。

三月三日受法：江河四渎一切水官、四海大龙正。

太白仙人受法：五方五帝、五方禁师、五方吞精啖毒夜叉神王。

天帝太一受禁法：青龙、白虎、朱雀、玄武、北斗七星、东治大禁师、万石赵侯骠骑大将军、苏平南公、八部将军、七十二禁师、陈师、赵师、直符小吏、直日童子、护直今日。

仅仅通过这些神灵之名即不难看出道教对于咒禁疗法的影响与渗入。

然而不管咒禁之术如何受到宗教的影响，其本质始终不能改变，仍然是建立在“伪科学”指导下的“伪技艺”体系。因为咒禁疗法虽然在一定的发展时期中，较原始阶段更多地承认了神灵的存在，但任何咒禁之术都是要役使神灵为施术者的目的服务，而不是秉承神灵的意愿行事。此乃巫术与宗教的本质区别。

再谈佛教。在敦煌古医籍残卷中，可以见到佛教医学咒禁法的流传。例如难产之时：“又方，有咒法：南无干施婆，天使我广说此咒偈……”①然而这种域外咒禁方法的传入，对于中国传统巫术体系并不重要，至多不过是斗米之中再增几粒的关系。值得注意的是佛教医学中数学“七”的运用：“七七遍咒于晨朝时”，“捣取七遍”，“日咒七遍，乃至七日”②。同样，中国传统的咒禁疗法中亦能看到“七”的广泛应用，如“七日之中闭口不共人语”，“七日勿洗手”，“七日斋戒”，“每七遍，一遍盐水漱口，三七遍成一禁”③，等等，不胜枚举。比较中、印医学体系中数字“七”的运用有两点不同：其一，印度医学运用数字“七”的范围比中国医学广，例如服药剂量：“服七丸……渐加至

---

① 马继兴主编：《敦煌古医籍考释·不知名方第十种》，第288页。

② 马继兴主编：《敦煌古医籍考释·佛家方第一种》，第491页。

③ 均见孙思邈：《千金翼方·禁经上》。

二七丸……可至三七丸。原出《僧深方》”①,眼疾之时“洗目至七日”②,等等。而在中国医学里,唯有咒禁疗法才见强调“七”。其二,中国的咒禁之术(包括医疗及其他各种目的)虽然广泛应用与强调数字“七”,但没有自身的文化背景。不仅在天文、数学中见不到“七”有什么特殊意义,而且可以说在中国的神秘数字信仰(或称之为数术)体系中,一、二、三、四、五、六、八、九,皆有其特定意义,唯独“七”是例外。③ 因而很难设想咒禁疗法能够脱离中国固有的传统文化,无本无源、无根无据地频繁使用“七”。但在印度、波斯、巴比伦、亚述、埃及等地则不同,“七”确实是极为神秘的数字,被用作象征上帝的数字。④ 研究世界医学的学者已然注意到神秘数字“七”可以作为考察各种古代医学理论体系间相互影响的一条线索,例如:“古代东方文化对希波克拉底医学的巨大影响可以从《论数字“七”之书》(*The Book on the Number Seven*)中看到”⑤;“东方美索不达米亚的影响再次被‘人才成熟经过两个七年期’的理论所证明(按,指亚里士多德的《生理学》)”⑥。信奉“七”这个数字的魔力,确实可以追溯到几千年以前的美索不达米亚文明,而且与医学和巫术均有极为密切的关系。他们将一位神圣的疾病魔术师——水神“亚”(Ea)称之为“七”,被医生们当作祖先来奉供⑦。如果考虑到中国咒禁之术中神秘数字“七”

---

① 马继兴主编:《敦煌古医籍考释·唐人选方第一种》,第 152 页。

② 马继兴主编:《敦煌古医籍考释·佛家方第一种》,第 491 页。

③ 冯承钧在其所著《摩尼教流行中国考·译序》中说:“又考吾国之数字,以三、五之用为多,如三纲五常、三光五行之类是也。七数为用较少,惟西域之人常用之,如七死、七生、七难、七宝、七音是也。”(商务印书馆,1937 年,第 1 页)

④ 杨希枚:《论神秘数字七十二》,台湾大学《考古人类学刊》,1974 年第 35～36 期,第 12～45 页。

⑤ 文兹梅尔:《世界医学五千年史》,马伯英译,人民卫生出版社,1985 年,第 35 页。

⑥ 同上书,第 41 页。

⑦ 同上书,第 7 页。

与外来文化的影响有些联系的话，则必须注意到这种影响并不是在东汉以后伴随佛教一同传入，因为在马王堆医书的咒禁疗法中已然能够看到“七”的充分表现。巴比伦对于中国文化的影响可能有两条途径，即通过波斯—印度入中国，或从波斯直接进入中国。说到这里，讨论的内容已然超出了咒术本身，涉及到巴比伦与中国古代文化交流的问题。正像其他许多学科不可避免地要遇到这一问题，但又不宜轻下结论一样，咒术中的神秘数字“七”，也只能是作为一个问题被提出，以资专题研究者一并考虑。需要说明的是，即或咒禁之术中的神秘数字“七”被认定含有外来文化的影响，这也不带有任何文化起源“一元论”的色彩。“交流”与“独创”，谁也不能独揽秋色。

循环与对立

——阴阳家的“意”

阴阳学说是中国古代先哲思维活动中最富哲学味道的理论构想，著名的科学史家李约瑟称此为“古代中国人能够构想的最终原理”①。几乎所有研究古代文化思想、哲学、科学史的学者都承认，阴阳学说对于中国传统医学的发展具有极为重要的促进作用，并在古代医学领域中获得了充分的运用与一定的发展。然而先秦以“阴阳”之名立身的“阴阳家学”与医学理论中之“阴阳学说”是否一致呢？以下所述，可谓对此的略说。其要在于，阴阳家学渗入医学后，使得医学理论出现了一个由秉承阴阳家学之主旨——以阴阳消息、循环言说顺逆常变，到强调阴阳对立、平衡的转变。所谓阴阳学说自身的发展与进步，也恰是在这个过程中逐步实现的。

一、阴阳家及其学说旨要

阴阳与五行、气等学说相互结合，构成了中国古代的哲学思想体系，这些观念也是中国传统科学思想的基本要素。有关这些观念的

---

① 李约瑟：《中国科学技术史》第二卷《科学思想史》，第254页。

起源、发展及具体运用，历来就是研究中国古代哲学史、思想史、科学史者所关注的焦点。阴阳与五行，在早期各自为说，因而在研究早期文化思想时必须分而论之。就对医学发展的影响而言，阴阳学说要早于五行说。在先秦遗存的医学史料中，几乎看不到五行学说的深刻影响，而阴阳之说在解释疾病生成、人体生理等方面则已得到某种程度的运用。

以“阴阳”为说，起源甚早。① 汉人总结先秦学术之源流，称其为“阴阳家”：

> 阴阳家者流，盖出于羲和之官，敬顺昊天，历象日月星辰，敬授民时，此其所长也。及拘者为之，则牵于禁忌，泥于小数，舍人事而任鬼神。②

其中谈到“阴阳家”之学的两种表现形式，似乎等同于天文历法，没有任何哲学色彩。这是由于阴阳学说的哲学含义并非形成于一日；而且当其具有了一定的哲学含义时，也往往是隐含在天人关系的论说之中。然而阴阳学说中虽然包含有天文星历等内容，但这只是表面现象，其目的并不在观象、授时、制历，而是要通过这些现象来说明阴阳变化的规律以及顺乎阴阳的重要：“四时、八位、十二度、二十四节各有教令，顺之者昌，逆之者不死则亡。”由于阴阳观念最初即建立在阳光之有无、向日或背日这些直接作用于人类感官之上的自然变化，因此“四时”的变化受到了格外的强调：“序四时之大顺，不可失也。”所谓四时之序，即春生、夏荣、秋收、冬藏，阴阳家强调这是“天道之大经也，弗顺则无以为天下纲纪”③。这一原则不仅适用于天地间有生

---

① 如《后汉书·方术传》云：“若夫阴阳推步之学，往往见于坟记矣。”

② 《汉书·艺文志》。

③ 以上均见《史记·太史公自序》。

之物“生、长、化、收、藏”的自然变化和人为的农牧生产活动，而且被模拟于政治、人事。这就是阴阳家学的基本内容。需要注意的是，力倡顺应“四时”、“阴阳”变化之序的阴阳家之学，其思维模式的要点在于阴阳交替、轮转的循环，而不在对立。其阴阳消长的实质，不是此消彼长，而是阴、阳各自在一定时限内的自身消长。即春夏为“阳生至盛极”的阶段；秋冬为“阴生至盛极”的阶段。在这两个阶段中，阴或阳分别经历了由初生到盛极而衰的过程：“阳至而阴，阴至而阳”；“因阴阳之恒，顺天地之常”①。《吕氏春秋》中以“圜道”为题，列举了日夜一周；月躔二十八宿；精行四时；物动则萌—生—长—大—成—衰—杀—藏；云气西行，水泉东流，日夜不休，上不竭，下不满等现象来说明“天地车轮，终而复始，极则复反”的循环规律。与阴阳家顺应四时阴阳的思维方式乃属一脉。因此，在“气”分阴阳，阴阳又复分太、少（太阴、太阳、少阴、少阳），分属四时的理论体系中，所要强调的并不是一分为二、阴阳对立。

如果舍弃四时、昼夜循环轮转的时间因素，那么阴阳相互对立的属性就自然而然地显露出来了。例如山南、水北为阳，山北、水南为阴；日为阳，月为阴；昼为阳、夜为阴；天为阳、地为阴，乃至男女、水火、风雨、雌雄等，无不视为对立之两面。具有哲学内涵的阴阳学说正是沿着这样一种思维方式逐渐发展起来。这种观念对于医学理论发展的影响，在早期远不如讲究顺应“四时之序”的阴阳家学大，但逐渐成为主流——在医学理论中的作用，远大于“四时之序”的阴阳循环观念。如此，大致可以看清阴阳、五行两种学说在先秦与两汉时期出现过一个有趣的变化：阴阳家学原本以循环观念为主，而当阴阳对立的属性逐渐受到重视与阐发后，其循环的思想反不太受重视，往往被研

---

① 《国语·越语下》。

究者所忽略；而五行学说因相生、相克之说的盛行，反而被看成是循环观念的典型表现，忽略了五行原本才是分“类”、定“性”的最初表现形式。

关于阴阳观念的发展，还有一点需加注意：即早期的阴阳概念并不是万物属性的抽象，而是专指阴阳二气。在周宣王即位时（约西元前 827 年），已有了“阳气”的提法；到西周末年，伯阳父以阳气与阴气的运动解释地震的成因，为众所周知（见《国语·周语上》）。《吕氏春秋·古乐》云：“昔古朱襄氏之治天下也，多风而阳气畜积，万物散解，果实不成，故士达作为五弦琴，以来阴气，以定群生。”视“乐”可通天地间的阴阳之气，这是古今对音乐理解不同的重要区别。《国语·周语》论乐甚详，与此相似：“如是而铸之金，磨之石，系之丝木，越之匏竹，节之鼓而行之，以遂八风。于是乎气无滞阴，亦无散阳，阴阳序次，风雨时至，嘉生繁祉，人民和利，物备而乐成，上下不罢，故曰乐正。”声音的传导，被认为是与天地间的阴阳之气直接相通，并能产生影响。有形的阴阳之气发生偏盛，也是疾病发生的原因之一。《左传》昭公元年载医和云：“天有六气，降生五味，发为五色，征为五声，淫生六疾。六气曰阴、阳、风、雨、晦、明也。分为四时，序为五节，过则为灾。阴淫寒疾，阳淫热疾”云云。即是说阴、阳之气的过盛（淫）则致病。但是在以后的思维发展中，阴、阳几乎成为一对抽象的概念，不一定要寻其形质了。

二、医学中阴阳循环、对立的不同表现

“四时之序”模拟于政事，形成了《礼记·月令》中所规定的种种相关制度，这是阴阳家学的典型表现。四时之序紊乱，则必发疾疫，“月令”类著作中多有记述，如：孟春之月“行秋令，则其民大疫”；季

夏之月“行春令，国多风咳”；仲冬之月“行春令，民多疥疠”，等等。看起来很像是有关自然界气候异常与发病规律的描述与认识，但实际上所云“行某令”皆是指王政人事而言。因此不论是阴阳家学，还是先秦道家思想，虽然其中蕴含有许多哲学性的思想要素，但其本质皆是政治论的社会哲学。大约在秦汉时期，这些思想要素才逐渐发展成为宇宙论哲学。① 而在这个过程中，一些被现代人称之为自然科学的知识体系，显然不是完全被动地接受当时社会中普遍知晓的思想观念、理论学说，而是积极地创造、发展宇宙论式的哲学。从而推动了整个社会文化思想的进步。就医学领域而言，可以清楚地看到从秉承阴阳家“四时之序”旨意到注重阴阳对立、平衡观念的演进。

在今本《黄帝内经》中，对于顺应“四时之序”的重要性，有许多详细的说明：

> 夫四时阴阳者，万物之根本也。所以圣人春夏养阳、秋冬养阴，以从其根，故与万物沉浮于生长之门。逆其根，则伐其本、坏其真矣。故阴阳四时者，万物之终始也，死生之本也。逆之则灾害生，从之则苛疾不起，是谓得道。（《素问·四气调神大论》）

> 春者，天气始开，地气始泄，冻解冰释，水行经通，故人气在脉。夏者，经满气溢，入孙络受血，皮肤充实。长夏者，经络皆盛，内溢肌中。秋者，天气始收，腠理闭塞，皮肤引急。冬者盖藏，血气在中，内着骨髓，通于五脏。是故邪气者，常随四时之气血而入客也，至其变化，不可为度。（《素问·四时刺逆从论》）

---

① 李泽厚：《中国古代思想史论》，人民出版社，1985年，第314页。

受四时之序、阴阳轮转观念的影响，在针刺疗法、诊脉之法中形成了“四时脉法”和以“四时”为理论依据的针刺方法。如果对于早期的阴阳家学没有一定的了解，则颇难理解这些诊断、治疗方法的立意。例如后世的脉学理论将“浮脉”（取之有馀，按之不足）作为病在“表”的征象，而在今本《黄帝内经》中却是作为春季的正常脉象；后世的针灸学根据疾病的症状决定深刺或浅刺，而在当时却主张依季节而定，等等。① 后世的中医学基本扬弃了这类内容，仅仅在养生学方面继承了春生、夏长、秋收、冬藏的思想。

至于阴阳家学“使人拘而多畏”，“牵于禁忌，泥于小数”之弊，当然在医学领域中也有所体现，例如：

> 正月、二月，天气始方，地气始发，人气在肝；三月、四月，天气正方，地气定发，人气在脾；五月、六月，天气盛，地气高，人气在头；七月、八月，阴气始杀，人气在肺；九月、十月，阴气始冰，地气始闭，人气在心；十一月、十二月，冰复，地气合，人气在肾。

相应地，在针刺方法上自然就会有所规定：

> 春夏秋冬，各有所刺，法其所在。春刺夏分，脉乱气微，入淫骨髓，病不能愈，令人不嗜食，又且少气；春刺秋分，筋挛逆气，环为咳嗽，病不愈，令人时惊，又且哭；春刺冬分，邪气著藏，令人胀，病不愈，又且欲言语。（《素问·诊要经终论》）

以下还有夏、秋、冬三季的详述，略而不赘。这些规律在针灸治疗学中并无实际意义，因其本质乃属虚构的规律。注家不识阴阳家学，强释之曰：“这一节申述了违反治疗法度，如春刺夏分、夏刺秋分等，不

---

① 廖育群：《汉以前脉法发展演变之源流》，《中华医史杂志》，1990 年第 4 期；《秦汉之际针灸疗法理论的建立》，《自然科学史研究》，1991 年第 3 期。

应刺而刺之，非但原来的病没有治愈，反使病势更加深入或恶化了。所以治病必须及于病所，不可太过或不及，恰如分际，是临床上最宜注意的事。”①实际上只要结合上一段不同月份“人气所在”的论述，即不难看出“牵于禁忌”的本质。

在今本《黄帝内经》中，阴阳学说的运用逐渐发展成为一种强调对立、平衡的抽象概念。这种阴阳学说实质上已大不同于上述的阴阳家学。在阴阳的概念中既包含有以阴阳二气的融合构成宇宙万物之本体的一面，亦有注重阴阳不同属性特征之“象”学的一面。前者在医学理论中表现为对于生命形成、禀赋厚薄、情志形体特征等的解说；后者则可具体地指导诊断与治疗——阴阳的辨识是“辨证施治”的核心。这类论述在今本《黄帝内经》表现得相当充分，其最高度的概括是：

> 阴阳者，天地之道也，万物之纲纪，变化之父母，生杀之本始，神明之府也。……阴静阳躁，阳生阴长，阳杀阴藏。阳化气，阴成形。寒极生热，热极生寒。寒气生浊，热气生清。
>
> 水为阴，火为阳。阳为气，阴为味。……味厚者为阴，薄为阴之阳；气厚者为阳，薄为阳之阴。……气味辛甘发散为阳，酸苦涌泄为阴。（《素问·阴阳应象大论》）

这样的阴阳学说，其重点已然不再是循环的观念，而是二者的对立属性；其中的两分之法亦不再是特指“四时之序”（时间概念），而是将这种“以量定性”的方法移植到了与药物理论有关的“气”、“味”学说中。总之，阴阳既是最高度的抽象与概括，又以“数之可十，推之可百”以致用，因而成为医学基础理论中最重要的组成部分。

---

① 南京中医学院医经教研组编著：《黄帝内经素问译释》，上海科学技术出版社，1959年，第113页。

三、医学中的特例：三阴三阳

阴阳之说在古代医学领域中有一种特殊的表现形式，即三分阴阳而成太阴、少阴、厥阴和太阳、少阳、阳明。这六个名词在医学中是极为重要的概念术语：经脉学说的主体即是以此为名——手、足各有三阴、三阳之脉，合为“十二正经”；《素问·热论》在论述外感热病时，亦是以此为名——外感病的进程被划分为太阳、少阳、阳明（在表），太阴、少阴、厥阴（在里）六个阶段。东汉的重要医学著作《伤寒杂病论》即以此为纲，发挥而成，故后人称此为“六经辨证”体系。

三分阴阳，较二分阴阳而成太、少，多出“阳明”与“厥阴”两个名称。而这种分法在中国传统文化的其他领域中基本上是看不到的。所以大约早在汉代就已经有人开始对这一问题予以探讨，《素问·阴阳离合论》开篇的设问即是：“今三阴三阳，不应阴阳，其故何也？”回答则是：“阴阳者，数之可十，推之可百；数之可千，推之可万；万之大，不可胜数，然其要一也。”似乎不属明确的对答，其后则是有关十二经脉的解说。赵洪钧在其自刊本《内经时代》[①]中对以上问题的回答是：“岐伯的答话不讲经脉分布处皆是搪塞，直讲经脉则答非所问。张景岳之医理可谓精深，岂知他也不能正面回答这一问题。《类经·会通类》‘阴阳五行’中抄下这段话，没作任何说明。接着照抄大量经文，毫无心得。《类经附翼·医易义》大讲《易》理，仍说不清三阴三阳。看来回答这个问题实在不容易。”而赵氏认为：“比较可靠的原

① 赵洪钧：《内经时代》（自刊本），石家庄红旗印刷厂，1985年。

始三阴三阳说，就是三男三女说。”即《易》传《说卦》中所言：

乾，天也，故称呼父。坤，地也，故称呼母。震一索而得男，故谓之长男。巽一索而得女，故谓之长女。坎再索而得男，故谓之中男。离再索而得女，故谓之中女。艮三索而得男，故谓之少男。兑三索而得女，故谓之少女。

按照赵氏的解释，是在《易》学中先产生了三阴三阳的概念，再被医学理论所吸收。但在《易》学发展的漫长历史中，除了要解说八卦的形成是由“乾坤生六子”外，基本上没有三阴三阳的内容。对中国传统医学颇有研究的日人丹波元简论“三阴三阳”时说：

太少阴阳，原是四时之称。……而后世说《易》者，专用此论蓍策之数矣。以阳明、厥阴，合称三阴三阳者，医家之言也。（《医剩》卷上）

正因“三阴三阳”为医家之言，故历来研究阴阳学说的哲学家、史学家极少谈到这一问题。即或是在传统医学领域内部，亦大多是只能言“三阴三阳”之用，却避而不谈其缘由。

在西晋王叔和所著《脉经》中，保存有若干先秦医家论脉的内容，其中有两处涉及到三阴三阳，是现今所知最早的史料。

扁鹊曰：脉一出一入曰平，再出一入少阴，三出一入太阴，四出一入厥阴；再入一出少阳，三入一出阳明，四入一出太阳。脉出者为阳，入者为阴。

脉平旦曰太阳，日中曰阳明，晡时曰少阳；黄昏曰少阴，夜半曰太阴，鸡鸣曰厥阴，是三阴三阳时也。少阳之脉，乍小乍大，乍长乍短，动摇六分，王十一月甲子夜半，正月二月甲子王……动摇至六分以上，病头痛、胁下满，呕可治，扰即死。刺两季胁端，

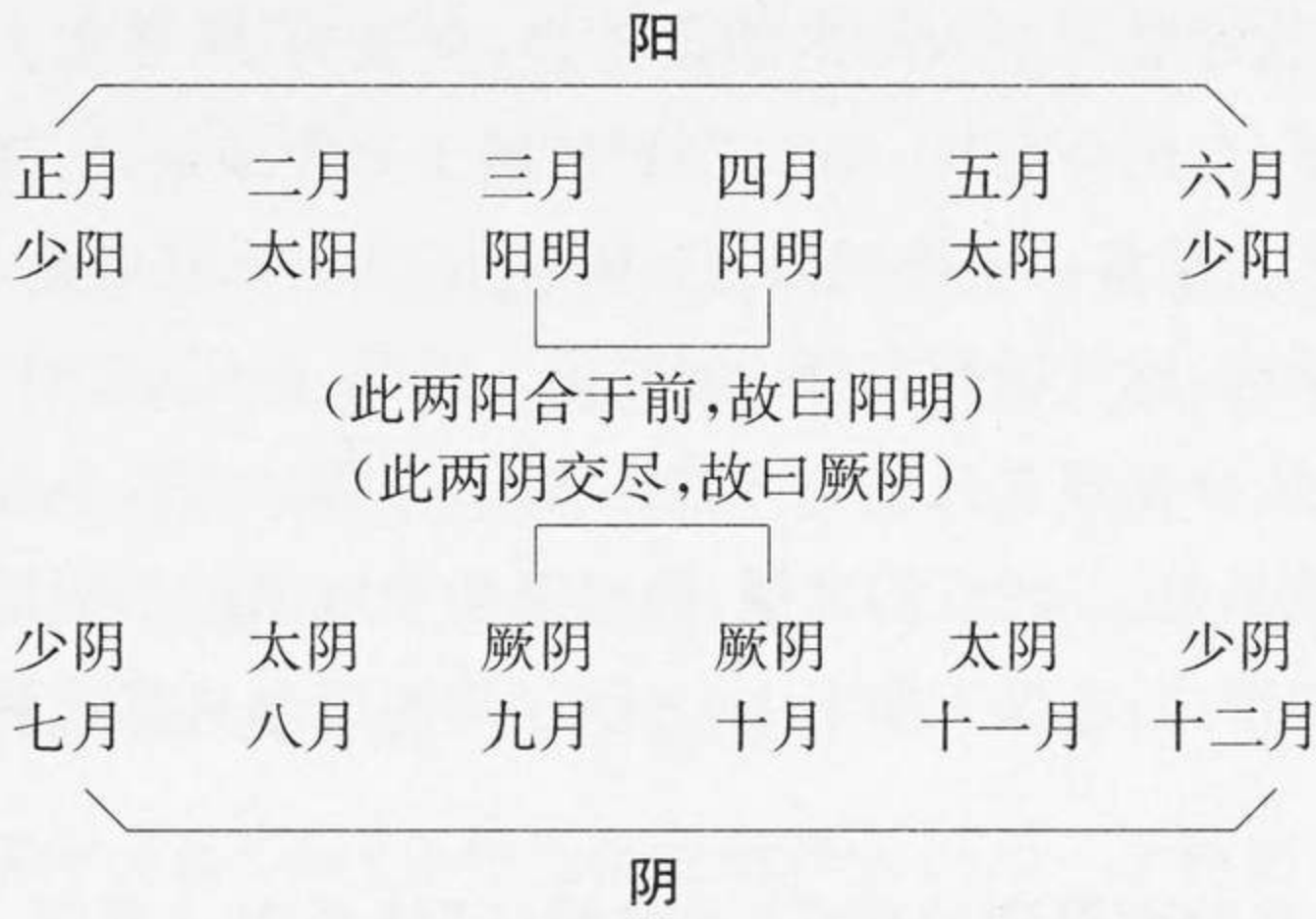
足少阳也，入七分。

其他五脉亦有如上引少阳之脉的叙述，从略。《脉经》中保存的扁鹊脉法，亦见于《素问》、《灵枢》、《难经》这三部汉代医学著作中，但无扁鹊之名。对这一现象只能认为是王叔和编撰《脉经》时仍能见到扁鹊著作之遗存（《汉书·艺文志》著录有《扁鹊内经》、《扁鹊外经》等），而这些著作的内容亦被收入今本《黄帝内经》。因为王叔和是不可能倒行逆施节录今本《黄帝内经》的内容，而冠以扁鹊之名的。从这些内容中不难看出，在先秦时期诊脉与经脉紧密相关，是一同发展起来的。而三阴三阳的概念既用于诊脉法中阴阳盛衰的定量表示，又是经脉的名称，而且有将一昼夜划分为六段的时间表示法等。

《灵枢·阴阳系日月》讲述经脉，足部为三阴、三阳，双侧合十二条经脉；手部则只有二阴、三阳，双侧合十条经脉，没有手厥阴之脉。而这与马王堆汉墓出土医书中的经脉记载相合，说明是早期经脉学说的延续。其解释为："腰以上为天，腰以下为地，故天为阳，地为阴。故足之十二经脉，以应十二月；手之十指，以应十日，日主火，故在上者为阳。"对手足经脉的定名及厥阴、阳明的含义均有解释：

寅者，正月之生阳也，主左足之少阳；未者，六月，主右足之少阳。卯者，二月，主左足之太阳；午者，五月，主右足之太阳。辰者，三月，主左足之阳明；巳者，四月，主右足之阳明。此两阳合于前，故曰阳明。申者，七月之生阴也，主右足之少阴；丑者，十二月，主左足之少阴。酉者，八月，主右足之太阴；子者，十一月，主左足之太阴。戌者，九月，主右足之厥阴；亥者，十月，主左足之厥阴，此两阴交尽，故曰厥阴。

将其中月份与三阴三阳之配合的内容摘出，即成下图，阴阳循环，由弱到强再到弱的变化规律即可一目了然。



有意思的是，紧接其下的又是类似《素问·阴阳离合论》的问题：“今乃以甲为左手之少阳，不合于数，何也？”“此天地之阴阳也，非四时五行之以次行也。且夫阴阳者，有名而无形，故数之可十，离之可百；数之可千，推之可万，此之谓也。”说明了三阴三阳配经脉的独特用法，与四时阴阳、《易》学体系等不可强合。由于今本《黄帝内经》属医学论著之汇编，对一些理论性问题的看法与解释不可能一致，因而对于三阴三阳的理解亦有仁智所见之不同。例如《素问·脉解》中三阴三阳与十二月的配合就是另一种方式，属阴阳相间，没有阴阳各司半载的意思。这或许亦可说是阴阳学说从阴阳家学式的循环模式逐渐向阴阳平衡观转移的一种表现形式。当然，在后一种配合方式中，亦未脱循环的观念。

许多研究者看到中国古代医籍中有气血运行、如环无端、周流全身等语，就误以为这是几千年前有关血液循环的发现，其实不然。事实上，中国古代从未想到过“君主之官”——心，会昼夜不停地跳动；而且将伸手可触的心前区搏动解释为“胃之大络”的跳动。所以有关气血运行、环流全身的构想，乃是以肺为源头：十二经脉起始于肺；人一呼脉行三寸，一吸脉行三寸。气血的运行，乃是沿着十二经脉的

次序，按每次呼吸行进六寸的速度前进，全长为16.2丈。在这样的思想指导下，自然会有某一时间“脉气”居于某经或某处、当刺或不可刺之说。无论是将一昼夜划分为三阴三阳“六时”，还是配合十二月，均与经脉学说、脉气循行有着一定联系。因此，前引《素问》的问答对话中，以经脉分布回答三阴三阳的问题，不应视为“答非所问”，而是正解。也就是说，三阴三阳之说，确属医学领域中运用阴阳理论的一种特殊表现形式；在汉人学术中，三阴三阳的概念只能追溯到经脉学说体系。

另外，在前面提到的热病“六经辨证”体系中，《素问·热论》尚不具备以阴阳观念来区别病症的思想。其中，各个阶段的病症都是阳性体征，都是热病。三阴三阳只是指“表里”而言，依“一曰太阳、二曰阳明、三曰少阳、四曰太阴、五曰少阴、六曰厥阴”之序由表向里（从阳到阴）逐渐发展；从七日至十二日，经过再一次的循环，各经病症逐渐消除。而到了《伤寒杂病论》中，虽然承袭了所谓“六经”的体系，但三阴病症全部转为虚寒的阴性体征，由此构成了阴阳辨证的思想体系，所谓“实则太阳，虚则少阴”；“实则阳明，虚则太阴”等。这是阴阳循环向阴阳对立转变的又一典型表现。足见中国传统医学基础理论体系中最为重要的阴阳观，并不是在早期经典中就已经完成了。三阴三阳说，似乎也具有从循环发足，最终转到以对立、平衡为重的特点。

四、医学与易学

“不知《易》，不足以言大医。”语出明代医学大家张景岳，并说这

是唐代名医孙思邈之垂训。然检之孙氏原作，其中有关医者当知《易》的原话却是这样的：

> 凡欲为大医，必须谙《素问》、《甲乙》、《黄帝针经》、《明堂流注》、十二经脉、三部九候、五脏六腑、表里孔穴、本草药对，张仲景、王叔和、阮河南、范东阳、张苗、靳邵等诸部经方；又须妙解阴阳禄命、诸家相法；及灼龟五兆、周易六壬，并须精熟，如此乃得为大医。（《千金要方·大医习业》）

在孙氏原话中，《易》不过是作为医家博学多识的一个侧面，并未与医家著作、医学理论相提并论。而且在孙氏的著作中亦实看不到医学与《易》有何联系。大体说来，在宋代以前的医学著作中，均很少提到《易》。特别是在《素问》、《灵枢》、《伤寒杂病论》等划时代的医学代表作中，根本看不到《易》的影响，更找不出基础理论中有什么内容是直接来源于《易》。

如果翻看一下古代的医学著作，其中涉及《易》的内容基本都属借卦象为喻。如《左传》昭公元年载晋平公请医和诊疾，谓其病为“蛊”。有人问：“何谓蛊？”医和对曰：“淫溺惑乱之所生也。于文，皿虫为蛊；谷之飞亦为蛊；在《周易》，女惑男、风落山谓之蛊。”但即便是这样的比喻，在宋代以前的医学文献中也是极为鲜见的，自宋代开始才略见增多。例如以卦象比喻人之器官：

> 观卦者（䷓），视之理也。视者目之用也。目之上纲则眨，下纲则不眨，故观卦上巽而下坤。颐卦者（䷚），养之理也。养者口之用也，口之下颌则嚼，上颌则不嚼，故颐卦上艮而下震。①

又如喻药理者：

---

① 张从正：《儒门事亲》卷二，上海科学技术出版社，1959年，第63页。

荷叶之物中央空，象震卦(☳)之体。震者，动也，人感之生足少阳。①

但也有非借卦象，不足以意会其理的妙用。例如由黄连与肉桂组成的著名方剂“交泰丸”最初并无方名，只是作为黄连这味苦寒药的配伍使用而出现，但这一寒一热两种药物的配合，却使人们想到了黄连所“清”是在上之“心火”，肉桂所“温”是在下之“元阳”，如此逆转上阳下阴、上火下水的“否塞”之象，犹如“否”(䷋，上天下地，即上阳下阴之象)至“泰”(䷊)的转变，故被名之曰“交泰丸”②。

后人之所以会认为原本为卜筮之书的《易》与医学理论具有密不可分的渊源关系，这主要是因为《易》被视为阴阳学说的源头。其中最早的，且广为人知的，大概要数《庄子·天下》所说：“《易》以道阴阳。”其后，人们大多是在将爻的画法“—”、“--”解释成阴阳之代表的基础上，不断地阐发从阴阳两爻到八卦图形，以至六十四卦图形中所“隐含”的阴阳变化。然而注重文化发展演变过程的研究者早已指出：《易》本无阴阳观念，“《易》以道阴阳”是战国时思想。③ 那么《易》又何以会有如此变化呢？这是因为在易学的发展过程中，《易经》的本来面目变得越来越模糊，越来越成为一种供思想家发挥个人学说的工具。《易经》与那些同属儒家经典的著作相比，后者内容与形式的统一规定了解说的发展不可能随意发挥；而前者却有内容与形式

---

① 李杲：《兰室秘藏》卷上，人民卫生出版社，1957年，第12页。

② 韩愁《韩氏医通》云：“火分之病，黄连为主……生用为君，佐官桂少许，煎百沸，入蜜，空心服，能使心肾交于顷刻。”(江苏科学技术出版社，1985年，第22页)

③ 谢松龄：《天人象：阴阳五行学说史导论》，山东文艺出版社，1989年，第26～27页。又，胡维佳《阴阳、五行、气观念的形成及其意义——先秦科学思想体系试探》一文在讨论“阴阳观念起源”时亦列举了大量论据及前人的相同看法。文载《自然科学史研究》，1993年第1期。

可以相互分离、多途发展的特点。义理，是《易》的内容；象数，是《易》的形式，故说《易》者尽可各执一端。正如《汉书·方术传》所说“仲尼称《易》有君子之道四焉”，即《易·系辞》所言：“以言者尚其辞，以动者尚其变，以制器者尚其象，以卜筮者尚其占。”

因此可以说：“易学的发展史，是《易经》的形式与内容割裂分离的历史，也是它不断走向形式化和抽象化的历史”；“而取向于事物矛盾关系的卦象说，则开辟了我国古代辩证法思想发展的一条重要途径”①。一般认为，大讲阴阳的《易传》形成于战国中晚期之间，至迟也在战国末期。医学与《易》学，大致均是在这一历史时期接受了阴阳学说，但两者间却无直接的启承关系。最能说明这一点的，是易学体系采用的数字奇偶是“阳奇阴偶”，即：“天一地二、天三地四、天五地六、天七地八、天九地十”②，尤特以九、六为阴阳的代表，凡阳爻皆称为九，阴爻皆称为六。而医学中却是沿着天有六气、地有五行，即“天六地五，数之常也”③的阴阳奇偶关系发展，故有五脏（阴）、六腑（阳），男八、女七，阳脉六、阴脉五等具体表现。古代中医接受易学阳奇阴偶之说者，唯有一例，即认为妇女月经尽后六日内可以受孕成胎，一、三、五日为男，二、四、六日为女。有关此说的较早记载是《医心方》中所引用的《洞玄子》，后世引此说时，多称“道藏经云”，并称道家“戒六日之淫，为此也。过此皆不能成孕”④。此说虽属荒谬，却一直占有统治地位，唐、宋、元、明、清历代医家大多宗此说。张介宾虽然相信“《易》之为书，一言一字，皆藏医学之指南”⑤，但于此处却有

---

① 徐子宏译注：《周易全译·前言》，贵州人民出版社，1991年，第2、6页。
② 《易·系辞上》。
③ 《国语·周语下》。
④ 《墨娥小录·房中秘要·求嗣法》。
⑤ 张介宾：《类经附翼·医易》。

不同见解:“道藏经以一日、三日、五日得者为男等说,总属臆度,渺茫非有确见也,余不敢遵信。”这是因为他知道“有十日半月及二十日之后受胎者”①。总之,历史上研究医、《易》关系最著,力倡医源于《易》之说者虽属张介宾,但归根结底,他所得到的实质性结论亦不过是“欲该医、《易》,理只阴阳”②。《易》只不过是阴阳学说的一个载体而已。

纵观阴阳家、阴阳学说的发展历史及其与医学的关系,大致可以得到这样一种印象:阴阳家学,本是一种以四时阴阳之序言说政事的社会哲学论;先秦时期的辩证思维未必尽寓其中,而是伴随着人类思维的进步十分自然地产生并发展起来的,易学是承载这种理性思维的重要载体。西汉董仲舒融阴阳、五行之说的哲学思辨性于儒家“五常”之中,完成了儒学自身发展的第一步,故虽有罢黜百家之举,但百家之说已入其中。自王莽好符命,光武以图谶兴,《河图》、《洛书》、《七经纬》等书遂盛行于世。这些书籍虽受到孔安国、毛公、贾逵等人之斥责,但如郑玄等经学大师亦为之作注。如果说经学内史研究者留意的是今古文经之争、郑学的兼容性,社会学家关注的是透过经学时看社会集团间的权益之争、地位转变,那么思想史、科学史研究理应重在东汉时期出现的融《易》、太极、两仪、四象、八卦与阴阳、五行之说为一体,辅以数位推演来解释天地生成、政治人伦、万物化生、物理之情的学术风气与思维方法。尽管入学正宗以其为“妖妄,乱中庸之典”,隋炀帝“发使四出,搜天下书籍与谶纬相涉者,皆焚之,自是无复其学”③,但宋明理学之兴,实可看作是这种变化的重演。

---

① 张介宾:《景岳全书》卷三十八、三十九。
② 张介宾:《类经附翼·医易》。
③ 《隋书·经籍志一》。

东汉与宋代两次“异端”之兴，皆包含有探索终极真理、解释万物自然、构筑宇宙发展模式的进步倾向。中国古代哲学的宇宙论、辩证思维即是在这个过程中逐渐发展起来的。然汉、宋相较，区别在于：两汉之学颇重五行，阴阳学说仍带有极强的循环色彩；宋代以后则是以阴阳为纲，纬以五行。周敦颐的太极图将阴阳二气置于五行、万物之上是很典型的例子。就医学而言，汉代大讲阴阳、五行之说，既有承袭阴阳循环观念的一面，亦有注重阴阳对立、平衡的充分表现，是其长处所在。晋唐时期却风尚大变，独重实用。到了宋代，学术风尚又有所变化，医家对于理论的兴趣也随之转浓，汉代医学经典中的阴阳之说才备受青睐，阐发注释越来越多。在这样的环境下，阴阳学说越来越成为理论医学基础的基础，也才出现了谈论医、《易》关系者。然而真正鼓吹“医《易》同源”的，乃是当代之人，随便检阅一下架上之书，即见有：

《中国医易学》，邹学熹，邹成永，四川科学技术出版社，1988年。

《医易会通》，李浚川，萧汉明，人民卫生出版社，1991年。

《周易·传统医学与百病预测》，中国医药科技出版社，1991年。

《生命与八卦——医易启悟》，田合禄，田蔚，山西科学技术出版社，1991年。

《医易汇通》，邹学熹，四川科学技术出版社，1992年。

《中国八卦医学》，刘杰，袁峻，青岛出版社，1995年。

《周易文化与中医学》，孟庆云，福建科学技术出版社，1995年。

《易学与中医》，张其成，中国书店，1999年。

至于说当代何以会有如此之多的“医易”著作问世，张其成先生在一套易学研究丛书的总序中给出了如下解释：中国古代“只有一本书是由符号系统与文字系统共同构成，只有一本书是为儒家与道家共同尊奉的，只有一本书对人文和科学都产生过重大影响，那就是《周易》”。因此，“《周易》是华夏文明的总源头，是中华文化的聚集点”①。

你，以为如何？

---

① 张其成：《易学与中医·总序》。

气血运行

——意构的生命理论框架

“气”、“血”是中国传统医学理论体系中的重要概念。不管“气”、“血”具有何等抽象的、哲学性的含义，从大自然呼吸到的“气体”与存在于脉管中的“血液”毕竟是其本体，是其最基本的所指。

“气”、“血”的运行，始终伴随着生命现象，是生命赖以维系的基础。然而这种与生命现象共存的气血运行究竟是怎样实现的，在基于不同认识途径的传统医学与近代医学中是否有可能存在着相同的认识呢？

一、问题的提出

科学史研究者在中国古典医籍中，似乎找到了许多足以说明古人对呼吸及血液循环机理早已有所认识的证据，因而对此大加褒誉。例如医学史家在评价《黄帝内经》一书的价值时，贾得道氏称：“《内经》对血液循环已有明确肯定的认识”；“对肺的呼吸作用及其与血液循环的关系，似乎已有模糊的认识”①。范行准氏认为，其“血液循环

---

① 贾得道：《中国医学史略》，山西人民出版社，1979 年，第 53 页。

理论也和近代生理相近”①;而俞慎初氏则更加肯定地说:“和现代生理学说无异”②。又如余瀛鳌氏亦认为其中有“体循环和肺循环概况的大致正确的论述”③,等等。国外学者称其为“血液循环系统的第一次提示”,“是颇为惊人的预言”④。当然也有持“皮里春秋”之态度,对此不予评述者⑤,但在总体上基本看不到明确的否定性评价或深入的分析性论述。

这或许是由于呼吸与循环对于当代人来说,实在是最基本的生理常识,因而臆度古人焉能对此无所认知?但在一切详细讨论之前先请注意:在《黄帝内经》乃至其他医学经典中,从未言及过“心跳”这一最基本的生理现象与生命指征!注意到这一点,对客观把握古人有关呼吸、循环生理机制的认识无疑是十分重要的。为要看清中国古代医学的气血循环理论何以是“意构的理论架构”,并不具有与近代西方医学哪怕只是近似的认识,需要先复习一下西方医学以实证科学为基础,逐步完成认识呼吸、循环生理机制的过程,以便与中国传统医学进行比较。

一、对于血液循环的认识

在血液循环发现之前,盖伦(Galen, 129～200)提出潮汐说,认为血液是经同一条道路返回心脏,像潮汐那样涨落不已,这种理论在很长一段时间内一直占统治地位。尽管盖伦对于心血运动的解释并不

---

① 范行准:《中国医学史略》,中医古籍出版社,1986 年,第 28 页。

② 俞慎初:《中国医学简史》,第 35 页。

③ 余瀛鳌:《从两部古典的中医名著看中国医学的早期成就》,载于《中国古代科技成就》,中国青年出版社,1978 年,第 428 页。

④ 文兹梅尔:《世界医学五千年史》,第 16～17 页。

⑤ 例如赵璞珊所著《中国古代医学》,中华书局,1983 年。

正确，但“他在活的动物身上进行实验，由此考察了心脏的作用”，“是古代最值得注意的两个实验之一”①。其后，达文西、维萨留斯通过尸体解剖，对心室中隔存在有小孔提出怀疑与否定；塞尔维特（M. Servetus，1509～1553）与柯伦波（M. R. Colunbus，1516～1559）描述过肺循环；切萨宾诺（A. Cesalpino，1519～1603）对大循环作过推测；1603 年法布里修（Fabricius，ab Aquapendente，1537～1619）又报道了静脉瓣，这些科学成就为哈维（W. Harvey，1578～1657）的发现奠定了基础。1628 年，哈维的《心血运动论》（*Movement of the Heart and Blood*）出版，对于血液的循环过程作出了正确的描述。② 哈维的正确认识不是靠思辨或先验的推理，据他自己说，是根据“反复的活体解剖”③。

二、对于呼吸的认识

在生理学中，呼吸与血液循环是密不可分的，只有弄清气体交换的机制，才有可能揭示肺循环的生理意义。

1617 年，弗拉德（Fludd）把一个玻璃器皿倒立在水面上，在器皿里燃烧一些物体，结果器皿内的空气体积有了一定的缩小，接着火焰就熄灭了。胡克（R. Hooke，1635～1703）等人的研究证明空气中含有一种活跃的成分为燃烧与呼吸所必需，这显然就是现代人所说的氧气。胡克还证明，如果把一股气流不断地吹到肺上，胸壁的运动对于维持生命就不是必要的。洛厄（R. Lower，1631～1691）利用胡克的人工呼吸实验，弄清血液颜色的转变完全是由于血液在肺中与空

---

① 丹皮尔：《科学史及其与哲学和宗教的关系》，第 103～104 页。

② 参见《中国医学百科全书·医学史·心血运动论》，第 252～253 页。

③ 丹皮尔：《科学史及其与哲学和宗教的关系》，第 183 页。

气接触，吸收了一些空气的缘故；马约（J. Mayow）在 1669 年阐明："空气中含有生命所绝对必需的某种成分，这种成分在呼吸时进入血液里去。"然而"这一切健全的研究成果后来被人遗忘了，直到一百年以后方由拉瓦锡重新发现"①。

从上面的简单追述中不难看出，阐明呼吸、循环的生理机制离不开实证的研究方法。而那些"中间环节"的作用尤不可忽视，它们不但是最终达成完整的正确认识的必要基础，而且东西方医学（实质上是"传统医学"与"近代医学"）体系的差异，恰恰是伴随着每一个"中间环节"的出现而逐渐加大的。

现在我们就来看一看没有进行过这类实验性研究的中国古代医学，在呼吸与循环方面的认识究竟是怎样的。

二、中国古代医学不知"心脏跳动"

在中医学的经典著作中涉及心脏功能及其病变的论述颇多，但却没有认识到"心脏跳动"这一生理现象！这或许会令人产生不可思议之感，然而如果我们能够摘掉现代人所具基本生理学常识的"有色眼镜"，忠实地考察古代文献的内容，就会发现这才是历史的本貌。

今本《黄帝内经》中关于心脏功能的典型论述是："心者，君主之官也，神明出焉"；"心者，生之本，神之变也"。虽然一再提到"心主身之血脉"，但这仅仅是建立在五行学说基础之上的一种划分方法，如同"肺主身之皮毛、肝主身之筋膜、脾主身之肌肉、肾主身之骨髓"一

① 丹皮尔：《科学史及其与哲学和宗教的关系》，第 185～186 页。

样，并不具有现代生理学的意义。

对于心脏及其他脏腑疾患的描述，亦同样是根据五行配属关系进行划分的。作为一个实质性的器官，“心痛”是其主要病变之一。严重时可导致“旦发夕死，夕发旦死”①，与现代所说心肌梗塞基本吻合。《灵枢·本藏》对各脏腑的疾病有较详细的描述，有关心脏的一节如下：

> 心小则安，邪弗能伤，易伤以忧；心大，则忧不能伤，易伤于邪。心高则满于肺中，悗而善忘，难开以言；心下则藏外易伤于寒，易恐以言。心坚则藏安守固；心脆则善病消瘅热中。心端正则和利难伤；心偏倾则操持不一，无守司也。

总之，在所有关于心脏功能与疾患的描述中，未见言及“心脏跳动”，亦未涉及“脉律”与“脉率”的问题。

正是由于古人不知心脏跳动这一基本生理现象与生命指征，因而在言及猝死急救时，只知观察“呼吸”和体温。例如著名的先秦医家扁鹊诊虢太子“尸厥”之例，论其病属昏厥的根据是：“子以吾言为不诚，试入诊太子，当闻其耳鸣而鼻张，循其两股以至于阴，当尚温也。”②成书于东汉末年的《伤寒杂病论》救治自缢者时，所注意的生命体征之恢复亦是如此，“一人以手按揉胸上，数动之……如此一顷炊，气从口出，呼吸，眼开”。最著名的检验专著——宋代《洗冤集录》的《救死方》中所依据的生命指征依旧不外呼吸与体温：“若心下温，一日以上犹可救”；“口噤，有微气者”；“但须心头温暖，虽经日亦可救”；或曰“若肉未冷”等。

推测古人未能认识“心脏跳动”的原因可能有二。一是中国古代

---

① 《灵枢·厥病》。

② 《史记·扁鹊仓公列传》，第2788页。

虽然确有基于医学研究目的而进行人体解剖活动的记载①,但这种尸体解剖是观察不到心脏跳动的;其二则是由于“心之官则思”这种对于心脏“官能”的普遍认识,使人不可能想像这个“君主之官”会昼夜无休止地跳动。而只有当险危临身时,才会出现征兆性的“心动”。例如《战国策·赵一》:“襄子如厕,心动,执问途者,则豫让也”;《史记·高祖本纪》:“高祖之东垣,过柏人,赵相贯高等谋弒高祖,高祖心动,因不留”。其中所言“心动”,显然与心跳的节律性运动不是一回事。同样,医家亦认为:“悲哀愁忧则心动,心动则五脏六腑皆摇”,甚至可以见到“心时跳时止”②的看法。

然而人们不禁要问:对于每一个人均伸手可触,甚至于可以肉眼观察到的左胸前的心脏跳动,难道古人就会真的不知道吗?的确,古人知道心前区的跳动现象,但却没有认识到这是心脏在跳动:

> 胃之大络,名曰虚里,贯膈络肺,出于左乳下,其动应衣,脉宗气也。盛喘数绝者,则病在中;结而横,有积矣;绝不至曰死。乳之下,其动应衣,宗气泄也。③

尽管知道其重要性——“绝不至”者预示着死亡即将来临,并将其称之为“脉宗气”,但其理论构想却是设想生命动力的来源在于胃——在于胃靠消化吸收功能获得了力。所以位于“左乳下”、“其动应衣”的心尖搏动,才会被解释成“胃之大络”的跳动。而这对于不知道心脏有条不紊的跳动是由自律神经所控制着的古人来说,难道不是十分自然的,甚至可以说是一种“合理的”理论性解释吗?

---

① 《汉书·王莽传》,中华书局,1962年,第4145~4146页。
② 龚廷贤:《云林神彀》卷二《怔忡》。
③ 《素问·平人气象论》。

三、以胃为中心的循环体系

在中国古代医学的理论体系中，虽然没有认识到以心脏为动力来源的血液循环系统，但这并不等于说没有气血循环的思想。否则也就不致引发如是之多有关中国古代早已认识到血液回圈的论说了，所以需要弄清的只不过是中国古代医学有关气血运行之理论构想的本来面目究竟是怎样的。

在中国古代文化与医学中，心脏“君主之官”的地位，实际上只能用于解释人类的精神活动，而气血生成与运行等生理活动的中心是“胃”：

五藏者，皆禀气于胃，胃者五藏之本也。①

人以水谷为本，故人绝水谷则死，脉无胃气亦死。②

人之所受气者，谷也。谷之所注者，胃也。胃者，水谷气血之海也。胃之所出气血者，经隧也。③

谷始入于胃，其精微者，先出于胃之两焦，以溉五藏，别出两行，营卫之道。④

正是基于这种胃为气血之源头的生理学认识，因而构筑起以胃为中心的经脉循环体系：气血的运行起始于手太阴肺之脉，而手太

---

① 《素问·玉机真藏论》。
② 《素问·平人气象论》。
③ 《灵枢·玉版》。
④ 《灵枢·五味》。

阴肺的经脉并非起始于肺，而是始于胃肠所在的“中焦”。经过五脏六腑十二经脉相互衔接所构成的循环圈后，复归之于肺。① 十二经脉的走行，在现存最早的医学著作，即 1973 年湖南马王堆西汉墓出土的帛书《阴阳十一脉灸经》和《足臂十一脉灸经》中，原本是各自独立、互不相连的。至《灵枢·经脉》中，虽然有关各经脉走行的描述较马王堆帛书有所发展，但经脉的主干仍是各自独立的，其相互联系是靠“支脉”完成的。如足厥阴肝经的循行是从足至头，而其与肺脉的衔接是通过“其支者，复从肝别贯膈，上注肺”实现的。

有关“经络”是否属于客观真实存在的一种生命现象，不是此处所要讨论的问题。然而即便承认经脉学说中的某些内容，是对迄今尚未弄清其实质的一种生命现象的客观描述，那么仍旧可以设想：其中构成各脏腑相互联系的“支脉”，显然是为了构筑这个可以解释人体气血运行的循环圈而加入的。

误将中医所说“经脉流行不止，环周不休”解释为现代医学所说的血液循环者，大多是由于没有深入考察两种医学体系不同的理论构造模式，盲目推断：“在大体解剖上已了解到心脏与脉管相通，血液是循环不息并受到心脏支配的。”②而没有考虑到就“大体解剖”之所见而言，实际上可谓人体无处不与脉管相通，并非仅是心脏；而且这也不足以使人认识到血液循环是由心脏支配的。《灵枢·动输》有关足背动脉为何会跳动的解释，清楚地表明了这一点：“足之阳明，何因而动？岐伯曰：胃气上注于肺……此胃气别走于阳明者也。”因而虽然在五行配属上为“心主血脉”，但在实际的病理学解释上常可见到

---

① 《灵枢·经脉》对于十二经脉走行的描述是：第一条经脉是“肺手太阴之脉，起于中焦，下络大肠，还循胃口，上膈属肺，从肺系横出腋下……”；最后一条足厥阴肝经的终止是“其支者，复从肝别贯膈，上注肺”。

② 韦以宗：《中国骨科技术史》，上海科学技术出版社，1983 年，第 23 页。

脉与胃的密切关联:“胃不实则诸脉虚”;“胃中空则宗脉虚”,等等。

这种以胃为中心的循环,在中医学中被概括为“营”、“卫”两气的运行。即:

> 人受气于谷,谷入于胃,以传与肺,五藏六府皆以受气。其清者为营,浊者为卫。营在脉中,卫在脉外,营周不休,五十而复大会。①

有关“营气”运行的解释较为明确,其源头始自胃,然后传之于肺,依十二经手足、阴阳相互配属的关系依次运行。但在到达最后一条经脉“足厥阴肝经”后,没有像《灵枢·经脉》所构造的那样——通过“支脉”与肺相接,而是构造了另一种循环模式:即通过任脉与督脉形成总数为十四条经脉的“循环圈”(图 1)。

图 1 营气周流次序示意

“卫气”虽然亦产生于胃,但属“水谷之悍气也,其气慓疾滑利,不能入于脉也,故循皮肤之中,分肉之间,熏于肓膜,散于胸腹”②。有

---

① 《灵枢·营卫生会》。

② 《素问·痹论》。

关其循行的描述较为混乱，概括地讲是“一日一夜五十周于身，昼日行于阳二十五周，夜行于阴二十五周，周于五脏”①。因其与血液循环关系不大，故可略而不论。

四、动脉—脉动

中医经典称跳动之脉为“动脉”。如《素问·三部九候论》称：“上部天，两额之动脉；上部地，两颊之动脉；上部人，耳前之动脉。”《难经·一难》云：“十二经皆有动脉。”等等。按说这与近代医学所言“动脉”是一致的，但实际上两者在使用“动脉”一词时，唯有这样一点点相同，涉及到其概念、定义时则是完全不同的。

首先，在中医学里，“脉”是一个十分模糊的概念，可见的血管与不可见的经络现象均被称之为脉。这种混淆是由于古代中医学不具备对整个脉管系形态的认识。② 因而“动脉”一词就不可能具有与“静脉”相对应的概念含义。例如，将刺络时“血出而射”（刺中小动脉）释为“血气俱盛而阴气多”；将“血少黑而浊”（刺中小静脉）释为“阳气蓄积，久留而不泻”③。

在没有认识到心脏跳动引起脉搏跳动的前提下，从属于各经脉的“动脉”跳动被认为是各自独立的。这一观念在“三部九候”的诊脉方法中，体现得最为明确。

---

① 《灵枢·卫气行》。

② 廖育群：《古代解剖知识在中医理论建立中的地位与作用》，文载《自然科学史研究》，1987，(3)：244～250。

③ 《灵枢·血络论》。

所谓“三部九候”,即在人的头、手、足三部各取动脉三处进行诊察,通过比较这九处的脉象变化以推断疾病位置的诊脉方法(见下页表 1)。如果这九处的脉象基本一致,则说明“阴阳匀平”,身体健康。即所谓“九候若一,命曰平人”①。倘若阴阳失衡,罹疾患病时,上下左右的脉动就会出现变化,故“察九候独小者病,独大者病,独疾者病,独迟者病,独热者病,独寒者病,独陷下者病”②。所谓“独疾”或“独迟”,即是说某一处的脉快于或慢于其他处的脉。

“三部九候”脉法具有较强的数术色彩③,其所选择的各处动脉并不与经脉学说相吻合。例如为要满足“三三为九”的数字需要,不得不在只有心肺的“中部”添入一个“胸中之气”以凑足“三”。但这种诊脉法所依据的诊断标准——“参伍不调者病;三部九候皆相失者死;上下左右之脉相应如参春者,病甚”④等,却可追溯到马王堆出土医书的《足臂十一脉灸经》⑤。蔡景峰氏将“脉如参春”释为严重心脏病时出现的“三联音奔马律”,即每一次心跳分裂成三个声音,似不准确。其原因正如蔡氏文章中所谈到的:“这种声音只能应用耳朵听才能感觉出来”;19 世纪西方医学报告这一症状,“是结合用听诊器及近代的科学仪器进行检查的”。但蔡氏又说:“古人虽然还没有发明听筒,但可用耳直接贴紧病人胸壁去倾听心脏跳动的声音。”⑥这种

---

① 《素问·调经论》。

② 《素问·三部九候论》。

③ 廖育群:《汉以前脉法发展演变之源流》,文载《中华医史杂志》,1990,(4):193~199。

④ 《素问·三部九候论》。

⑤ 《足臂十一脉灸经》曰:“揗脉如三人参春者,不过三日死。”见《马王堆汉墓帛书四》,文物出版社,1985 年,第 5 页。

⑥ 蔡景峰:《中国医学史上的世界记录·异常脉律的记载》,湖南科学技术出版社,1983 年,第 10~20 页。

推测从技术的角度讲，似乎距离“揣脉”的一般方法太远；从心理的角度讲，似乎过于“科学”——重又蹈入古人已知心脏跳动与脉搏关系的虚设前提条件。

表1 三部九候法

三部	九候	脉位	主候
上	天 地 人	两额之动脉 两颊之动脉 耳前之动脉	头角之气 口齿之气 耳目之气
中	天 地 人	手太阴 手阳明 手少阴	肺 胸中之气 心
下	天 地 人	足厥阴 足少阴 足太阴	肝 肾 脾胃

正是因为中国古代医学没有认识到心脏与脉搏跳动的直接关系，所以不可能意识到全身的脉搏跳动必然是一致的。故而常常可见言说某一处脉率改变的诊断意义，如：“诊右脉沉而紧，左脉浮而迟”①；或见古医书载诊脉法云：“左右齐诊，而脉动应于医之手。左右动数不齐者，死之兆也”②。这种将脉搏跳动孤立化的态度，在明代李时珍之后竟然发展到将寸口脉（手桡侧动脉）的寸、关、尺三部亦区分出迟（慢）、数（快）的脉率不同！

李时珍《濒湖脉学》称：“寸迟必是上焦寒，关主中寒痛不堪，尺是肾虚腰脚重”；“寸数咽喉口舌疮，当关胃火并肝火，尺属滋阴降火

① 《素问·病能论》。

② 丹波元简：《医剩·左右齐诊》，人民卫生出版社，1955年，第52页。

汤”。李中梓《诊家正眼》效法其说:“寸迟上寒,关迟中寒,尺迟火衰”;“寸数喘咳,关数胃热,尺为相火”;“右数火亢,左数阴戕”。并对脉率改变的促、结、代脉亦加以如是区别。其他如李梴《医学入门》、徐春甫《古今医统》、张介宾《景岳全书》等均可见此类论述。

凡上所述,说明中国传统医学视“动脉”为与心跳毫无关联的现象,其着眼点在于“脉动”本身。因而自马王堆帛书《阴阳十一脉灸经》开始,即在描述每一经脉走向之后,均有“是动则病”某某病的记述;该墓出土的另一部医学著作《脉法》及江陵张家山汉墓出土的《脉书》均言:“它脉静,此独动,则生病。夫脉固有动者,骭之少阴,臂之巨阴、少阴,是主动,疾则病。此所以论有过之脉也。”或如《黄帝内经》所言:“脉之卒然动者,皆邪气居之”;“阳明者常动,巨阳、少阳不动,不动而动大疾,此其候也。”而当诊脉方法从“分经候脉法”(即分别诊察各经脉循行部位上出现的脉动)过渡到“独取寸口”(只诊手桡侧动脉一处)后,对于脉率与脉律的改变亦从未言及与心动的关系,而只是根据数术观念言说其与五脏病变的关系。即“五十动而不一代者,五藏皆受气。四十动一代者,一藏无气。三十动一代者,二藏无气。二十动一代者,三藏无气。十动一代者,四藏无气。不满十动一代者,五藏无气”①。这是对脉律异常的解释。另外在《难经》和《脉经》中对脉率从“一呼三至”到“一呼六至”的加快,以及从“一呼一至”到“四呼一至”的减慢亦均有较长的论述,脉率低于正常者,称之为“损”脉,与五脏的配属关系是:“一损损于皮毛(肺),二损损于血脉(心),三损损于肌肉(脾),四损损于筋(肝),五损损于骨(肾)。”②

---

① 《灵枢·根结》。

② 《难经·十四难》。

五、对于呼吸的认识

呼吸心跳的不同在于，这一现象是如此明确地关联到躯体的表面，乃至毫无疑义地会被每一个正常的人所感知，并十分容易地即可了解到呼吸与生命的必然联系。然而要想正确地解释呼吸生理，则必须对肺循环及气体交换有所认识。否则就不可能设想呼吸过程仅仅是在肺部完成的。如果气体仅仅是被吸入肺中，随即呼出，呼吸的意义又何在呢？对于中国古代医学来说，其认识水平恰恰是处于这样一个缺乏认识呼吸机理所需基础知识的层面上，那么他们对与生共存的呼吸现象又是如何解释的呢？

《灵枢·五味》说："五藏六府皆禀气于胃，……其大气之精而不行者，积于胸中，命曰气海，出于肺，循咽喉，故呼则出，吸则入。"使人感觉到其对呼吸的理解是气从肺呼出，但气体的循环路径似乎是：

气 → 入胃 → "精而不行者" → 积于胸中

入胃 → （通过经脉）至五脏六腑后 → 出于肺 → 循喉咙而出

另外在《素问·经脉别论》中有这样一段颇值得研究的话：

> 食气入胃，散精于肝，淫气于筋；食气入胃，浊气归心，淫精于脉，脉气流经，经气归于肺，肺朝百脉，输于皮毛。毛脉合精，行气于府，府精神明，留于四藏，气归于权衡，权衡以平，气口成寸，以决死生。

几乎所有的注释均将此段文字说成是"食物"入胃的消化吸收过程。但在整个《黄帝内经》中，凡言及消化吸收时，一般均称"谷入

于胃”①,且自然要涉及到血的生成,而在此段文字中不仅根本没有涉及到血的生成,而且先后九次提到“气”字。显然,将“食气”二字释为“食物”是不妥的。“食”字用作动词为“吃”或“受纳”之义。其实,将吸入气体称之为“食气”已明确地见于马王堆汉墓出土帛书《十问》之中;《淮南子·墬(地)形训》与《论衡·道虚篇》称养生家行呼吸吐纳之术亦为“食气”。如果这个解释能够成立,则不仅可以看作是当时对呼吸生理的解释,从而领悟到诸如前引“胃者,水谷气血之海。胃之所出气血者,经隧也”等许多经文的含义,而且还能有助于理解当时所行随呼吸进出针之补泻方法的立意。即呼吸之气沿人身经脉运行而遍布全身,故“候呼引针,呼尽乃去。大气皆出,故命曰泻”;反之“候吸引针,气不得出”,并要用左手按压针孔“推阖其门,令神气存,大气留止,故命曰补”。

至《难经》成书时,对于气体在体内的循环提出了新的构想:“呼出心与肺,吸入肾与肝,呼吸之间,脾受谷味也。”对于具有一定科学知识的现代人来说,恐怕很难理解古人这种说法的意思,然而前人的注释却十分有助于弄明白古人是如何思考的。

三国时代的吕广注释说:

> 心肺在膈上,主内,脏中之阳,故呼其气出;肾肝在膈下,脏中之阴,故吸其气入。

宋代丁德用释曰:

> 肾肝在膈下,主内,因呼而出至心、至肺,故呼出心与肺也。
>
> 又,心肺者在膈上,主外,故吸即随阴而入至胃、至肝。

---

① 如《灵枢·经脉》言:“谷入于胃,脉道以通,血气乃行”;《口问》言:“谷入于胃,上注于肺”;《营卫生会》言:“谷入于胃……其清者为营,浊者为卫”等。

《难经·十一难》在解释“脉不满五十动而一止,一脏无气”时,再次重复了同样的观点:

> 今吸不能至肾,至肝而还,故知一脏无气者,肾气先尽也。

《难经》还构想了一个“生气之原”,即人体三维空间的中点。称:

> 十二经脉者,皆系于生气之原。所谓生气之原者谓十二经之根本也,谓肾间动气也,此五脏六腑之本,十二经脉之根,呼吸之门。

无论是“生气之原”还是“肾间动气”,这些概念在今人看来无疑均十分抽象,难免使人觉得中医理论虚幻、玄妙、难解,但其源起与本意却或许极为简单与直观——源于对腹主动脉搏动的感知。因为《难经·十六难》在言说五脏的“内证”时,同样谈到了脐周有“动气”,“按之牢若痛”,无疑是触摸到了腹主动脉的跳动。这样,《难经》就为呼吸与十二经脉气血运行找到了一个脱离了胃的消化吸收之能、肺的橐籥(风箱)之功,而是与先天之本(脐)紧密联系的原动力。

在成书于隋唐时期的《诸病源候论》中,还能看到另一种与呼吸有关的理论构想。此书虽然亦同样是秉承气循环于脏腑、经络之间的基本思想,但认为其起始的源头在肺:“五脏皆禀气于肺”①,且如果在循环脏腑之后再回到肺,即会引起一系列的肺部疾患:

> 久咳逆候:肺极虚故。肺既极虚,气还乘之。
>
> 咳逆上气候:肺虚,咳而气还聚于肺。
>
> 久咳逆上气候:虚则邪乘之,气逆奔上也。
>
> 咳逆上气呕吐候:五脏皆禀气于肺,寒搏于气,气聚还肺。

---

① 与前引《素问·玉机真藏论》言“五脏者,皆禀气于胃”的说法不同。但应注意:禀于胃的气,应是饮食精微之气;禀于肺的气,应是源于自然界的空气。

咳逆短气候：嗽则气还于肺间，则肺胀。

从这些有关肺的病因、病理解释中不难看出：其中所说的“肺”，无疑是实实在在的器官；其中所说的“虚”，乃是实实在在能够容纳气体的空间；其中所说的“气”，就是实实在在的气体。肺与气，都不是什么抽象的功能；虚，也不是看不见、摸不着的功能衰退。尽管书中没有说明不应返还于肺的气，究竟应该从何处呼出，但不是从肺呼出这一点却是十分明确的。

实际上，将肺视为“橐籥”（风箱）——推动气血运行的原动力，亦是古人早已有之的一种理论构想。《灵枢·五十营》说：“一呼脉再动，气行三寸；一吸脉亦再动，气行三寸。（一昼夜）一万三千五百息，气行五十营于身……凡行八百一十丈也。”这显然是将呼吸运动释为脉搏跳动、气血行进的力量来源。其后，《伤寒论·平脉法》中亦谈到：“呼吸者，脉之头也。”宋代陈言则称：“凡诊脉，须先识脉、息两字。脉者血也，息者气也。脉不自动，为气使然。”记录宋代名人苏东坡与沈括医学言论的《苏沈良方》则明确无疑地道明了肺的“橐籥”功能和气体循环于五脏的看法：“喉则下通五脏，为出入息。五脏之含气呼吸，正如冶家鼓鞴。”①

六、讨　论

没有必要的实验性研究，是不能对呼吸生理、血液循环产生正确认识的。如果我们没有忘记中国古代还有源于五行说的“五德终

① 《苏沈良方》，人民卫生出版社，1956年影印版，第15页。

始”、运行于天地之间的“五运六气”等形形色色的循环理论，恐怕就不应该将中医学中所构想的人体气、血沿经脉周流不止的“循环”理论与现代生理学所说的血液循环牵强到一起。

在没有必要的生理、生化基础知识的情况下，如何来解释“生命之理”、构建理论性的解释体系呢？从“气血运行”这样一个具体问题的剖析过程中，我们看到古人如何以“意”构想出“以胃为原动力的循环体系”、“以肺为原动力的循环体系”，以及“以身体中点为原动力所在”的理论。实际上这样的例子还有许多许多，可以说传统医学的每一个概念、术语、理论都可以进行如此剖析。也只有经过“历史的”分析，才能弄清这些概念、术语、理论在不同历史时期的不同含义；从而真正理解由这些概念、术语、理论以及治疗技艺构成的传统医学的总体。

总之，通过以上的论说不难看出：实际上，许多在今人看来玄妙难解的医学术语（例如气、血、生气之原、肾间动气等），在其创用伊始乃是以最直观、最现实的客观存在为基础的。以这样一些直观的认识，构建起对于“生命之理”的解释体系——传统医学的基础理论的过程，即是医家用“意”的过程；同时，随着时代的演进，一些原本明确具体的概念，逐渐被赋予新的内涵，成为无法说清其准确意思的概念（例如“虚”），这也是医家用“意”的过程。当西方近代医学传入之后，传统医学阵营中，出现了以近代医学解释传统医学概念与理论——以使其科学化；或是进一步将传统医学的概念、术语抽象化——以此“化解”其与近代医学间的矛盾，这也可以说是近代乃至当代传统医家一种用“意”的过程与表现形式吧。

运气的天空

——高阁中的“意”

古人以为做医生者，当上知天文、下通地理、中傍人事，疗疾治病方能效如桴鼓。对于医家来说，所需掌握的“天文”知识，在早期主要是指一年当中寒来暑往所形成的“春生、夏荣、秋收、冬藏”——即阴阳家学所谓的“四时之序”及其与人体生理、病理的关系①；此外还多少包括一点对于“天命”的了知，即如唐代大医家孙思邈所言：作为医生不但必须熟读各种医学著作，还要“妙解阴阳禄命、诸家相法及灼龟五兆、周易六壬，并须精熟，如此乃得为大医”②。

随着时代演进，在言说一年当中天地间阴阳二气运转形成“四时之序”的基础上，又逐渐出现了一种推而广之到能够根据天地间“五运”与“六气”的规律性运转，推算出六十年一个“甲子周期”中某一年、某一时疾病属性的学说——这就是所谓的“运气学说”。

到了宋代，医学考试每卷均有“运气一道”，要求学生答出题中所言年份的“五运六气所在、所宜，处方为对”③，标志着运气学说已然

---

① 详见《黄帝内经·素问·四气调神大论》，并可参见本书中有关“阴阳学说”的论说。

② 孙思邈：《备急千金要方》卷一《大医习业第一》，人民卫生出版社，1955 年，第 1 页。

③ 何大任：《太医局诸科程文格》，台湾商务印书馆影印《文渊阁四库全书》第 743 册，第 19 页。

成为中医学基础理论的组成部分。对于此时的医家来说，所谓“上知天文”，大概莫过于懂得每年的“运气”。时至今日，也仍会时常听到有人吟咏清代医家张倬在《伤寒兼证析义》一书中所言“谚云：不读五运六气，检遍方书何济？”①来说明懂得每年的“运气所在”对于医家是何等重要之事。

然而相信在耐心阅读了以下的析论之后，一定会发现这个最能体现医家博学多识，或被今人誉为古代气象医学的“运气学说”，竟然完完全全是一个以“意”构建的虚幻图景。

一、运气学说的基本内容

“运气”即“五运六气”之缩略。其基本思想是认为宇宙间存在着木、火、土、金、水“五运”与风、寒、湿、燥、君火、相火“六气”的循环往复运动，主宰着每年疾病的基本性质。

一、五　运

“五运”，是由五行与时间概念结合而成，又因所用时间单位及配合方式的不同而有以下区分：

1. 大运（亦称岁运、中运）：大运即主管一年的岁运，是五运中最重要与最主要的核心内容。每年的大运取决于五行与天干的配合。但在运气学说中，五行与天干的配置与一般所见传统方式不同，即不是东方甲乙—木、南方丙丁—火、中央戊己—土、西方庚辛—金、北方

① 丹波元胤：《中国医籍考》，第1404页。

壬癸一水，而是甲己一土、乙庚一金、丙辛一水、丁壬一木、戊癸一火。凡天干按顺序排列为奇数的，该年所配之运呈“太过”（有馀）之势；偶数的，所配之运呈“不及”（不足）之势（表 1）。

表 1 “大运”的五行、阴阳属性

天　干	甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛	壬	癸
五　运	土	金	水	木	火	土	金	水	木	火
太过(＋)/不及(－)	＋	－	＋	－	＋	－	＋	－	＋	－

2. 主运：五行在一年之中又分主“五时”，叫作主运。依木、火、土、金、水之序，各主 73 日 5 刻①，年年不变。

五行与四时（四季）的配合在较早的时代即已产生，为解决两者间的配合问题，每一季节的最后 18 天被解释成“属土”。这样，五行在一年当中平均各主 72 日。然而这种配合关系无法满足使“四时之序”与五行的生克循环联系在一起的愿望，于是古代的思想家又构造了“五时”之说——在四季中间插入“长夏”一季，用于与土配合。在《黄帝内经·素问·金匮真言论》中可以见到“春胜长夏，长夏胜冬，冬胜夏，夏胜秋，秋胜春”之语；该书《六节藏象论》又有“五运相袭，而皆治之，终期之日，周而复始”之说，表明这种在运气学说中被称之为“主运”的配合，即五行与一年之中各个时段的配合，在运气学说形成之前即已存在。在此基础上，五行从“主时”发展到“主岁”，则脱离了季节特征与五行属性间存在的类同性②，但也因此才形成了运气学说的固有定义——仅仅是根据天干地支的阴阳、五行属性确定某一时段（年、半年、五分之一年、六分之一年）的疾病属性。

---

① 一日百刻，故五运主时相加，计 365.25 日。

② 例如季节之“夏”与五行之“火”皆有“热”的特征。

另一方面，五行主时的顺序虽然年年不变，但其与上述较早时期即已存在的“五时配五行”毕竟有所不同。区别在于运气学说中的“主运”附加了“太少相生”（阴阳相间）的推算法则，即根据当年大运的太过、不及来确定该年主运中每一运的阴阳属性。例如根据表1可知：天干属己的年份，其大运为“土运不及”，所以主运中的土亦属阴；再依据阴阳相间的原则推算出该年五个时段的“运”（主运）依次为：木运不及、火运太过、土运不及、金运太过、水运不及（参见表2）。概言之，主运的基本特征是一方面继承了“五时”配五行的传统；另一方面为了与大运建立联系、为了将“五行”与“阴阳”联系在一起，而增加了“太少相生”的推算法则。

表2　甲、己（土运）之年“主运”的比较

五时	春（73.05日）	夏（73.05日）	长夏（73.05日）	秋（73.05日）	冬（73.05日）
天干为“己”之年：大运为“土运不及”					
主运	木运不及	火运太过	土运不及	金运太过	水运不及
天干为“甲”之年：大运为“土运太过”					
主运	木运太过	火运不及	土运太过	金运不及	水运太过

3. 客运：客运与主运的唯一不同在于每年的初运不确定，而是依大运确定，再依五行相生之序依次推其后各时之运。客运在今本《黄帝内经》所保存的运气论述中并没有明确的说明，据明代医家张景岳说，《天元玉册截法》中有此说，且“行于主运之上，与六气主客之法同”。所以“虽本经未有明言，而运气生化之理，在所必至，当以《天元玉册》为准”①。

① 张介宾：《类经图翼·五运客运图说》，人民卫生出版社，1965年，第47页。

二、六 气

“六气”一词在先秦即已使用，但解释不一。如《庄子·逍遥游》说：“若夫乘天地之正，而御六气之辩”，注家对其中所言“六气”便有种种不同解释①；《左传》昭公元年医和诊疾时说：“天有六气”，指的是“阴、阳、风、雨、晦、明”，与后世医家所言“六气”也没有关系。运气学说中的“六气”大抵是源于对五行配属的风（木）、寒（水）、燥（金）、湿（土）、暑（火）“五气”进行改造——将其中的“暑”（热）变成“君火”与“相火”，则成为包括两个“火”的“六气”。以求能够与十二地支、三阴三阳实现配合，解决五行属性是“二阳三阴”②的问题（表3）。

表3 六气与三阴三阳、地支的配属关系

地支	子午	丑未	寅申	卯酉	辰戌	巳亥
阴阳	少阴	太阴	少阳	阳明	太阳	厥阴
六气	君火	湿	相火	燥	寒	风

主宰一年之“气”的最基本推算方式与推算“大运”相似，即某年地支所配之气。但这种主宰一年的“气”后来却被人完全忽略了，以致连名称也没有。人们注重的乃是分主各“时”的气，且同样有“主气”与“客气”之分。

1. 主气：依木、君火、相火、土、金、水之序排列的“六气”，自大寒节开始各主四个节气，年年不变，故称“主气”。“气”与“时”的这种配属方式在《黄帝内经·素问·六微旨大论》中称之为“地理之应六节

① 郭庆藩：《庄子集释》，中华书局，1961年，第20～21页。

② 《白虎通德论》卷二《五行》。

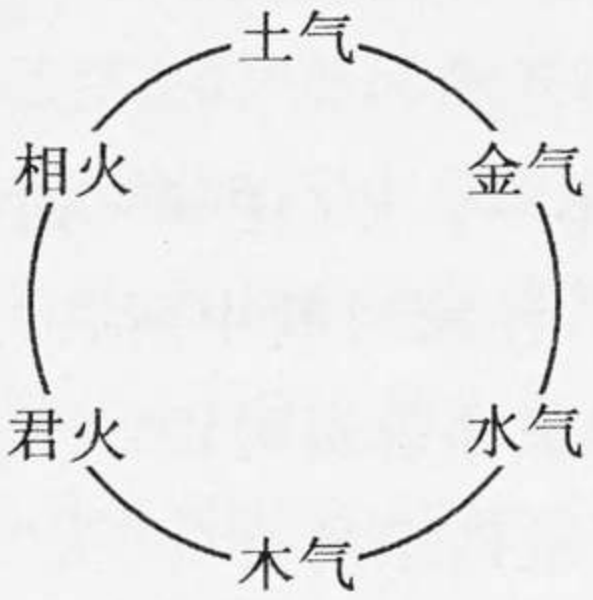


图1 “主气”(地理之应六节气位)示意

气位”,仍然带有极强的五行色彩(图1)。因为只要将君火与相火看作是一项,则其排列顺序、相互关系仍然是五行相生序;且在各气与时的配合方面也与未经改造的配合方式基本一致——即仍旧符合春木、夏火、长夏土、秋金、冬水的顺序。

2. 客气:客气是根据六气与地支的配合决定的,“气”与“时”的配合每年不同,故称“客气”。其具体的推算方式是:将一年分为“六步”,每步60.875日;每步各有一气主之;六气的名称与排列顺序为少阴君火、太阴湿土、少阳相火、阳明燥金、太阳寒水、厥阴风木;每年地支所决定的是“三之气”(即图2中的C位,A为初之气,F为终之气),其配属关系如表3所示。这种配属关系已然不符合五行相生的关系了,其回圈顺序是以三阴三阳说为基础的(图3)。

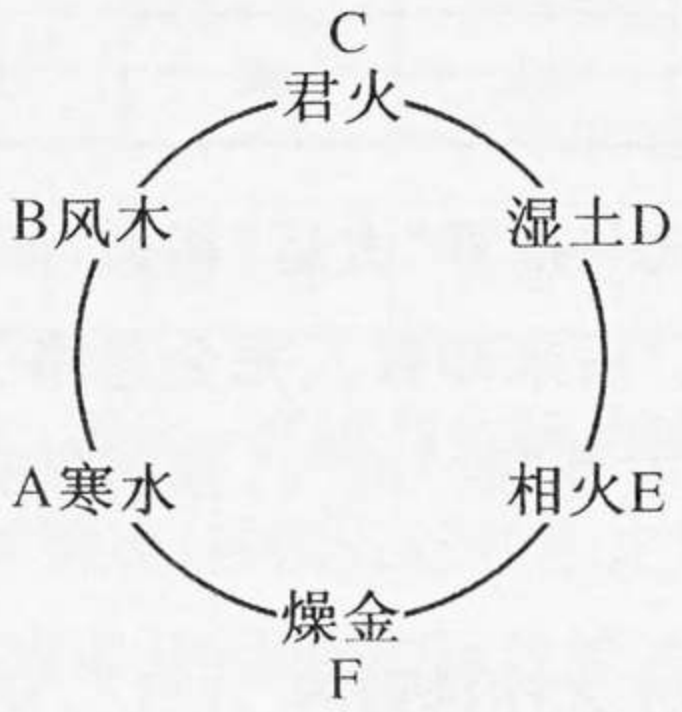


图2 “客气”(天道六六之节)示意
(图中各气的定位在子、午之年)

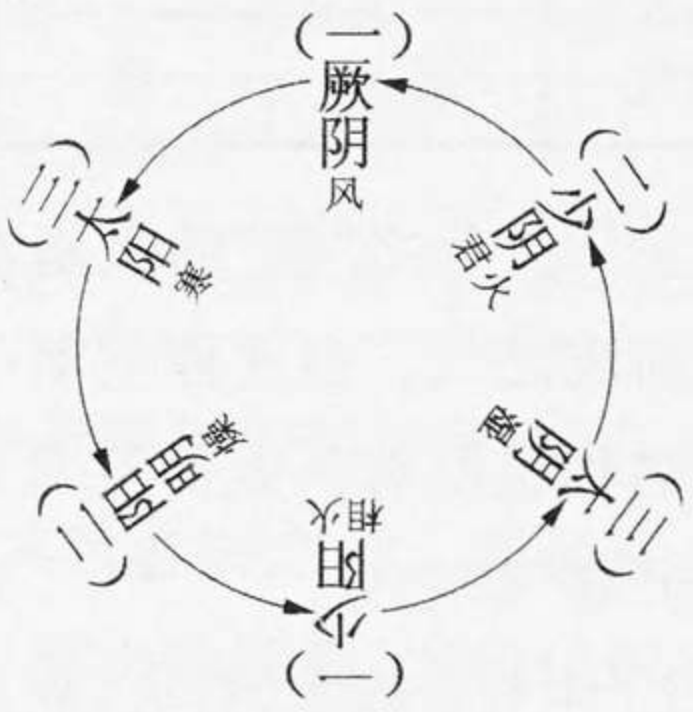


图3 三阴三阳之位

然而必须注意,运气学说作为医学理论,所强调的毕竟是“六气”本身的性质,而不是三阴三阳的位置,因为只有六气本身的性质才能构成病症、病机、治疗方法等相互关系的理论性解释。所以在运气学

说中称六气为本、为六元，而三阴三阳只不过是六气之“标”①，是为“命其位”②而设。尽管如此，图 3 所示“三阴三阳”之位还是为运气学说中六气部分的推衍提供了说理依据。首先，从图中可以看出其阴、阳各居一半，相互平衡；阴、阳各自的排列顺序是一、二、三；阴、阳之间是一阴与一阳相对，二阴与二阳相对，三阴与三阳相对。在运气学说的发展中，这个六气循环圈的用法越来越丰富。规定了顶端（上）为“司天”之位，因而与之相配属的“气”则名之曰“司天之气”；与其相对应，位于最下端的是“在泉”③之位，其气名之为“在泉之气”（参见图 3），而其他各气的位置则均可依三阴三阳的定位推知。

在“运”与“气”的交合中（亦可看作是天干与地支、五行与阴阳的交合），运气学说还规定了一些概念：

1. 天符：当某一年大运（天干）的五行属性，与按“天道六六之节”所规定的地支的五行属性相合时，称之为“天符”。

2. 岁会：当某一年的大运，与按“地理应六节气位”所规定的地支的五行属性相合，且位于“五方”之正位时，称之为“岁会”。

3. 太乙天符：即某一年既是天符，又是岁会。

4. 同天符：当大运“太过”之年与“在泉之气”相合时，称之为“同天符”。

5. 同岁会：当大运“不及”之年与“大泉之气”相合时，称之为“同岁会”。

以上是运气学说中的一些基本概念与推算方法。在此基础上，根据推算所得运、气的属性言说某一年、某一时民众当患何病，当以

---

① 《素问·六微旨大论》。

② 《素问·五运行大论》。

③ 在泉，即“在地”（或在地中）之意。如《白虎通·五行》言：“阴气在黄泉之下，任养万物。”

何药治疗，便是运气学说的实用价值所在。然而这个内容十分复杂、系统化了的运气学说体系，实际上是宋以后人对唐以前各种运、气推算方式进行归纳总结的结果。为要解决不同推算方法间的矛盾，所以才规定了主运、客运、中运、主气、客气等多种名称。当我们以这个体系化了的学说去绳墨唐以前运气的相关史料时，无疑大多都能找到足以比附的内容，于是便会以为运气学说从其诞生之日起就是一个如此复杂的系统，并深深地被远古圣贤的聪明睿智所折服，然而历史的本貌却并非如此。因此为要真正理解“运气的天空”，就必须以历史的眼光去研究一下运气学说发展形成的脉络。

二、运气学说的形成与演变

现存记载运气学说的最早文献，是组成今本《黄帝内经》①的两部独立著作之一《素问》中所收录的七篇以“某某大论”为题的论文。因其内容均是讲述“运气学说”，故后人通常将这七篇文章统称为“《素问》大论七篇”或“《素问》运气七篇”。即：《天元纪大论》、《五运行大论》、《六微旨大论》、《气交变大论》、《五常政大论》、《六元正纪大论》、《至真要大论》。由于在《素问》中，除这七篇大论之外，基本看不到运气学说的影响，而这七篇大论又是通过唐代王冰在注释《素问》

---

① 《黄帝内经》之名始见于西汉末年刘向与刘歆父子所编撰的目录学著作《七略》。但实际内容如何并无人知晓。以为传世的《素问》、《灵枢》两书即是《七略》所著录的《黄帝内经》，本是西晋名士皇甫谧的一种揣测，但后人多从此说而成为“定论”。为尊重这一约定俗成的说法，又要避免将《七略》视为《素问》与《灵枢》的成书年代下限，故只能将其称为“今本《黄帝内经》”。

时，“于先生郭子斋堂，受得先师张公秘本”，并用此补齐了当时传世的《素问》因“第七一卷，师氏藏之，今之奉行，惟八卷尔”①的残缺才显露于世的。因而有关这七篇大论是否同于《素问》缺失之卷的内容，以及其成文究在何时等，历来就是医史研究中争论不休的话题。有人认为《素问》原书已有运气思想，且与七篇大论指导思想一致、语言相近，故七篇大论就是《素问》原文。② 但也有人据其天文学内容推断：三世纪后方有可能，下限应在七世纪的隋唐。③ 较多的学者均因齐梁间人全元起首注《素问》时即为八卷，无七篇大论；隋杨上善所注《黄帝内经太素》④中亦无涉七篇大论之内容，而倾向于接受七篇大论与运气学说均非《素问》原有之内容，且成立之年代可能较晚。最甚者以为十世纪之前并无运气学说，故隋唐时其他医家不谈运气，七篇大论及王冰的注释均为后人所伪造。⑤

实际上七篇大论成于何时与这些论文是否属于今本《黄帝内经》的固有内容，乃是两个问题。如果认定今本《黄帝内经》，即《素问》与《灵枢》的成书年代是在公元 1 世纪之前，则七篇大论不可能是《素问》的固有内容，因为使用干支纪年是从东汉四分历开始的(85 年)。《素问》其他篇节的共性是：五行配天干只用于纪日；在涉及五行与季节相配的问题时，大多是五行配四季(土不主时)，且只有“生、长、收、藏”的概念，没有与土相配的“化”；只有少数几篇引入了“长夏”与土相配。这与成书于一世纪的《白虎通·五行》在解释五行配四季时

---

① 王冰：《黄帝内经·素问·序》。

② 王树芬：《运气七篇考辨》，《中华医史杂志》，1987，(4)：229。

③ 郝葆华，王瑾：《〈内经〉“七篇大论”成书年代新论》，《中华医史杂志》，1984，(1)：46。

④ 《黄帝内经太素》是一部以类书形式对《素问》和《灵枢》进行改变的著作。成书年代不详。

⑤ 范行准：《五运六气说的来源》，《医史杂志》，1951，(1)：3。

所说“土尊不任职，君不居部，故时有四也”是基本一致的。

另外，在《素问》中只有〈脉解〉篇提到三阴三阳与十二月的配合，但其对应关系是：

正月	三月	五月	七月	九月	十一月
太阳	厥阴	阳明	少阴	少阳	太阴

如将其画成循环的圆环，则太阳与少阴相对，厥阴与少阳相对，阳明与太阴相对，符合脏腑、经络学说中三阴三阳的对应关系①，而与运气学说中六气的阴阳定位不合（参见图 3）。同时，在《素问》中也根本没有火分君、相的思想。凡此种种，均说明七篇大论与《素问》的其他篇节在理论构造间存在着一定的差距，显示着一定的时代距离。

然而从另一方面讲，在《素问》中确实已然出现了将四季改换成五时，以求与五行配合完璧的意识。值得注意的是：“长夏”这一概念的使用不仅解决了四季与五行以及与风、寒、湿、热、燥五气配合的矛盾，而更为重要的是奠定了“五运循环”的思想。只要从“五运主时”向前跨越一步，即构成了“五运主岁”的新说。此外，在《灵枢·岁露论》的“虚实”之论中也涉及到了“年”的问题：

> 三虚：乘年之衰，逢月之空，失时之和。
>
> 三实：逢年之盛，遇月之满，得时之和。

因而如果设定今本《黄帝内经》的成书时代是在两汉之交，或再略晚一点，那么可以说在东汉的中后期，产生运气学说的条件已然基本具

---

① 所谓脏腑、经络的阴阳属性对应关系是：太阴与阳明相对，如手太阴（肺）与手阳明（大肠）、足太阴（脾）与足阳明（胃）相表里；少阴与太阳相对，如手少阴（心）与手太阳（小肠）、足少阴（肾）与足太阳（膀胱）相表里；厥阴与少阳相对，如手厥阴（心包）与手少阳（三焦）、足厥阴（肝）与足少阳（胆）相表里。

备。如果考虑到当时的天文机构中居然有医生供职①，则真是不能不考虑运气类的著作最有可能是出自这等以天文与医学之结合作为自己的学问与工作的人。另外，有人根据音韵变化的研究，亦认为七篇大论应成于东汉。② 至于这些论著究竟是由王冰补入《素问》，还是其先师秘本既载，显然并不重要。

表 4　七篇大论中“五运”、“六气”的运用方式

篇名 / 配合	天元纪	五运行	六微旨	气交变	五常政	六元正纪	至真要
五行配天干	主岁	主岁				主岁	?
五行配五时				只有四时		分太少	
六气配地支（阴阳方式）	主岁	主岁	主时		主岁	主岁 主时	?
六气配地支（五行方式）			主时				
备　　注			候气法	占星法	讲五运太过、不及，但不言配天干。创司天、在泉之用。	将岁运改为中运，以与司天、在泉配合。	主要是讲病机。

尽管古今学者对七篇大论及运气学说成立的年代有不同看法，但一般均是将七篇大论视为一个完整的体系，以为“七篇各有议题，

---

① 据司马彪《续汉书》记载：“太史令一人，六百石。本注曰：掌天时、星历。”其下刘昭注引《汉官仪》说：“太史待诏三十七人，其六人治历，三人龟卜，三人庐宅，四人四时，三人《易》筮，二人典禳，九人籍氏、许氏、典昌氏各三人，嘉法、请两、解事各二人，医一人。”（见《后汉书》志第二十五《百官二》，中华书局，1965 年，第 3572 页）

② 钱超尘：《内经语言研究》，人民卫生出版社，1990 年，第 293 页。

篇篇衔接,浑然一体”①。然而通过对七篇大论的具体内容详加考察,却可以发现这七篇文章虽然以讲运气为共同特点,但无论是在运气推算方法上,还是在核心理论的构想方面均有所不同。正像学者们通过对内容进行考察后发现构成今本《黄帝内经》的各章并非一人、一时之作一样,七篇大论也同样具有这一特点。表4通过比较五行与天干、六气与地支的配合方式,以及在主时、主岁方面的不同用法,提示当时的运气推算是按不同方式进行的。以下择其要点稍加介绍:

1. 干支推运气:七篇大论中的《天元纪大论》和《五运行大论》采用的即此种方法。其方法简捷明了,即以五行配天干以定运,依天干的奇偶分太过与不及;地支配六气以定气,每年只有一运与一气。由于一年之中只有一运、一气,故不需要界定主运、客运,主气、客气的概念差异,天干与地支均用于纪岁。

这种运气推算方法虽然简单,但却充分体现了要将五行与阴阳结合在一起的基本理念。首先,五行与天干相配以纪岁,固然是以五行学说为立足点,但根据天干的奇偶将某一属性之“运”区分出太过与不及,即已实现了五行与阴阳的结合。然后在“愿闻其与三阴三阳奈何合之?”的命题下,通过将五行所生之“五气”改造成含有君、相二火的“六气”,并与三阴三阳、地支配合,则全面实现了天(干)与地(支)、五行与阴阳的密切配合。

2. 六步六气:《六微旨大论》采用的即此种方法。首先,六气在一年中各主60.875日;每年地支所纪之气为第三气,其馀各步之气依六气循环圈推算即知。而其候太过、不及的方法却是“移光定位”——根据“平气”常数与实测日影的差异来确定,固有当至而至(平气)、未至而至(太过)、至而未至(不及)三种情况。这就是所谓的

---

① 王琦等:《运气学说的研究与考察》,知识出版社,1989年,第206页。

“天道六六之节”。在与五行说的结合方面，是以将六气排列顺序改变成五行相生序——风、君火、相火、湿、燥、寒，各主四个节气，称之为“地理之应六节气位”。与上述“干支推运气”之法比较，可以看出两种方法天、地的内涵有所不同——在“干支推运气”之法中，五行属天，六气属地；在“六步六气”之法中，阴阳循环序的“六气”属天，五行相生序的“六气”属地。在前者中有运、有气；而在后者中，只是“隐含”着五行，或者说只有“气”、没有“运”。换言之，此法不过是敷衍天文家候气、推步之法而成。

3. 六气分天地：这是最能反映人们宇宙构想的一种运气模式。六气循环圈的用法在此发生了最重要的改变，说明如下：

由三阴三阳组成的六气循环圈，在前述“干支推运法”中，只不过是为了说明六气每六年循环一次，没有其他含义。或者说从中丝毫看不出当时之人对于六气在宇宙间的存在状态是如何思考的，是宇宙间的“气”每年变换一种属性，还是具有不同属性的六气轮流执政？如果是后者，那么不当政的其他五“气”又蕴藏于何处？

然而在“六气分天地”的理论构想中，这个六气循环圈却是明确地被置于天地之间。因而顶端之位名之曰“司天之位”，其气即“司天之气”；下端之位名之曰“在泉之位”，其气即“在泉之气”（图 4）。其他四位、四气均不必注意。每一年的“司天之气”是根据地支决定的。与“干支推运法”比较，虽然两者均是以地支配六气，但前者是以五运与六气共同主宰宇宙、天地来构筑理论体系的，而此处则舍

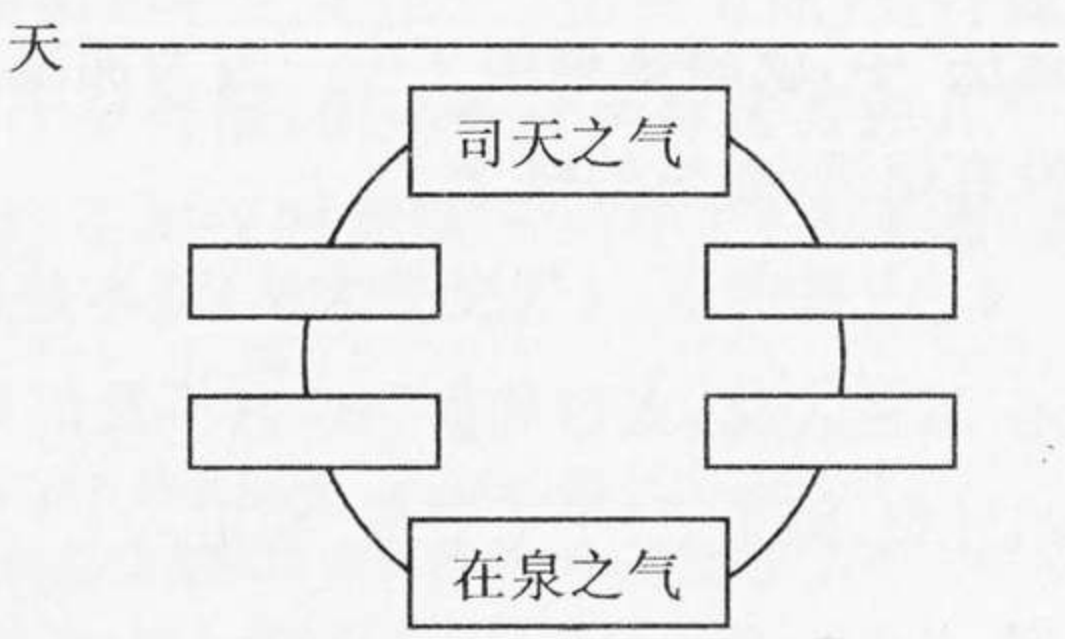


图 4　六气在天地间循环往复的构想

弃了五行、五运，纯粹从寓存于天地之间的“气”来设想与解释宇宙的存在状态、运动规律。颇似东汉大哲学家王充《论衡·谈天》所言：“天地，含气自然。”另外，一个十分有意思的问题是：六气循环圈的六个位置虽然是阴阳对立，但六气本身的性质却并不具有这样的矛盾性。例如“太阳寒水”所对为“太阴湿土”、“少阴君火”所对为“阳明燥金”，从阴阳的角度讲“太阳与太阴”、“少阴与阳明”虽然属性不同、相互对立，但“寒与湿”、“火与燥”在性质上却是相近的。“司天之气”与“在泉之气”的这种共性，为解释每年的运气属性和疾病特征提供了基本保证。例如凡地支为丑、未之年时，其运气表现即为：“湿气下临，埃冒云雨；地乃藏阴，大寒且至，蛰虫早伏，地裂冰坚，水增”——一派湿、寒景象。

在《六元正纪大论》中，对于司天、在泉二气共主一年的理论构想又有所发挥：将五运置于天地之间，而称其为“中运”。如此又再度实现了阴阳、五行两说的结合。为适应这种新的理论构想，该篇的作者将“天干与地支合”而称之为“天符”的概念，改成“中运与司天之气合”，复又补充了“中运与在泉之气合”为“同天符”及“同岁会”等新概念。因此必须分清哪些概念是在运气学说的发展过程中新出现的，并弄清这些概念的定义与使用范围。如将“中运”的概念移到“干支推运法”中，就颇难理解了——因为那里虽然也使用六气循环圈，但却没有司天、在泉的概念。

4. 占星定运：《气交变大论》基本是这种体系的作品。其中虽然细述“五运之化，太过如何”和“其不及何如”，但没有天干配五行定五运的思想，而是依“上应五星”而定：

> 岁运太过则运星北越，运气相得则各行其道。
>
> 岁运太过，畏星失色而兼其母，不及则色兼其所不胜。

与星占中所说:“五星有色、大小不同,各依其行而顺时应节。不失本色而应其四时者,吉;色害其凶,凶”;“凡五星见伏、留行、逆顺、迟速应历度者,为得其行,政合于常;违历错度,而失路盈缩者,为乱行。乱行则为天矢彗孛,而有亡国革政、兵饥丧乱之祸云”①等十分接近。因而可以说这种基于星占的推算方式,只不过因为是用在医学领域,所以“天人之应”的具体表现主要是人体疾病的描述。

《素问》中的七篇大论可以说是一组专讲运气问题的论文群,由于每篇论文的相对独立,才使得上述分析成为可能——使得我们能够了解早期运气学说的多种推算方法。同时,正是由于这七篇原本各自独立的论文表现出注重五行、五行与阴阳的结合的共性,故可以从中察知运气学说所具有的时代特征。以下对此略加说明:

构成今本《黄帝内经》的《素问》与《灵枢》这两部医学经典的最终成书年代虽然无法确定,但无疑是在运气学说形成之前。其在理论运用方面存在的一个显著特点是阴阳与五行两种学说在不同的章节中往往是独立存在的。例如在人格划分方面,以黄帝与伯高问对写成的《灵枢·阴阳二十五人》,实际上是将人分为木、火、土、金、水五类,与阴阳无涉;而以黄帝与少师问对形式写成的《灵枢·通天》虽然也是将人分为五类,但所依据的却唯有阴阳理论,即太阴之人、少阴之人、太阳之人、少阳之人、阴阳和平之人五种。另一方面,五行说在今本《黄帝内经》中运用得尚十分有限,例如在针灸疗法方面几乎看不到五行说的踪影。② 但是到了东汉时期就不一样了,成于此间的

---

① 《晋书》卷十二《天文中》,中华书局点校本,1974年,第320～322页。

② 在今本《黄帝内经》中虽然有几篇文章提到各经脉位于肢端的五个穴位名为井、荥、输、经、合(后世定名为“五输穴”),但未见与五行说有什么联系,只是与“四时”关系较为密切。此外,在其他有关针灸疗法的论述中就看不到五行说的任何踪影了。详见拙著《秦汉之际针灸疗法理论的建立》,文载《自然科学史研究》,1991年第3期。

针灸著作《黄帝明堂经》将五行说与穴位的属性紧密地联系在一起。① 降至《难经》,简直就是依据五行来言说各穴的主治。② 另外,《难经》中力辩脏应为六(脏属阴,阴数偶),腑应为五(腑为阳,阳数奇);讲一脉为"十变"的原因是五邪(五行)与刚柔(阴阳)的综合结果(5×2=10);将积聚分为阴、阳两种,再将积分为五类,并依五行方位定其性——肝(木)之积在左、心(火)之积在上、脾(土)之积在中、肺(金)之积在右、肾(水)之积在下,其病因也是因为病邪依五行相克规律传变,遇所克之脏当"王"(旺)之时,邪气不能继续向下传递而留滞成"积"。凡此种种,均表现出对于五行的注重,以及对于五行与阴阳相结合的注重。③ 前面已然说过,言说运气学说的七篇大论当产生于今本《黄帝内经》其他篇节之后,其中强烈地表现出要将五行与阴阳说融为一体的愿望。就此观之,与东汉时期医学理论发展的时代特征是一致的。

---

① 例如《黄帝明堂经》明确规定了各条经脉肢端的五个穴位(五输穴)的五行属性。并规定了各经脉的这五个穴位是按五行相生序排列;阴经与阳经的同名穴之间是相克关系(参见下表)。

五 输 穴	井	荥	输	经	合
阳经五输穴的五行属性	金	水	木	火	土
阴经五输穴的五行属性	木	火	土	金	水

② 例如《难经·七十三难》言:"诸井者,肌肉浅薄,气少,不足使也。刺之奈何?然诸井者,木也;荥者,火也,火者木之子。当刺井者,以荥泻之。"这是根据五行相生的理论,泻"子"之气,则"母"之气必然向"子"转移,故刺荥可以代替刺井。又,《七十九难》曰:"《经》言'迎而夺之,安得无虚;随而济之,安得无实。虚之与实,若得若失;实之与虚,若有若无'何谓也?然迎而夺之者,泻其子也;随而济之者,补其母也。假令心病,泻手心主俞,是谓迎而夺之者也;补手心主井,是谓随而济之者也。"所引《经》言,见于《灵枢·九针十二原》。历代注家均释此为一种针刺手法,即按照经脉来的方向斜刺进针为泻;顺其走向进针为补,称之为"迎随补泻"法。而《难经》作者又是依五行学说将其释为"泻其子"与"补其母"。

③ 关于《难经》如何运用阴阳、五行之说于脉诊、脏腑、腧穴、疾病等各方面,可参见拙著《〈难经〉医学理论的时代特征》,文载《中华医史杂志》,1993年第1期。

运气学说的理论框架，无疑是由阴阳与五行来支撑的，但两说的重要程度稍有区别。比较而言，五行学说的地位与作用更重要一些。因为在运气学说成立的时代，像宋明理学那样以阴阳统摄五行的思想体系尚未形成，五行位尊于阴阳之上。所以在这些早期的运气论著中，不管具体内容究竟讲的是什么，总要先冠以五行的大帽子。如《天元纪大论》开篇即言：“天有五行御五位，人有五藏化五气”；“五运相袭而皆治之”；“五运终天，布气真灵，总统坤元”，等等。《六元正纪大论》虽然以讲六气为主，但仍不离“五运之化”、“五运宣行”等语。从推算形式上讲，五运主时产生最早；尔后有鬼臾区据早期文献《太始天元册》将五运主时推衍到主岁，运气学说才逐渐发展起来。而与地支、三阴三阳相配的六气，虽然其中的“火”被改造成了君、相二火，在时序排列上也与五行的排列不同，但其本质还是与五行范畴密切相关的寒、暑、燥、湿、风“五气”。因为无论是疾病的性质，还是自然气候的特点，都需要用五行的分类模式加以表现。

如果推究唐以前运气学说未见广泛流行的原因，恐怕主要有两点。首先，如果这类论著真是出自皇家天文机构中的医家之手，则恐怕从一开始就属金匮石室之秘宝，外人不易得见。而且自晋泰始三年开始禁星气、谶纬之书后，历代朝廷均多有相似禁令，私习天文是要杀头的。第二个原因则应考虑到宋代以前虽然有各种医学经典传世，但在实际中医家注重的是方药等实用技艺。例如晋代名士皇甫谧认为今本《黄帝内经》“其论遐远，然乘述多而切事少”，故“删其浮辞”，只选与针灸疗法密切相关的内容编成《针灸甲乙经》①。唐代王焘编撰的类似“全书”的大型医学著作《外台秘要》，对于被后世尊为医圣的张仲景

① 《针灸甲乙经》的内容系采自《素问》、《灵枢》、《明堂孔穴针灸治要》三书，被誉为现存第一部针灸学专著。其编撰旨趣详见该书《自序》。

所著《伤寒杂病论》,仅仅是采用了其中的方剂,而未见引用其理论性内容。医学理论受到医家的重视,乃是宋代以后的事情。这与理学兴起后,学者们在思想意识上渐将原本归于“百工贱业”的医学视为“吾儒格物穷理之一端”;伴随着知识分子日见增多,出现了一批具有较高文化素养的“儒医”,以及统治者对医学的重视等都有密切的关系。只有到了这时,《伤寒论》的六经辨证体系才成为临床治疗的指导原则;张仲景也在经历了“亚圣”的称号后,登上了“医圣”的宝座;《伤寒论》再不被当作“方书”,成了“理、法、方、药”齐备的“医经”。而运气学说也成了备受关注的医学理论。

概观宋以后对运气学说的研究,其要有三。一是将七篇大论作为古圣遗言而大加阐发,硬是构成了一个完整的体系,使得七篇大论能够相互发明、训解,似乎唐以前原本就是按照如此复杂的体系去推算每年的运气。官方的医学考试,每卷必有“运气一道”,要求考生能够答出题中所给年份的“五运六气所在、所宜,处方为对”,无疑对运气学说的普及起到了巨大的促进作用;编于明代的大型方书《普济方》更是按照五运六气胪列方药——甲子一周六十年的处方都可在此查得。据清代医家记载,医界流行之谚为:“不读五运六气,检遍方书何济。所以稍涉医理者,动以司运为务。”足见运气学说在一些医家头脑中以及医学理论中的地位。

其二则是从实证的角度予以批判:“当时圣人不过言天地之气运行旋转如此耳,至于人之得病,则岂能一一与之尽合,一岁之中不许有一人生它病乎?”①《四库全书总目提要》评汪机的《运气易览》云:“所云衍各图,亦颇有发明。然治病自以脉证为主,拘泥司天、在泉,

---

① 徐大椿:《医学源流论》卷下《司天运气论》,台湾商务印书馆影印《文渊阁四库全书》第785册,第673~674页。

终无当于经旨也”;评董说的《运气定论》云:“治病者求之望闻问切,参以天时地气,亦足得其概矣。正不必辨无证无形之事也”。皆属批判态度。

其三则是对运气学说的改造。一些医家或许是由于既不承认可以根据每年的运气推断疾病的属性,又在思想意识上存在着对于古圣言论的绝对崇信,所以只能采取“六经注我”的方式赋予运气学说新的解释。享誉金元四大家的刘完素、张从正可谓这方面的代表。他们的基本主张是“有是证(症),则有是气”——这实际上是彻底地将运气学说改造成了病机学说。即不再遵守干支与运气的配合,而仅仅是将“六气”的属性(风、寒、暑、湿、燥、火)作为疾病性质(病机)的抽象概念,据此言说疾病的治则。刘完素的代表作《素问玄机原病式》、《素问病机气宜保命集》中所大谈的“运气”,皆是这种有其名而无其实的病机化了的运气学说——因为其中基本没有推算方法存在。

三、科学与玄学——两种错误的解释

当代的中医从业者,大多视运气学说为玄中之玄,望而生畏。这是因为当代人过于注重从哲学的角度对中国传统文化中的阴阳、五行学说加以解释。即:阴阳的意思是说所有的事物均可一分为二,两方面之间存在着既对立又统一、可以相互转化的关系;五行是对事物属性的一种划分,相互之间存在着相生、相克的关系,甚至极端唯物地将五行说成是“五种元素”。因而尽管学过中医的人没有不知道阴阳、五行的,但是很少有人知道在古人的头脑中,阴阳本是实实在

在存在于天地之间的“气”，五行既是一切事物的基本属性，又是构成万物的本体（五德）；而且无论是阴气、阳气，还是五德，都是按照一定的规律（天道）运动着。同时，在他们的头脑中，也和其他所有的人一样，或多或少存在着一个“科学的宇宙图像”，无论如何也不会有人认为天圆地方、“气”按照“天道”运转于天下地上的空间之中。如此自然很难理解运气学说赖以存在的“宇宙”①模型。面对贾人居奇、标榜此道者的玄谈，唯有自愧才疏学浅，尊敬有加。好在临床治病，并非必须，故束之高阁，仰慕足已。衣食于此道者的另一种表现是抓住自然界气候变化与发病有所联系的客观事实，而言：

> 运气是我国古代研究天时气候变化，以及气候变化对人体发病影响的一种学说。它是以自然界的气候变化，以及生物体（包括人体在内）对这些变化所产生的相应反映作为基础，从而把自然气候现象和生物生命现象统一起来，把自然气候变化和人体发病规律统一起来，从宇宙间的节律上来探讨气候变化对人体健康与疾病发生的关系。②

这是“阐明”运气学说之科学内涵的代表性意见，但这种解释本身并不科学。因为运气学说所论述的并不是一年当中客观存在的季节、气候变化，而是臆想的六十年一个周期的气候变化。在这里，人体疾患和包括气候在内的所有自然变化均是天地间运、气循环运转的表象。也就是说医家不必去观察自然气候的变化，不必通过各种诊察手段去了解某一患者的疾病属性，只要知道某一时段的“运气所在”

---

① 上下四方谓之宇（空间），古往今来谓之宙（时间）。运气学说与如此含义的宇宙构想确实具有密切的关系。

② 程士德主编：《素问注释汇粹》附二《五运六气学说简介》，人民卫生出版社，1982年，下册，第532页。

就够了。尽管运气学说的成立，可以说是“天人合一”观念在医学中的运用，但这个“天”的概念并不是泛指自然界，而是控制着自然界一切变化的“运”，这个更高一层次的“天道”。即便是六气，虽貌似言说阴阳之变化，但其运转规律仍旧是由“运”决定的，因而才会必然地按照六气循环圈所规定的方式与时间，稳步地、定时地向前推移。由此不难看出，以完全是先验的、机械循环的指导思想为基础建造起来的运气学说，在其构成中虽然移植了前此医学中能够反映气候变化与人体发病客观联系的内容（五行与四时相配，即主运），但其总体框架恰恰是处于前此之医学“由经验归纳上升成为理论”的对立面上。这就必然导致一部分具有怀疑精神、注重实证与经验的医家会在抽象肯定运气学说的同时，对于其本质予以否定——仅仅是将六气作为病机的抽象概念，将六气间阴阳相互对立与制约的关系作为治疗原则。这种没有推算程式的“运气学说”，虽然在形式上保留了运气学说的名词术语，但其实质性的内容已被悄然置换成“根据四诊（望闻问切）所见实证判定疾病性质”这样一个合理的内涵了。

应该说无论是将运气学说神秘化，还是将其科学化，都不是真正读懂了运气学说的表现。正确的研究方法只能是将运气学说放在孕育它的文化、时代背景下加以考察。一般认为东汉时兴的谶纬之学对运气学说的产生具有极大影响。例如日人丹波元简直言运气学说是：“凑合纬、医二书，所立正是一家。”① 又有人指出：“五运”与“六气”并称可能起源于《易》纬，并在纬书与运气论著间找到了许多相同与相似之处。② 然而如果追问一句：谶纬又源出何处呢？恐怕就不太容易回答了。或又问：运气之书既然与纬书有如是之多的相似、

---

① 丹波元简：《医剩·运气》，第15页。

② 王士福：《五运六气说起源的商讨》，《医学史与保健组织》，1958，(2)：127。

相同之处，是否也可称之为纬书的一种呢？实际上，只要考虑到东汉以后谶纬之学的昌盛，经学大师亦为之撰注，或博采纬书以释经，就不难想见当时的整个社会文化风貌。可以说，在科学史研究中，对于东汉时期的文化背景最应注意的就是当时出现了一种远胜于西汉时期的、融《易》理与阴阳五行诸说为一体，辅以数位推演来解释天地生成、政治人伦、万物化生、物理之情的学术风尚与思维方法。运气学说本身既是这种时代风尚的产物，同时也是构成这种时代风尚的一个组成部分。

最后，不妨借用方以智的哲学术语——交、轮、几[①]，对运气学说的体系进行一下概括：

1. 交(对立的相交)：天与地、阴与阳、动与静相交——故有干与支相交、五运与六气相交、主与客相交、司天与在泉相交等。

2. 轮(周而复始的运动转化)：五运的循环、六气的循环——故有岁运、主运、客运、主气、客气的推衍以及五行的生、克，六气的胜、复。

3. 几(征兆)："至数之机，迫迮以微。其往来可见，其往可追。敬之者昌，慢之者亡。"(《素问·天元纪大论》)"谨候气宜，无失病机。"(《素问·至真要大论》)

运气学说所要阐述的正是宇宙运动的德(本体)与道(规律)，以及医家应该如何察知运动过程中显露的征兆(几)，并将其用于医疗实践的问题。只不过因为运气学说所阐述的这个"终极真理"完全是以"意"构建的，所以只能被束之高阁，独享寂寞。

---

① 《东西均·三征篇》云："交也者，合二而一也；轮也者，首尾相御也；凡有动静往来无不交轮，则真常贯合，于几可征矣。"

脚　气

——意想的风土之疾

据说“脚气病”曾广泛流行于包括中国在内的东方米食诸国；每年死亡人数，动以数万计。① 其原因在于精制的大米缺乏维生素 B1，由此导致下肢麻木疼痛、水肿，严重时侵犯心脏，突然死亡。然而每当我在医史著作中读到诸如此类的叙说，就不能不引起对一段往日生活的回忆，并由此引出种种的困惑。

一、亲身经历所引出的困惑

1969 年，成千上万的北京“知识青年”来到了云南省西双版纳的密林中。按照医学书中所述脚气发病的原因与条件，他们的生活环境完全具备了该病流行的条件：

1. 主食完全是大米。只有在过年时，才会从很远的地方运来一点面粉（每人 1 斤）。

按，根据近代营养学知识，完全脱壳大米的维生素 B1 含量较低，此乃脚气病流行于东方米食之国的重要原因。

---

① 朱洗：《维他命与人类之健康》，文化生活出版社，1950 年，第 2 版，第 83 页。

2. 由于副食极度匮乏以及劳动强度大，每人每月平均食米 30～40 公斤。

按，当碳水化合物的代谢增大时，肌体对于维生素 B1 的需求也随之增加。这是造成脚气发病的又一重要因素。

3. 虽然没有检测过当地大米的维生素 B1 含量，但相信机械脱糠的纯净度绝不会逊色于古代的手工操作。

按，营养学家早已指出“由于机器的精碾，致大米中含维生素的胚芽及外部的糠皮均被碾去”；1890 年荷兰政府派到南洋群岛的医学研究员 Eijkman 观察到以碾白米喂鸡会产生“脚气病”，并经实验证实①。

4. 副食极度匮乏。② 雨季通常是米饭和咸菜，甚至盐水；旱季也经常只能吃到水煮的南瓜、洋白菜、酸菜。肉食大约两月一次。

按，并非以米为主食就一定会患脚气病。因为维生素 B1 广泛存在于各类食物当中，故只要副食丰富即可从其他途径获得补充。

5. 高劳动强度。由于完全是依靠肩挑手挖修建水库，且受工程时限的制约，故劳动时间一般在 12 小时。且亚热带的气候高温多雨，其甚达到连床脚都会长出枝叶的程度。

按，在这种环境下从事强体力劳动，肌体新陈代谢的加快可想而知。然而就是在这种饮食构成、季节气候、劳动强度、年龄特征等各方面条件都能满足脚气发病要因——“维生素 B1 摄入不足、需要增加”的情况下，成千上万来自北方的知识青年苦干数年，同时建成水

---

① L.J.Harris：《维生素的理论与实用》，张鸿钧，孙岩森译，上海科学技术出版社，1959 年，第 32、6 页。

② 其原因在于：(1) 水利施工单位，没有自给自足的生产基地；(2) 虽有少量菜地，但半年多雨，蔬菜生长困难；(3) 雨季道路毁坏，交通阻断；(4) 伙食标准的制约，除购买大米外，所剩无几；(5) 时值越战期间，周围农村的农副产品首先要满足援外的需要。

库五座，却始终没有出现过一例脚气患者。① 倒是营养不良性水肿极为普遍，并因此造成众多的下肢溃烂，长期不愈。

所谓“亲身的感受”还不仅于此。如果你在中国民众中作一个小小的调查，问问他们是否知道脚气病，几乎所有的人都会毫不迟疑地回答：“知道。”但他们的理解又几乎毫无例外地是就“脚癣”（俗称“香港脚”）而言。这种情况并非仅仅存在于一般民众之间，日本医史学家真柳诚曾授我一在中国药店购得的“脚气水”，其上竟赫然写着“beriberi”（脚气的英文名）。足见医务工作者亦对此病不甚了解。即便是年迈的医史专家，如果没有刻意研究过脚气的历史，亦难免会有同样的误解。例如有人释敦煌卷子中的“疗脚气方”为：“二药合用治疗脚气，脚上生风毒疮肿，共收消肿解毒、杀虫止痒之效。”②

然而无论如何，“脚气”概念的混淆与本义的迷失，似乎不应出现于老年人当中。因为有关著作普遍谈到：脚气病曾广泛流行于20世纪30～40年代的中国社会，此后因生活水平提高，脚气病亦随之消亡。③ 但实际上，当代的中国百姓不论其年纪有多大，却基本都不知脚气为何病。此与日本老人对于脚气病的了解程度形成了鲜明的对照。④

---

① 需要说明的是，此间我作为水利四团团部卫生所的医务人员，负责各营连每月的疾病统计，而且经常为周围的民众看病，但从未见到或听说过此病。

② 马继兴主编：《敦煌古医籍考释》，第218页。当然，这里存在着另一种可能，即作者以为该处所言“脚气”并非beriberi，而是今日所言脚癣。

③ 例如张鸿钧、孙岩森在翻译L.J.Harriss所著《维生素的理论与实用》一书时，对于书中所言“脚气病尝流行于米食区域，例如日本……及中国的一部分地方”，即特别加了“译者注”（上海科学技术出版社，1959年，第37页），云：“指解放前；解放后由于政府的关怀及提倡营养，此病已极少见。”《简明不列颠百科全书》（中国大百科全书出版社，1985年中译本，第4册，第346页）亦将脚气消亡的部分原因归之于生活水平提高。

④ 据板仓圣宣《模仿的时代》（假说社，1988年，上册，第7页）介绍，日本人在谈到“脚气”这种历史的疾病时，“稍上年纪者会想起：‘医生要用木锤敲击患者的膝盖’；年纪再大一些的人会说：‘脚肿得很大，很快就变得不能走路’；而老年人则视其为可怕的疾病，‘一旦脚气攻心，数日即亡’；还会有人告诉你：‘日俄战争时，数十万的士兵患脚气，数万人因此而亡’，等等”。

此外，如果设定前述 30～40 年代的脚气流行为真，并相信此后的消亡是由于生活水平提高，那么在 20 世纪 60 年代初，中国大陆连续多年严重的自然灾害流行时，此病理应再度出现。因为众所周知，此间民众的生活水平已然降至极低，不仅蛋白、脂肪匮乏，就连碳水化合物亦得不到满足。因而从理论上讲，在这种情况下至少南方米食诸省应能见到此病流行，但实际上只有大量的浮肿、肝硬化等疾病出现，始终没有见到脚气病的踪影。

如果再将目光延伸到整个中国历史，围绕着“米食”与“脚气”密切关联的解说，还会有更多的困惑。例如，作为水稻的主要栽培国，中国南方种植稻米已有几千年的历史，何以会在晋代突然出现这种疾病？“江南”与“岭南”的稻作史，并无明显的先后之分，何以最先记载此病的葛洪会说“先起岭南，稍来江东”？宋代以后，水稻种植发展空前，何以此病鲜见，以致概念混淆？

看来要使上述种种困惑得到比较合理的解释，首先需要弄清真正的脚气病，即维生素 B1 缺乏症的流行状况。如此才能进一步看清“脚气”这个历史病名的自身历史。

二、近代的脚气病

自 19 世纪末至 20 世纪初，在经历了一个科学发现的“必要渐进过程”后，人类始对维生素及营养缺乏性疾病有了基本正确的认识。因而选择近代国人在此方面的研究与记载作为深入了解脚气病史的切入点，应该说是一种较好的方法。在侯祥川所著《营养缺乏病纲要

及图谱》[①]中，给出了一些20世纪30、40年代一般民众食物营养成分（参见表1）及脚气病之发病情况（参见表2）的统计资料，对于准确把握脚气流行的状况极有帮助。

表1　不同阶层民众每日维生素B1输入量（原书表9）

等　　别	调查时期	维生素B1输入量（10^{-6}克）	热力输入量（卡）	维生素B1（10^{-6}克）/卡
上海工厂工人	1935年5月	539	2 724	0.198
上海精巧工匠	1935年5月	865	2 679	0.319
上海某医院职员	1935年4月	1 059	3 200	0.331
南京殷富家庭	1934年11至12月	1 084	3 184	0.300
南京小康家庭	1934年11至12月	1 056	2 870	0.368
南京中等家庭	1934年11至12月	804	2 829	0.284
南京中等以下及贫苦家庭	1934年11至12月	1 138	2 322	0.490
北京中等家庭	夏季	1 343	2 901	0.463
北京西郊农户家庭	夏季	1 433	3 139	0.457
北京大学学生	冬季	1 421	3 044	0.467
北京中学学生	春季	1 118	2 746	0.407
北京工厂工人甲	冬季	1 179	3 134	0.375
北京工厂工人乙	春季	1 509	2 889	0.522
北京某中等饭店顾客	秋季	1 605	3 000	0.535
河南商丘农林学校学生	1936年5至7月	1 312	3 135	0.419
同上	1935年11至12月	1 507	3 420	0.441
华北某30个家庭	1922年夏季	1 333	2 471	0.539
华中长沙劳动工人	1924年5月	612	2 998	0.204
华北67区农户总平均	全年（1929～1932年）	2 075	3 186	0.651
华中22区农户总平均	全年	1 215	3 486	0.349
华南46区农户总平均	全年	812	3 364	0.241

① 人民卫生出版社，1957年。以下所引统计资料，皆据此书。

表1反映出两方面的情况。其一是维生素B1的摄入量。其中最低者为南方城市工人(上海、长沙),次则南京中等家庭和华南农户。而南京“小康家庭”、“殷富之家”以及上海的“精巧工匠”、“医院职员”等皆无摄入不足的问题。其二是维生素B1与热能的比率问题。按照Cowgill氏的理论①来看表1的资料,脚气易发人群仍然主要是南方城市工人。

上述资料进一步加强了本文第一节中,那种源于切身感受而生的、对于古代脚气史料诠释的怀疑。例如,唐代医家孙思邈在论述此病源流时所说:“自永嘉南度(渡),衣缨士人,多有遭者”,“近来中国士大夫虽不涉江表,亦有居然而患之者”②,历来都是被作为经典之说广加征引。相信米食即会导致脚气的史家对此的解释大多为:“南渡后改食米,故多患脚气;此后运河开通、南粮北运,则北方亦见此病”;谨慎者于此还会加以特别说明:“脚气病并不是吃了稻米就会发生,而大多是吃了缺乏维生素B1的精米所致。”③然而上述资料恰恰可以说明,尽管精白米的维生素B1含量确实贫乏,但只要不是限定以此为唯一摄入食品,则并不会导致脚气发生。正如表1所示,生活水平稍好的上海“精巧工匠”、“医院职员”已无脚气之忧,更不用说南京的“小康”、“殷富”之家。永嘉衣缨士人南渡后,或确变为以精米为主食,但却没有任何证据能够说明他们不再饮酒食肉,或贫困潦倒到食无菜蔬的地步。又如在表2中可以看到,属于“水稻、小麦区”的庐

---

① 侯氏在该书中指出:“根据Cowgill氏的理论,维生素B1与热量的比率在0.3以下就要发生脚气病。表2(原书表8)的结果说明,比率在0.3以下者脚气病的病发数较多,完全符合这种理论。”

② 《千金要方》卷七《论风毒状第一》,第138页。

③ 详见侯祥川:《我国古书论脚气病》,《中华医史杂志》,1954,(1):16。范行准:《中国病史新义》,中医古籍出版社,1989年,第248、245页。

州、芜湖、武穴等地，其1934年的脚气发病率竟然低于属于“小麦、高粱区”的济南。看来吃米确实未必发脚气。至于以“南粮北运”作为北方亦见此病的原因，就更显得牵强。首先，如同无法说明南渡之人的饮食结构会单一到唯以精米为食一样，北人开始食米同样不足以构成脚气流行的充分条件；其次，南粮北运究竟在多大程度上改变了北方的饮食结构，更是甚可怀疑之事。就我的经验而言，乐于食米，不过是近一二十年发生在北方年轻一代身上的事。对于父辈年龄的北方人来说，“米饭吃不饱”（不习惯）乃是司空见惯的耳熟之语。而表1的资料亦完全可以证实，事实上北方各地、各阶层民众的饮食皆不存在维生素B1缺乏的问题。凡此种种，皆说明脚气病在中国的流行，并没有想像的那么严重。而表2的资料似乎亦可证实这一点。

表2　脚气病病发数与维生素B1输入的关系（原书表8）

地　　区	脚气病病发数（入院百分率）		维生素B1（10^{-6}克）
	（1933年）	（1934年）	卡
小麦、高粱区			
济　南	0	0.11	—
怀　庆	0.04	0	0.813
归　德	0	0	0.801
保　定	—	0.03	—
天　津	—	0.01	—
平　均		0.03	
33地区平均			0.665
水稻、小麦区			
庐　州	—	0.07	—
芜　湖	0.18	0.05	0.167
南　京	0.20	0.22	—
上　海	0.59	0.26	—
武　穴	—	0	—
平　均		0.12	
22地区平均			0.349

续 表

地　区	脚气病病发数(入院百分率)		维生素 B1(10^{-6}克)
	(1933 年)	(1934 年)	卡
水稻、茶区			
南　昌	0.60	0.40	0.136
杭　州	0.18	0.23	—
德　安	—	0.14	0.280
长　沙	0.71	0.23	—
平　均		0.25	
19 地区平均			0.218
西南水稻区			
昆　明	0.68	0.31	—
11 地区平均			0.217
水稻两获区			
汕　头	0.14	0.30	—
广　州	1.22	1.42	—
鼓浪屿	0.77	0.77	—
福　州	—	1.59	—
平　均		1.02	
11 地区平均			0.239

粗略一看表 2 所载脚气的发病区域，确有“脚气大国”之感。但仔细观察“病发数”一项，却可发现除属于“水稻两获区”的广州、福州两地外，其他各地的“入院百分率”皆低于百分之一，甚至不到千分之一！如此的“发病率”，实在只能称得上是“偶见”。即便是广州、福州，其入院率亦只不过在 1.5%左右。以如此之低的发病数来说明一种疾病与饮食习惯之间的密切关系，似乎有些困难。因为还有其他原因，例如慢性酒精中毒、肝肾病变等，亦可导致与缺乏维生素 B1 相同的病变结果——辅羧酶生成减少，甚至完全没有。

实际上，由于“白米维生素含量低→致使摄入不足→脚气发生”

这一因果关系的实现，需要以“没有其他摄取源”为必要条件，因此脚气流行大多是出现在一些特殊的生活环境中。例如，明治初期仅吃米饭和咸菜的日本海军，在远程航行过半后，总会有大量的脚气患者出现；即便是在“维生素 B1 缺乏症几乎只见于慢性酒精中毒患者”①的西方国家，脚气也同样会出现在某些船员和囚犯之中——如果只吃白面包而不是全麦面包②，但每日食用白面包的一般民众却从不患此病。此外一些有关脚气病的统计数字与实验亦大多来源于监狱、精神病院或军队③，因为除了动物，只有在这类特殊环境下，才有可能实现对饮食的有效控制。

具体到中国，近代的脚气流行，实际上主要是发生在二战前后这样一个特殊时期，而且主要是在难民这样的特殊人群中。侯氏之书的记述如下：

> 1937 年日本侵犯上海，很多受难人民每天食陈久的白米饭及少量咸菜，在 2 个月左右就发生了很多脚气病患者。当膳食改良后（如增加了黄豆和赤豆），患者就渐减少。这可在附图 8（略）看出：在 9、10、11 和 12 四个月内，在一个难民医院、一个难民收容所、一个难童教养院内脚气病病发数很高；当膳食改良

---

① 《简明不列颠百科全书》第 4 册，第 346 页。

② L. J. Harris《维生素的理论与实用》（第 36 页）中介绍：1930 年，丹麦捕鲸队的一艘船上有 51 人患脚气，原因是未食用全麦面包；美国某监狱以白面包为主要食物，亦使犯人中出现了脚气病。又，在“beriberi”病名由来的多种解释中，有一种说法为：源于阿拉伯语的 buhr（苦闷、喘息）和 bahri（船员），即因红海的阿拉伯水手常患脚气而得名。见山下政三：《脚气的历史》，东京大学出版会，1983 年，第 24 页。

③ 例如，1905 年，W. Fletcher 在一精神病院进行食物实验，仅摄白米者有 25% 患此病；H. Fraser 与 A. T. Stanton 在一铁路工人劳动收容设施中进行了同样的实验，获得同样的结果，论文发表于 1909 年。见 C. Singer & E. A. Underwood, *A Short History of Medicine*，引自酒井静、深濑泰旦日译本，朝仓书店，1986 年，第 612 页。

后，病发数就逐渐降低。同时，在某普通医院就诊的一般市民，因没有受到战争的影响，所以在一年之中脚气病病发数与以前相同。

书中所示其他反映出脚气问题严重的统计数字，其时间坐标也大多是集中在这一“非常时期”。例如，据上海前工部局卫生处统计：1936 年脚气病例 179 人，1937 年为 278 人，1938 年突增至 1 100 人。又如某医院 1934 年的门诊脚气患者为 97 人，1938 年却激增到 1 288 人，另有 273 名住院病例。

科学的发展不仅认识到维生素与某些疾病的关系，不仅可以利用检测手段与给药实验来判定根据症状表现所做出的临床是否准确，还通过纯粹的科学实验——对健康者的维生素排泄量进行检测而了解到：许多毫无疾病表现的“健康者”，也存在着严重的维生素缺乏问题。换言之，在维生素 B1 的缺乏没有达到相当严重的情况下，并不会造成脚气病的普遍流行。这样一来，本文开始所言“种种困惑”中的一个方面——具备脚气发病条件却未发病的问题，大致得到了一个最肤浅的解释。

同时，当代的“脚气”概念混淆与本义迷失，也就不再是一个难释其由的孤立现象。因为如果真正的脚气病在相距不远的过去，确实广泛存在于中国社会，那么在国人当中，就理应对其具有一定的认识；而不致在语言中出现将脚癣称之为脚气的问题（例如日本就各有名称，绝无混淆）。反之，从概念混淆、本义迷失、视脚癣为脚气这一现象，亦可证明真正的脚气并不多见于近代社会的一般民众之中。然而如果这一解释充分成立，则又必然会导致上述“困惑”之另一侧面的进一步加剧。即当脚气发生对于饮食条件的要求达到如此“苛刻”的程度时，我们是否还能相信古代文献中那些有关“脚气”的记载？或者说，顾名思义地将脚癣等与脚有关的疾病当成“脚气”的历

史，是否仅限于近代？

三、中国古代的脚气记载

虽然营养不足、维生素缺乏曾在极大程度上影响了国人的健康与发育，但通过上述有关资料的介绍与分析可知，除生活于二战前后这一“非常时期”中的若干“特殊人群”外，因维生素 B1 缺乏而引发的脚气病并非十分严重。那么，古代的情况又如何呢？尽管历代医学著作中多有关于脚气的记述，但已有的研究却足以说明：这一结论同样适用于此前的时代。为避免数据胪列导致文章变得冗长，甚至是干扰思路，在此只选一两位曾对这些记述做过详细考察之学者的研究结论，以示其要。

首先，具有临床经验的日本学者山下政三在其所著《脚气的历史》中，对中国古代的脚气病概貌，做出了如下归纳[①]：

1. 脚气病始见于晋代(265～420)。晋初或稍前，起源于岭南地区(广东省、广西省、安南地区)的脚气，逐渐向长江下游的南部地区蔓延，但为数稀少。

2. 西晋永嘉(307～313)年末，迁都南京后，始见脚气多发。然直到南北朝(439～589)时代结束，江北仍全然不见。

3. 隋(581～618)至唐初(618～?)，始越过长江、蔓延北方；唐代(618～907)广泛流行于中国全境。这一扩展方向，与米食的普及相一致。

---

① 山下政三：《脚气的历史》，第 1～3 页。

4. 北宋(960～1127)初期,虽可见脚气流行,但多属轻症。此后日见减少,因而出现了不解其义的医家,脚气病的概念随之混乱。北宋后期的所谓“脚气”,乃是各种腰脚痛、关节疾患。

5. 南宋(1127～1279)、元代(1271～1368)基本无脚气。当时被诊断为脚气者,大部分是腰脚痛、关节疾患之类疾病。

6. 明代(1368～1662)呈地区性散发,因而在某一局部可见对于脚气认知的提高。但总体上还是或将腰脚痛、关节疾患视为脚气,或将其与真脚气混为一等,概念极为混乱。

7. 清代(1662～1912)基本无脚气。相关医学知识近乎阙如。但据说清末在沿海地区有若干轻症出现。

在另一位对东亚脚气病做过专门研究的医史学家廖温仁所著《支那中世医学史》中,除强调“古无此病。周汉古籍所言脚之种种疾病,如厥、痿厥、缓风、湿痹、尰……流肿、痿躄等,仅是脚之麻痹、肿痛、软弱或风湿性关节炎。中日诸家强释为脚气,不当”之外,对于由晋至清之间,脚气出现时间、盛衰曲线、概念混淆状况的论说,可谓与山下氏所见略同①。

要之,山下与廖温仁两氏的研究,不但如同其他学者一样指出了“在古代医学著作的‘脚气’项下,混杂有种种其他疾病”的问题,而且均注意到:尽管宋、元、明、清的医学著作中不乏脚气之说,但实质却是概念的混淆,真正的“脚气病”基本不存在。如将此与前述民国时期的情况联系起来,岂非前后一贯,更可相互发明。

如此一来,前述困惑又得到了部分解决——宋代以后的问题基本可以释怀。但随着外围屏障的步步攻破,核心问题也就更加毫无遮拦地凸显出来——这个核心问题就是晋唐的“脚气之疾”。的确,

---

① 廖温仁:《支那中世医学史》,科学书院,1981年,第386～388页。

就症状描述而言，晋唐医书的记载确实与脚气病应有的表现极为相近。因而不仅是一般望文敷衍者，就连毫不轻信“脚气”之名、敢于对宋代以来之脚气记载做出近乎全面否定的山下与廖温仁两氏，也都承认晋唐的脚气记载是名实相符。并以“永嘉南渡之后衣缨之士以米易面”和“南粮北运”作为脚气这一新鲜疾病出现并越过长江向北蔓延的原因。但是他们似乎没有考虑到宋代以来米食日渐普及，何以反无此病？以致出现概念混淆、医家不识的问题。因而按照严谨的逻辑推理，我们只能承认：

1. 晋代在岭南与江南地区，出现了一种被当时医家称之为“脚弱”的疾病；唐代蔓延北方，并定名化为“脚气”。

2. 其症状特征一如《肘后》、《千金》、《外台》等所述，与过去习见之足部疾患有所不同。

3. 从临床症状的描述看，其病理改变为近代医学所言“多发性神经炎”。至于这种名称、临床症状，乃至病理改变皆与近代医学所言“脚气”相同的新疾病，是否因维生素 B1 缺乏而引起，则完全是另一个问题。

> 因为很多（营养）缺乏病的症状与非营养性疾病的症状相类似，……所以在发现有某些症状时，仅能大体地说：可能是由于某种营养素缺乏所致。实际上，除了很少数的缺乏症状有特异性外，其他都是非特异性的，即是可以由其他因素而发生的，要单独地凭症状来诊断往往有困难。
>
> 两侧对称的多发性神经炎是脚气病的症状，但是患严重糖尿病、传染性神经炎或重金属中毒等，都可以引起同样的症状。①

---

① 侯祥川：《营养缺乏病纲要及图谱》，第 52 页。

医史学家在论述晋唐医学时，虽然总要谈到“炼丹术”与“脚气病”两个问题，但似乎无人注意到重金属中毒的症状会与脚气相同，并由此想到两者间可能会有所牵连。

四、矿物药中毒的问题

尽管神仙不死、服食炼丹之术的历史，可以追溯到战国甚或更早，但着眼于借助金石不朽之性以求肉身永驻之观念的产生，却相对而言要晚得多；虽然丹砂、水银的利用①早已见于原始人类与始皇的墓葬，但饵食之风的兴起与隆盛，也需另当别论。在陈国符先生所撰《中国外丹黄白术考论略稿》②中，给出了许多有助于了解这段历史的重要提示，摘录如下：

1. 丹即丹砂，即红色之硫化汞。金丹者，丹砂而可制黄金者。金丹至唐代通称外丹。

2. 我国之金丹术与黄白术，可溯源至战国时代燕齐方士之神仙传说与求神仙仙药；盖战国时代先有神仙传说与求神仙奇药，及西汉始有金丹术与黄白术之发端也。

3. 西汉以丹砂制黄金（《史记·封禅书》言李少君“事化丹沙诸药齐为黄金”；《汉书·淮南王安传》云方术之士所作《中篇》，“言神仙

---

① 卢嘉锡、路甬祥主编《中国古代科学史纲》（河北科学技术出版社，1998 年，第 307 页）云：中国“至迟在公元前 7 世纪春秋时代就开始利用水银了；至迟自战国时代就开始人工炼制水银”。“古代的炼汞法有低温焙炼法、下火上凝法、上火下凝法以及蒸馏法四种”；“最初的炼汞法可能是低温焙炼法，操作者易遭受汞中毒”。

② 收于陈国符：《道藏源流考》下册，中华书局，1963 年，第 370～437 页。

黄白之术”;《汉书·刘向传》载“吏劾更生铸伪黄金”),但是否用以服食,史未明言,不可考。然刘向《神仙传》载“任光,善饵丹”、“主柱,饵丹砂”、“赤斧,炼丹,与消石服之”,是西汉或西汉以前,已有饵丹砂者。

4.《抱朴子·金丹》述小饵丹方多种,皆用丹砂。故虽从葛洪所言“余问诸道士以神丹金液之事,……了无一人知之者。……或得杂碎丹方,便谓丹方尽于此也”可知:至晋代为止,金丹尚少传布。但从饵食丹砂的角度观之,却并无本质区别。其主要成分皆为汞、砷和铅。

5. 南北朝时,金丹术较晋代为流行。及唐代,外丹术乃臻极盛。唐梅彪《石药尔雅》列“有法可造”之丹名 70 种,“有名无法”者 28 种。盖是时飞炼外丹,全国已成风气。

6. 宋人之于外丹,多已不复置信;斥外丹黄白为邪术,专讲内丹。故自宋代起外丹乃衰降。及元明,外丹术衰微。

7. 葛洪 24 岁时往广州,遂停南土,尝由日南(越南之顺化)往扶南(柬埔寨与越南南部)。其后因所闻见,记晋代南洋产砂之国,附于《太清金液神丹经》之后。咸和初,洪欲求丹砂,又至广州,止罗浮山而卒。

8. 伴随着饵食金丹,中毒身亡的记载亦时有所见。此乃唐代之后,外丹衰微的重要原因之一。

结合以上陈国符先生所述外丹兴衰的梗概,对矿物药中毒与脚气病之间可能存在的牵涉,产生出以下几点看法:

首先,就第 7 条葛洪南行求丹观之,岭南无疑是产丹砂、水银之地。故在当地存在因饵食丹砂,或因制炼、生产水银所致慢性中毒的现象,当属自然。葛洪至此,始见此等以肢体软弱无力为主要表现的

多发性神经炎患者，于是乃有“脚弱之疾，先起岭南”之说①。尔后江南金丹渐兴，服食中毒，乃必然因果。故若推测衣缨之士南渡后必染此风而有此等病证，似乎要比推测他们过着食无鱼肉、菜蔬，唯以精白米果腹而患脚气，更为合理一些。

其二，古代的资讯交通，不比当代如此迅速畅通。因而虽饵食丹砂、制炼水银所致中毒，必存在于葛洪之前，但囿于闻见所限，故记说之事往往多系身历。间接经验的综合，在早期极为有限。

其三，除汞之外，铅、砷中毒也是极需注意的问题。这是因为在外丹术中，视赤色的丹砂为“阳”，黑色的铅为“阴”——阴阳相济，才能“合得至宝”②。“铅与汞是金丹术中的双翼，几千年的研究都以铅、汞为主要对象。铅的发现更早于汞。”③同样，砷的使用也很普遍。现代医学著作在谈到脚气病的鉴别时，特别强调了与铅、砷中毒的鉴别。就铅中毒而言主要有以下三种情况，鉴别要点在于：

1. 绞痛型——疼痛在腹部的脐下区，属阵发性，喜按，呕吐，便秘。

2. 瘫痪型——肌肉疼痛痉挛，随后呈瘫痪。以常用肌肉为显著，如腕指、腓肠，成垂腕、足垂。

3. 脑病——头痛、记忆减退、失眠、耳鸣、幻听、谵妄、激昂或忧郁。而砷中毒时：“与铅中毒多相似。显著的感觉障碍为与肌萎缩性脊髓

---

① 据卢嘉锡、路甬祥主编《中国古代科学史纲》(第311页)介绍，时至今日，贵州、云南、湘西等地仍采用土法炼汞。由此可见，“岭南”确属产丹之地。所不同者在于，如果出现中毒所致多发性神经炎，不会有人再将其称之为“脚弱”。

② 王琎：《中国古代金属化合物之化学》，载于王琎等：《中国古代金属化学及金丹术》，中国科学图书仪器公司，1957年，第11页。

③ 曹元宇：《中国古代金丹家的设备和方法》，载于王琎等：《中国古代金属化学及金丹术》，第68页。

侧索硬化症及铅中毒的区别点。”①就此观之，恐怕首先不得不承认矿物药中毒与脚气的症状表现，实在是相同甚多——即便是“鉴别要点”，也谈不上泾渭分明。盖因两者的实质性病理改变皆是多发性神经炎。其次，毋宁说古代医学文献中描述的脚气症状，有很多与矿物药中毒的症状更为相似。例如，《千金要方》论脚气见症时所说：“有脚未觉异，而头项臂膊已有所苦；有诸处皆悉未知，而心腹五内已有所困”；“或见食呕吐、憎闻食臭，或有腹痛下痢，或大小便秘涩不通”；“或精神惛愦，或喜迷忘、语言错乱”；“或觉转筋，或百节挛急”；“或小腹不仁”②，等等，或较之“先见下肢痿软无力、腓肠肌疼痛”为主要症状的脚气病，更接近于上述矿物药中毒的某些特征。

其四，唐代金丹风行全国之前，北方虽早有服石之风，但流行的主要是五石散。其主要成分为钟乳石、白石英、紫石英、赤石脂与硫磺，不含最易引起多发性神经炎的汞、铅等重金属。③ 从医学著作的记载中可以看到，服用五石散后最主要的症状表现是燥热难耐，需寒食、寒饮、冷水洗浴，故五石散又称“寒食散”；此外则是因各种疮痈之症，夺人性命。因而是否可以考虑：恰是随着含汞、铅之剂的外丹北越长江、风行全国，以汞、铅为代表之重金属中毒的多发性神经炎病症，也才殃及中原的士大夫。

其五，史书中虽不乏对于中毒现象的认识，但毕竟是以急性中毒（短期内死亡）和显而易见的体表征象（疮痈发作）为主。例如，《宋

---

① 上海第一医学院：《实用内科学》，人民卫生出版社，1959 年第 5 版，第 396、401 页。

② 《千金要方》卷七《论风毒状第一》，第 138 页。

③ 但也有人推测五石散含磐石（一种含砷矿物），理由是上述“五石”并无剧毒。详见王奎克：《“五石散”新考》，收于赵匡华主编：《中国古代化学史研究》，北京大学出版社，1985 年，第 80 页。

书》载刘亮服丹后,“心动如刺,中间便绝”;《华阳陶隐居内传》记衡山道士邓郁之“饵之而死”;《魏书·释老志》云魏太祖令“死罪者试服之,多死无验”,但却将原因归于服丹“非其本心”;常被引用的赵翼《廿二史札记》所述唐太宗、宪宗、穆宗、敬宗、武宗、宣宗,及臣下杜伏威、李道古、李抱真的服丹之害,皆是中毒致死;诸书所载某人服丹、“白日升天”,亦是急性中毒所致迅速身亡。此外则是服丹后“眉发立坠头背生疮”、“患疽致死”的描述①。而对于慢性中毒,则少见论述。换言之,由于认知水平的制约,尚未能在慢性中毒之“果”与服丹之“因”间,建立起认识上的联系。致使将慢性中毒的表现,视为与丹药无关的独立疾病。

总之,上述外丹兴起于晋代、历南北朝而大盛于唐,宋元之后内丹走俏而外丹衰微、逐渐演变成外用药的“时间坐标”,与脚气兴衰的曲线可谓大致吻合。如果摘掉“米食必致脚气多发”这副有色眼镜,则恐怕很难认为这种吻合纯属偶然。

此外,由于在有关脚气病的较早全面性记述,即唐代医家孙思邈之《千金要方》的论述中,谈到此病出现后,岭表江东有释门中人支法存、仰道人等“偏善斯术”;“又,宋齐之间,有释门深师,师道人述法存等诸家旧方,为三十卷。其脚弱一方,近百余首”;《外台秘要》“砺砂牛膝三物散”下记:“苏恭《脚气方》云是婆罗门法”,因而使人考虑到:脚弱(或脚气)这一新病名的出现,是否会与佛教传入的时代背景有关?即是否存在西域医术影响的问题。② 沿着这条思路,又发现“在

---

① 对于魏晋以降,外科疮痈著作的迅速发展,史家多以为与服石中毒具有密切关系。详见赵璞珊《服石与外科发展——兼论〈刘涓子鬼遗方〉》,参见氏著《中国古代医学》,中华书局,1983年,第77~80页。

② 例如范家伟《东晋至宋代脚气病之探讨》(《新史学》,1995,6(1):155)即依据这两条资料谈到“西域医术影响”的问题。而我在《江戸時代の腳氣について》(《日本研究》第14集,1996年,第103页)一文中亦对此表述了完全赞同的意见。

西方文献中，最早记载此病的是 jacob De bondt (Bontius)之《印度医学》(*De medicina Indorum*, 1642)"①。但当我以为会在古代印度医学文献与专讲佛教医学的著作中，找到类似的病名或记述时，却竟然一无所获。这说明，尽管晋唐时期确实存在西域医学知识的传人，而且我们对其诸多影响至今仍可谓"知之甚少"②，但僧医对"脚弱"之疾的认识与治疗方法，却未必简单到直接源于西域医学知识。因为大多数僧医生长在中国，虽其社会身份为"僧"，但所掌握与使用的医学知识、治疗技术却源于"汉"。因而我现在对僧医善治"脚弱"的问题，另有一解：

据《隋书·经籍志》载，魏晋以来有释道洪撰《寒食散对疗》一卷、释智斌撰《解寒食散方》二卷、释慧义《寒食散杂论》七卷。虽不可言多，但在书志所载数量极为有限的释家医方中，仍可谓十分醒目。佛教徒行医术，本兼有弘教之目的，故于中国传统的神仙方术自然要形成抵触与较量。"灵帝崩后，天下扰乱，独交州差安，北方异人咸来在焉，多为神仙辟谷长生之术，时人多有学者，牟子常以五经难之，道家术士莫敢对焉。"③可见佛教徒是站在神仙方术的对立面上，因而一些僧人撰"解散"方书、从事服石之疾的治疗，或许含有超出一般医疗行为的用意，应进一步从佛道两家对立的角度深入思考。

---

① C. Singer & E. A. Underwood, *A Short History of Medicine*, 第 612 页。

② 季羡林序《饶宗颐史学论著选》(上海古籍出版社，1993 年，第 19 页)时感慨："中印文化交流关系千头万绪。过去中外学者对此亦有很多论述。但是，现在看来，还远远未能周详，还有很多空白点有待于补充。特别是在三国至南北朝时期，中印文化交流之频繁、之密切、之深入、之广泛，远远超出我们的想像。在科技交流方面，我们的研究更显得薄弱，好多问题我们基本没有涉及。……我深深感到，我们在这些方面的知识何等浅陋。"

③ 牟融：《理惑论》。据梁释僧佑撰《弘明集》卷一，四部丛刊初编缩本，第 8 页。

五、脚气病史的研究

综上所述不难看出，在脚气病史研究中存在着两个重要的问题。一是如果我们放弃了已成“定论”的“白米病因说”，并承认仅仅依据症状描述，实难判断历代文献记载于“脚气”病名项下之疾病的性质，那么真正的“脚气病”的流行状况究竟如何？其二则是当这一病名成立时，其性质是否为“真脚气”，抑或是在某一历史时期才出现了概念的混淆与本义的迷失？这些显然都是医史研究，特别是疾病史专题研究所应回答的问题。然而迄今的中国脚气病史，在这两个关键问题上展现的实在是一幅令人疑惑丛生的图画。问题的产生，显然与“绘图方法”具有密切的关系。因而我愿在就这些问题做进一步探讨的同时，顺便借题发挥地谈谈医史研究中的一些问题。

首先是“真脚气”流行史的问题。众所周知，绝对忠实地再现过去，对于史学的任何一个领域来说都是不可能的。历史的真实面貌永远都不会像史书中所记述的那样简单。而这一点在疾病史中的严重程度，大概可以说名列前茅。其原因在于生命现象（疾病也是一种生命现象）的复杂程度，在自然界中位居榜首。具体到脚气病来说，由于具有相同病理改变与临床表现的疾病有多种（如梅毒、白喉等各种感染，酒精中毒、妊娠、糖尿病、肝肾疾患、矿物药，都能引发“多发性神经炎”；此外还存在着家族性与原因不明的“慢性进行性多发性神经炎”），因而即便是对于现代医学来说，其鉴别诊断也是一件非常困难的事情；而对于古人来说，易于混淆的疾病就更多了，例如风湿病——不仅与脚气病同样具有肌肉、关节病变，而且还有脚气病中所

强调的“冲心”之症(心脏病变)。因此在探讨“真脚气”的历史时,我们只能客观地说:以近代的实证资料为依据,中国历史上确实存在着真正的脚气病;但其存在的历史并非简单到古今一脉、但见脚气之名即有脚气之实的地步。

然而这种实事求是的结论定然不会令“以记述科技成就及其发展变化为己任”的科学史家感到满意。其原因在于:科学史研究,出于这一学科自身概念与定义的需要,总是在有意无意地挑选那些符合“近代科学”、具有“科学价值”的历史事件加以描述,借以说明历史上的发明与发现,以及相关的人物如何伟大。若仅止于此,问题倒也不大,要命的是以近代科学知识强释古人。例如在脚气问题上,坚持将《千金翼方》中的“穀白皮”说成是“谷白皮——即较细糠秕”,用以说明古人对病因早有正确认识,并有完全符合近代营养学的治疗方法①,即是一例。另一方面,虽然科学史也是一种历史学,但较一般史学更多地具有科学哲学的味道,总是在试图解释科学认识发展的连贯过程。因而往往会不自觉地出现不适当地“构建历史”的倾向——即通过淡化不利因素,把原本十分复杂的问题,简化为一个单纯的问题;有时还需在断裂的史料记载间增入一些链接成分,从而完成一个系统的解释。与此同时,由于一般史学家难免缺乏对于自然科学专业知识的足够了解,所以通常总是借助专科史的研究成果来进行自己的社会史研究(例如在“南北移民”的研究中,引用有关脚气之疾的论说)。在这种情况下,如果基础出了问题——专科史的所谓研究成果并不正确,那么建立在此基础之上的“大厦”将会如何,自然

---

① 马伯英:《中国医学文化史》,上海人民出版社,1994 年,第 569～570 页。范行准氏早已指出:“此予友李君失检致一再误传也。穀,非谷也。穀亦称构,古多与楮为一物……乃高二三丈之落叶乔木。”见核堂:《医史卮言·脚气》,《医史杂志》,1948,(3·4):37。

可想而知。

其次则是脚气病名成立时的性质问题。于此我们既可看到近代中国假日本之径学习西方医学的历史，亦能看到其对中国医史的影响。

本文第一节曾经使用“脚气概念的混淆与本义迷失”的说法，其时是将“脚气”作为维生素 B1 缺乏症的病名来使用的。然而在经过二、三、四节的论说后，如果还要使用这一说法，那么就只能更加严格地将脚气的“本义”释为：“具有晋唐医书所述症状的那种疾病”；而所谓“概念的混淆与本义的迷失”，也只能是针对宋代以降，医家不识脚气为何、望文生训的现象而言。因为“脚气”与 beriberi 的对译，释其病因与饮食结构相关，进而阐明本质是“维生素 B1 缺乏症”，乃是在日本海军军医高木兼宽及西方学者，分别对流行于近代日本海军中和南亚诸国的“真脚气”进行独立研究之后才逐渐形成与明确的①。实际上，直到 20 世纪 20 年代中期，“脚气＝beriberi＝维生素 B1 缺乏症”这一脚气“概念”都未在当时的中国医界占据主导地位。例如，1924 年内务部为派代表参加涉及脚气等地区性流行疾病的国际医学会议，致函中华民国医药学会，云：

> 查脚气病，为吾国南方数省，时有发生，北省次之。究因为何发生，有何防止方案，亟需互相讨论。②

说明既不知病因，也不知治法。至于病名，显然不过是在接到邀请函

---

① 在此之前，尽管“真脚气”在日本十分猖獗，但“脚气”同样是一个“历史的病名”，一个完全依据临床症状而不问病因为何的病名。概言之，凡见“冲心”之症（或肢体症状），即名之曰“脚气”，而不管引起上述症状的原因是真脚气，还是梅毒性心脏病、胆道蛔虫或其他。详见拙著《记载与诠释——日本脚气病史的再检讨》。

② 《内务部致中华民国医药学会函》，《民国医学杂志》，1924，(10)：25。

后，照本宣科。又如1925年的医学论文，还将脊髓灰质炎（小儿麻痹后遗症）称为脚气：

> 肠“梯扶斯”及巴拉“梯扶斯”等经过之中，所谓并发症脚气者，致其预后不良或既治愈之后，亦使遗有下肢运动及知觉麻痹，永不得自由步行诸憾事，颇为多睹。
>
> 复披览外国文献，多发性神经炎之并发于肠“梯扶斯”者，亦多有记载。①

“梯扶斯”即“チフス”（伤寒）；“巴拉”乃“バラ”（蔷薇），巴拉“梯扶斯”即癍疹伤寒。值得注意的是，古代医书言“伤寒后发脚气”，即发热数日后见下肢麻痹，与此相似。再看一个称铅中毒为脚气的例子：

> 患儿，四个月，人乳营养
>
> 既往症：一月前精神不爽，时呈呕吐无热，绿色黏液样下痢，来院求治。
>
> 现在症：下腿浮肿，膝及阿细雷斯腱反射（一），胸壁连珠著明，当即就乳儿脚气之诊而加疗焉。
>
> 不数日浮肿尽消，及一星期后则见嘎声，由耳鼻咽喉科之检查，又证明左侧回归神经麻痹，故乳儿脚气诊益确，但至入院后十八日，四肢渐呈痉挛……
>
> 患儿母体检查：皮肤铅反应（＋＋）
>
> 诊断：脑膜炎，乳儿脚气及佝偻病。
>
> 此病之原因实由于铅中毒，来源：母体之化妆品。②

---

① 谢宝贤：《“梯扶斯”样病及脚气》，《民国医学杂志》，1925，(5)：262。

② 稻叶逸好：《所谓脑膜炎乳儿脚气及佝偻病》，《民国医学杂志》，1926，(10)：408。

有意思的是，此例的报告者为日本医生，但他却将自己明言“病因实为铅中毒”、只是临床症状为多发性神经炎的这个病例诊断为“脚气”。结合上述脊髓灰质炎之例观之，看来直到此时“依据肢体症状的脚气诊断”仍旧不衰。这位日本医生还讲述过另外一例“脑型乳儿脚气”①，但两例均未言明是在中国，抑或是旧日在日本的经验。1940年，有余惠民氏以维生素B剂治疗一例脚气的“实验报告”②。以上就是我查阅手边可得之这一时期的《民国医学杂志》，所获有关脚气的记载。虽然没有时间去详查所有的杂志，但从相关文章的数量及这些报告皆属“一例”，即可推知其发病频度，更何况这难得的几篇报告还不都是“真脚气”。

恰因此时医学领域中出现了“脚气＝beriberi＝维生素B1缺乏症”的新知识，所以在史学性论述中也就自然而然地出现了相关文章。③ 于是这一伴随着医学发展才出现的病名“新义”，便被说成了是晋唐脚气之名的“本义”。科学史研究领域中“成就派”的看家本领——发明权之争，于此亦有表现。例如耿鉴庭云唐代元稹(779～831)诗中“短脚知缘旧施春”一语与霉米致脚气说类似，译作“我知道你的脚病是因为吃了旧日人家布施的陈米”。又就教其师丁福保老先生，得复示：“这样解释，一点不错。”故谓：中国人言“霉米致脚气

---

① 稻叶逸好讲，王有纲记：《脑型乳儿脚气》，《民国医学杂志》，1926，(11)：453。

② 余惠民：《“惟皮革新”Vibixin治疗脚气之实验》，《新医药刊》，1940年9月，第94期，第54页。

③ 据中国中医研究院编《医学史论文资料索引1903—1978》，此间可见陈邦贤《中国脚气病流行史》(1927)，廖温仁《脚气病疗法之历史的研究》、《东洋脚气病理之历史的研究》(1929)，汪淑子《脚气病与名人》(1931)，汤慕殷《脚气病考》(1940)，傅刚《脚气病概论》(1941)等文章。

之说，较铃木梅太郎之发明，尚早一千余年”①。然范行准以为其解诗有悖本义。同时另据唐初孟诜言黍米：“不得与小儿食之，令不行。若与小猫食之，其脚便局曲不正；缓人筋骨，绝血脉”，而将“食白米而致脚气”的认知时间又提前了数百年，并说：“苟铃木诸人先能参此文献，或能早悟其因，而维他命发现权自可拔赛先登矣。”②其后，侯祥川更是盛赞“我国先人对脚气病的发现远早于其他国家。在比较可靠的记载里，《左传》与《诗·小雅》在公元前 544 年即已记载此病”；“并有很多经验符合于现代脚气病的科学理论”③。直到今日，言及中国的“世界第一”时，亦多要谈到此事④。

但从另一方面讲，也并非所有的人都如此看待中医的脚气病名。例如俞尔科为《中国大百科全书》所撰写的“脚气”词条，就采取了比较慎重的态度：首先，没有将脚气等同于 beriberi，而是译作 weak foot；其次，在症状描述后，虽言“此病即西医的脚气病”，但又说：“包括维生素 B1 缺乏，以及营养不良、多发性神经炎等疾病。”再者，在病因和治则上，采用了传统的外感、内伤说，及利湿、调和气血法，只是在最后提到：“应多食粗粮、瓜果蔬菜，不宜单食精制的大米和面粉。”⑤值得注意的是，这种观点作为《大百科全书》的词条，是要经过编委会审定的，因而与一般论文不同——所代表的并非一己之见。然而遗憾的是，很难看到有人注意、接受这样的观点。就像人们乐于相信“华佗可行剖腹手术”，而从不理睬对此的怀疑与考证；乐于接受“对于药物的认识都是来源于生活经验”的说教，而无意深究巫术式

---

① 耿鉴庭：《元稹的咏病诗》，《医史杂志》，1948，(3·4)：24。
② 核堂：《医史卮言·脚气》，《医史杂志》，1948，(3·4)：37。
③ 侯祥川：《我国古书论脚气病》，《中华医史杂志》，1954，(1)：16。
④ 例如蔡景峰所著《中国医学史上的世界纪录》，第 92 页。
⑤ 《中国大百科全书·中国传统医学卷》，第 203 页。

思维方式的重要作用一样。这种现象的普遍化，除了前述研究者自身的原因外，还在于就一般民众与社会宣传媒体而言，对于历史问题的解说，只有与当代一般科学知识、思维方式相吻合时，才能被理解、被接受。就像高深的佛理只有被“世俗化”为念一句“阿弥陀佛”即可往生西方净土时，才能获得广大的信徒。

尽管上述有关脚气问题的研究，已然显得十分复杂、头绪万端了，其实还远远不够。例如，我们尚未涉及脚气发病率的高低，是否与人种、民族有关的问题；既然脚气的基本病理改变是多发性神经炎，自然就与神经系统具有密切的关系，那么所谓“非常时期”的脚气多发，除饮食条件外，是否与精神因素有关？城市与乡村，在饮食结构基本相同的情况下，城市多发，这与空气等种种其他因素是否有关？……

站在这样一个中间地带，灵魂中“属阳”的一半欲罢不能地试图深入、深入、再深入，将脚气，不，将医学史中的每一个问题都搞清楚；而“属阴”的另外一半灵魂却总是在说：“这有什么用呢？文字游戏！你们的所谓学问，不就是在古书今作中抄来抄去吗?!”——这其实不仅仅是我灵魂中的自我矛盾，实乃发生在许许多多科学史工作者，以至史学研究者家中的夫妻、父子间的真实对话。难道科学史也需要做一点“世俗化”的改造，才能被理解、被接受吗？因“亲身感受”而产生的对于脚气的种种困惑，通过上面的辨析，大致可以解决；而因治科学史之“亲身感受”所产生的种种困惑，又当如何解决呢？

性命双修

——道家养生之意

中国古代各种哲学思想均程度不同地对中医理论体系的形成有所影响。比较而言，道家思想的影响尤为重要。但当前对医、道二者关系的一些评述却不甚正确。如有人认为“医学之有阴阳五行之说，原由道家渗入”，并以为具有这些古代哲学思想内容的医学理论体系乃“道家新创之医说”①。也有人径以“《老子》的医学思想”、“《庄子》的医学思想”为题而大加阐发②。这种明显有悖于老、庄道家思想本意的看法，虽不能代表一般科技史家与史学家的普遍看法，但以为追求长生不死乃是道家宗旨之一，因而开创了中医养生学的观点，却是极为常见的。其实这种观点只是未能正确把握道家思想精髓而产生的一种偏见，不足以说明道家思想与中医养生学之间的关系，及其对于中国古代医学理论体系发展的影响。兹就此试加辨析。

一、道家生命观

一般认为道家思想的特征之一，是幻想通过各种养生修炼而达

---

① 刘伯骥：《中国医学史》。

② 李良松，郭洪涛：《中国传统文化与医学》。

到长寿不死,“因而开创了中医养生学”①;或从考察养生学源流的角度说:“寿命的无限延长说,即源自哲学特别是老庄学说。”②著名的中国科学史家李约瑟在其《中国科学技术史》中强调指出:“道家思想乃是中国的科学和技术的根本”,研究道家思想体系“对于了解全部中国科学技术是极其重要的”。但他也同样认为:“道家思想从一开始就迷恋于这样一个观念,即认为达到长生不老是可能的”;“道家迷恋于肌肉坚实、肤色丰美的青春,他们相信可以找到能够用以遏制衰老过程或返老还童的技术”③。可见,李约瑟乃至许多科学史家都自然而然地将追求不死成仙的思想和服食、导引、房中、行气等各种具体养生方法的起源归之于道家和道家思想体系。

然而如果我们认真考察一下先秦道家对于“寿命生死”问题的看法,就不难发现上述观点并非道家宗旨。在《老子》中,虽然没有直接讨论人的寿命生死问题,但从其一切均不得违反自然规律的宗旨观之,是不可能相信长生不死的,即所谓:“飘风不终朝,骤雨不终日”;“天地尚不能久,而况于人乎?”④而成书于其后的《庄子》,对于生死乃自然规律这一点,则有较明确的说明,如:“终其天年而不中道夭者,是知之盛也”;“死生,命也”⑤。“生之来不能却,其去不能止”⑥。在《庄子》借寓言、故事阐发道家思想的表现形式中,虽然提到寿限“上及有虞,下及五伯”的彭祖;在南伯子葵与女偶的对话中有“子之年长矣,而色若孺子,何也”⑦;肩吾闻于接舆言:“藐姑射之山,有神

---

① 《中国医学百科全书·医学史卷》,第33页。
② 《中国大百科全书·中国传统医学卷》,第558页。
③ 李约瑟:《中国科学技术史》第二卷《科学思想史》,第154页。
④ 《老子·二十三章》。
⑤ 《庄子·内篇·大宗师》。
⑥ 《庄子·外篇·达生》。
⑦ 《庄子·内篇·大宗师》。

人居焉，肌肤若冰雪，淖约若处子”①，等等，但不能将这些描述作为道家追求长生不死的例证。因为道家引用这些故事传闻，目的在于说明凡事不可刻意追求，即所谓：“世之人以为养形足以存生，而养形果不足以存生，则世奚足为哉？”②另外，《庄子》在以封人与尧之名写成的对话中，更加明确地表达了道家“不知说（悦）生，不知恶死”，方为“真人”的思想：

> 封人曰：“寿、富、多男子，人之所欲也。女独不欲，何邪？”尧曰：“多男子则多惧，富则多事，寿则多辱。是三者，非所以养德也，故辞。”③

类似的言词还有许多，但均说明了一个事实，即先秦道家作为一种富含哲学内容的思想体系，不仅原本不存在追求长生不老、得道成仙的思想，而且与这种思想还是相互对立的。道家关于养形不足以存生的见解，或“方生方死，方死方生”④等关于生命现象的阐说，并不仅仅在于要人们懂得追求不死成仙的荒谬，而更重要的是借助“死生”这一最能反映自然规律无法抗拒的事实，去说明自然规律和“道法自然”的思想宗旨。

道家是主张“保身”的，但这一概念同样不包含追求长寿的含义。《庄子》曾以舜让天下于子州支伯，而子州支伯却以“予适有幽忧之病，方且治之，未暇治天下也”却之，和子华子以“两臂重于天下”劝昭僖侯莫争邻国之地等事例，说明“此有道者之所以异乎俗者也”，“能

---

① 《庄子·内篇·逍遥游》。
② 《庄子·外篇·达生》。
③ 《庄子·外篇·天地》。
④ 《庄子·内篇·齐物论》。

尊生者，虽贵富不以养伤身，虽贫贱不以利累形”，不可“见利轻亡其身”①的价值观念。

若参之以《韩非子·显学》中有关“身”与“寿”的议论，则更能清楚地看到这两个概念的差别：

> 今或谓人曰“使子必智而寿”，则世必以为狂。夫智，性也；寿，命也。性命者，非所学于人也。而以人之所不能为说人，此世之所以谓之为狂也。
>
> 今有人于此，义不入危城，不处军旅，不以天下大利易其胫一毛，世主必从而礼之，以为轻物重生之士也……今上尊贵轻物而重生之士，而索民之出死而重殉上事，不可得也。

尽管在言及“保身”思想时，必须要考虑到杨朱学派的影响，以及《庄子》外篇、杂篇的一些内容是否出于后学之手等问题，但有一点是十分清楚的，即无论是道家的“保身”还是杨朱的“贵身”，原本都是对人生价值观的阐发。至于说杨朱后学与道家后学如何将这种身与天下孰轻孰重的价值观念改造成清心寡欲、长生久视的养生理论，则将在后面讨论。

二、道家本旨与“养生”

“养生”一词，首先见于道家经典《庄子》一书，这也就是后来有人认为养生学源于道家思想的原因。但是，《庄子》一书中先后三次出现的“养生”一词，基本上都不具备后世使用这一语词时所要表达保

---

① 《庄子·杂篇·让王》。

养身体、促进健康长寿的概念。

首先,在《内篇·养生主》中,以“吾生也有涯,而知也无涯。以有涯随无涯,殆已”的问题,引出一段“庖丁解牛”的故事。文惠君在听完庖丁讲解何以“臣之刀十九年矣,所解数千牛矣,而刀刃若新发于硎”的道理后说:“吾闻庖丁之言,得养生焉。”意即领悟到了如何轻松自如地治理天下,而不必再像尧舜那样“股无胈,胫无毛,以养天下之形,愁其五藏以为仁义,矜其血气以规法度”①。

其次,在《外篇·达生》中再次提到“养生”的问题:“善养生者,若牧羊然,视其后者而鞭之。”这里,“养生”几乎可以看作是“驭民”的同义词。然后以单豹(“养其内而虎食其外”)和张毅(“养其外而病攻其内”)二人亡故的故事来说明治世不可偏执一端的道理:“此二子者,皆不鞭其后者也。”

最后,在《杂篇·让王》中亦涉及到“养生”二字:“道之真以治身,其绪馀以为国家,其土苴以治天下。由此观之,帝王之功,圣人之馀事也,非所以完身养生也。今世俗之君子,多危身弃生以殉物,岂不悲哉!”这一节紧衔本文第一节所提到的“保身”若干事例之后,所言“完身养生”虽然表达了生命重于名利的思想,却没有后世所用“养生”一词的固有含义。

总之,由于先秦道家思想所强调的“道”含有对自然规律的理解,所以“无为”的本意是要人们顺应自然,不做违反自然的事。人类及其他一切生物,与无机物一样,都是自然的组成部分,因而不论是人的躯体(生命),还是人类的社会秩序也都要顺应自然,这就是“无为而治”的经世之道。“养生”一词在这里是概括从“无为”到“无不为”之间的具体方法,因而自然而然地出现在论说治国、驭民、保身的各

---

① 《庄子·外篇·在宥》。

个方面。如果能够注意到在《庄子》一书中，对于与肉体寿限有关之事，多以“养形”名之，则不难体会“养生”的“生”字，主要是指人类的社会秩序，并不是就生命(形体)本身而言。

对于先秦直至西汉前期道家思想体系实质的把握，实在不应忘记《汉书·艺文志》的评语：“道家者流，盖出于史官，历记成败存亡祸福古今之道，然后知秉要执本，清虚以自守、卑弱以自持，此君人南面之术也。”虽然道家与儒家的治世之学相互抵触，然其本质不过是“道不同不相为谋”①而已，切不可将道家思想仅仅理解为纯属消极“出世”的学问。

三、“养形”之术

正如前引《庄子·外篇·天地》中所言：“寿、富、多男子，人之所欲也。”对于死亡的恐惧和长寿的希求，乃是人类的本能，而当人们力图通过某些手段与方法去有目的地实现这一愿望时，就出现了所谓的养生之术。如同文化与文明的任何其他表现形式一样，养生之术也是人类智慧的产物，是构成文化与文明的组成部分。从这一角度出发，则不必要也不可能深究养生之术究竟起源于何时，养生思想与行为的产生是十分自然的，完全不需依赖任何思想体系或睿智哲人的启发。

事实正是如此。前面已经说明了追求长生久视等思想与道家思想体系的不兼容性，现在则要说明这些方法如何独立于道家思想体系之外，客观地存在于当时的社会之中。

---

① 《史记·老庄申韩列传》。

《庄子·外篇·刻意》称:“吹呴呼吸,吐故纳新,熊经鸟申,为寿而已矣。此道引之士、养形之人、彭祖寿考者之所好也。”这段话足以说明两个问题:首先,庄子将“道引之士、养形之人”与“山谷之士、非世之人”,“平世之士、教诲之人”,“朝廷之士、尊主强国之人”,“江海之士、避世之人”等四者相提并论,认为皆属“刻意尚行”的无道之士,是不为道家所提倡的。只有达到“不刻意而高”、“不道引而寿”的境界,才是“天地之道、圣人之德”。这就十分清楚地表明了先秦道家对养生之术的态度。

其次,这段话还说明习练养生之术的“道引之士、养形之人”已是当时社会的客观存在,是追求“寿考”者的行为。就养生之术的具体方法而言,“吹呴呼吸,吐故纳新”是行气之法,“熊经鸟申”是导引之术。又,《内篇·逍遥游》中还提到有“不食五谷,吸风饮露”的神人,可见辟谷之术在当时已经流传。现在就以马王堆出土的帛书、竹简为例,来看一看后人称之为“养生”,而在先秦道家眼中只能称为“养形”的诸种方法的概貌。

一、辟　谷

马王堆出土的《却谷食气篇》对其具体方法及“绝谷”后出现不适反应的调理方法有所介绍。其法要求“与月进退”,即自朔日起“去谷食石韦”,日增其量,至月圆后逐日减少。当感到“首重足轻体轸”时,“则呴炊(吹)之,视利止”。由于此法在“辟谷”之后,仍食用某些特定植物,兼行“呴吹”,故亦有“食气”、“服食”诸法的性质。

二、食　气

是指依照一定的方法进行呼吸,以达到养生的目的。其理论基础是认为“天地之至精,生于无征,长于无形,成于无体,得者寿长,失

者夭死”。要点在于:强调深呼吸,“翕(吸)气之道,必致之末……息必探(深)而久”;时间有朝暮之别,“宿气夜散,新气朝聚,以彻九窍而实六府”。四季各有避忌,“食气有禁,春避浊阳,夏避汤风,秋避霜雾,冬避凌阴”①。

三、服　食

此法内容最多,在马王堆帛书中有“食松柏,饮走兽泉英,可以却老复壮、宁泽有光”;“夏三月去火,以日爨享(烹),则神慧而聪明”;“春三月食之(指薤),苛疾不昌,筋骨益强,此谓百草之王”;卧时饮淳酒,以其为“五谷之精气”,等等。

四、导　引

是指通过躯体运动达到祛病健身之目的,故有医疗体育之称。马王堆出土的《导引图》绘有各种姿势的人形,旁注“引聋”、“引膝痛”、“熊经”、“以杖通阴阳”等,正与《庄子·外篇·刻意》所云:“道引之士、养形之人”喜好“熊经鸟申”相合。

五、接　阴

是指男性可以通过某种特定的性行为方式,达到长寿的目的。在记述各家论长寿之策的《十问》中,有六家言及此事,足见其在当时的养生学中占有极为重要的地位。在这六家中唯有“彭祖”一家主张以彻底禁欲的方式来避免“阴精漏泄”而致病,其他五家均着眼于性行为方式与长寿的关系。其要点为:

1. 不泄精,“必使玉泉毋倾,则百疾弗婴,故能长生”。

---

① 《十问》,见《马王堆汉墓帛书四》。

2. 在性行为的过程中，以“吸入”(“饮夫泉英”、“饮夫天浆”，当指唾液)的方式达到补益之目的。“接阴”之术与《合阴阳》、《天下至道谈》中所讲的“戏道”完全不同。“戏道”是有关性艺术的讲解，男女处于完全平等的地位，强调双方性高潮的配合。而“接阴”术的中心是男性，女性仅是工具，如同“服食法”中的“食”，“食气法”中的“气”一样，是一种可资摄取的补益物质。

此外，在马王堆帛书的《养生方》、《杂疗方》中，还有许多用药物治疗“老不起”的方法，反映出“老”的概念与性功能的密切关系。

严格地讲，对于这批出土材料既要考虑到其内容与先秦文化具有极为密切的传承关系，也要考虑到其墓葬年代为公元前 168 年这一事实决定了这些材料不可能不包含西汉前期的文化。然而即便如此，在有关“养生”的种种方法中仍然看不到任何道家有关精神休养学说的影响。道家名其为“养形之士”，确实是恰如其分地把握了这些养生方法的实质。其理论核心是以取外界之物质补益充实自身为着眼点，因而只能说这时的养生学尚处于以“命”为主体的初级阶段。那么，一种包含“性”(精神)、“命”(肉体)双修两方面旨趣、高层次的养生学又是如何形成的呢？

四、道家学术思想的演变

在讨论先秦道家学术思想演变时，“宋尹学派”的存在与影响是十分重要的。所谓“宋尹学派”乃战国道家学派的一支，代表人物为齐国稷下学宫的两位学者——宋钘、尹文。由于稷下学宫为各派学士“讲集议论”之所，久而久之，各派主张自然会相互影响。所以宋尹

学派虽以“道”为主，但其学术思想实杂糅儒墨，趋于名、法。以本体化的道、精、气、神等概念解释天地万物和精神活动是这一学派的特点之一。例如：“夫道者，所以充形也。”①“气者，身之充也。”②因而对于他们所说的“虚而无形谓之道”③，必须注意从“虚而无形”乃是“没有固定形状”的角度去理解。对于心理、思维这类生命现象的复杂表现形式，他们以“精气”说来加以解释：“人之生也，天出其精，地出其形。合此以为人，和乃生，不和不生。”而本体化的“心”，乃是这种禀受于天之“精”的寓存之所——“精舍”④。所以“心”的重要也就不言而喻了：“心之在体，君之位也。九窍之有职，官之分也。”⑤循此而进，“修心”便具有十分重要的作用：“定心在中，耳目聪明，四枝坚固，可以为精舍”；“修心静音，道乃可得”；“我心治，官乃治；我心安，官乃安”；“四体既正，血气既静，一意抟心，耳目不淫，虽远若近。思索生知，慢易生忧，暴怒生怨，忧郁生病，病困乃死。思之而不舍，内困外薄，不蚤（早）为图，生将巽舍”⑥。

宋尹学派主张以虚、静的方式来“修心”，是否与其身处稷下而受到燕齐方士之流的影响有关，无从稽考，也不十分重要。因为严格地讲，宋尹学派的立论主旨是以道、精气、心的本体化为基础的，即只有“虚”才能够得“道”；要“虚”，就必须去“欲”、去“知”；“动则失位，静乃自得”⑦。以此实现道之本体的自我存养。然而在宋尹后学手中，“得道”的含义则被解释成“爱身”、“命乃长久”，并将此称之为

---

① 《管子·内业》。
② 《管子·心术下》。
③ 《管子·心术上》。
④ 《管子·内业》。
⑤ 《管子·心术上》。
⑥ 《管子·内业》。
⑦ 《管子·心术上》。

“养生”：

故曰欲爱吾身，先知吾情。君亲六合，以考内身。以此知象，乃知行情。既知行情，乃知养生。

无迁无衍，命乃长久。

形性相葆，一以无二，是谓知道。①

郭沫若《宋钘尹文遗著考》认为《管子》中的《心术》、《白心》、《内业》均为宋尹学派遗作，但《白心》成书较晚。故《心术》、《内业》为宋钘著述或其遗教，而《白心》则出自尹文。我们强调宋尹后学之言，是因为不明乎此则无从窥见道家学术思想如何一步步地发生着不易察觉的内在变化。若将此处所言“养生”与《庄子》“庖丁解牛”、“善牧羊者鞭其后”例中所说“养生”混为一谈，则深自误矣。

其后，荀子批判地吸收了宋尹学派的许多观点，提出“形具而神生，好恶喜怒哀乐臧(藏)焉，夫是之谓天情”②的“形神观”，对于形成讲究性、命双修之养生学的理论，以及对“养形”之意义与目的的正确理解，无疑是有积极影响的。而在庄子后学笔下，不仅直接记载了宋钘、尹文之学，而且亦可见到引用以“静”修身存形的故事，并称此为“至道”：

无视无听，抱神以静，形将自正。必静必清，无劳女(汝)形，无摇女精，乃可以长生。目无所见，耳无所闻，心无所知，女神将守形，形乃长生。……故我修身千二百岁矣，吾形未尝衰。③

因此可以说先秦道家是在较晚时期才形成讲究形神关系、追求长生

---

① 《管子·白心》。

② 《荀子·天论》。

③ 《庄子·外篇·在宥》。

的立论学说。这种学说是原本独立于道家思想体系之外的“养形”之术向性命双修发展的理论基础。

在本文第一节有关道家“保身”思想的论述中，已经提到这种观念与杨朱学派“贵生”的主张颇为相近。侯外庐在论说“二派思想在相互影响之下，其后学便由离而合”之关系时说，庄子“后学则稍取为我之旨，几近乎杨朱之徒”，并指出“《庄子》外、杂篇（特别是《让王篇》）均以赞赏态度记载他们言行”。说明道家讲“保身”与吸收杨朱学派的思想有关。较之《老子》、《庄子》内篇所倡道法自然、无为而治等思想宗旨，已经可以看作是道家自身学术思想发展演变的一种表现。然而更值得注意的是，这种与墨家功利、儒家伦理相对立的价值观，进一步演变出了通过去除嗜欲而追求“长生”的味道：

> 肥肉厚酒，务以自强，命之曰烂肠之食；靡曼皓齿，郑、卫之音，务以自乐，命之曰伐性之斧。
>
> 燀热则理塞，理塞则气不达，味重珍则胃充，胃充则中大鞔，中大鞔而气不达，以此长生，可得乎？
>
> 俗主亏情，故每动为亡败。耳不可瞻，目不可厌，口不可满，身尽府种，筋骨沈滞，血脉雍塞，九窍寥寥，曲失其宜，虽有彭祖，犹不能为也。①

一般认为上引《吕氏春秋》诸篇内容系出自杨朱后学之手，反映了“杨朱后学由贵生而取养生之道，几近于庄子之徒的特点”②。然而根据前面的辨析，可知《庄子》所言“养生”并非长生久视之义。所以不妨将此看作是“贵身轻物”之价值观与道家彻底否定“欲”的主张相结合的产物。不论是杨朱后学，还是接受了“贵身轻物”主张的道

---

① 以上三节分见《吕氏春秋》之《本生》、《重己》、《情欲》。

② 侯外庐：《中国思想通史》。

家后学，必然要因这种观点的“利己主义”性质而备受攻击，孟子即是一例（参见《淮南子·氾论训》）。因此（或许是在战国时期的学术辩论中）转而向讲究去除嗜欲的“治身”之道发展乃是十分自然的事。所以“贵生”才变成了“长生”，不再是拿“物”或“天下”来和人身相比，论其轻重，而是与以长寿著名的养形之士“彭祖”相比。另一方面，当道家的社会地位发生转变时，则进一步促进了“治世”与“治身”在其思想体系中主、次地位的转变。

五、道家社会地位演变的影响

以重道尚法为宗旨的“黄老道德之术”，战国时流传于齐国等地。《史记·孟子荀卿列传》称慎到、环渊、接子、田骈等人，“皆习黄老道德之术，因发明序其指意……于是齐王喜之”。《史记·乐毅列传》载：“乐臣公善修黄帝、老子之言，显闻于齐，称贤师。”《史记》又称用黄老之术治理齐国的曹参亦获贤相之称。汉初执政者采用黄老清静无为之术，与民休息，对恢复和发展生产起了积极作用。这种社会背景对于老子之“名”及其学说的传播颇有促进作用。如文、景之时，有“王生者，善为黄老言，处士也，尝召居廷中”①；“窦太后好黄帝、老子言，帝及太子诸窦不得不读黄帝、老子，尊其术”②；建元（前 14～前 135）中，“章以修黄老言显于诸公间”③，等等。然而这时老子之学无

① 《史记·田叔列传》。
② 《史记·外戚世家》。
③ 《史记·袁盎晁错列传》。

疑是作为治国、驭民之术而得势于世的。老子“知名度”的提高，或可看作是后来兴起的道教尊奉老子为教祖的原因之一，但这时追求长生之术的方士并不依托老子，而是较多言及黄帝。如：“少君言于上曰：‘黄金成以为饮食器则益寿，益寿而海中蓬莱仙者可见，见之以封禅则不死，黄帝是也。’”①又如《汉书·艺文志》所载“神仙十家”中，黄帝之名凡四见，另有“宓戏”、“上圣”、“神农”各一。马王堆出土《十问》的发问者，黄帝居四，尧、王子巧父、盘庚、禹、齐威王、秦昭王各一；回答者依次为天师、大成、曹熬、容成、舜、彭祖、耇老、癸、文挚、王期。

及至汉武帝罢黜百家，独尊儒术，虽然黄老之术因儒家学问的改造与相容而继续以“外儒内道”、一明一暗的形式存在，但毕竟已属失势。这一转变，导致“一批治黄老之学的知识分子分别转向从事学术与方术”②。道教研究者瞩目于这种转变对于道教产生的作用，以为黄老学者与方仙道士相结合，形成了道教的雏形——黄老道。然而就《隋书·道经部》所言“汉时诸子，道家之流有三十七家，大旨皆去健羡、处冲虚而已，无上天官符箓之事”观之，则不难发现政治地位转变所带来的直接后果是迫使道家虚静无为、顺应自然的主张，在退出政治舞台后，只能向“治身”发展。成书于东汉的《老子河上公注》即是一个十分明显的代表。如：《老子·三章》（括弧内为河上公注）：虚其心（除嗜欲去烦乱），实其腹（怀道抱一守五神也），弱其志（和柔谦让不处权也），强其骨（爱精重施髓满骨坚也）。又，《老子·六章》：谷神不死（谷，养也，人能养神则不死。神谓五脏神也，肝藏魂、肺藏魄、心藏神、脾藏意、肾藏精与志。五藏尽伤，则五神去）。《老子》的

---

① 《史记·孝武本纪》。

② 朱越利：《道经总论》。

思想就是这样被改造成了养生学的理论，当然老子本人乃至道家思想也就逐渐被人理解成为养生学之源了。① 但也正是由于这种转变，道家“虚无恬淡”的精神境界才得与“养形”之术相结合，形成性命双修的养生学。三国时魏人嵇康的《养生论》说：

> 君子知形恃神以立，神须形以存。故修性以保神，安心以全身。又呼吸吐纳，服食养身，使形神相亲，表里俱济也。

这可以说是明确指出“养生”一词固有定义的典范。

---

① 王充《论衡·道虚篇》已将各种养生之术归于道家和老子。如说：“世或以老子之道，为可以度世”；“道家相夸曰：真人食气”；“道家或以导气养性，度世而不死”，等等。

“意”的领地

——中医各科要义概说

有史可考的医学分科，始于周代。据《周礼·天官冢宰》记载，当时的官医分为食医、疾医、疡医、兽医四科。食医：“掌和王之六食、六饮、六膳、百羞、百酱、八珍之齐”；疾医：“掌养万民之疾病”；疡医：“掌肿疡、溃疡、金疡、折疡之祝药劀杀之齐”；兽医则专掌治疗家畜之病。从中可以看出，人兽之别、内外之分，是医学分科的最初着眼点。此后，随着医学的发展，分科亦渐趋具体化。《史记·扁鹊仓公列传》中有“带下医、耳目痹医、小儿医”之语，说明妇科、五官科、儿科等已渐成专门。唐代太医署中，医生分为医师、针师、按摩师、咒禁师四种，但“医师”含括体疗、疮肿、少小、耳目口齿及角法诸项，故实际分科当不止四种。各科的内涵亦不可全从字面理解，如按摩师的职责包括“损伤折跌者，正之”①，这在后世的医学分科中，当属骨伤科的治疗范围。宋代太医局将医学分为九科，即大方脉（内科）、风科、小方脉（儿科）、眼科、疮肿、产科、口齿兼咽喉科、金镞兼书禁科、疮肿兼折伤。② 元、明之时扩展到十三科③；清初减为十一科，后

---

① 《新唐书·百官三》，中华书局点校本，1975年，第1245页。

② 《宋会要辑稿·职官二十二之三十六》，中华书局，1975年，第2878页。

③ 详见陶宗仪：《南村辍耕录·医有十三科》，第188页；《明史·职官三》，第1812页。

又减为九科①。

分科，是医学进步的重要标志之一，代表着该时代医学各方面独立发展的客观状况。值得注意的是，中国古代医学的分科特点，与其理论学说具有密切的关系，例如“风科”或“伤寒”，在今天看来只是某一类内科疾病，在中国古代却独立成科；某些分科的名称虽然古今一贯，但其实际内涵却有所不同，显示出古人在认识疾病、治疗疾病的原理方面与现代医学有所不同。以下择其要点略加说明。

一、内科：疾医、大方脉、风科

受近代医学之影响，现代中医学中亦有内科（internal medicine）这一分科，但在古代却没有这一名称。从本质上讲，《周礼》的疾医、疡医之分已有内科、外科的性质，但在以后的漫长岁月中，虽然出现了妇人、小儿、骨科等许多分支学科的专著，并在医学分科中取得了各自的独立地位，却始终没有形成明确的内科学。许多以论述内科疾患为主体的医学著作实际上都兼含妇科、儿科、外科等各方面的内容。这主要是因为以整体观念为特征，靠调整机体平衡达到治疗目的之中国传统医学的理论体系与治疗方法，不仅仅适用于各种内科疾患，同样也是其他临床各科的指导理论与治疗原则。因此，历代虽不乏以某一方面之特长名世的医家，却极难看到独限内科的医家。

---

① 详见《清史稿·职官二》，中华书局，1977年，第3326页。

一般认为，在中国传统医学里，除去特殊标明而独立出来的专科如妇、儿、眼、正骨等科之外，其余的病症均属内科范畴，但这的确只能说是今人的划分方法与“内科”概念。古代对于现今所谓“内科疾患”的最基本的认识乃是根据病因的内、外不同，将其中属感受外邪而罹病的“时病”单独列为一科，称之为“风科”（宋元时期）或“伤寒科”（明清时期）；将气血不足、饮食劳倦、情志不调等内因性疾患，称之为“杂病”。

病因的内外之分、对外感病的论述，虽可追溯至先秦，但经典性的全面论述当以东汉末年的《伤寒杂病论》为代表。又，据其书名不难看出：伤寒与杂病，是两大类疾患的名称。后经西晋太医令王叔和的整理，将其中论外感病的内容编成《伤寒论》，则进一步明确了两者间的界限，这或许是宋以后伤寒独立分科的渊源。推崇此书之理、法、方、药的医家逐渐形成了一个独立的伤寒学派，与之相对应的是一些被后人称之为“温病学派”的明清医家，他们在治疗方法、病机理论方面虽另有新见，但本质上仍属外感病的研究。由于病因理论的影响，宋以后的“大方脉”科虽与“内科”的概念十分相近，但在分科中却始终未能将“风科”纳入其中。

在杂病治疗方面，历代著作大多是以广博为务，以兼收为径。隋唐时期的一些大型医书所列病症、病名均达数百种，宋代的《圣济总录》则多至千种以上。但自金元开始，由于医家对医学理论的普遍重视，杂病著作不再以广博为胜，转而注重对于病机、辨证的探讨与研究。如金元四大家的一些著作，以及明清时期著名医家张介宾的《景岳全书》、张璐的《张氏医通》、喻昌的《医门法律》等，均不同程度地表现出这一特点。

所以，在近代医学影响下逐渐形成的中医内科，永远都会呈现出足以含括其他各科的态势。

二、外科：疡医、疮肿科

中医外科在历史上，实际是以研究与治疗各种化脓性感染、皮肤病、瘿瘤、痔瘘、损伤等为主要内容。概言之，凡皮里膜外（胸、腹膜腔之外）的各种有形疾患均可归属于外科的范畴。《周礼》称之为“疡医”。自宋代伍起予《外科新书》问世，“外科”一词的应用渐趋广泛，但在医学分科上，从未使用“外科”作为分科名称。其特点是在理论、治则、用药等方面均注重内、外的结合与统一。

近代西方医学的“外科”（surgery），是以手术、器械治疗损伤、畸形和其他病变的技艺，但其核心是手术；主要处理急性损伤和一些非手术治疗不可的慢性病。而中医外科基本上没有以手术治疗内脏疾患等慢性病的内容，重建和置换手术、生理手术（如切断迷走神经减少胃酸分泌以治疗消化性溃疡）、组织和器官移植手术等均属阙如。在矫形（如缺唇修补）、损伤、痔瘘、化脓性感染等方面虽然也使用手术疗法，但更注重药物疗法。由此构成了中西外科医学的主要区别。因此，如果将所谓的中医外科译为 surgery，是不能正确表述其内涵的。对此有较多了解的外国学者，往往使用 external 组词以表明中医外科的本质。

中医外科，基本上可以说是沿着治疗“皮里膜外”之疾患这样一条轨迹发展的。如在《宋史·艺文志》中载有外科文献 19 种，而以“痈疽”命名者即占 14 种。因而综观金元以前的外科学发展，可以说是以研究疮疡的名称、部位、具体治疗方药为主，即以医方的传授与创新为重点。虽然有托补、生肌、活血化淤等内治法的应用，但对

于舌苔、脉象等在这类疾患治疗中的意义并不太重视，辨证施治法则的运用尚不明显。其原因或如南宋陈自明在其《外科精要》序文中所言："今乡井多是下甲人专攻此科……况能疗痈疽，持补割，理折伤，攻牙疗痔，多是庸俗不通文理之人。一见文繁，即便厌弃。"金元以降，医学发展的总趋势已然转入对病机、辨证施治的理论性研究，在外科学方面同样表现出这一特点。元代太医齐德之在《外科精义》一书中，首次将各种脉象的变化与外科临床紧密联系起来，并在外科治疗中建立起消、托、补的基本法则。明清时期又出现了以王洪绪为代表的"全生集派"，注重阴阳学说的运用；以高锦庭为代表的"心得集派"，将温病学说中的"三焦辨证"引入外科领域之中，等等。

沿着这条轨迹发展的中医外科学，在治疗方法上，以内外结合为其最基本的原则与特点。在外治方面，药物仍是重点，虽然不乏应用手术疗法直接去除病灶的表现，但与近代医学的手术疗法实有许许多多本质的差别。

三、儿科：少小、小方脉

明确提出儿科专门化始于唐代太医署，其"医师"中含有"少小"，与体疗、疮肿、耳目口齿等并列。宋代以后称"小方脉"，其意如宋代朱肱《类证活人书》所说："小儿大人，治法一般，但小分剂。"——仅仅是用药的剂量有所不同而已。然而这一说法实际上并不准确，因为在中医看来，两者间的区别并非仅仅是像西方医学那样——根据体重来计算用药剂量，还存在着质的差别。例如宋代

钱乙在其所著《小儿药证直诀》中提出小儿属于“纯阳之体”的观点，所以将《伤寒杂病论》中由八种药物组成的“肾气丸”，改造成不含附子、肉桂两种助阳之品的“六味地黄丸”，用以治疗小儿发育迟缓等疾病。

一般说来，中医儿科著作多自胎养开始，继之以初生、养护之论述；对于小儿生理、病理特点、诊治要点及常见多发疾病均有详尽阐述，由此构成儿科专门。

“胎养”之说虽然被现代科学所承认，但在古代，其本质却是基于“外象而内感”之交感巫术的思维方式，“故自初妊迄于将产，饮食居处皆有禁忌”①。儿科中独有的生理学说为“变蒸”之论，此说以西晋王叔和《脉经》的记载为最早：“小儿是其日数，应变蒸之时，身热而脉乱，汗不出，不欲食，食则吐呕者，脉乱无苦也。”此后隋代巢元方《诸病源候论》始见详细的解说：“小儿变蒸者，以长气血也。变者上气，蒸者体热。从初生至三十二日，一变；六十四日再变……三百二十日，十变，变且蒸……积五百七十六日，大小蒸毕也。”孙思邈《千金要方》亦说：“大小蒸都毕，乃成人，小儿所以变蒸者，是荣其血脉，改其五脏，故一变竟，辄觉情态有异”；“当其时有热微惊，慎不可治及灸刺”。

儿科诊法中，自宋代开始出现诊指纹法。即以小儿食指掌侧皮下静脉的形色变化作为察病依据，食指的初节称为气关、中节为风关、末节为命关，静脉的形色变化在“气关”为轻，达“命关”为重。

儿科杂病与内科本无本质区别，唯麻（麻疹）、痘（天花）、惊（惊风）、疳（疳积）四大证属儿科特有的疾病。明清两代的儿科著作有相当大的部分是以讨论这四种疾病为主，其中又尤以论痘疹者为最多。

---

① 孙思邈：《备急千金要方·妇人方上·养胎第三》，第20页。

以清代陈梦雷等编《古今图书集成·医部全录》为例，其卷千四〇一至千五〇〇是儿科部分，而其中自卷四五九开始，至卷五〇〇，计42卷全部为“痘疹门”。虽是节选诸书，但总字数已超过90万。足见由于明清时期麻疹、天花等传染性疾患的危害甚重，因而受到医家的广泛重视。清初曾有过一段时间，痘疹独立于小方脉之外，单独成为一科。

四、妇产科：带下医

妇产科的疾患集中表现在经、带、胎、产几方面。一般认为，中国古代将妇产科称为“带下医”的原因，即在于这些疾病均集中表现在下腹部(腰带以下)。例如《素问·骨空论》云：“女子带下瘕聚。”张仲景《金匮要略》在讨论妇人之病时概之曰：“此皆带下，非有鬼神”；对妇人出现下利、少腑里急、腹满、手掌发热、唇干口燥等症状的诊断是：“此皆属带下。何以故？曾经半产，淤血在少腹不去。”先秦著名医家秦越人“过邯郸，闻贵妇人，即为带下医”①，是知“带下”之名由来甚久，而“带下医”即妇科医。

在医学分科中，首先是产科专门的重要性得到了重视与承认。自宋代开始，医学分科中将“产科”独立；明清两代改称“妇人科”。但从文献记载与中国传统文化背景看，医生在妇、产两方面主要是承担治疗疾病的角色，虽然有像宋代杨子建《十产论》那样专论正产、倒产、横产，并涉及转位手法的著作，但接生分娩的具体操作实主要是

① 《史记·扁鹊仓公列传》，中华书局，1982年，第2794页。

由“稳婆”(接生婆)承担的。

与近代西方妇产医学发展形成的历程相比较,由于中国传统医学的自身特征与社会环境两方面因素的制约,故在中国不可能出现类似西方那样以产钳的使用与改进(约数百种之多)为象征的、脱胎于外科而形成的一门独立学科——产科学,自然也就不可能有产前骨盆测量、分娩机械原理之类的研究。因此与医学的其他分支学科不同,在当今社会中已无“中医产科”存在,一些产后杂病的调治不过是内科整体治疗的一种表现形式。但妇科的情况则全然不同,西方近代医学除了在切除生殖系统肿瘤等方面足以表现出其外科手术的长处外,所谓妇科医生手中掌握的药物,不过只有雌激素与孕激素两种,无论是治疗月经不调、子宫功能性出血,还是不孕症、更年期综合症,都只能靠这两种激素制造人工周期。而中国传统医学的药物、针灸等整体治疗在调整因自律神经、内分泌系统紊乱而引起的许多功能性妇科疾患方面则体现出其方法多样、疗效明显且稳定持久等各种长处。

五、骨科:正骨、接骨

骨科成为独立的医学分科是在元代,称之为“正骨科”。明代谓之“接骨科”。从名称中即可看出其内涵主要是指骨损伤的治疗。其治疗范围主要是骨、关节和周围软组织的损伤;另外,对骨髓炎、骨肿瘤等骨病也兼见涉及。中医骨科的主要内容包括手法整复、器具固定、内外用药几大方面。前两项与西方医学多有相同、相通之处,而内外用药则是中医骨科的独到之处。活血化淤、补气补血是最常用

的治则，在促进骨痂生长、恢复肢体功能、治疗骨髓炎等方面确有明显的临床效果。

有意思的是，湖北张家山出土汉简《引书》中记载有下颌关节复位等“手法复位”的内容；唐代太医署的按摩博士“掌教‘导引’之法以除疾，损伤折跌者，正之”，据此可知在骨伤科形成专门以前，手法整复属于“导引术”的范畴，因而将“导引”解释为医疗体育、养生之术是不准确的。应该说，无论是通过医生之手引起患者躯体的被动运动，还是患者模仿“熊经鸟申”的自主运动，都属于“导引”之术、“外治”之法。在古人头脑中并没有将前者定义为“手法整复”，后者名之曰“体育锻炼”；前者为“治病”，后者为“养生”的区别。

在近代西方医学中，骨科（orthopaedics）的本义是矫形外科。该词来源于组合“将畸形弄直”和“儿童”两个古希腊语的词根，这与18世纪初西方建立起儿童矫形医院，应用牵引方法矫正畸形有很大关系。在中国人的头脑中，并非没有浮现过“以器械固定，强行矫正畸形”的图景，但却是以此比喻与嘲笑那些“违背自然规律、只图表面效果”者——“专治锣锅，不管死活”。换言之，习惯于顺应自然的中国人大概从来没有想到过畸形可以矫正，没有想到过强行矫正畸形也可以作为一种治疗手段或医学的内容，所以在中医骨科里，矫形外科的内容基本上可以说是不存在的。然而在骨折治疗方面，中医却认为药物可以改变“自然”，而且民众也普遍认为骨折时应该喝些“骨头汤”以帮助断裂处的骨痂生长、加速愈合，然而现代医学却对此持完全否定的态度，以为“毫无关系”、“该多长时间长好，就得多长时间”——可以说这也是一种“顺应自然”的观念。可见在东西方两种文化、医学体系中，都有“顺应自然”（无奈）与“改造自然”（参与）的意识，但却各有各的表现形式。

六、眼　　科

《史记·扁鹊仓公列传》中虽已有“耳目痹医”之称，但独立的眼科至宋代始见形成。中医眼科学的要点可以概括为：

1. 在理论上建立起五轮八廓的学说体系。

2. 将眼球疾患区分为内障、外障两大类。

3. 在治疗上虽仍不离中国传统医学内外结合的基本宗旨，但外治法的进步十分突出。

“五轮八廓”是中医眼科识病辨证的基本理论与方法。“五轮”的名称与应用法则是：

气轮：目之白睛(巩膜)，内应于肺，属金。

风轮：白内黑睛(虹膜)，内应于肝，属木。

血轮：目两角大小眦(内眦、外眦)，内应于心，属火。

肉轮：上下两胞(眼睑)，内应于脾，属土。

水轮：青内一点黑莹(瞳孔)，内应于肾，属水。

“八廓”是依八卦方位划分眼部，两者相较，与眼之不同组织结构具有内在联系的“五轮”说，显然要比纯粹按区域划分的“八廓”之说合理得多。因而在临床上，亦主要是根据五轮之分来辨析疾病。“五轮”之说虽然具有五行配属味道，但其根源却在印度眼科之中。

内外障之分：凡是发生在眼球内部的疾患称之为内障；发生在眼球外部，如结膜部的疾患称外障。宋元时期的眼科专著《秘传眼科龙木论》列举眼病 72 种，计内障 23 症，外障 49 症。由于当时对于眼

底疾患、视神经病变尚不可能有足够的形态学认识，因此内障之述多是对白内障的辨别、手术适应范围与时机等。采用针拨之法时，必须是“犹见三光”者，如果“瞳人颜色如明月，问睹三光不见光”，则不宜针拨。

针拨之术一般认为是来源于印度医学，但眼科外治之法并不仅限于此。手术疗法的器械与方式均可称之为“针、割、钩、烙”。其中之“针”，用于拨内障，其他三种均用于外障。明代傅仁宇《审视瑶函》概之曰：“钩，钩起也。割，割去也。针非砭针之针，乃拨瞳神之针。烙即熨烙之烙……大抵钩割针烙之法，功效最速，虽有拨乱反正之功，乃乘险救危之法，亦不得已而用之。全在心细胆大，必症明而部分当，又兼服药内治，方为两尽其美。”

七、口齿咽喉科

“口齿咽喉科”始设于宋代，唐时“耳目口齿”为一科。在唐代的《千金要方》中，目、鼻、口、唇、齿、喉、耳、面诸类疾患，统称之为“窍病”；而且知道耳、鼻、喉相互贯通，这些大概就是这一分科形成的依据。与西方近代医学的相同之处在于，两方面均存在着将五官疾患从内科中析出，单独加以论述研究的倾向，但在西方医学中，耳、鼻、喉各科是在经过独立发展的阶段后，才由分到合地形成了 ear-nose-throat department(耳鼻喉科)。

有关耳、鼻的生理、病理研究始终停留在汉代医学的水准上，即鼻为肺之窍，耳为肾之窍，以此决定治则，没有突破性的进步。对于牙齿疾患，唐代已有汞合金补牙法的记载，外用熏法治疗牙痛亦是常

用的方法，但从风、火、肾虚等方面解释与治疗牙病仍是主体。以牙齿及其周围组织的病变为核心，在这一点上中西医学是一样的；所不同的是中国传统医学缺乏错殆矫正方面的内容。

喉科专著大量问世是在清代。这些著作大多是根据喉部的症状表现进行分类，治疗方法亦是多种多样，包括内服、外用与针灸等。值得注意的是，中医喉科并不是以咽喉组织本身的固有病变，如咽喉部的肿瘤、发生器官的病变等为基本着眼点，而是以全身疾患出现的咽喉部炎症为研究重点，许多口腔炎症亦包括在其中。

八、针 灸 科

针灸疗法是一种独见于中国传统医学的治疗方法，但近年来习用此法者已遍及世界各地，其疗效逐渐得到世界上许多国家的医生和患者的承认。而针灸疗法在中国传统医学中的地位和重要性则在于：一般认为中医治疗体系之主体不外两途，即“神农—草药”的药物治疗学和“黄帝—针砭”的针灸治疗法①。现代人为针灸疗法所下的定义是：“应用针刺艾灸的方法，通过经络腧穴，以调整脏腑气血的功能，从而达到治疗疾病的目的。”②然而这一定义所反映的实际上是现代针灸学的内涵，或者说是现代人对于针灸疗法作用机理的理解与认识。在古代，不要说是在医学理论尚且十分不发达的原始、奴隶

---

① 例如刘复《神农本草经·序》说：“尝考医学源流，古分二派，一曰炎帝神农，二曰黄帝轩辕。神农传本草，黄帝传针灸。家法不同，学派遂异。”（中国古医学会，民国31年刊本。）

② 南京中医学院主编：《针灸学讲义·绪言》，上海科学技术出版社，1964年。

社会，就是到了汉代乃至其后，针与灸这两种治疗手段亦没有单纯被作为调整机体功能（阴阳平衡）以治疗各种疾病的方法。而往往是被作为直接触及病灶的“外治”手段，因而才会形成“火齐（剂）毒药攻其中，镵石针艾治其外”①的普遍看法，并在刺法上规定了皮、肉、筋、脉、骨等浅深次第②。

无论是以刃具式的砭石切割痈肿排脓，还是用尖锐的砭石放血，都是为了去除身体上的病邪。只不过从后世发展的结果观之，前者被看成是手术刀的滥觞，应归入外科治疗法；而后者则成为金属针具的前身，被视为针刺疗法的起源。见于今本《黄帝内经》的金属针具——九针，不仅包含有与砭石相当的切割、放血之具，而且还有顶部圆钝的按摩器“圆针”——“长一寸六分，针如卵形，揩摩分间，不得伤肌肉，以泻分气”，和“锟针”——“锋如黍粟之锐，主按脉勿陷，以致其气”。《灵枢·九针论》说：“锟针，主按脉取气”；“必大其身而员其末，令可以按脉勿陷，以致其气，令邪气独出”。说明古代“针”、“刺”的概念与方法，与后世均有不同之处。其中包含有虽名之曰“针”、称之为“刺”，但实际上所用并非锐利之器、亦不穿透肌肤的治疗器具与方法。因此大致可以说徒手操作属于“按摩”与“导引”的范围，而利用器具施加按压的治疗则归之于“刺”，而且还包括手术刀在内。这基本上才是古人头脑中对“针”这一概念所下的定义。在“九针”中虽然已出现了锋如蚊虻喙的毫针，能够较深地刺入肌肤，但由于当时并没有严格地将“经脉”从人体可见组织中区别出来，十种是被视为人体组织结构的一部分，所以“经脉之病”亦只是隶属于从体表向内脏

---

① 《素问·汤液醪醴论》。原文作“必齐”，许多注家已指出“必”字系“火”字之误，颇为有理。

② 《素问》之《刺齐论》、《刺要论》。

逐渐深入的一个层次，“欲以微针通其经脉，调其血气，荣其逆顺出入之会”①的治疗方法，仍含有极强的外治法色彩。

同样，如果简单地从热能的物理作用去解释灸法的产生与机理，亦未免太现代化。范行准氏指出：“火是鬼神所畏，用火灸焫含有驱逐鬼神之意。”②此外还应注意到，这一治疗行为的主角，也许既不是“火”也不是“热”，而是“烟”。因为在古人的头脑中，对烟的作用有着特殊的思考：灵魂、鬼物等不可见之“物”运动的通路。这也就是说，以火接近人体或某一患处进行治疗，含有令致病之“物”循人为制造的通路——烟，离去的意思。《周礼》中掌祭祀之职的春官大宗伯行“禋祀”时，均要积柴薪，点燃后将奉献给神的东西置于其上。郑玄注云：“禋之言烟，周人尚臭。烟，气之臭闻者，……燔燎而升烟，所以报阳也。”载于烟上之物虽因事不同而有别，但假烟上升以成祀的方式却是一样的。另外，马王堆出土帛书《五十二病方》中治疗“婴儿瘛”的巫术方法中亦有“取屋荣蔡（即屋顶之草），薪燔之”的行为，山田庆儿释其目的为“使被疫鬼夺去的小儿之魂，知道返回之通路的所在”③，是极有见地的。这些均有助于思考早期灸法产生时的思想基础。当然，随着医学的发展，针、灸两法逐渐较多地符合于今人所下之定义，例如在今本《黄帝内经》中，针灸之法已分别出现了补泻的操作方法等。但诸如“风寒客于人……或痹不仁肿痛，当是之时，可汤熨及火灸刺而去之”④这种说明针灸属治外、能直接驱除病邪的记述绝不鲜见。灸法还被用于烧灼体表的赘生物“疣”和痈疽；刺法更是

---

① 《灵枢·九针十二原》。

② 范行准：《中国医学史略》，第15页。

③ 山田庆儿：《夜鸣之鸟》，译文载《日本学者研究中国史论著选译》第十卷，第259～260页。

④ 《素问·玉机真藏论》。

广泛地用于处理痈疽、疮疡、腹部脓肿、淋巴结核造成的瘘管，放出腹水、阴囊积液、关节腔积液，和直接刺杀肠道蛔虫等；但也规定了腹腔内的某些疾患“不可动之”，所以“不可灸刺”，否则必然造成不良后果，甚至死亡。真正符合现代针灸学定义的针灸治疗学体系，是在东汉以后才逐渐形成的。西晋皇甫谧摘选今本《黄帝内经》中的有关理论和《明堂经》的腧穴学内容，编成《针灸甲乙经》，始将“依据经脉的”和“基于腧穴的”两种针灸方法紧密地联系在一起，成为针灸专门的经典之作，其中已经没有那些应该属于“外科”范畴的内容了。

九、祝 由 科

“祝由”一词始见于今本《黄帝内经》，谓古代治病“唯其移精变气，可祝由而已”，其后始有“毒药治其内，针石治其外”的方法。唐代王冰据此释“祝由”之义为：“祝说病由，不劳针石而已”。不知“祝由”与“咒”之间是否具有某种联系：一是在有“咒”之说，但尚无其字的时候，用来表示“咒”的意思，因为“祝由”之切（业＋又）即是“咒”；另一种可能是“咒”的音、字皆后出——源于“祝由”的约音。然而不管二者之间是否具有这样的关系，总之在医学领域中都是“以语言（咒语）治疗疾病”的意思。

不论中外，咒禁巫术均是古代医学的重要组成部分。这主要是因为在近代自然科学产生之前，自然与超自然的界限并不清楚，一旦法术无验，被否定的仅仅是法术的操作者，而不是法术本身。在中国古代，咒禁疗法在医学中始终占有一席之地。在马王堆汉墓出土的医书中，“咒禁”与其他治疗方法混在一起；隋代始设“祝禁博士”，唐

代称"咒禁师";宋代改称"书禁";元明两代遵《素问》"移精变气,祝由而已"之旧语,称"祝由科"。

咒禁疗法的本质是巫术(magic),"是人类的一种基本精神活动和实践活动。巫术是属于科学、宗教学、人类学、哲学、神学等领域的现象,它不是理想的人类文化形态,但又是不能忽视的人类社会的一个实际侧面"①。巫术的治疗方法虽然不可能具有确实的作用,但也不能因此即将其排斥于传统医学的体系之外。本书中有专门一章详述"咒禁疗法",可参。

---

① 伊东俊太郎等编:《科学技术史词典》,光明日报出版社,1986 年中译本,第 739 页。

“意”的延续

——唯一存活的传统科学

一、承认中医

作为中国人，在几十年的生活经历中从未看过中医、吃过中药的人大概不多。退一万步讲，即便是那些体壮身强、与“医学”尚无多少缘分的人，至少也知道“中医”的存在。因而尽管他们自己没有什么直接的经验与需求，但或许会劝说那些在健康方面遇到麻烦的亲朋好友：不妨去试试中医。最为滑稽的还是那些从小接受现代科学教育，毕生以现代医学为职业，在思想意识中坚定地认为中医不科学、是糟粕的西医人士，一旦罹疾患病而现代医学又无力救助时，难免也会低下一贯高昂的头——去看中医、吃中药。

这些不过是发生在我们生活中的一些寻常小事，有什么值得奇怪吗？然而如果想一想前些年放映的一部名叫《北京人在纽约》的电视剧和近期上映的电影《刮痧》，或许就不会认为发生在我们生活中的一切都是那么理所当然了：《北京人在纽约》中的女主角阿春，因为让中医为儿子治疗关节病，而被前夫告上法庭；《刮痧》中的情景与此相似——刮痧疗法造成的皮下出血，成为爸爸虐待儿童的罪证，从而使得父亲丧失了对亲生儿子的监护权。

当现代医疗已经足以满足社会需求的时候，中国人为什么会在

有病的时候看中医、吃中药？为什么会在对中医并无直接经验的情况下，建议他人去尝试中医治疗？为什么满脑袋“科学”的西医人士在不得已的情况下，也会接受曾被自己嗤之以鼻的中医？为什么在观看上述影视节目时，会觉得外国人可笑？这是因为他们“承认中医”——承认中医是一种医学，至少是承认中医可以治病。正是由于这种承认的存在，中国人才会对于发生在自己身上或身边的事情司空见惯，毫不觉得有什么奇怪；才会觉得违背“常理”的外国人是那么可笑！你千万不要小看这种“承认”的价值——试想：在科学如此昌盛、足以统治知识领域甚至是普通民众思维方式与价值观念的当今社会，如果没有这种“承认”，传统医学是否还有可能生存？从另一方面讲，在“科学”或“不科学”几乎成为“正确”与“不正确”之同义语的当今社会，中国人仍然能够“承认”中医是一种“医学”——尽管它与称之为“科学”的现代西方医学是那么的不同，这是否足以说明在中国人的“科学观”中多少隐藏着一些特殊的“基因”。当身体中的这些“特殊基因”处于活动状态时，难免就会对当代科学的“绝对正确性”提出某种质疑，甚至会问：在当代科学之外，是否还存在着“另一种科学”？当然，对于大多数中国人来说，这种“特殊基因”通常是处于不活动的状态——因为现代科学实在是太强大了，而且是那么直观，易于学习、理解与接受；几乎所有的现代人，就其知识结构而言，都是以现代科学作为养成教育的唯一内容；几乎所有的现代人，在衣食住行的方方面面，无不受惠于飞速发展的现代科学技术，从而在心灵深处对“科学”产生了一种类似宗教的崇拜与信任。然而即便如此，中国人身上隐含着的这种“特殊基因”还是极易被启动——只要一旦遇到现代西方医学无法解决的疾病，就会想到中医。不管多么信仰“科学”，却很难看到“宁死不吃中药”的中国人。

对于中医的“承认”，是由什么因素决定的？首先当然是特定的

生活环境：只要是生活在这片土地上，就会看到中医的存在；在接受现代科学养成教育的同时，同时也受到这种存在潜移默化的影响。其次，中医具有悠久的历史，过去的“承认”成为传统文化的组成部分，影响着当今之人；而当今之人的“承认”，又继续营造着“中医”与“民众”相互依存的特定生活环境，构成传统文化的延续，并不断影响后人。再者，无论如何还必须看到，在中国人的思维方式中，存在着一种天生注重形象思维，而不太追求严格的形式逻辑和“非此即彼”形而上学的倾向。因此他们并不在意中医的理论是否“科学”，天生与中医那套在外行看来属于“玄而又玄”的理论存在着某种精神上的共鸣。最后还有一点，可以说也是最重要的一点：社会对于任何一种学说、技艺、事物是否采取承认的态度，往往简单到完全是从实用主义的态度出发——“不管黑猫白猫，抓住老鼠就是好猫”，所以“承认”的最根本理由，还是在于中医确实能够治病！

二、存活的理由

如果查阅一下科学史类的著作目录，会十分容易地找到以中国古代天文学、地理学、数学、化学、物理学、生物学、农学等为书名的著作。尽管相当一部分学者以为中国古代“化学”，不过是炼丹术；所谓“生物学”，不过是有关花鸟虫鱼的博物性记载，不能称之为化学或生物学，但却普遍承认天、算、农、医这四大领域是自成体系，堪称为“学”的。然而时至今日，依然存活的却唯有“中国传统医学”。换言之，只有中国传统医学没有被近代西方医学所取代，而过去曾十分发达的天文学、数学等，皆被相应的西方科学所取代。某种传

统科学知识体系的死亡，自然有死亡的理由——这无非是由于相应的新兴知识体系的优越性足以取代旧有的体系。因而今天如果有人倡议继承或复兴中国古代天文学、数学体系，那一定会被视为极端的民族主义心理在作祟——因为旧的知识体系已然彻底丧失了继续生存的理由。

站在只有近代西方医学才是“科学的医学”的立场上，作为中国传统科学一个分支领域的古代医学，也早就丧失了生存的理由，但它却依然存活着。于是便需要从其他的角度为其寻找存活的理由。最常见的解释是：中国地大人多，近代西方医学虽然在明末清初即已开始传入，但在此后很长的一段时间中始终无法满足幅员辽阔的广大农村与落后地区卫生保健的需求，因而需要传统医学作为补充。再者，在落后、保守心态的支配下，人们往往会对传统的东西更容易接受，而对先进的“科学”持抵触态度。一句话：中医存活的理由在于“落后”。然而从现实情况看，这客观与主观两方面的理由都不能成立。

首先，从经济的角度讲，民国时期那种倾家荡产也打不起一针青霉素、链霉素的状况早已不复存在。相反，在 20 世纪下半叶的数十年中，不要说中医惯用的健脾补肾、滋阴养血的药剂的价格无疑会大大高于一般的西药，就是一剂普通的感冒药，其价格也通常是一支退烧针剂或抗生素的数倍。所以公费医疗的管理条例对中药的使用有种种制约，而对西药则没有任何限制。因此，试图从经济或价格的角度去寻找中医存活的“理由”，显然是行不通的。

其次，是现代医疗服务是否能够满足需求的问题。在当代中国的大中城市中，现代医疗卫生保健的普及程度，已然完全能够满足市民的需求。按照上述“弥补不足”的解释，传统医学在大中城市中理应丧失其继续生存的理由，但情况却恰恰相反——人们在可以十分

容易地充分享受现代医疗的状况下，对传统医学仍然有所需求。而且往往是在十分便利的现代医疗无法解决自身的疾病烦恼时，才需要费些气力、舍近求远、不惜重金地寻找那些“华佗再世”的中医大夫。而在偏远地区，人们通常是费尽气力、舍近求远、不惜重金到县城、省城甚至首都寻求西医的治疗。如果你有机会到县城去看一看，就会发现县医院（西医）总是繁忙拥挤，而县中医院却时常门可罗雀。足见民众中并不存在亲近传统、抵触“科学”的心态，反而是对西医充满了崇拜与迷信。“打吊针”（输液）通常被视为疾病严重、且得到了最好治疗的象征。老人“打了吊针”后死亡，晚辈可以充分自慰——尽了孝道；孩子“打了吊针”后死亡，父母足以自慰——尽了爱子之心。

对于一个医学生来说，如果他学的是中医，那就一定要在大城市中寻求就业的机会——他可以成为教授、专家，可以从事研究，甚至出国讲学，最差也可以成为一个收入不差的临床医生。但如果他到了基层，那就趁早改行——因为那里更需要的是西医。

从上述方方面面的比较观之，中医赖以生存的基础显然不是“落后”。这一点在未来时代中或许会表现得更加明显。因为在现代社会中，西医更具有满足基本卫生保健需求的能力；而中医实际上更适于“城市贵族”现代病、老年病不断增多，病情日趋复杂，对卫生保健的需求不断提高的客观状况。经济越是发达，人们就越是需要多种不同的医疗服务；诊断设备越是先进，现代医学不能解决的问题就越见增多；物理、化学、手术等足以改变人体自然状态的治疗手段越是进步，医学本身造成的疾病（医源病）也就越是复杂。这些，都为中医、中药这种注重恢复人体自然状态与功能的医学提供了更大的活动舞台。——这，实际上才是中医能够在当代社会中存活的基本理由。

三、我们正在丢弃什么

半个多世纪以前，一些对中西医学均有所了解的日本医药学家开始利用现代化学实验手段，研究中药的有效成分。这种研究的动机也许仅仅是站在现代医学的立场上——为了从生药中寻找某些新的药物资源；也许完全是一种纯粹的科学研究——欲知其然与所以然。然而当某些中国的“先进分子”效法此道时，或许除了上述两种可能的动机外，怀中那颗无论怎样被西方科学熏陶也永远不会泯灭的“中国心”还会构成第三种“动机”——研究、利用、昭示中国的文化遗产。应该说无论哪一种动机，都是十分美好的。但自那时以来，中医界人士即对这种研究持强烈的批评态度：这将导致中医的消亡——“存药废医”！

半个多世纪过去了，“存药废医”的悲惨景象似乎并未出现——“辨证论治”仍然是当代中医施医给药的原则；中药有效成分的研究，也没有取得预期的效果。其原因在于单味药物的有效成分的研究与提取，相对而言还比较容易实现；但中医之所以能够治病，在大多数场合下都是依靠多种药物的配合，而试图搞清这“一锅汤”中有效成分的研究，恐怕实在是比当年居里夫人发现并提取到放射性元素还要困难。据从事过此项研究的业内人士讲：多种中药熬成的“一锅汤”，是一个不可思议的奇妙世界——单味药物中或酸或碱的有效成分放在一起煮上几十分钟，照理说只能生成一大堆盐，哪里还能保持原来的性质与活性？但中医讲究的偏偏就是“用某药制约某药”、“用某药辅佐某药”。这个熬药的普通砂锅，实在是可与太上老君的炼丹

炉相比——在这个小小的混沌世界中，不知造就出了些什么令科学家感到伤透脑筋的东西。

实际上，即便是单味药有效成分的研究也没有那么简单。如果你去翻阅这方面的研究报告，一定会看到许许多多同一模式的研究报告：药物学家通过某种实验方法，弄清并提取到某种植物中的有效成分。你会认为这就是伟大的科学，这就是科学的伟大，这就是某种自然之物能够治病的本质。但如果你是一位有实际治疗经验的临床大夫，就会发现问题并非如此简单。例如注射从麻黄中提取的麻黄素，可以像服用生药麻黄一样兴奋交感神经而起到平喘的作用，但通常却不能起到发汗治感冒的作用。业内人士发现，人参叶中“人参皂甙”的含量并不比根中的含量低，但以价格低廉的“人参叶”替代价格昂贵之“人参”的美好愿望，却根本无法实现。研究者只能告诉你说：人参的根中含有的一些其他成分，是叶中所不具备的，例如黄酮类物质。那么，在这种情况下，难道我们不能问一下：究竟什么才是人参的“有效成分”？这时，你会发现自然界的伟大：一种植物并非等于一种单一的物质，而是一个完整的“小宇宙”——其中究竟含有多少种“有效物质”？这些生活在一起的“有效物质”相互之间具有怎样的特殊关系？构成这种植物的多种物质中，究竟哪些是所谓的“有效物质”，哪些可以断言为“无效物质”？“有效物质”与“无效物质”间是否还存在着相互依存不可或缺的关系？……自然造化的鬼斧神工就是如此奇妙。当我们骄傲地宣称：通过科学的手段人类正在不断认识自然，并要求公众充分相信这种认识，仿效这种认识途径继续深入地不断认识自然的时候，也许正是逐渐远离自然、遗弃自然的过程。

这种观点，难免有“反科学”的嫌疑、有不可知论的味道，其实不然。毫无疑问，只有科学实验才能告诉我们人参中含有一种名叫人

参皂甙的物质(或者说是一种“有效物质”),并能说清这种物质的化学成分与药理作用;还能告诉我们人参根、叶药效不同的原因在于根中含有一些叶中没有的其他成分;甚至不必怀疑,总有一天科学实验能够说清那“一锅汤”的混沌世界中发生了怎样的变化,造就出了哪些治疗疾病所必需,而自然界中又没有的物质。但是,从“必然王国”向“自然王国”迈进的路途实在是太遥远了。甚至于从理论上讲,人类永远只能相对深入地了解因果长链中的某些环节,而不可能穷尽它。记得有位伟人曾经说过:哲学的光荣就在于坚持从世界本身说明世界,而把其中的细节问题留给未来的自然科学。中西医学,中国古代注重整体的哲学性思维方式与近代科学注重实证与分析的研究途径,恰恰可以作为人类认识自然的两种代表性模式。无论单独强调哪一方面,难道不是片面吗?因此,对于得天独厚享有祖宗遗产与近代西方科学双重恩惠的中国人来说,最好不要轻易地丢弃某一方面,变成只能用一只眼睛看东西、用一只手吃饭做事的残疾人。

围绕着“唯一存活的传统医学”这样一个特殊事例,可以说中国社会正在丢弃的还远远不仅仅是一种哲学式的思维方式。从上面的论述中不难看出,要想成为一个好的医生,实在是需要有渊博的知识与聪明的头脑。在古代社会,为儒、为医是智者的两大选择,前者治理人类的社会秩序,后者治理人类的肉体之身。固有“不为良相,则为良医”之说。但在当今社会,充分发挥个人聪明才智、完成自我实现的途径实在是太多了。相比之下,医学已经不可能像过去那样获得众多杰出人才的青睐。中国古代那种以“医者意也”为特征、需要极大的个人创意的医学,必然会被易于理解与掌握的、技术化的医学所取代。

其次,商品经济的发展也不适于中国传统医学个性化特征的生存。这一问题通常是以“药物”为媒介表现出来的。首先是手工抓药

的问题：在降低成本、提高效率的时尚影响下，药工对那些只配“一剂”的处方充满了怨气，因为他们的劳动报酬是根据抓药多少来计算的。一张处方如果配5剂甚至10剂，其“劳动效率”就会高得多。在这种情况下，医生即便再想贯彻“辨证论治”的原则——根据病人服药后的变化不断调整处方，也不得不顾忌到药工的眼色与抱怨。一个幼儿感冒的病例，按照实际情况大概只需要配一剂药就可以了，但是如果关系到医生与药工两方面的利益，患者就不得不拿回一大堆药。相比之下，西药的药片、瓶装的水剂、注射的针剂，如果不是大夫黑了心肠为了多卖药、多赚钱，一般是不会有这样的问题的。

于是，人们自然要考虑改进中药的剂型——使它与西药一样方便。这时，中医的“辨证论治”的特色，具体问题、具体分析的“灵魂”也就丧失了托身的场所。具体到剂型的改革，日本的汉方医学采取的是沿袭古代“散剂”的做法，即将某些常用方剂制成药粉，直接吞服，称为“散剂”；以开水浸泡或煮沸后饮其药液，谓之“煮散”。散剂除了不能灵活调整其成分构成的问题外，就药物成分本身而言，应该说与汤剂、丸剂、膏剂等没有本质的区别。但在中医的故乡，剂型的改造却更加“现代化”。一条条流水线生产出的是装在安瓿中的透明液体。我曾经就某儿科研究所生产的此类“现代中药”问过业内人士：根据其配方看，治疗儿童的感冒应该没有问题，但何以实际效果却极不明显？回答是：为了追求没有沉淀物与悬浮物，而导致“有效成分”大受影响。

看来，早年科学实验与探索并未导致的“存药废医”问题，在经济杠杆的驱动下，在追求“现代化”美好愿望的推动下，终于有可能出现。

中国传统医学的“传统”与“革命”

西方人称中医为“traditional Chinese medicine”(中国传统医学)。在一般人看来,“传统”的最大特点就在于从古到今一脉相承,流传沿用而不变。再者,传统的东西还往往具备这样一个特点:从其诞生伊始,就是一个精美的“成熟体”,因而对于后人来说只需继承发扬,只需殚精竭虑地去理解古代睿智圣贤的微言大义。就医学而论,所谓“科学化”与“现代化”的问题,那只是在西方近代医学传入之后,当一种全新的医学体系从根本上否定了传统医学的理论体系及其赖以存在的基础,并占据了医疗、卫生保健的主要舞台时,传统医学的领地中才被动地出现了“革命”。然而如果我们仔细观察中国的传统医学,则不难发现:传统之中还有传统,传统之中也有革命。

一、传统中的“传统”

为了便于理解“传统中的传统”这一表述方式所欲说明的问题,不妨以“外科”在传统医学中的地位以及一些相关问题作为讨论的切入点。

当某位医生大施“回春妙手”之神技,治愈了某患者的顽症痼疾

时，常可见患者送上一面写有“华佗再世”四个大字的锦旗或牌匾，以赞誉这位医生技艺高超——好比神医华佗再现人间。华佗是谁？在华夏大地可谓妇孺皆知。《三国演义》中说华佗曾为关羽刮骨疗毒，后因要为曹操开颅治头痛而遭杀害。而医学史家则根据《三国志·华佗传》及注文中所引用的《华佗别传》有关华佗开腹取疾的病例记载，来言说中国传统医学原本含有高明的手术技艺，只不过后世失传了等。

在此，我们不必深究华佗是否真的能够实行开腹手术，只需注意当代民众与史学家、科学家对于华佗作为中国古代杰出医家代表一事所持的肯定态度。但是必须注意的是，当代人之所以对华佗持肯定赞誉的态度，在于他们均受到了近代西方医学的影响和现代科学教育的熏陶，从而首先是在思想意识中接受了“手术疗法”——对此种疗法持肯定态度，所以才会对华佗予以肯定与赞扬。然而这却不能代表传统意识——因为这种肯定的态度并非从古至今一脉相承。从总体上讲，由于古代医家对于手术疗法多取否定态度，因而华佗也往往难免要受到指责与批判。宋代张杲著《医说》，其中评价华佗“剖臆续筋之法”为“别术所得，非《神农本草》经方条理药性常道尔”，并说只有张仲景的著作才是“众方之祖，学者当取法云”。明代医家虞抟著《医学正传》，赞扬《黄帝内经》、《难经》是“医家之宗”；东汉张仲景的《伤寒杂病论》是“千古不刊之妙典”；对于华佗“刳腹背、湔肠胃而去疾”的治疗方法——手术疗法，则指责为“涉于神怪”。清代喻昌著《医门法律》，指责华佗是“浸涉妖妄，医脉之断，实儒者先断之也”。

据说华佗曾创制了可以起到麻醉作用的“麻沸散”，并运用于手术之中。虽然史书、医籍中并无“麻沸散”药物构成的记载，或者说“麻沸散”只是一种传说，但日本古代有位名叫华冈青洲(1760～1835)的医师，基于对华佗“麻沸散”麻醉效果的执拗崇信与追求，终

于研究出可以起到麻醉效果的“通仙散”，并在世界上首次完成了乳癌切除手术，从而名垂青史。像华冈青洲这样，受到某种传闻的影响，激发出再创造的热情，并最终获得成功的现象，在科学史上被称之为“激发传播”(stimulus diffusion)。其大概的意思是说：由于听说某种“发明”的存在，从而激发出独立再创造的动机与热情，并付诸实践、取得成功。这种听说到的“发明”究竟是真是假并不重要，重要的是这种讯息使得其他人相信该“发明”是可能的，从中获得了创造的动机与信心。相比而言，中国古代的医家却丝毫没有从华佗开腹疗病及“麻沸散”的传说和故事中获得任何再创造的动机与热情，其原因恰恰在于“传统中之传统”的巨大影响力。

那么这个具有强大影响力的“传统中之传统”又是如何形成的呢？“外科手术”果真自古以来就在中国传统医学中无立锥之地吗？

当我们将整个中国古代医疗实践称之为“传统医学”时，其中确实存在着“外科”、存在着刀割线缝的治疗方法。类似于手术刀的医疗器具“砭”，最早见述于 1973 年湖南马王堆三号汉墓出土的医书中(墓葬年代为公元前 168 年)。从其记述中可以看出，“砭”的用途是切开痈肿，称之为“启脉”；并有需视痈肿大小浅深，选择或制备适用之“砭”的说明。其后，在今本《黄帝内经》中记载了称之为“九针”的医疗用具，其中含有相当于“砭”或手术刀的“铍针”——长四寸，宽二分半，末如剑锋，以取大脓(《灵枢·九针十二原》)。降至隋唐时期，医书中开始教人如何以手术方法治疗金疮肠断、修补兔唇等。这些似乎都足以说明中国的传统医学中同样含有外科、含有手术疗法。然而从另一方面讲，我们也必须看到：尽管可以说砭石与铍针具有相当于手术刀的功能，但在中国历史上“外科”实际上是以治疗外部的疾病为定义，并不具有现代医学之“外科”——“以手术为治疗方法之核心”的含义。但即使如此，这种切开排脓的小手术也还是要受到

非议。南宋医家陈自明在其所著《外科精要》序文中介绍了外科不受医家重视的状况:“今乡井多是下甲人专攻此科。”陈自明本人虽然重视外科,但他对外科发展的贡献却在于:将内科的理论学说、治疗方法移植于外科;在体表局限性病灶的治疗当中,贯彻中医内科“辨证施治”的所谓“整体疗法”。明代医家薛己注释此书时评价:“虽以疡科名其书,而其治法,固多合外内之道。”这是所谓“中医外科”发展过程中的一个重要转折。换句话说,正是由于出现了许许多多这样的转折,才形成了无论内外疾患,中医皆强调“内治”这样一种“传统”。

宋代以后,知识分子对医学的态度有较明显的转变。从鄙视医家为“君子不齿”的“百工贱业”,转而云“不为良相,则为良医”;称医学是“吾儒格物穷理之一端”。在社会上出现了众多的“儒医”。由于研究“儒医”问题的大多为社会学学者,因而他们往往只能注意到“儒医”均有良好的文化素养、道德风范等外在特点,很难发现“儒医”对医学体系自身产生了怎样的影响。前述陈自明无疑可以称得上是一位文化素养不错的医家,是不同于“下甲人”的儒医,而这也正是他的《外科精要》“多合外内之道”的根本原因。类似之例如金元四大医家中的朱震亨,他先从朱熹的四传弟子许谦习儒,后改业医。从学医、业医的目的上讲,朱震亨言:“吾既穷而在下,泽不能致远。其可远者,非医将安务乎?”①此乃儒医共同的价值观,即将为医惠民作为自我实现的途径之一。而在医学理论上,朱震亨则力主“滋阴”(阴为体,“滋阴”即补其形质,扩太极而大之),反对刀针。例如妇人乳腺炎,必有成脓时,此时放出脓汁本是正治,但朱震亨却斥责说:“庸工

① 宋濂:《故朱丹溪先生朱公石表辞》。引自《丹溪心法》,上海科学技术出版社,1959年,第389页。

喜于自炫，便用刀针引惹拙痛。”①又例如明代的儒医王肯堂，在其所著《证治准绳》中载有治疗一切痈疽肿疡的著名方剂“仙方活命饮”，药物组成中含有代替刀针作用的穿山甲（取其钻洞之性）、皂角刺（取其刺透之功），同样反映出崇尚温和的治疗方法、避免直接动用刀针的倾向。在方书中还能见到名为“代刀散”的方剂，也是以内服皂角刺来代替直接动用刀针。

在眼科治疗方面，中国传统医学通常是从肝脏功能着眼，采用内服药治疗为主。印度眼科传入之后，中医除接受了“金针拨内障”的技术，还在钩、割、烙等手术治疗方面大受影响。可以说经过在手术疗法方面吸收域外医学技艺，中医眼科始见较明显的发展，形成了药物（内服与外用）和手术疗法并重的格局。在流传的眼科著作中，虽然能够看到印度医学知识直接或间接的影响，但均系经过改造后的吸收。在理论方面，将印医的“五轮”改造成与五行相配的“五轮”说；对于“钩割针烙”的手术疗法，则在明记“右龙木论金针开内障大法”的同时，却又说：“钩割针烙之法，肇自华佗。”②清代黄庭镜《目经大成》则说：“原夫钩割针烙之术，仿黄帝九针所作，闻自汉华元化先生得来，一云龙树山人，未知孰是。”这些在学术源流上附会黄帝九针、华佗技艺的，还算不上保守派；至如《一草亭目科全书》、《异授眼科》、《银海指南》等，则在内容上只取药物治疗方法，根本不接受手术疗法。有意思的是民国时期曹炳章（1877～1956）在编撰《中国医学大成》时，于眼科则唯收此三书，其用心显然是为了捍卫“传统中之传统”。

类似情况在药物学中也有表现，这从历代医家对于《神农本草

---

① 朱震亨：《局方发挥》，第63页。

② 傅仁宇：《审视瑶函》卷一《钩割针烙宜戒慎论》，上海人民出版社，1959年，第29页。

经》的态度可以知晓。众所周知,《神农本草经》是现知最早的本草学著作,但其载药不过三百馀种。南北朝陶宏景搜采历代名医附经为说的文字进行增补,唐宋两代再行修订而成《新修本草》与《证类本草》,其载药数量及各方面内容均大有增加,但《神农本草经》原文的核心地位却毫不动摇。明清医家对于《神农本草经》的尊崇程度空前无比,他们批评李时珍在《本草纲目》中引用金元医家的见解注释《神农本草经》;并从《新修本草》、《证类本草》等保存有原始文字的官修本草中辑复早已失传的《神农本草经》;著有《本草崇原》、《本经逢原》、《神农本草经百种录》、《本草经读》、《本经疏证》等"疏本经大义"的著作。医家们一边不断地赋予东汉医家张仲景所著《伤寒杂病论》的条文以新的解释,通过重新排序而提炼出一个"六经辨证"的纲领,一边又在指责魏晋太医令王叔和的首次整理是"碎剪美锦"、"贾人居奇"。我们固然可以认为这些现象都是尊经复古的表现,但还需注意到他们并非有经即尊、凡古必复。再何况《伤寒杂病论》原本并非是"经",而是通过宋代以后医家的重新解释才从一般方书上升成为理论性著作,成为"经"的。显然,后世医家实际上是在整理、构建医学体系的过程中,根据自身的需求寻找适合的材料。中医著作虽然不胜枚举,医方著作又何止千万?但其中最受推崇的核心著作不过数种;常用的方剂、药物亦都十分有限,于是这些内容便构成了中国传统医学宝库中的核心、精粹、主流——也就是传统中的传统。

二、传统中的"革命"

中国科学院院长路甬祥在一篇阐述科学发展之历史的文章中谈

到:“科学的意义在于发现和创新。有新的发现,对已有的知识按新的观点进行分析和归纳,创造新的科学理论和新的科学方法,或者开发科学知识新的应用”;“贝尔纳(T.D.Bernal, 1901～1971)提出,许多科学观念的改变就合成一场科学革命。迄今,已发生的科学革命,其中包括一些重大的科学突破,往往不仅仅是重大知识和方法上的创新,而且从某种意义上是对原有知识结构和理论体系的重整与更新”①。这些固然都是就诞生于西方的近代自然科学而言,但索之于中国古代的科学——古代中国人对自然的认识,亦不无相合之处。传统医学的基础理论体系虽然基本上可以说形成于秦汉时期,今天的中医教材虽然还在使用着这些经典性著作作为教材、作为指导临床实践的准绳,从表面上看“传统”可谓是漫长历史过程中的“保守性”方面,是对某种文化内容的继承,但实质上其间亦屡屡有“革命”发生。这种革命有多种表现形式,首先即是扬弃②,例如第一节中所谈对于外科手术疗法的直接排斥。同时通过对某些认知方法与实用技艺的大加提倡,从而在丰富多彩的医学知识与应用技艺中构建起一个核心的体系。其二则是概念的重组,例如在先秦时期“阴阳”与“五行”本为两家之学,各自为说,表现在医学领域中亦是如此:众所周知,《黄帝内经》各篇并非成于一人之手,亦不是一时之作,其中某些篇章以“阴阳”为立论基础,某些则以“五行”为说理工具。至东汉时期,出现了《难经》,其最主要的特点之一就是要将阴阳与五行结合

---

① 路甬祥:《科学的历史经验与未来》,《自然科学史研究》,1998 年第 3 期,第 197～206 页。

② “扬弃”的准确含义并非是指简单的排斥或否定,而是指通过否定某些内容、改造某些内容,进而建立起某种新的东西。

在一起。① 例如讲“一脉为十变”,原因是五邪(五行比类)与刚柔(阴阳划分)相互作用(5×2=10);积聚分为阴阳两种,是阴阳的运用,续将“积”分为五类,则是五行说的体现。后世秉此,大谈五脏各自的“气血”、“阴阳”问题,正是“五行”与“阴阳”两说相合的延续与发挥。

又如在后人补入今本《黄帝内经》的“七篇大论”中,出现了前所未见的“运气学说”。这个学说的第一个特点是将“五运主时”,即五行在一年当中各主72日的学说向前拓展了一步——五行不仅主时,而且主年。于是便产生出了一种新的学说。“五行主时”,原本与四季气候变化等自然现象有着密切的关系,但向前拓展一步之后,即与“自然”失去了任何内在的联系。运气学说的第二个特点,是将五行(五运)与阴阳(六气)结合在一起,用以解释疾病发生、疫病流行的原因。由于五行与阴阳结合在一起,于是“五运”便各有“太过”与“不及”的两种表现形式;又由于五行要与六气(三阴三阳)相配存在着困难,于是又将五行中的“火”加以改造,出现了“君火”、“相火”的概念。这些改造、新的概念,对于此后中医理论的发展产生了深刻的影响。“七篇大论”所阐发的虽然都是“运气学说”,但这七篇文章原本各自独立,使用着不同的概念与推算方法。简单地说,一种推算方法中不过各有一运一气。但是到了宋代,医家却要将这七篇文章视为一个整体,或者说是有意识地要将其改造成一个完美的体系,由此便产生出多种“运”与“气”的概念,分别称之为主运、客运、中运、大运,主气、客气、岁气、司天之气、在泉之气等。用现代语言说,即在“运气”之下分别出现了许多子概念。

“革命”的另一种表现形式是赋予原有的概念术语新的内涵与解

---

① 廖育群:《〈难经〉医学理论的时代特征》,《中华医史杂志》,1993年第1期,第20~26页。

释。例如金元以后的医家，或许是因宋代医学考试必有“运气一道”的影响，对运气学说极为熟悉，并常常可见强调运气学说重要性的论说。但从事实际治疗的医家无疑都不难发现，临床上并看不到疾病的属性存在着依运气推算所示的规律。于是便又对运气学说进行了偷梁换柱的改造。例如金元四大医家之一的刘完素，以力倡运气而闻名，但他所说的运气并非依时间变化的运气，而是根据临床表现而定。虽然刘完素强调“医教要乎五运六气……不知运气而求医无失者鲜矣”(《素问玄机原病式·自序》)，又著《内经运气要旨论》以“明天地之造化，论运化之盛衰”，但他思想中所要说明的实际是认为天地间存在着不同属性(风、寒、暑、湿、燥、火)的“病气”，这是使人患病的根本原因：“病气为本，受病经络脏腑谓之标也。”(《素问玄机原病式·六气为病》)天地间的“病气”谁也看不见，脱离运气循环的固定时间推算，则只不过是通过临床表现来反推病因为何——感受了天地间的哪种“病气”。因此这样的运气学说，不仅不是真正的运气学说，甚至连病因学说方面的意义也不甚明确。其实质乃是对疾病性质、属性的诊断(定性)，并由此决定治疗方法。金元以后的运气提倡者，实质上有许多都属此类。

又如“元气”是一个十分古老的概念术语，金代医家李杲强调一切疾病皆由脾胃之气受损引起，于是便将“元气”解释为“胃气”；后来的医家重视“补肾”，便将“元气”解释为“肾气”。古人在不知道尿循环、尿生成的基本生理过程时，以为经口进入胃、肠的水分是通过某个器官渗入膀胱的，所以五脏六腑中含有一个后人不能确指为何器官的“三焦”。在《黄帝内经·素问》中明确地指出，三焦的功能是“决渎之官，水道出焉”；但大约在唐代开始，三焦被解释成为人体上、中、下三段，心肺之疾可以说“病在上焦”，脾胃之患为“中焦之疾”，胎产经带、阳痿不育、腰膝酸软则属“病在下焦”。到了清代，温

病学家脱离东汉张仲景以来“六经辨证”的体系，用上、中、下“三焦”作为划分热病进程的“阶段”，使得这个概念的内涵发生了彻底的改变。

综观中国传统医学几千年的发展历史，小的“革命”时时可见，但有几次大的“革命”不容忽视。首先是今本《黄帝内经》集结成书的时代，过去一般认为今本《黄帝内经》成书于战国时代，但自马王堆汉墓医书出土之后，这种观点受到了极大的冲击，很多学者倾向于其集结成书应在西汉末年，甚至再晚一点。今本《黄帝内经》，即《素问》与《灵枢》两部独立著作，虽然处处可见有关人体生理、病理的不同解释以及完全不同的治病方法，但从其分别由“九卷”、九九“八十一篇”这样的“完美数字”构成，即能体会到编撰者力图构建完美体系的用心。西汉末年，王莽曾“网罗天下异能之士，至者前后千数，皆令记说廷中，将令正乖缪、壹异说”(《汉书·王莽传》)；公元 79 年，“诸儒会白虎观，讲议五经异同，帝亲称制临决，如孝宣甘露石渠故事”(《后汉书·章帝纪》)，都反映出当时文化体系整理的背景。特别是王莽时代，其事所涉明显不是儒家学问正统，所网罗者乃“天下异能之士”，理应与“方技”有关；其目的又是“正乖缪、壹异说”，这些都有助于我们思考《素问》、《灵枢》的成书时代、编辑意图等。下面这个典型的例子可以看出今本《黄帝内经》中是如何“壹异说”的。

《素问·五脏别论》开篇之处提出了这样一个问题：

> 黄帝问曰：“余闻方士或以脑髓为藏，或以肠胃为藏，或以为府；敢问更相反，皆自谓是，不知其道，愿闻其说。”

由此可知，中医的“脏腑学说”在早期并没有一个统一的模式，而是呈多样性状况。其下为回答这一问题而言：

脑、髓、骨、脉、胆、女子胞，此六者地气之所生也，皆藏于阴而象于地，故藏而不泻，名曰奇恒之腑。夫胃、大肠、小肠、三焦、膀胱，此五者天气之所生也，其气象天，故泻而不藏，此受五脏浊气，名曰传化之府，此不能久留，输泻者也。

在其后的文字中又谈到：

所谓五藏者，藏精气而不泻也，故满而不能实。六腑者，传化物而不藏，故实而不能满也。

概括这些论述的内容则成表1，这也就是自《素问》之后直至今日，中医教科书中的脏腑学说。

表1　脏、腑的划分与功能

分　　类	器　　官	功　　能
五　　脏	心、肝、脾、肺、肾	藏精气而不泻，满而不能实
六　　腑	胃、大肠、小肠、三焦、膀胱、胆	传化物而不藏，故实而不能满
奇恒之腑	脑、骨、脉、胆、女子胞	藏而不泻

然而这个体系化、经典化的“脏腑学说”却有许多可以质疑之处，述之如下：

1. “胆”即是六腑之一，又是奇恒之腑。上引《素问·五藏别论》述“传化之腑”时虽未言及胆，但后面对比五脏六腑功能时，言六腑为“传化物而不藏”，显然指的不是数目为“六”的奇恒之腑，而是通常所说的“六腑”。

2. 一般言说五脏六腑时，是阴阳相对，即脏为阴、腑为阳，何以此处奇恒之腑“皆藏于阴而象于地”呢？

3. “传化之腑”何以为五？而不是像其他篇中所说为六？

如果仔细分析一下上引文字中有关“奇恒之腑”与“传化之腑”的文字，则可整理成表2，并不难发现两者已经构成了一个自洽的对应体系。

表2 “奇恒之腑”与“传化之腑”的比较

分　类	数字	器　官	比类	功　能
奇恒之腑	6	脑、髓、骨、脉、胆、女子胞	象地	藏而不泻
传化之腑	5	胃、大肠、小肠、三焦、膀胱	象天	泻而不藏

表3 “五脏六腑”说的基本内容

分　类	数字	器　官	比类	功　能
五　脏	5	心、肝、脾、肺、肾	象地	藏而不泻
六　腑	6	胃、大肠、小肠、三焦、膀胱、胆	象天	泻而不藏

这样一来便不难看出，上述质疑诸点之问题的产生原因，大概皆是因为该篇作者要将表2所示的自洽体系与另一种自洽体系“五脏六腑”说(表3)融合在一起而引起的。不管这个改造、融合的结果是否完美，但作者“壹异说”的意图是十分清楚的，而且千百年来并未有人对此提出质疑，始终将这一模式“五脏—六腑—奇恒之腑”作为中医脏腑学说的范式。值得一提的是，在大约成书于东汉时期的《难经》一书中，有人对“五脏六腑”说提出了改造的意见，即：

1. “脏”应该为“六”(偶数阴)

2. “腑”应该为“五”(奇数阳)

具体的改造办法是：

1. 将两枚肾脏解释成两个独立的“脏”——左“肾”(属阴、属水)，右“命门”(属阳、属火)

2. 因六腑中的“三焦”有名而无形，故“腑”为五

尽管在中国传统文化中“阳奇阴偶”的数术观念一直被广泛使用，但这一“合理化建议”却未被医学家们接受——某种理论学说一旦形成，便会植根于民众之中，要想改变并非易事。只是到了宋代以后，随着《难经》一书在医学中的地位上升，医学家们才逐渐在思辨与理论构建中开始重视“命门”——将其作为一个独立的概念加以论说。其代表人物即明代医家张景岳。①

类似之例则是经脉学说，近年来由于湖南长沙马王堆、湖北江陵张家山汉墓医书，以及四川绵阳经络木人等一系列考古发现，方使人们了解到早期经脉学说的多样性。直到今本《黄帝内经》成书时，《灵枢·经脉》给出了一个经脉学说的范式，起到了“正乖缪、壹异说”的客观作用。此后人们即一直尊而奉之，未见大的改变。

第二次大的革命，可以说是出现于宋代，延及金元。例如东汉医家张仲景所著《伤寒杂病论》，原本只是被视为一部“方书”，自宋代成无己注释此书，始展现出一个“六经辨证”的理论体系，因而受到越来越多医家的重视。《伤寒杂病论》才逐渐从“方书”上升成为“经”；张仲景也历“亚圣”之位，最终走上“医圣”的宝座。医家从《伤寒杂病论》中阐发出的微言大义、六经辨证体系、组方理论、用药原则，是否能够代表东汉时期的医学认识与水平，大可加以研究。日本中世纪的著名医家、古方派的代表人物吉益东洞力倡使用《伤寒杂病论》的方药，但其所著《药征》一书却认为《伤寒杂病论》的用药原则毫无例外地只是对症下药——有是症，则用是药。或许这更接近于《伤寒杂

---

① 详见张氏所著《景岳全书》，其要在于将左肾视为“真阴”、“真水”的寓存之处；右肾（命门）为“真阳”、“真火”的寓存之处。创制了“左归丸”、“右归丸”两个代表方剂，分别用于滋补“真阴”、“真阳”。

病论》的本意。

其后，出现了各以己说鸣于世的刘完素、张从正、李杲、朱丹溪四位代表性人物，被后人称之为“金元四大家”。这四位人物的共性在于皆自谓忠实于《黄帝内经》，然理论学说却各不相同。《四库全书总目提要》谓：“儒之门户分于宋，医之门户分于金元”，即是指此而言。这四位医家的共性之二在于虽然立说各异，但却均试图以一个终极的原因解释复杂多样的疾病现象：刘完素认为所有的疾病都由“火热”为患；张从正说疾病非人身固有之物，故可归为一个“邪”字，用汗、吐、下三种方法将病邪驱出体外即可含括“治病”的全部意义；李杲以为脾胃消化饮食、吸收营养，乃是生命之本，故只需调理好脾胃则无病不愈；朱丹溪视“阴”为本，无阴之体则无阳之用，所以治病只在滋阴。从表面上看，这四位医家代表了金元时期医林中不同学派的见解；但从本质上看，他们都是在“力矫时弊”——否定当时社会上普遍流行的医学理论与治疗方法。换句话说，也就是要在医学理论与治疗方法上促成一场革命。事实上他们的目的也都达到了，刘完素创制的著名方剂“防风通圣散”至今仍作为常用成药售于药店，并从理论上修正了以往“先解表、后清里”的治疗原则——表里双解；李杲的“补中益气汤”同样售于今日之药店，并被广泛应用于贫血、骨折不愈合、胃下垂等多种疾患的治疗当中；朱丹溪滋阴养血的“王道”更是备受后人青睐；唯有张从正的攻邪理论——“霸道”，难被医家、患者所接受。

第三次革命应该说产生于近代西方医学传入之后。研究者一般较注意西方医学传入之后，传统中医如何捍卫自己的医学体系与生存空间，却忽略了由于存在着另外一种医学体系，传统的一方在不知不觉中即会发生许许多多潜移默化的变化。例如在西方医学传入以前，中医并不了解人体的脉管系、神经系，他们认为这些都属于“脉”

的概念范畴。只有当清晰的解剖图、脉管系模型，以及有关血管、神经的功能解释都展示眼前时，中医才知道“经脉”是看不见的。并在某些人试图以血管、神经解释“经络”时，发出强烈的反对意见。又譬如中医几千年来甚至不知道心脏会跳动，在他们的心目中，“心”为君主之官，岂能日夜不休地劳动？因此十二经脉循环圈的起点是在胃——通过消化饮食获得了气血运行的功能。也许有人会问：难道中国古人对于自己胸前手触可知的心尖搏动会无所察觉吗？的确有所察觉，但在中医学里将此解释为：“胃之大络，名曰虚里，出左乳下，其动应衣。”或许又有人会问：难道活人与死人存在着心跳或不跳的差异也不被人察觉吗？中国古代对于死亡的判断的确只注意呼吸和体温。任何一位老中医，不管他的现代科学知识多么有限，不管他多么保守、排斥西医，恐怕没有再将经络与血管混为一谈，或不知心脏会跳动者；他们虽然会反对用西药治疗肾炎，但不会再认为尿是从肠子深入膀胱的，而且清楚地知道这是“腰子”出了毛病。在没有搞清肺循环与气体如何交换的时代，人们绝对不可能设想吸入的空气只是到了肺里，而是设想吸入的空气要在五脏间周游一周。然而现代的中医再也不会这样看待呼吸过程了，其原因就在于有了西方医学的存在。诸如此类的例子不胜枚举，如果看看这些事实、这些变化，谁还能说中国传统医学与近代西方医学仅仅是对立的关系，是相互排斥的？谁还能够无视西方医学传入之后，传统医学内部发生的变化？实际上，西方医学传入之后，中医学内部所发生的革命，是最彻底的、也是最重要的一次革命。在这场革命中，中医接受了近代科学有关人体形态、解剖学方面的基本知识，否定了自身体系中的错误学说。在这场革命中，中医接受了西医的病名，而将自己原来的病名，如气虚、血虚、痰湿、气郁等，改称为“证”，强调中医的特色在于“辨证施治”。其实，“证”与“症”在前此的汉语中是通用的，凡“症”皆可称

“证”。“辨证施治”的提出，实际上要迟至近人编写中医教材才见使用。他们不会再像李时珍那样说三指诊得之脉会出现寸快尺慢（食指快、无名指慢），因为他们知道心跳决定脉搏只能是一致的。但是他们并不去批判自古以来这种说法的错误性，不去思考何以会有这种错误产生，不去怀疑究竟哪位医生真的摸到过这种脉。他们悄悄地扬弃自己传统中的谬误；努力发扬光大传统医学的长处与优势，希望能将经过这次革命性的改造之后所形成的新的“传统中的传统”——辨证施治的思想方法、丰富的治疗经验、用药知识，传递给自己的后代。并希望全人类都能受惠于东方传统科技中唯一仍旧具有生命力的知识体系——中国传统医学。他们还希望西方医学能在吸收东方文化的基础上也发生一场革命，从而创立出一种新的医学体系。

三、传统医学的现代化

问题一：现在的中医是否与古代的中医相同？

问题二：如有不同，那么区别何在？

这样的问题应该由谁来回答？西医与一般人一样——无力回答这样的问题，因为他们不了解中医这门学问。史学家（包括科学史家）及哲学家大概可以对问题一作出原则性的回答：“不一样”，但却无法回答问题二——因为他们同样不了解这门学问的具体内容与发展的过程。

中医业内人士大概会说“没什么区别”——因为他们大多仅仅是在二维空间上看待并使用着这门“依然存活的古代科学”。就像本文

一开始所谈到的那样：人们往往会认为传统的东西从古到今一脉相承、流传沿用而不变；从其诞生伊始，就是一个精美的“成熟体”，今人所言莫不属“古已有之”。

专业的医史研究者理应是上述问题的回答者，因为他们既了解中医这门学问，又有历史的眼光——能够在三维空间上看待一门学问的发展过程。但遗憾的是几十年来的医史研究似乎太习惯于按照历史朝代分别阐述医学各个方面的发展与进步，似乎这就是历史发展的必然轨迹，而忽视了历史的真实面貌。在最近几年的医学史研究中，同时还悄然出现了一个十分有趣的新现象，即避让开这个核心、主流，而是注目于没有纳入“传统中之传统”的那些内容，而且似乎越是远离主流的东西就越显得有味道。有人称此为“医学文化史”，有人称其为“另类医学史”，有人称其为“医学社会史”，甚至是“没有医学的医学史”。我以为这类研究都可以纳入一般历史学的范畴。因为就其本质而言，只不过是在历史研究的过程中扩大了史料的利用范围，拓展了史学研究的范围；弥补了“通史”本来就该包含人类在一切领域的认知活动，但实际上却未包含被今人称之为“科学史”的那些人文历史之缺陷。而对于医学史或科学史研究来说，则有助于看清“传统中之传统”——古代科学技术的主流体系是如何从庞杂的“历史存在”中拔萃而成的。

因此，医学史的研究，如果不是那种纯史学性质的考证，或“成就派”式的赞扬，而是真正能够深入到学术内部的理论性研究，那么就最有资格来回答什么是“中医现代化”的问题。这也就是为何我一再强调“传统中之传统”的原因所在。因为在漫长的历史中，构成这个“传统”的方方面面并未出现平行发展的局面。而是在特定的文化背景下，通过有目的的“选择”，构建起一个庞杂体系的核心，并因此引导与规定着这门学问的发展。另一方面，当知识的积累达到一定程

度，杰出人物、社会环境等各方面因素皆充分具备时，学问体系的内部即有可能产生或大或小的“革命”——知识的重整与创新。“传统中之传统”的构建与“革命”两方面的综合作用，决定了传统医学这门学问古今大不相同。可以说，今日的中医，绝不是古代的中医。从这一角度出发，从这样的立场看问题，中医并不存在“亟待解决”的现代化的问题——因为它已经“现代化”了，并将永远随着时代发展而不断发展。一切有关中医“现代化”的呼吁，实际上都是将当代的中医视为几千年来一成不变的学问体系，都是以当代西方医学为尺度来衡量中医这门学问。

至于说中国的传统医学究竟是否还有沿着自身固有轨迹向前发展的空间？无论是从理论上讲，还是从客观实际上讲，回答都应该是肯定的——只要你承认近代科学不是“唯一的科学”，不是“正确、真理”的同义词，不是“终极真理”。但究竟如何发展，则只能由事实做出回答，没有必要去做太多的空洞“预测”。

广西师范大学出版社中医图书品牌系列

医者意也——认识中医　廖育群

思考中医——对自然与生命的时间解读　刘力红

走近中医——对生命和疾病的全新探索　唐　云

挽救中医——中医遭遇的制度陷阱和资本阴谋　吕嘉戈

中医文化对谈录　张大钊

中医的神奇与玄虚一直让人困惑不解。中医的本质、特性、原理、功能及其与中国本位传统关系到底怎样，几乎是所有人都希望了解的。本书作者出身中医世家，又是一名科学家，他以丰厚的传统文化修养和精深的科学知识来认识中医的奥秘，从“医者意也”这个灵魂性的观念入手，系统展示了中医的全部秘密，把中医的思维方式、理路和标准讲得清清楚楚，同时就中医与巫术思维、阴阳学说、气血运行学说、道家养生学说等之间的内在关联性作了别开生面、极富启发意义的阐说。对于想了解中医、领略中医精魂、获得祛病养生捷径的读者来说，实为正本清源、拨云驱雾之作。文字简明扼要，极为可读。

ISBN 7-5633-6006-9

9 787563 360062 >

上海贝贝特

ISBN 7-5633-6006-9/R · 072

定价：18.00 元